



**Wspierająca
Szkoła**

Raport

opracowanie wyników ankiet sprawdzających wiedzę

Warszawa 2026

PROGRAM



**Wspierająca
Szkoła**
FUNDACJA ADAMED

WSPÓLFINANSOWANIE



Zadanie dofinansowane z budżetu Państwa ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025



Ministerstwo
Edukacji Narodowej

REALIZATOR



życie warte
jest rozmowy

WSPÓLORGANIZATOR





Spis treści

Wstęp.....	4
„Uczeń w kryzysie psychicznym – jak go rozpoznać i wspierać?.....	8
Ankieta sprawdzająca wiedzę przed szkoleniem.....	9
Ankieta sprawdzająca wiedzę po szkoleniu	13
Podsumowanie.....	20
„Rodzice ucznia w kryzysie psychicznym – jak ich motywować do współpracy?	22
Ankieta sprawdzająca wiedzę przed szkoleniem.....	23
Ankieta sprawdzająca wiedzę po szkoleniu	28
Podsumowanie.....	34
„Uczeń po próbie samobójczej – jak go wspierać w powrocie do szkoły?	36
Ankieta sprawdzająca wiedzę przed szkoleniem.....	37
Ankieta sprawdzająca wiedzę po szkoleniu	42
Podsumowanie.....	47
„Dobrostan psychiczny nauczyciela – jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami?	48
Ankieta sprawdzająca wiedzę przed szkoleniem.....	49
Ankieta sprawdzająca wiedzę po szkoleniu	54
Podsumowanie.....	59
„Pierwsza pomoc emocjonalna: jak rozpoznać kryzys samobójczy u ucznia i jak powołać zespół kryzysowy w szkole”	61
Ankieta sprawdzająca wiedzę przed otwartym webinarzem dla pracowników szkół.....	61
Ankieta sprawdzająca wiedzę po otwartym webinarze dla pracowników szkół.....	67
Podsumowanie.....	74
„Jak rozpoznać kryzys emocjonalny u nastolatka i jak zareagować?” – spotkanie edukacyjne dla rodziców	76
Ankieta sprawdzająca wiedzę przed spotkaniem edukacyjnym	76
Ankieta sprawdzająca wiedzę po spotkaniu edukacyjnym	81
Podsumowanie.....	87
„Pierwsza pomoc rodzicielska: jak rozpoznać kryzys emocjonalny u dziecka i nastolatka i jak zareagować?”	89
Ankieta sprawdzająca wiedzę przed otwartym webinarzem dla rodziców i opiekunów	89
Ankieta sprawdzająca wiedzę po otwartym webinarze dla rodziców i opiekunów	93
Podsumowanie.....	99
„Pierwsza pomoc rodzicielska: Uzależnienia dzieci i młodzieży”	100



Ankieta sprawdzająca wiedzę przed otwartym webinarzem dla rodziców i opiekunów	100
Ankieta sprawdzająca wiedzę po otwartym webinarze dla rodziców i opiekunów	104
Podsumowanie.....	111
Wnioski.....	113





Wstęp

Wsparająca Szkoła to pierwszy w Polsce kompleksowy program dotyczący zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży, skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Bezpośrednimi odbiorcami programu są dorośli – nauczyciele oraz szkolni psycholodzy, pedagodzy oraz pozostali pracownicy szkoły, a także rodzice. Celem programu Wsparająca Szkoła jest przekazanie powyższym grupom stosownej wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz przekazanie odpowiednich narzędzi, które pozwolą odpowiednio dbać o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży.

Podstawą do stworzenia programu Wsparająca Szkoła były wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2007) dotyczące profilaktyki w szkołach, dla której w kontekście zapobiegania zachowaniom samobójczym kluczowe jest:

- wzmacnianie zdrowia psychicznego dorosłych – nauczycieli i rodziców (dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat obciążenia psychicznego i możliwych zaburzeń psychicznych u siebie, innych dorosłych, dzieci i młodzieży oraz sposobów radzenia sobie z nimi);
- wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci i nastolatków (m.in. podkreślanie zasobów i mocnych stron, okazywanie życzliwości, zrozumienia, akceptacji, stosowanie pochwał);
- edukowanie dzieci i nastolatków n. t. wyrażania własnych emocji i radzenia sobie z nimi;
- zapobieganie przemocy w szkole;
- udostępnianie informacji o miejscach i telefonach pomocowych.

Istotnym punktem odniesienia podczas tworzenia programu były także, zawarte w przewodniku wdrożeniowym Live Life (WHO, 2021), cztery strategie zapobiegania zachowaniom samobójczym, które posiadają naukowo udowodnioną skuteczność: rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych u dzieci i nastolatków, wczesne identyfikowanie i adekwatne wspieranie osób z zachowaniami samobójczymi, ograniczenie dostępu do śmiertelnych metod, odpowiedzialne opisywanie zachowań samobójczych w mediach.

II edycja programu „Wsparająca Szkoła” realizowana była również dzięki dofinansowaniu z budżetu Państwa ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Dofinansowano ze środków budżetu Państwa Narodowego Programu Zdrowia. Zadanie pt. „Zobacz emocje – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej”.

W ramach niniejszej edycji programu odbywały się cztery szkolenia dla nauczycieli, każde trwało cztery godziny dydaktyczne. Tematyka szkoleń brzmiała następująco:

- Uczeń w kryzysie psychicznym – jak go rozpoznać i wspierać?
- Rodzice ucznia w kryzysie psychicznym – jak ich motywować do współpracy?
- Uczeń po próbie samobójczej – jak go wspierać w powrocie do szkoły?
- Dobrostan psychiczny nauczyciela – jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami?

Do każdego szkolenia opracowane zostały ankiety sprawdzające poziom wiedzy uczestników zarówno przed jak i po szkoleniu.

Szkoleniowcy to eksperci z zakresu suycydologii, którzy na co dzień udzielają konsultacji dotyczących kryzysu suycydalnego, próby samobójczej, samouszkodzeń czy postwencji. Szkolenia w ramach II edycji programu przeprowadzili następujący eksperci:

- Jolanta Palma – suycydolog, interwent kryzysowy
- Lucyna Kicińska – suycydolog, terapeuta narracyjny
- Małgorzata Łuba – suycydolog, psycholog, trener
- Joanna Skiba – suycydolog, pedagog, konsultant kryzysowy
- Magdalena Mastalerz – suycydolog, psycholog
- Maja Lipińska – psycholożka, suycydolożka, szkoleniowiec
- Melania Dominiak – suycydolożka, socjoterapeutka,
- Anna Malinowska – suycydolog, pedagog, pracownik socjalny, interwent kryzysowy
- Ewelina Cieśluk – suycydolog, nauczyciel, tutor
- Joanna Roch – pedagożka specjalna, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży
- Piotr Bakan – suycydolog, pedagog, psychoterapeuta



W ramach II edycji programu Wsparająca Szkoła zakwalifikowano 55 szkół z 16 województw. Dla tych placówek przeprowadzono łącznie 220 szkoleń dla kadry pedagogicznej, z których każde trwało cztery godziny dydaktyczne, co łącznie dało 880 godzin dydaktycznych zrealizowanych szkoleń. W szkoleniach uczestniczyło łącznie około 1221 nauczycieli.

Spośród zakwalifikowanych szkół – 35 placówek z 16 województw objęto pełnym finansowaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej – w ramach tych szkół przeprowadzono 140 szkoleń dla kadry pedagogicznej, każde po 4 godziny dydaktyczne co łącznie dało 560 godzin dydaktycznych zrealizowanych szkoleń. W szkoleniach dla placówek, których uczestnictwo zostało dofinansowane przez MEN przeszkolono łącznie 804 nauczycieli.

Zrealizowano 15 spotkań edukacyjnych dla rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do szkół biorących udział w programie Wsparająca Szkoła. W spotkaniach pt. „Jak rozpoznać kryzys u dziecka i nastolatka i jak zareagować” uczestniczyło łącznie 584 rodziców i opiekunów.

Ponadto przeprowadzono 6 webinarów otwartych dla wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów pt. „Pierwsza pomoc rodzicielska: jak rozpoznać kryzys emocjonalny u dziecka i nastolatka i jak zareagować”, w których wzięło udział łącznie 1760 osób.

W ramach programu opracowano również nowy cykl webinarów otwartych, poświęconych problematyce uzależnień dzieci i młodzieży pt. „Pierwsza pomoc rodzicielska: Uzależnienia dzieci i młodzieży”. Zrealizowano 4 takie webinary, w których uczestniczyło łącznie 513 osób.

Dodatkowo przeprowadzono 6 webinarów otwartych skierowanych do pracowników szkół pt. „Pierwsza pomoc emocjonalna: jak rozpoznać kryzys samobójczy u ucznia i jak powołać zespół kryzysowy w szkole”, w których uczestniczyło łącznie 1401 osób.

Szkoły biorące udział w programie Wsparająca Szkoła miały możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach. Bezpłatne konsultacje online dla rodziców i nauczycieli dawały możliwość odbycia indywidualnych spotkań ze specjalistą suycydologiem, podczas których każda zgłaszająca się na nie osoba dorosła miała okazję omówić sytuację i trudności emocjonalne doświadczane przez dziecko lub nastolatka. Główny obszar konsultacji obejmował zachowania ryzykowne, autoagresywne oraz samobójcze.

W ramach konsultacji dla nauczycieli w sprawie uczniów odbyły się 42 konsultacje.

W ramach konsultacji dla rodziców i opiekunów w sprawie dzieci odbyły się 223 konsultacje

Innym rodzajem konsultacji, w których nauczyciele mogli brać udział były bezpłatne konsultacje online dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, które dawały możliwość odbycia indywidualnych spotkań ze specjalistą-suycydologiem. Skierowane były do osób, które podejrzewały u siebie objawy wypalenia zawodowego lub doświadczały obciążenia emocjonalnego związanego z wykonywaną pracą w szkole. Odbyło się 5 takich konsultacji.

W ramach projektu szkoły biorące w nim udział miały możliwość opracowania we współpracy ze specjalistą procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Procedura zawierała wytyczne uwzględniające konkretny schemat postępowania, a także określała zadania poszczególnych pracowników. Jej stworzenie umożliwiło szkołom przygotowanie się na okoliczność wystąpienia zachowań samobójczych i adekwatne zareagowanie na nie przez grono pedagogiczne. Tworzenie procedury odbywało się w trakcie konsultacji online. W ramach projektu stworzono 55 procedur kryzysowych, które powstały dzięki 130 przeprowadzonym konsultacjom online.

Niniejszy raport przedstawia wyniki ankiet wypełnianych przez:

- nauczycieli i specjalistów z placówek edukacyjnych, a także pozostałych pracowników szkół (część I, II, III i IV raportu);
- wszystkich pracowników szkół chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat kryzysu psychicznego u dziecka i nastolatka, a także zrozumieć rolę i kompetencje szkoły w tym trudnym momencie (część V raportu)
- rodziców i opiekunów uczniów uczęszczających do placówek, które dostały się do II edycji programu „Wsparająca Szkoła” (część VI raportu)
- wszystkich chętnych rodziców i opiekunów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat kryzysu psychicznego u dziecka i nastolatka (VII część raportu)
- wszystkich chętnych rodziców i opiekunów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat uzależnień u młodych osób (część VIII raportu).



W II edycji programu Wsparająca Szkoła uczestniczyło w sumie 55 placówek:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie
- I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Pieszku
- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
- II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie
- IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu
- IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze
- VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie
- IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
- Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Perpetuum Mobile w Bydgoszczy
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowa Akademia” w Lublinie
- Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długowoli
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orłów Lwowskich w Opolu
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu
- Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie
- Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym
- Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi
- Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni
- Szkoła Podstawowa im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie
- Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Mierzynie
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie
- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu
- Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowej Soli
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku
- Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4PP „Czwartaków” w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach
- Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich w Łodzi
- Szkoła Podstawowa w Złotorzy
- Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pawła Adamowicza w Gdańsku
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie
- Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim
- Zespół Szkół Agropodsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
- Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie
- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku
- Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne
- Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
- Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
- Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszych
- Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
- Zespół Szkół w Szczurowej



Wsparająca Szkoła

- Zespół Szkół w Szumowie
- Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Certyfikat programu „Wsparająca Szkoła” otrzymało 55 szkół.

Gra edukacyjna dla uczniów pt. „Super Moce” została wysłana do 55 szkół, które zostały zakwalifikowane do II edycji programu Wsparająca Szkoła. Do każdej ze szkół trafiło po 5 egzemplarzy gry edukacyjnej, co łącznie daje 145 rozdyskutowanych egzemplarzy. Gracze wcielają się w postaci z grupy przyjaciół: Neona, Pixela, Focusa, Lunę, Elektę i Aurorę. Każdy z nich doskonale zna te dni, gdy życie niespodziewanie zamienia się w skomplikowaną układankę. W takich chwilach często nie potrafią pojąć swoich myśli i emocji. Wydaje im się, że sytuacja jest bez wyjścia, a uczucia zbyt trudne, by mówić o nich na głos. Siadają wtedy razem na ławce i próbują stawić czoła wewnętrznym demonom, dając sobie nawzajem wsparcie. Nie zawsze chodzi o znalezienie rozwiązania sytuacji – bywa, że już sama bliskość okazuje się kojąca. Ta ekipa wie, że jako ludzie mamy SuperMoce – są nimi umiejętności radzenia sobie wtedy, kiedy jest nam źle. Jedną z najważniejszych jest proszenie o pomoc i szukanie wsparcia, gdy czujemy się smutni i zmartwieni.

Do zakwalifikowanych 55 szkół zostały również rozesłane pakiety składające się z 2 egzemplarzy 6 poradników, 2 egzemplarzy scenariuszy lekcji, 10 plakatów informacyjnych dla młodzieży ze wsparciem rówieśniczym w 10 krokach i kodem qr do bezpłatnych materiałów dedykowanych

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę przed szkoleniem, formularz ankiety sprawdzającej wiedzę po szkoleniu oraz formularz ankiety ewaluacyjnej zostały wysłane w formie kwestionariusza online do wszystkich uczestników szkoleń.

PROGRAM



WSPÓŁFINANSOWANIE



Zadanie dofinansowane z budżetu Państwa ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

REALIZATOR



WSPÓŁORGANIZATOR





„Uczeń w kryzysie psychicznym – jak go rozpoznać i wspierać?”

Szkolenie to miało na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do identyfikacji i reagowania na kryzysy psychiczne występujące u dzieci i młodzieży. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie symptomy mogą wskazywać na kryzys psychiczny oraz jakie mogą być jego długoterminowe skutki dla zdrowia psychicznego i rozwoju młodej osoby. Prowadzący przedstawili konkretne strategie i interwencje, które mogą być stosowane w przypadku podejrzenia kryzysu, z naciskiem na empatyczne i skuteczne podejścia. Dodatkowo, szkolenie poruszało kwestię, kiedy i jak szukać wsparcia z zewnątrz, wskazując na zasoby dostępne w szkole i poza nią, które mogą okazać się pomocne w zapewnieniu kompleksowego wsparcia uczniowi w trudnej sytuacji. Celem było nie tylko pomoc w kryzysie, ale i budowanie odporności psychicznej wśród młodzieży.

W szkoleniu pt. „Uczeń w kryzysie psychicznym – jak go rozpoznać i wspierać?” wzięły udział 1262 osoby. Poniżej lista szkół wraz z liczbą osób, która wzięła udział w szkoleniu dla kadry pedagogicznej:

I.p.	NAZWA SZKOŁY	LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie	35
2	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu	23
3	I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu	20
4	II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie	18
5	IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu	15
6	IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze	13
7	VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie	30
8	IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie	17
9	Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku	36
10	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Perpetuum Mobile w Bydgoszczy	30
11	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowa Akademia” w Lublinie	12
12	Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie	26
13	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długowoli	17
14	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orłąt Lwowskich w Opolu	31
15	Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu	25
16	Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie	19
17	Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym	15
18	Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie	18
19	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie	19
20	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi	16
21	Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich	18
22	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni	35
23	Szkoła Podstawowa im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie	16
24	Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Mierzynie	21
25	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie	27
26	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu	20
27	Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym	52
28	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach	19
29	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach	31
30	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie	42
31	Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowej Soli	11
32	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku	30
33	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4PP „Czwartaków” w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach	25
34	Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich w Łodzi	30
35	Szkoła Podstawowa w Złotorii	26
36	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pawła Adamowicza w Gdańsku	16
37	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie	12
38	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy	13



39	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni	31
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie	16
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim	14
42	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie	18
43	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	19
44	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	22
45	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne	28
46	Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku	24
47	Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach	16
48	Zespół Szkół nr 21 w Warszawie	27
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie	50
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu	23
51	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach	16
52	Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie	22
53	Zespół Szkół w Szczurowej	18
54	Zespół Szkół w Szumowie	21
55	Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni	18

Ankieta sprawdzająca wiedzę przed szkoleniem

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę przed szkoleniem pt. „Uczeń w kryzysie psychicznym – jak go rozpoznać i wspierać?” zawierał: metryczkę składającą się z 6 pytań dotyczących: imienia, nazwiska, adresu e-mail, stanowiska pracy, stażu pracy oraz nazwy szkoły, którą reprezentuje ankietowany. Dane te były pobierane uczestników celach statystycznych oraz umożliwiały późniejsze wystawienie imiennego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla każdego z uczestników. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły przed realizacją szkolenia.

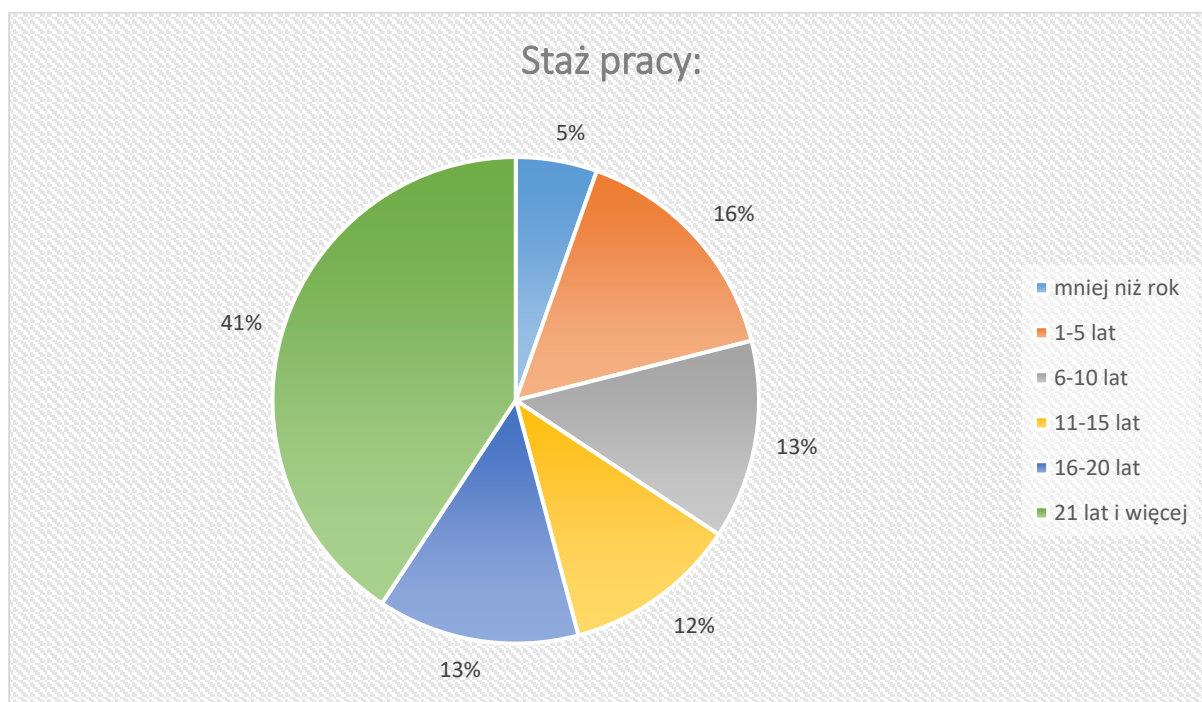
Formularz wypełniło 1073 osób, co daje ok. 85,0% zwrotu z ankiet.

I.p.	Stanowisko	Liczba osób	Procent [%]
1	Nauczyciel	862	88,3
2	Pedagog	64	6,0
3	Dyrektor/wicedyrektor	56	5,2
4	Psycholog	49	4,6
5	Pedagog specjalny	10	0,9
6	Nauczyciel wspomagający/współorganizujący	9	0,8
7	Wychowawca w internacie	8	0,7
8	Pielęgniarka	3	0,3
9	Wychowawca MOW	3	0,3
10	Bibliotekarz	2	0,2
11	Kierownik internatu	2	0,2
12	Terapia pedagogiczna	2	0,2
13	Kierownik świetlicy	1	0,1
14	Superwizor	1	0,1
15	Sekretarka	1	0,1

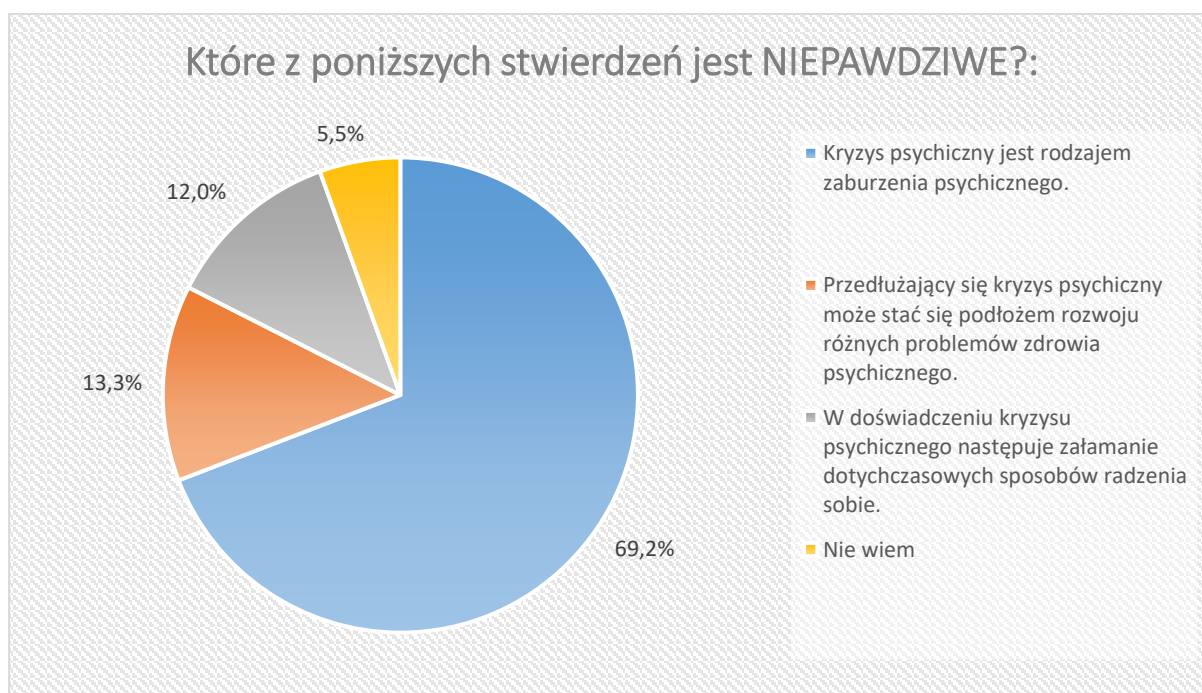
Tabela przedstawia strukturę stanowisk osób wypełniających ankietę przed rozpoczęciem szkolenia. Zdecydowaną większość respondentów stanowią nauczyciele, którzy liczą 862 osoby, co odpowiada 88,3% wszystkich badanych. Kolejne pod względem liczebności grupy to pedagodzy (6,0%), dyrektorzy i wicedyrektorzy (5,2%) oraz psychologowie (4,6%).

Pozostałe stanowiska reprezentowane są przez znacznie mniejszą liczbę respondentów i łącznie stanowią niewielki odsetek próby. Są to m.in. pedagogzy specjaliści, nauczyciele wspomagający/współorganizujący, wychowawcy w internatach i MOW, pielęgniarki, bibliotekarze, kierownicy internatów i świetlic, a także pojedyncze osoby pełniące funkcje superwizora i sekretarki.

Struktura ta wskazuje, że badanie przed rozpoczęciem szkolenia było zdominowane przez kadrę nauczycielską, przy jednoczesnym udziale przedstawicieli innych specjalistycznych ról funkcjonujących w środowisku oświatowym.



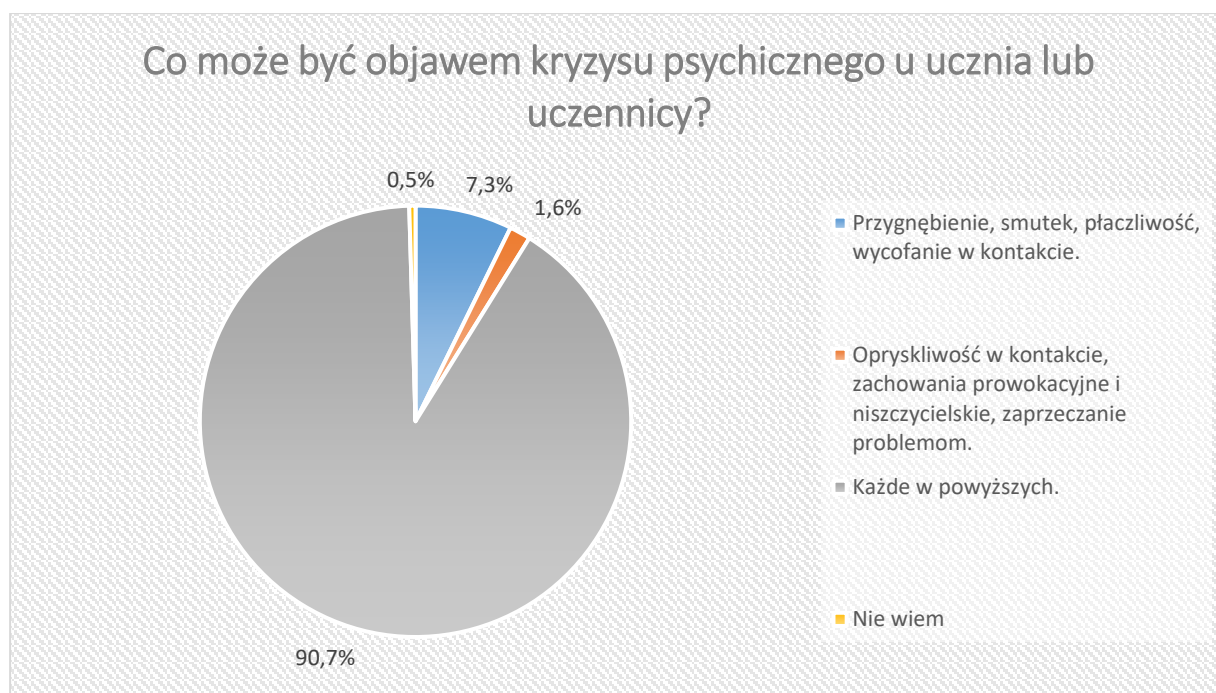
Wykres przedstawia strukturę stażu pracy osób wypełniających ankietę przed rozpoczęciem szkolenia. Najliczniejszą grupę stanowią respondenci z bardzo długim doświadczeniem zawodowym – 40,7% (437 osób) badanych posiada staż pracy wynoszący 21 lat i więcej. Kolejne grupy to osoby ze stażem 1–5 lat (15,7%; 168 osób), 16–20 lat (13,4%; 144 osoby) oraz 6–10 lat (13,2%; 142 osoby). Respondenci pracujący 11–15 lat stanowią 11,6% próby (124 osoby). Najmniej liczną grupę tworzą osoby ze stażem krótszym niż rok (5,4%; 58 osób). Uzyskane dane wskazują, że w badaniu przed rozpoczęciem szkolenia dominowały osoby o dużym doświadczeniu zawodowym.





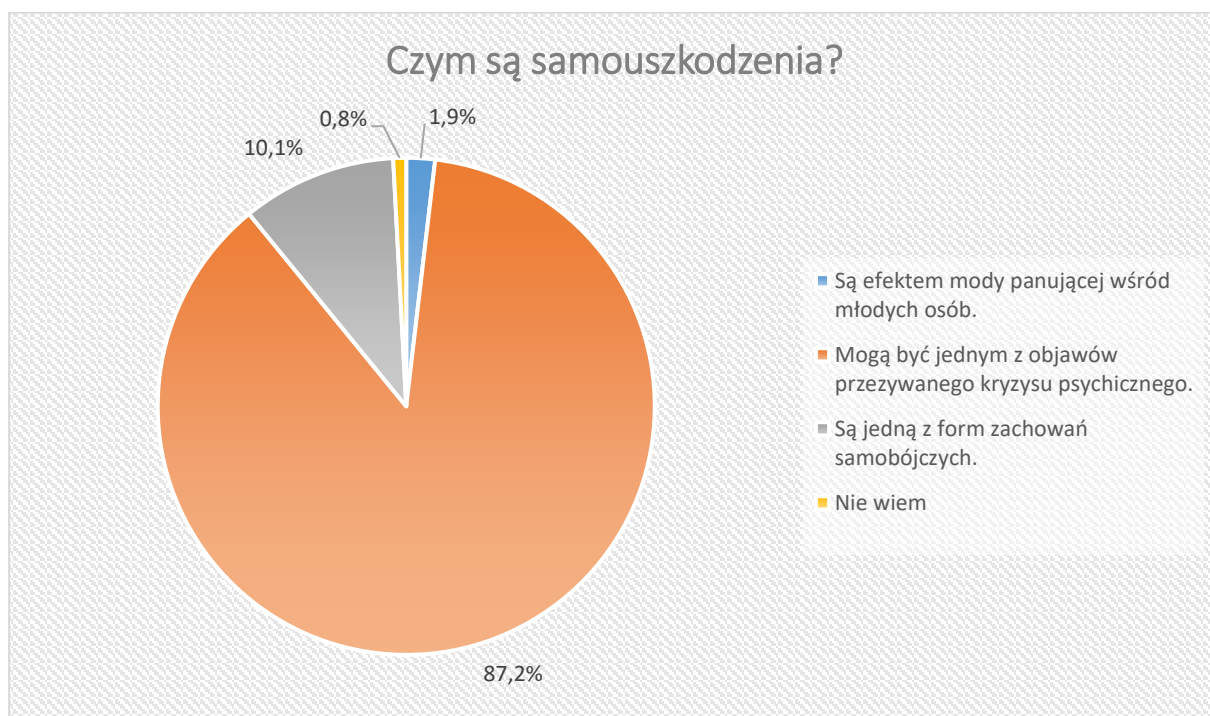
Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Kryzys psychiczny jest rodzajem zaburzenia psychicznego”.

Większość respondentów (69,2%; 742 osoby) prawidłowo wskazała nieprawdziwe stwierdzenie. Jednocześnie 331 osób, czyli 30,8% badanych, udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują, że mimo dominacji poprawnych odpowiedzi, niemal co trzeci uczestnik badania przed rozpoczęciem szkolenia nie posiadał pełnej i prawidłowej wiedzy w zakresie rozróżnienia kryzysu psychicznego od zaburzeń psychicznych, co potwierdza zasadność realizacji szkolenia.



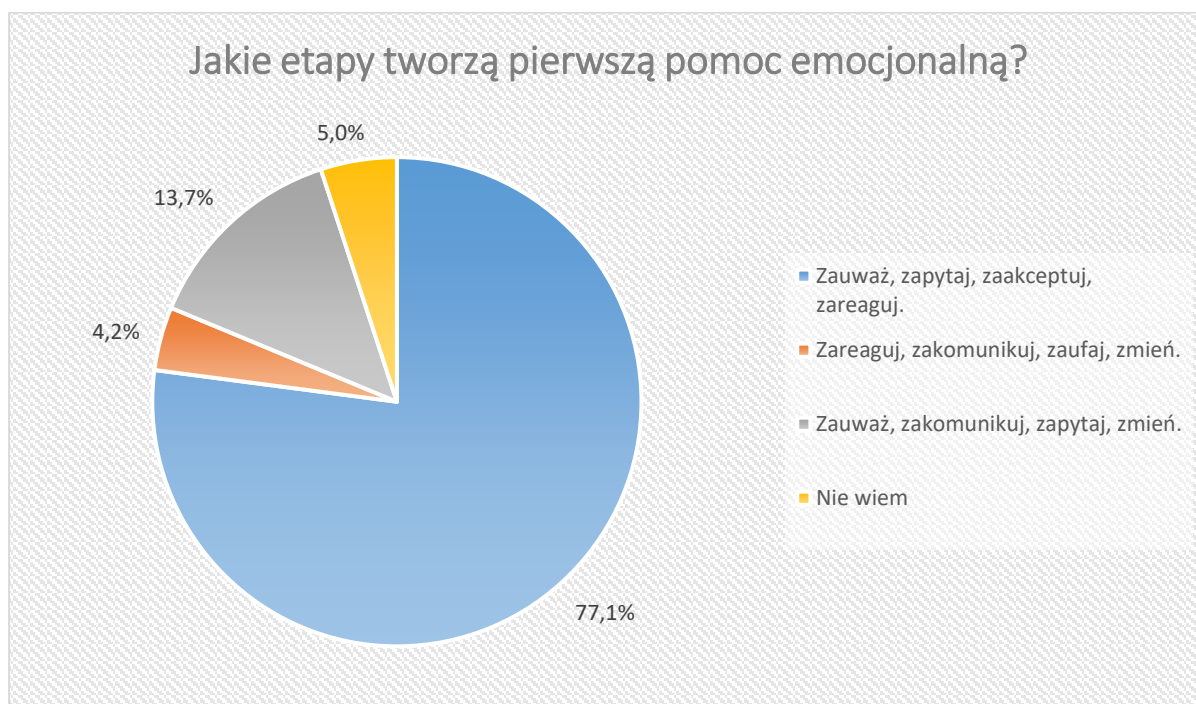
Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Co może być objawem kryzysu psychicznego u ucznia lub uczennicy?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Każde z powyższych”, gdyż kryzys psychiczny może przejawiać się zarówno objawami emocjonalnymi (np. przygnębienie, wycofanie), jak i zachowaniami zewnętrznymi (np. opryskliwość, zachowania prowokacyjne).

Zdecydowana większość badanych (90,7%; 973 osoby) udzieliła odpowiedzi prawidłowej. Jednocześnie łącznie 100 respondentów, czyli 9,3% badanych, udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki świadczą o wysokim poziomie świadomości uczestników badania w zakresie rozpoznawania możliwych objawów kryzysu psychicznego u dzieci i młodzieży już na etapie poprzedzającym szkolenie.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czym są samouszkodzenia?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Mogą być jednym z objawów przeżywanego kryzysu psychicznego”. Zdecydowana większość badanych (87,2%; 936 osób) udzieliła odpowiedzi prawidłowej. Jednocześnie łącznie 137 respondentów, czyli 12,8% badanych, udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy.

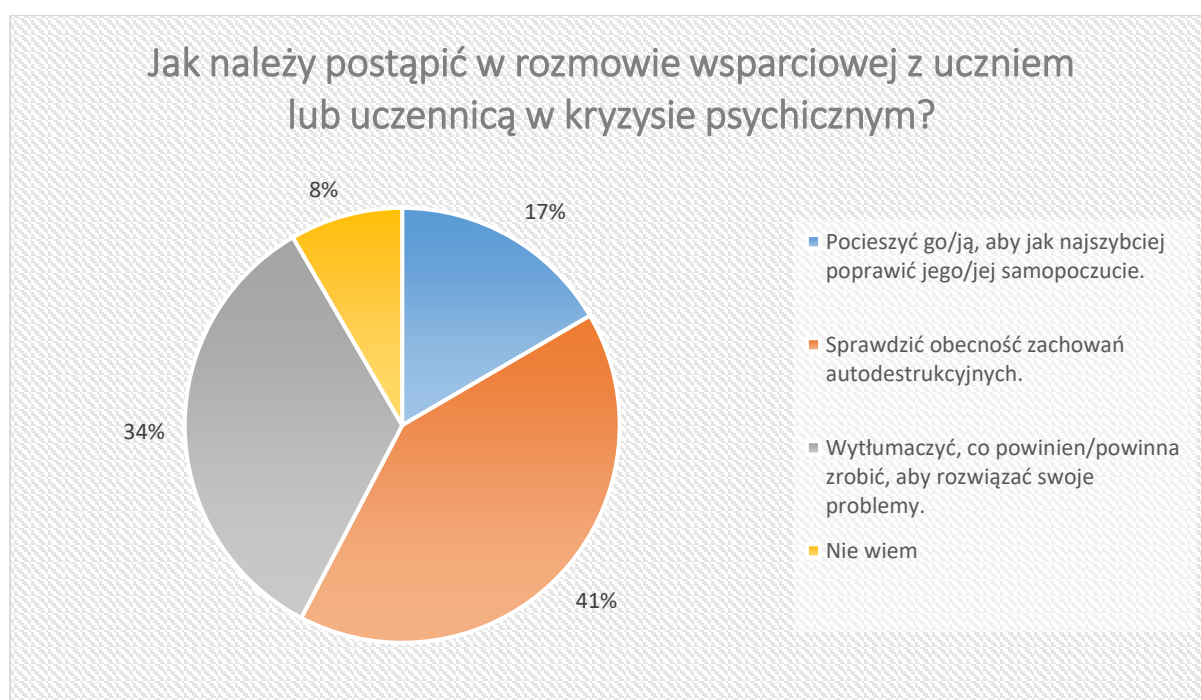
Uzyskane wyniki wskazują, że choć większość uczestników badania przed rozpoczęciem szkolenia posiadała prawidłową wiedzę na temat znaczenia samouszkodzeń, nadal zauważalna jest potrzeba doprecyzowania i uporządkowania wiedzy w tym obszarze, szczególnie w zakresie odróżniania samouszkodzeń od zachowań samobójczych.





Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Jakie etapy tworzą pierwszą pomoc emocjonalną?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było wskazanie sekwencji: „Zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj”.

Prawidłowej odpowiedzi udzieliła większość badanych (77,1%; 827 osób). Jednocześnie łącznie 246 respondentów, czyli 22,9% badanych, udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują, że choć większość uczestników badania przed rozpoczęciem szkolenia знаła podstawowe etapy pierwszej pomocy emocjonalnej, niemal co czwarty respondent wymagał uzupełnienia i uporządkowania wiedzy w tym zakresie, co potwierdza zasadność realizacji szkolenia.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Jak należy postąpić w rozmowie wspierającej z uczniem lub uczennicą w kryzysie psychicznym?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Sprawdzić obecność zachowań autodestrukcyjnych”, co stanowi kluczowy element rozmowy wspierającej w sytuacji kryzysowej.

Prawidłowej odpowiedzi udzieliło 41,1% respondentów (441 osób). Jednocześnie łącznie 632 osoby, czyli 58,9% badanych, udzieliły odpowiedzi błędnych lub zadeklarowały brak wiedzy. Uzyskane wyniki pokazują, że ponad połowa uczestników badania przed rozpoczęciem szkolenia nie wskazała prawidłowego sposobu postępowania w rozmowie wspierającej z uczniem lub uczennicą w kryzysie psychicznym, co wyraźnie potwierdza potrzebę pogłębienia wiedzy i kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej.

Ankieta sprawdzająca wiedzę po szkoleniu

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę po szkoleniu pt. „Uczeń w kryzysie psychicznym – jak go rozpoznać i wspierać?” zawierał, metryczkę składającą się z 6 pytań dotyczących: imienia, nazwiska, adresu e-mail, stanowiska pracy, stażu pracy oraz nazwy szkoły, którą reprezentuje ankietowany. Dane te były pobierane uczestników celach statystycznych oraz umożliwiały późniejsze wystawienie imiennego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla każdego z uczestników. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły przed realizacją spotkania edukacyjnego.



Formularz wypełniło 976 osób, co daje ok. 77,3% zwrotu z ankiet.

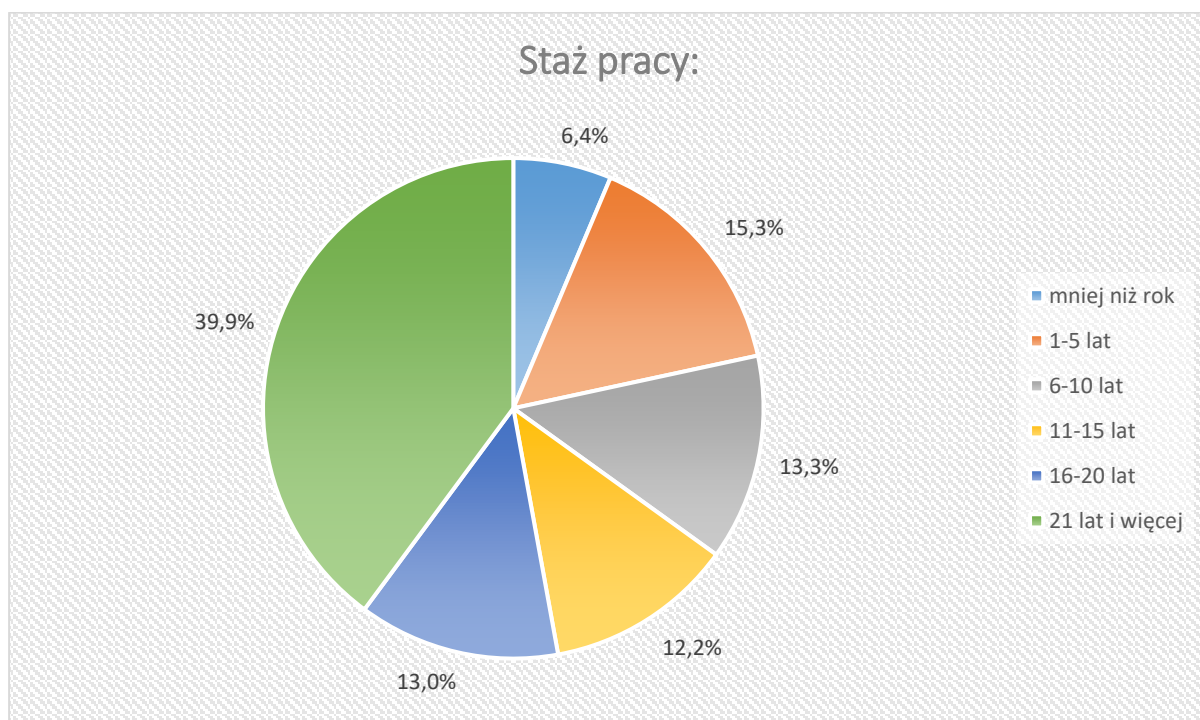
I.p.	Stanowisko	Liczba osób	Procent [%]
1	Nauczyciel	790	80,9
2	Pedagog	56	5,7
3	Dyrektor/wicedyrektor	50	5,1
4	Psycholog	43	4,4
5	Pedagog specjalny	10	1,0
6	Nauczyciel wspomagający/współorganizujący	7	0,7
7	Wychowawca w internacie	7	0,7
8	Pielęgniarka	3	0,3
9	Kierownik internatu	3	0,3
10	Wychowawca MOW	2	0,2
11	Bibliotekarz	1	0,1
12	Terapia pedagogiczna	1	0,1
13	Kierownik świetlicy	1	0,1
14	Superwizor	1	0,1
15	Sekretarka	1	0,1

Ankieta sprawdzająca wiedzę po zakończeniu szkolenia została wypełniona przez 976 osób. Podobnie jak w badaniu przeprowadzonym przed szkoleniem, największą grupę respondentów stanowili nauczyciele, którzy po szkoleniu stanowili 80,9% badanych (790 osób). W porównaniu do ankiety wstępnej, w której nauczyciele stanowili 88,3% (862 osoby), ich udział procentowy uległ zmniejszeniu.

Struktura pozostałych stanowisk po szkoleniu pozostaje zbliżona do tej obserwowanej w badaniu wstępnym. Pedagodzy stanowili 5,7% respondentów po szkoleniu (56 osób) wobec 6,0% przed szkoleniem (64 osoby), natomiast dyrektorzy i wicedyrektorzy odpowiednio 5,1% (50 osób) po szkoleniu i 5,2% (56 osób) przed szkoleniem. Udział psychologów wyniósł 4,4% (43 osoby) po szkoleniu, wobec 4,6% (49 osób) w badaniu wstępnym.

Pozostałe grupy zawodowe, takie jak pedagodzy specjaliści, nauczyciele wspomagający/współorganizujący, wychowawcy w internatach i MOW, pielęgniarki, bibliotekarze, kierownicy internatów i świetlic, a także pojedynczy respondenci pełniący funkcje superwizora i sekretarki, łącznie stanowiły niewielki odsetek próby zarówno przed, jak i po szkoleniu, a ich udział procentowy nie uległ istotnym zmianom.

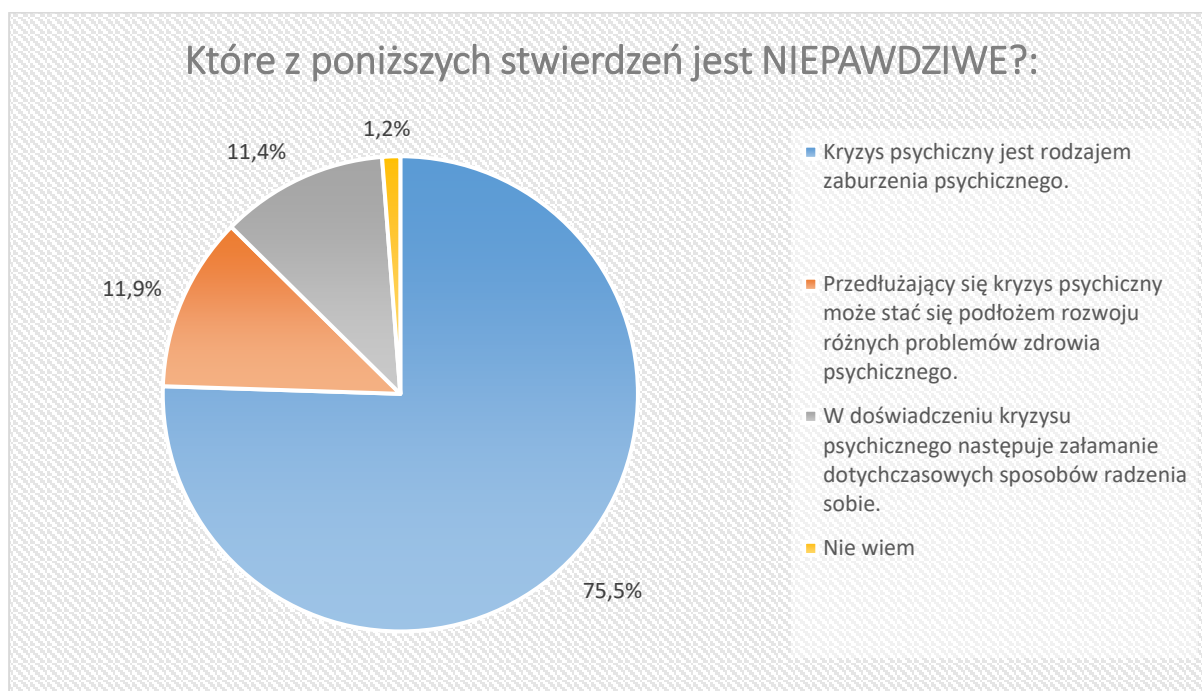
Porównanie struktury respondentów w obu pomiarach wskazuje, że ankiety przed i po szkoleniu były wypełniane przez w dużej mierze porównywalne grupy zawodowe, co pozwala uznać uzyskane wyniki za wiarygodne i umożliwia rzetelną ocenę zmian poziomu wiedzy uczestników szkolenia. Jednocześnie zauważalne różnice w liczebności respondentów sugerują, że nie wszyscy uczestnicy szkolenia wypełnili ankietę końcową (post-test).



Analiza stażu pracy osób, które wypełniły ankietę sprawdzającą wiedzę po zakończeniu szkolenia, wskazuje, że struktura doświadczenia zawodowego respondentów pozostaje bardzo zbliżona do tej obserwowanej w badaniu przeprowadzonym przed szkoleniem, mimo różnic w liczbie udzielonych odpowiedzi.

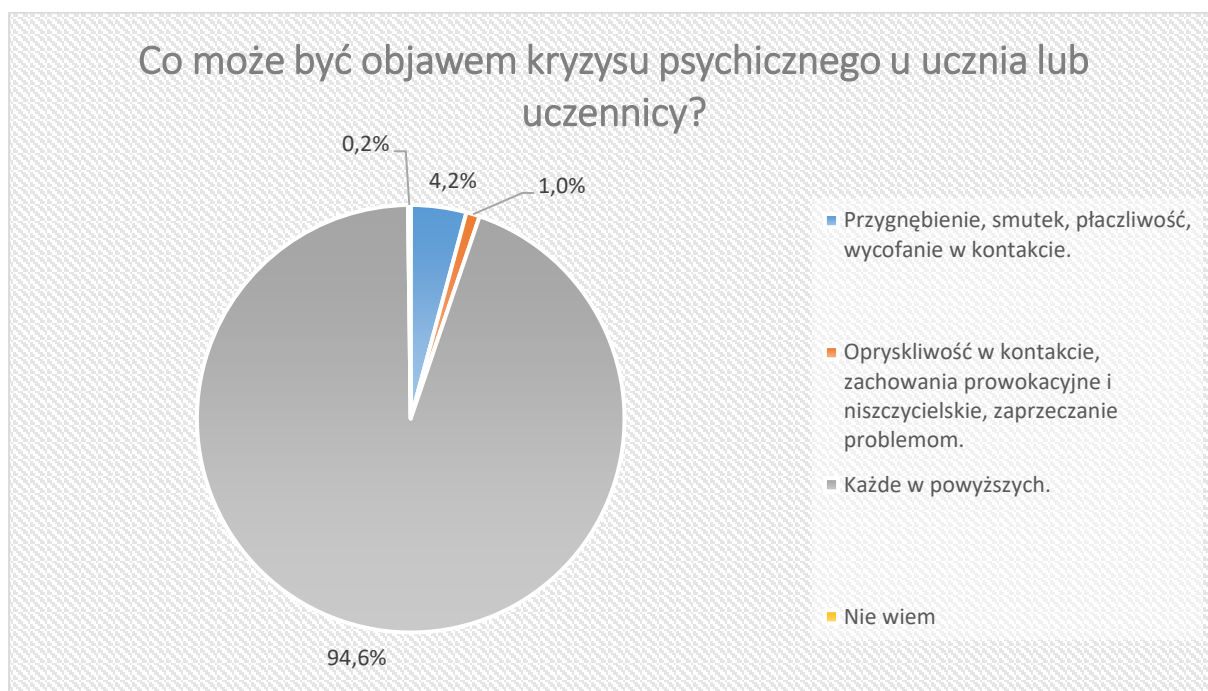
W ankiecie po szkoleniu najliczniejszą grupę stanowili respondenci ze stażem pracy 21 lat i więcej – 39,9% (389 osób), natomiast w badaniu przed szkoleniem odsetek ten wynosił 41,0% (437 osób). Respondenci ze stażem 1–5 lat stanowili 15,3% (149 osób) po szkoleniu wobec 16,0% (168 osób) przed szkoleniem. Osoby pracujące 6–10 lat stanowiły 13,3% (130 osób) w badaniu po szkoleniu oraz 13,0% (142 osoby) w badaniu wstępnym. Staż 11–15 lat deklarowało 12,2% respondentów (119 osób) po szkoleniu oraz 12,0% (124 osoby) przed szkoleniem. Udział osób ze stażem 16–20 lat był również zbliżony i wynosił 13,0% (127 osób) po szkoleniu oraz 13,0% (144 osoby) przed szkoleniem. Najmniej liczną grupę w obu pomiarach stanowiły osoby ze stażem pracy krótszym niż rok – 6,4% (62 osoby) po szkoleniu oraz 5,0% (58 osób) przed szkoleniem.

Pomimo zauważalnych różnic w liczbie respondentów biorących udział w ankiecie przed i po szkoleniu, rozkład stażu pracy w obu pomiarach pozostaje bardzo zbliżony. Wskazuje to, że ankieta końcowa została wypełniona przez grupę o porównywalnym poziomie doświadczenia zawodowego jak w badaniu wstępnym. Różnice w liczbie odpowiedzi sugerują, że nie wszyscy uczestnicy szkolenia wzięli udział w post-teście, jednak nie wpłynęło to istotnie na strukturę badanej próby, co pozwala na rzetelne porównanie wyników wiedzy uzyskanych przed i po szkoleniu.



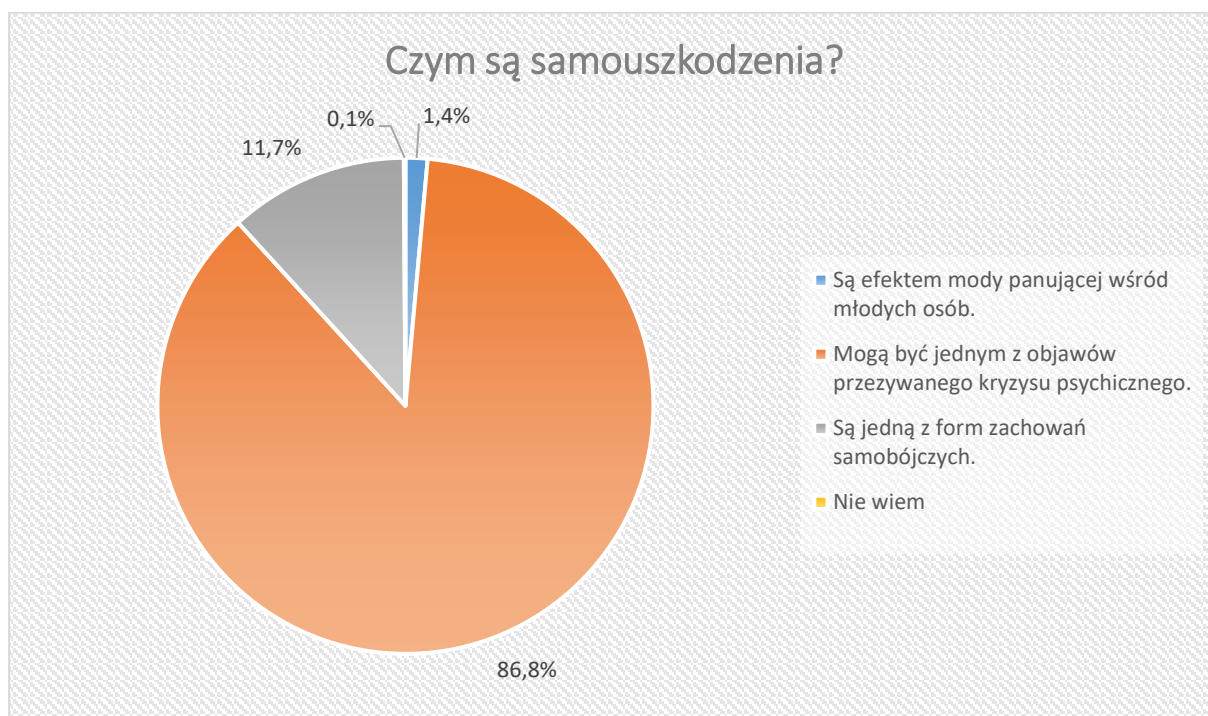
W ankiecie sprawdzającej wiedzę po zakończeniu szkolenia respondentom zadano pytanie: „Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe?”. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Kryzys psychiczny jest rodzajem zaburzenia psychicznego”. Po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliło 75,5% respondentów (737 osób). Odpowiedzi błędnych lub wskazania „Nie wiem” udzieliło łącznie 24,5% badanych (239 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem prawidłową odpowiedź wskazało 69,2% respondentów (742 osoby). Błędne odpowiedzi lub brak wiedzy zadeklarowało wówczas 30,8% badanych (331 osób).

Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi o 6,3 punktu procentowego, a jednocześnie wyraźny spadek liczby odpowiedzi „Nie wiem” (z 5,5% przed szkoleniem do 1,2% po szkoleniu). Pomimo różnic w liczbie respondentów biorących udział w ankietach przed i po szkoleniu, zaobserwowane zmiany świadczą o poprawie poziomu wiedzy uczestników w zakresie rozróżniania kryzysu psychicznego i zaburzeń psychicznych, co potwierdza skuteczność przeprowadzonego szkolenia.



Respondentom zadano pytanie: „Co może być objawem kryzysu psychicznego u ucznia lub uczennicy?”. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Każde z powyższych”. W ankiecie po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość badanych – 94,6% respondentów (923 osoby). Odpowiedzi błędnych lub wskazania „Nie wiem” udzieliło łącznie 5,4% badanych (53 osoby). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 90,7% respondentów (973 osoby). Odpowiedzi błędnych lub „Nie wiem” udzieliło wówczas 9,3% badanych (100 osób).

Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi o 3,9 punktu procentowego oraz wyraźny spadek liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy po szkoleniu. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w ankietach przed i po szkoleniu, zaobserwowane zmiany świadczą o pogłębieniu i uporządkowaniu wiedzy uczestników w zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego u dzieci i młodzieży, co potwierdza skuteczność przeprowadzonego szkolenia.

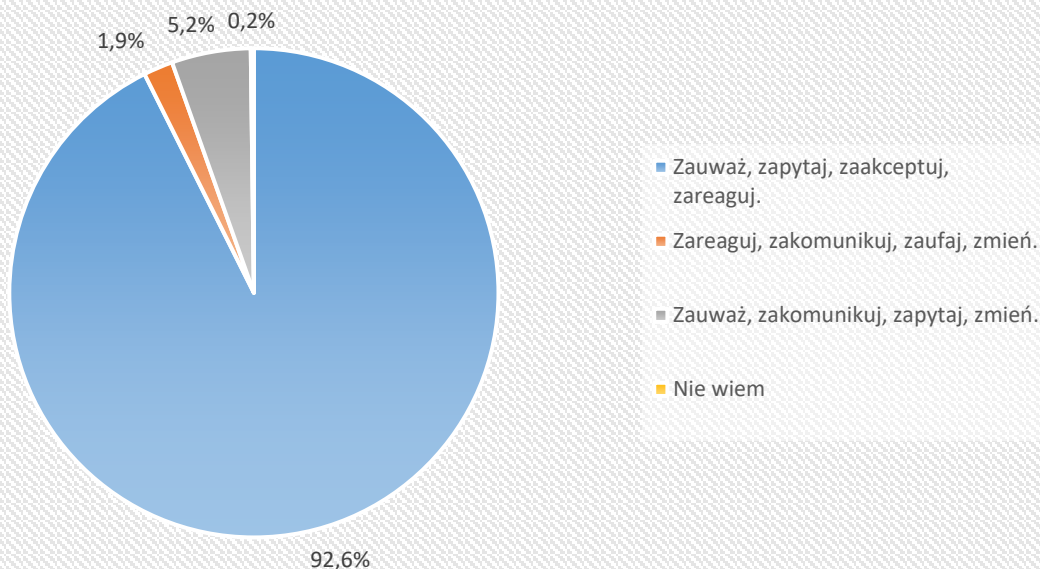


W ankiecie sprawdzającej wiedzę respondentom zadano pytanie „Czym są samouszkodzenia?”. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Mogą być jednym z objawów przeżywanego kryzysu psychicznego”. W ankiecie po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliło 86,8% respondentów (847 osób). Odpowiedzi błędnych lub wskazania „Nie wiem” udzieliło łącznie 13,2% badanych (129 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 87,2% respondentów (936 osób). Błędne odpowiedzi lub brak wiedzy zadeklarowało wówczas 12,8% badanych (137 osób).

Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje, że poziom wiedzy respondentów w tym obszarze utrzymał się na zbliżonym, wysokim poziomie, przy jednoczesnym spadku odsetka odpowiedzi „Nie wiem” po szkoleniu. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w ankietach przed i po szkoleniu, struktura odpowiedzi pozostaje porównywalna, co pozwala wnioskować, że szkolenie przyczyniło się do utrwalenia i doprecyzowania wiedzy uczestników na temat znaczenia samouszkodzeń w kontekście kryzysu psychicznego.

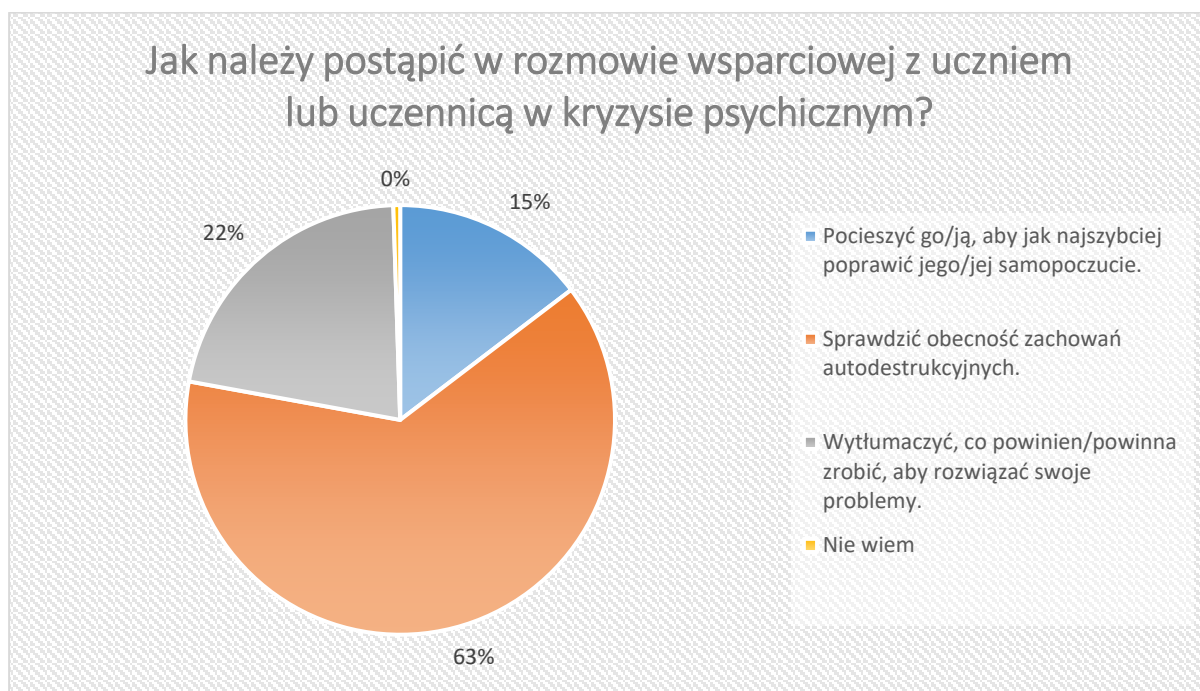


Jakie etapy tworzą pierwszą pomoc emocjonalną?



W ankiecie sprawdzającej wiedzę respondentom zadano pytanie „Jakie etapy tworzą pierwszą pomoc emocjonalną?”. Poprawną odpowiedzią była sekwencja: „Zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj”. W ankiecie po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość respondentów – 92,6% badanych (904 osób). Odpowiedzi błędne lub wskazanie „Nie wiem” stanowiły łącznie 7,4% odpowiedzi (72 osoby). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 77,1% respondentów (827 osób). Jednocześnie 22,9% badanych (246 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zaznaczyło odpowiedź „Nie wiem”.

Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wyraźny wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi o 15,5 punktu procentowego oraz znaczące ograniczenie liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy po szkoleniu. Pomimo różnic w liczbie respondentów biorących udział w ankietach przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki jednoznacznie świadczą o istotnym wzroście poziomu wiedzy uczestników w zakresie etapów udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej, co potwierdza wysoką skuteczność przeprowadzonego szkolenia.



W ankiecie sprawdzającej wiedzę respondentom zadano pytanie: „Jak należy postąpić w rozmowie wspierającej z uczniem lub uczennicą w kryzysie psychicznym?”. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Sprawdzić obecność zachowań autodestrukcyjnych”, co stanowi kluczowy element bezpiecznej i odpowiedzialnej interwencji w sytuacji kryzysowej. W ankiecie po szkoleniu prawidłową odpowiedź wskazało 63% respondentów (617 osób), co stanowi wyraźną większość badanych. Odpowiedzi błędne stanowiły łącznie 37% (359 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawnej odpowiedzi udzieliło 41,1% respondentów (441 osób). Jednocześnie 58,9% badanych (632 osoby) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy.

Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi o 21,9 punktu procentowego oraz prawie całkowite wyeliminowanie odpowiedzi „Nie wiem” po szkoleniu. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w ankietach przed i po szkoleniu, zaobserwowane zmiany jednoznacznie świadczą o istotnym wzroście wiedzy uczestników w zakresie właściwego prowadzenia rozmowy wspierającej z uczniem lub uczennicą w kryzysie psychicznym, co potwierdza skuteczność przeprowadzonego szkolenia.

Podsumowanie

W ankietach sprawdzających poziom wiedzy przed i po szkoleniu „Uczeń w kryzysie psychicznym – jak go rozpoznać i wspierać?” wzięła udział liczna i zróżnicowana grupa pracowników oświaty, w większości nauczycieli, ale także pedagogów, psychologów oraz kadry kierowniczej. Pomimo różnic w liczbie respondentów między pomiarem wstępnym a końcowym, struktura zawodowa i staż pracy uczestników obu ankiet pozostały porównywalne, co umożliwia rzetelną analizę zmian poziomu wiedzy.

Analiza wyników wskazuje, że już przed szkoleniem uczestnicy wykazywali stosunkowo wysoki poziom świadomości w zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego u uczniów oraz rozumienia znaczenia samouszkodzeń jako jednego z możliwych sygnałów kryzysu. Jednocześnie w kilku kluczowych obszarach – zwłaszcza dotyczących rozróżniania kryzysu psychicznego od zaburzeń psychicznych, etapów pierwszej pomocy emocjonalnej oraz właściwego prowadzenia rozmowy wspierającej – zauważalne były istotne luki wiedzy.

Porównanie wyników ankiet przed i po szkoleniu jednoznacznie wskazuje na wzrost poziomu wiedzy uczestników we wszystkich analizowanych obszarach. Największą poprawę odnotowano w zakresie znajomości etapów pierwszej pomocy emocjonalnej oraz prawidłowego postępowania w rozmowie wspierającej z uczniem w kryzysie psychicznym, w tym konieczności sprawdzania obecności zachowań autodestrukcyjnych. Wzrosła także liczba poprawnych odpowiedzi dotyczących definicji kryzysu psychicznego, przy jednoczesnym wyraźnym spadku odpowiedzi „Nie wiem”.



Z wyników ankiet można wywnioskować, że ze szkolenia pt. „Uczeń w kryzysie psychicznym – jak go rozpoznać i wspierać”, aż 79,4% uczestników (biorąc pod uwagę wszystkie 55 szkół) zdało test sprawdzający wiedzę po szkoleniu na ponad 75%. Natomiast biorąc pod uwagę szkoły, których udział był możliwy dzięki dofinansowaniu z MEN (35 szkół) to aż 79,5% uczestników zdało test sprawdzający wiedzę po szkoleniu na ponad 75%.

Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność szkolenia w zakresie porządkowania, pogłębiania i utrwalania wiedzy uczestników, a także wzmacniania ich kompetencji w obszarze wczesnego rozpoznawania kryzysu psychicznego i udzielania adekwatnego wsparcia uczniom. Szkolenie odpowiadało na realne potrzeby kadry pedagogicznej i przyczyniło się do zwiększenia poczucia przygotowania uczestników do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w środowisku szkolnym.





„Rodzice ucznia w kryzysie psychicznym – jak ich motywować do współpracy?”

Szkolenie poświęcone było zagadnieniu współpracy nauczycieli i szkolnych specjalistów z rodzicami i opiekunami uczniów w kryzysie psychicznym. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się co sprawia, że rodzicom trudno jest przyjąć informację o trudnościach dziecka, jak zaplanować rozmowę z rodzicem, jak go wspierać i motywować do współpracy. Omawiane były zalecenia, z jakimi rodzic powinien wyjść ze spotkania ze szkolnym specjalistą, a także pozaszkolny system pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego młodych osób.

W szkoleniu pt. „Rodzice ucznia w kryzysie psychicznym – jak ich motywować do współpracy” wzięło udział 1212 osób. Poniżej lista szkół wraz z liczbą osób, która wzięła udział w szkoleniu dla kadry pedagogicznej:

l.p.	NAZWA SZKOŁY	LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie	35
2	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu	23
3	I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu	19
4	II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie	16
5	IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu	15
6	IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze	13
7	VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie	35
8	IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie	14
9	Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku	37
10	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Perpetuum Mobile w Bydgoszczy	26
11	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowa Akademia” w Lublinie	22
12	Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie	21
13	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długowoli	15
14	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orłów Lwowskich w Opolu	32
15	Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu	20
16	Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie	17
17	Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym	15
18	Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie	17
19	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie	21
20	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi	16
21	Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich	22
22	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni	31
23	Szkoła Podstawowa im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie	16
24	Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Mierzynie	21
25	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie	20
26	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu	19
27	Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym	47
28	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach	19
29	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach	31
30	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie	46
31	Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowej Soli	10
32	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku	30
33	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4PP „Czwartaków” w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach	25
34	Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich w Łodzi	26
35	Szkoła Podstawowa w Złotorii	27
36	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pawła Adamowicza w Gdańsku	16
37	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie	12
38	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy	10
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni	18
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie	15



41	Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim	12
42	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie	17
43	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	19
44	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	20
45	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne	25
46	Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku	25
47	Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach	20
48	Zespół Szkół nr 21 w Warszawie	29
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie	40
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu	22
51	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszych	13
52	Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie	22
53	Zespół Szkół w Szczurówce	18
54	Zespół Szkół w Szumowie	22
55	Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni	18

Ankieta sprawdzająca wiedzę przed szkoleniem

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę przed szkoleniem pt. „Rodzice ucznia w kryzysie psychicznym – jak ich motywować do współpracy?” zawierał: metryczkę składającą się z 6 pytań dotyczących: imienia, nazwiska, adresu e-mail, stanowiska pracy, stażu pracy oraz nazwy szkoły, którą reprezentuje ankietowany. Dane te były pobierane uczestników celach statystycznych oraz umożliwiały późniejsze wystawienie imiennego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla każdego z uczestników. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły przed realizacją szkolenia.

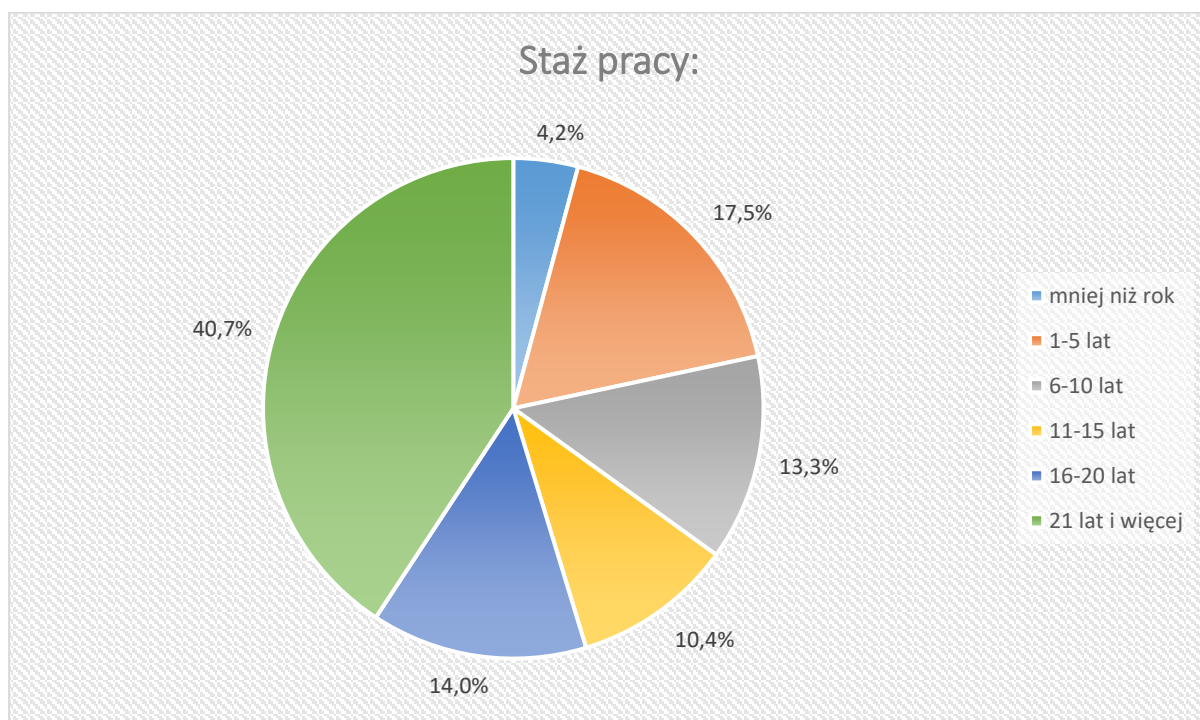
Formularz wypełniło 1053 osób, co daje ok. 86,9% zwrotu z ankiet.

l.p.	Stanowisko	Liczba osób	Procent [%]
1	Nauczyciel	849	80,6
2	Pedagog	60	5,7
3	Psycholog	54	5,1
4	Dyrektor/wicedyrektor	53	5,0
5	Nauczyciel wspomagający/współorganizujący	8	0,8
6	Wychowawca w internacie	8	0,8
7	Pedagog specjalny	7	0,7
8	Terapia pedagogiczna	5	0,5
9	Pielęgniarka	4	0,4
10	Kierownik internatu	2	0,2
11	Doradca zawodowy	1	0,1
12	Pomoc nauczycielska	1	0,1
13	Sekretarka	1	0,1

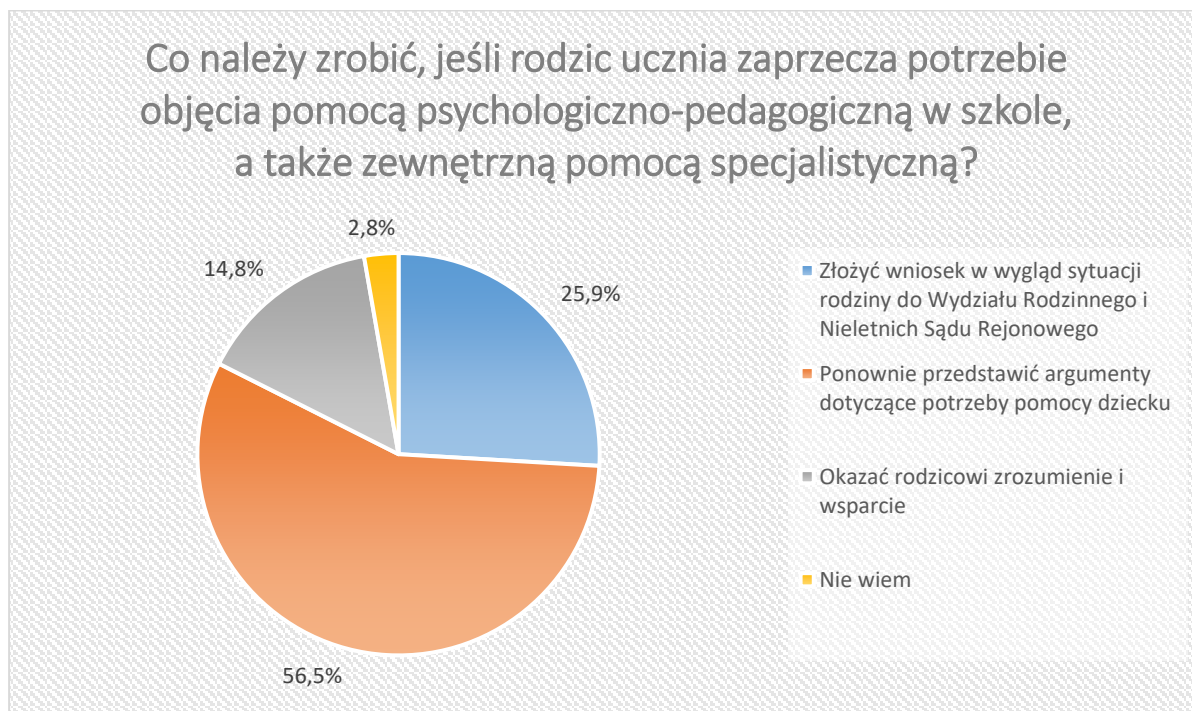
Tabela przedstawia strukturę stanowisk osób, które wypełniły ankietę przed szkoleniu. Formularz został wypełniony przez 1053 osoby, co stanowi ok. 86,9% zwrotu ankiet. Zdecydowaną większość respondentów stanowią nauczyciele – 849 osób, co odpowiada 80,6% wszystkich badanych. Kolejne pod względem liczebności grupy to pedagodzy (5,7%), psychologowie (5,1%) oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy (5,0%).

Pozostałe stanowiska reprezentowane są przez znacznie mniejszą liczbę respondentów i łącznie stanowią niewielki odsetek próby. Wśród nich znajdują się m.in. nauczyciele wspomagający/współorganizujący, wychowawcy w internatach, pedagodzy specjaliści, terapeuci pedagogiczni, pielęgniarki, kierownicy internatów, a także pojedyncze osoby pełniące funkcje doradcy zawodowego, pomocy nauczycielskiej i sekretarki.

Struktura ta wskazuje, że badanie przed rozpoczęciem szkolenia było zdominowane przez kadrę nauczycielską, przy jednoczesnym udziale przedstawicieli innych specjalistycznych ról funkcjonujących w środowisku oświatowym.



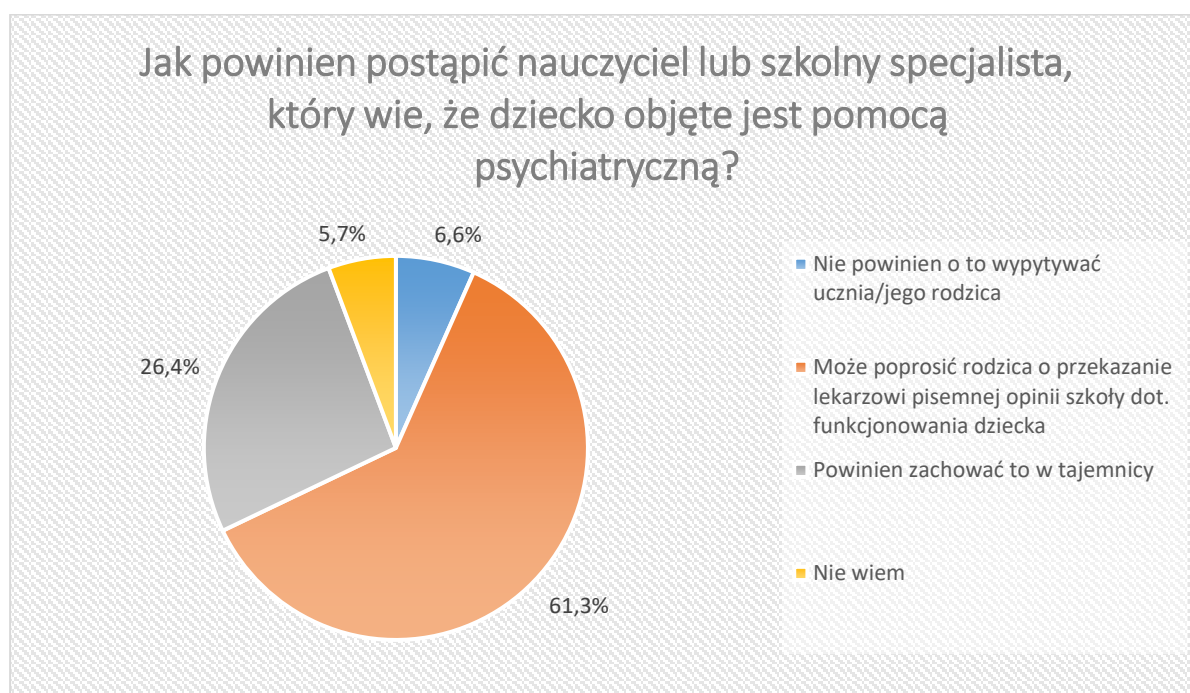
Wykres przedstawia strukturę stażu pracy respondentów. Najliczniejszą grupę stanowią osoby z bardzo długim stażem – 21 lat i więcej, które odpowiadają za 40,7% badanych (429 osób). Kolejną istotną grupą są respondenci z doświadczeniem 1–5 lat (17,5%, 184 osoby). Osoby pracujące 16–20 lat stanowią 14,0% próby (147 osób), natomiast staż 6–10 lat deklaruje 13,3% respondentów (140 osób). Mniejszy odsetek badanych posiada staż 11–15 lat (10,4%, 109 osób). Najrzadziej reprezentowane są osoby z doświadczeniem krótszym niż rok – 4,2% (44 osoby).



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Co należy zrobić, jeśli rodzic ucznia zaprzecza potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole oraz zewnętrzną pomocą specjalistyczną?”, zadane



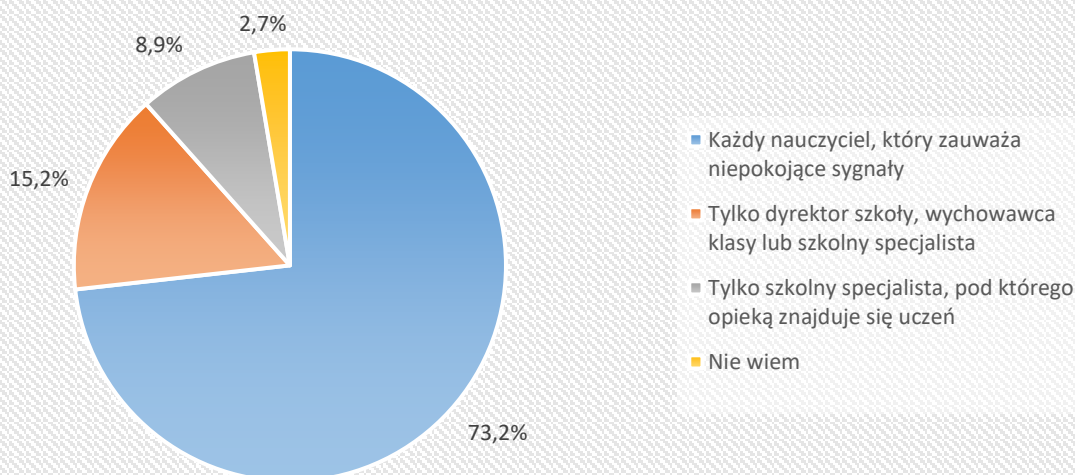
przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Okazać rodzicowi zrozumienie i wsparcie”. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 14,8% respondentów (156 osób). Łącznie 85,2% badanych (897 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują, że przed szkoleniem większość uczestników nie identyfikowała jako właściwego podejścia opartego na wsparciu i zrozumieniu rodzica, co potwierdza potrzebę wzmocnienia kompetencji w zakresie współpracy z rodziną ucznia w sytuacjach trudnych.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Jak powinien postąpić nauczyciel lub szkolny specjalista, który wie, że dziecko objęte jest pomocą psychiatryczną?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Może poprosić rodzica o przekazanie lekarzowi pisemnej opinii szkoły dotyczącej funkcjonowania dziecka”. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 61,3% respondentów (645 osób). Łącznie 38,7% badanych (408 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują, że choć większość uczestników badania posiadała podstawową wiedzę na temat właściwego postępowania w sytuacji współpracy szkoły z systemem ochrony zdrowia psychicznego dziecka, istotna część respondentów przed szkoleniem nie miała w tym zakresie jednoznacznych i poprawnych kompetencji, co uzasadnia potrzebę dalszego wzmocniania wiedzy i praktycznych umiejętności.

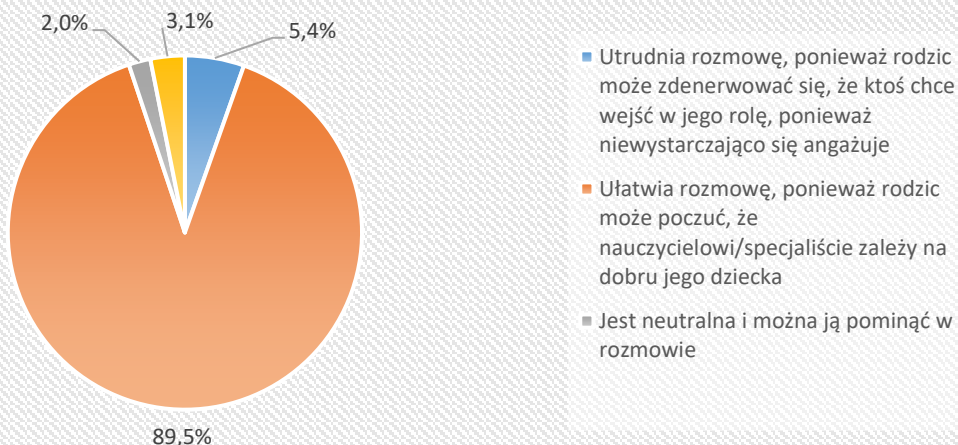


Kto może rozmawiać z rodzicem o podejrzeniu kryzysu emocjonalnego ucznia?



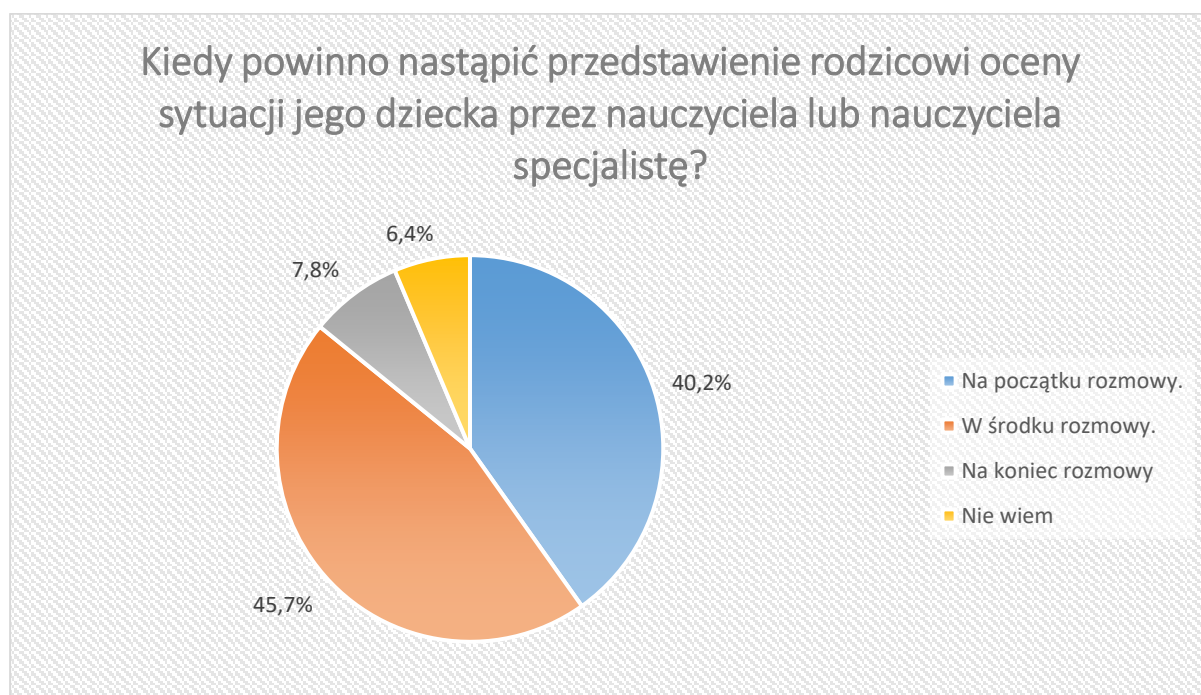
Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Kto może rozmawiać z rodzicem o podejrzeniu kryzysu emocjonalnego ucznia?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Każdy nauczyciel, który zauważa niepokojące sygnały”. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 73,2% respondentów (771 osób). Łącznie 26,8% badanych (282 osoby) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują, że większość uczestników badania była świadoma swojej roli i odpowiedzialności w zakresie reagowania na sygnały kryzysu emocjonalnego ucznia już przed rozpoczęciem szkolenia, jednak u części respondentów nadal występowały wątpliwości dotyczące zakresu kompetencji poszczególnych pracowników szkoły.

Jak wydzwięk ma wypowiedź „Cieszę się, że przyszła Pani na spotkanie. Wierzę, że zależy Pani na córce. Także dla mnie jej dobro jest ważne. Chcę z Panią porozmawiać, ponieważ martwię się o nią...”?





Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Jaki wydźwięk ma wypowiedź: «Cieszę się, że przyszła Pani na spotkanie. Wierzę, że zależy Pani na córce. Także dla mnie jej dobro jest ważne. Chcę z Panią porozmawiać, ponieważ martwię się o nią...»?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Ułatwia rozmowę, ponieważ rodzic może poczuć, że nauczycielowi/specjaliście zależy na dobru jego dziecka”, gdyż taka forma komunikatu wzmacnia relację, obniża napięcie i sprzyja współpracy z rodzicem. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 89,5% respondentów (942 osoby). Łącznie 10,5% badanych (111 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki świadczą o wysokim poziomie świadomości uczestników badania w zakresie znaczenia empatycznej, partnerskiej komunikacji z rodzicami już na etapie poprzedzającym szkolenie.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Kiedy powinno nastąpić przedstawienie rodzicowi oceny sytuacji jego dziecka przez nauczyciela lub nauczyciela specjalistę?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „W środku rozmowy”. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 45,7% respondentów (481 osób). Łącznie 54,3% badanych (572 osoby) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują, że przed szkoleniem ponad połowa uczestników nie posiadała jednoznacznej wiedzy dotyczącej optymalnego momentu przekazywania rodzicowi oceny sytuacji dziecka, co potwierdza potrzebę rozwijania kompetencji komunikacyjnych w pracy z rodziną ucznia.



Ankieta sprawdzająca wiedzę po szkoleniu

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę po szkoleniu pt. „Rodzice ucznia w kryzysie psychicznym – jak ich motywować do współpracy?” zawierał, metryczkę składającą się z 6 pytań dotyczących: imienia, nazwiska, adresu e-mail, stanowiska pracy, stażu pracy oraz nazwy szkoły, którą reprezentuje ankietowany. Dane te były pobierane uczestników celach statystycznych oraz umożliwiły późniejsze wystawienie imiennego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla każdego z uczestników. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły przed realizacją spotkania edukacyjnego.

Formularz wypełniło 964 osób, co daje ok. 79,5% zwrotu z ankiet.

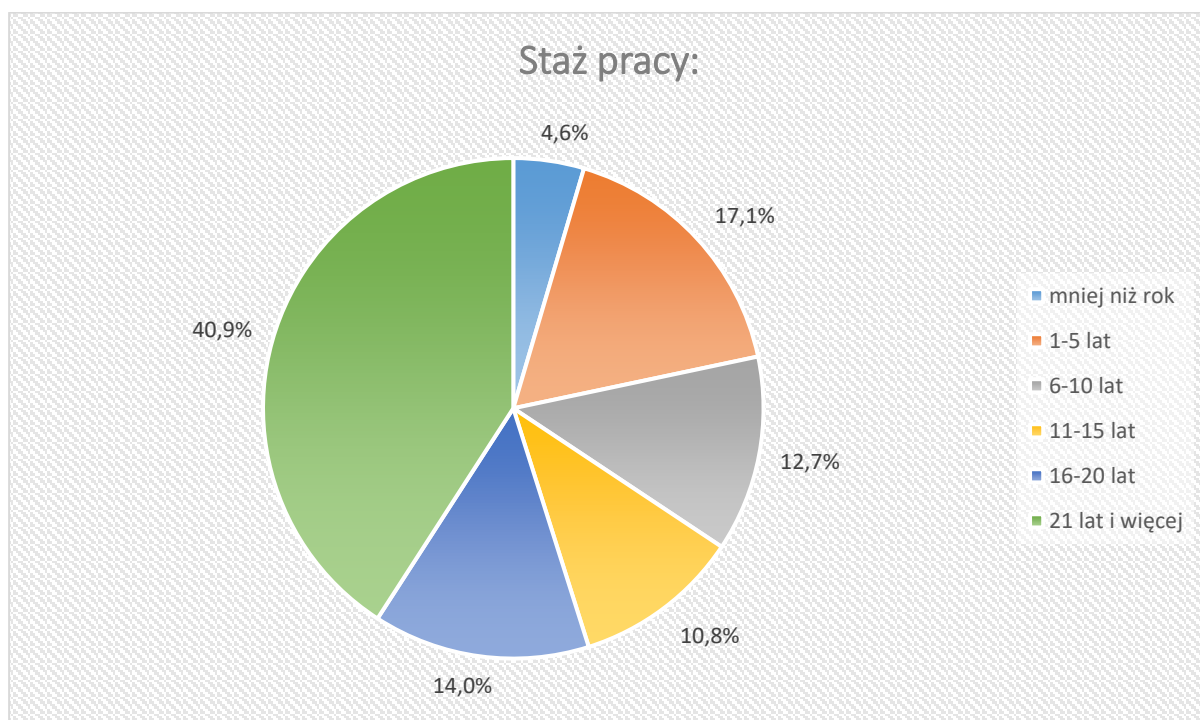
I.p.	Stanowisko	Liczba osób	Procent [%]
1	Nauczyciel	784	81,3
2	Pedagog	57	5,9
3	Psycholog	46	4,8
4	Dyrektor/wicedyrektor	49	5,1
5	Nauczyciel wspomagający/współorganizujący	6	0,6
6	Wychowawca w internacie	8	0,8
7	Pedagog specjalny	2	0,2
8	Terapia pedagogiczna	4	0,4
9	Pielęgniarka	4	0,4
10	Kierownik internatu	1	0,1
11	Doradca zawodowy	1	0,1
12	Pomoc nauczycielska	1	0,1
13	Sekretarka	1	0,1

Ankieta sprawdzająca wiedzę po szkoleniu została wypełniona przez 964 osoby, co stanowi około 79,5% zwrotu ankiet. Natomiast ankietę przed rozpoczęciem szkolenia wypełniło 1053 uczestników, co odpowiada 86,9% zwrotu ankiet. W obu pomiarach największą grupę respondentów stanowili nauczyciele. Po szkoleniu ich udział wynosił 81,3% badanych (784 osoby), natomiast przed szkoleniem 80,6% (849 osób), co wskazuje na niewielkie zmniejszenie udziału procentowego tej grupy przy jednoczesnym wzroście liczby respondentów.

Struktura pozostałych stanowisk po szkoleniu pozostaje w dużej mierze zbliżona do tej obserwowanej w badaniu wstępnym. Pedagodzy stanowili 5,9% respondentów po szkoleniu (57 osób) oraz 5,7% przed szkoleniem (60 osób). Psychologowie reprezentowali 4,8% badanych po szkoleniu (46 osób) i 5,1% przed szkoleniem (54 osoby). Udział dyrektorów i wicedyrektorów był niemal identyczny w obu pomiarach i wynosił 5,1% po szkoleniu (49 osób) oraz 5,0% przed szkoleniem (53 osoby).

Pozostałe grupy zawodowe, takie jak nauczyciele wspomagający/współorganizujący, wychowawcy w internatach, pedagodzy specjalni, osoby prowadzące terapię pedagogiczną, pielęgniarki szkolne, kierownicy internatów, doradcy zawodowi, pomoce nauczycielskie oraz sekretarki, łącznie stanowiły niewielki odsetek próby zarówno przed, jak i po szkoleniu, a ich udział procentowy nie uległ istotnym zmianom.

Porównanie struktury respondentów w obu pomiarach wskazuje, że ankiety przed i po szkoleniu były wypełniane przez w dużej mierze porównywalne grupy zawodowe, co pozwala uznać uzyskane wyniki za wiarygodne i umożliwia rzetelną ocenę zmian poziomu wiedzy uczestników szkolenia. Jednocześnie różnice w liczebności respondentów między pomiarami sugerują, że część uczestników nie wzięła udziału w badaniu wstępnym lub końcowym, co jest zjawiskiem typowym w badaniach ewaluacyjnych tego typu.

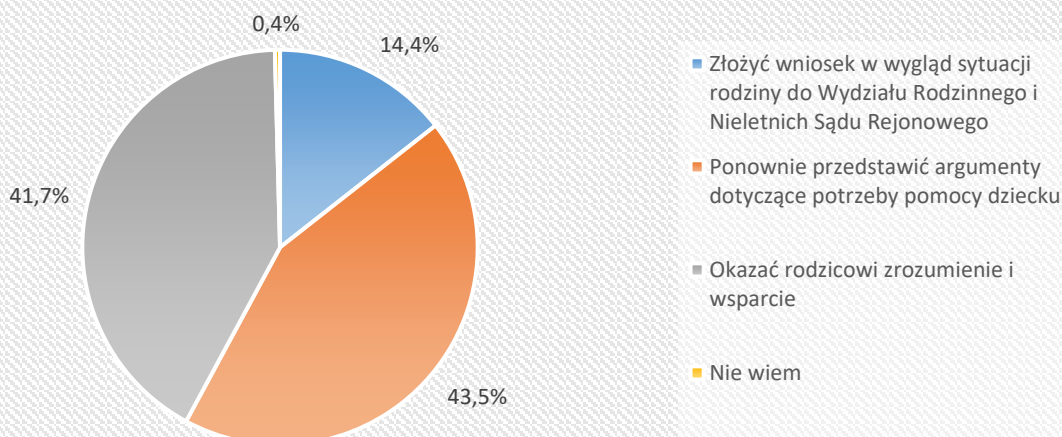


Wykres przedstawia strukturę stażu pracy respondentów w ankiecie przeprowadzonej po zakończeniu szkolenia. Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy z najdłuższym stażem pracy – 21 lat i więcej, którzy stanowili 40,9% badanych (394 osoby). Kolejną istotną grupą byli respondenci z doświadczeniem zawodowym 1–5 lat – 17,1% (165 osób). Osoby ze stażem 16–20 lat stanowiły 14,0% uczestników (135 osób), natomiast staż 6–10 lat deklarowało 12,7% badanych (122 osoby). Udział respondentów ze stażem 11–15 lat wyniósł 10,8% (104 osoby), a najmniej liczną grupą były osoby pracujące krócej niż rok – 4,6% (44 osoby).

Struktura stażu pracy respondentów po szkoleniu pozostaje bardzo zbliżona do tej odnotowanej w badaniu wstępnym. W ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem również dominowały osoby z najdłuższym doświadczeniem zawodowym (40,7%), a rozkład pozostałych kategorii stażu różnił się jedynie nieznacznie. Oznacza to, że uczestnicy obu pomiarów byli porównywalni pod względem doświadczenia zawodowego, co wzmacnia rzetelność analiz porównawczych i pozwala uznać uzyskane wyniki za wiarygodne.



Co należy zrobić, jeśli rodzic ucznia zaprzecza potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, a także zewnętrzną pomocą specjalistyczną?

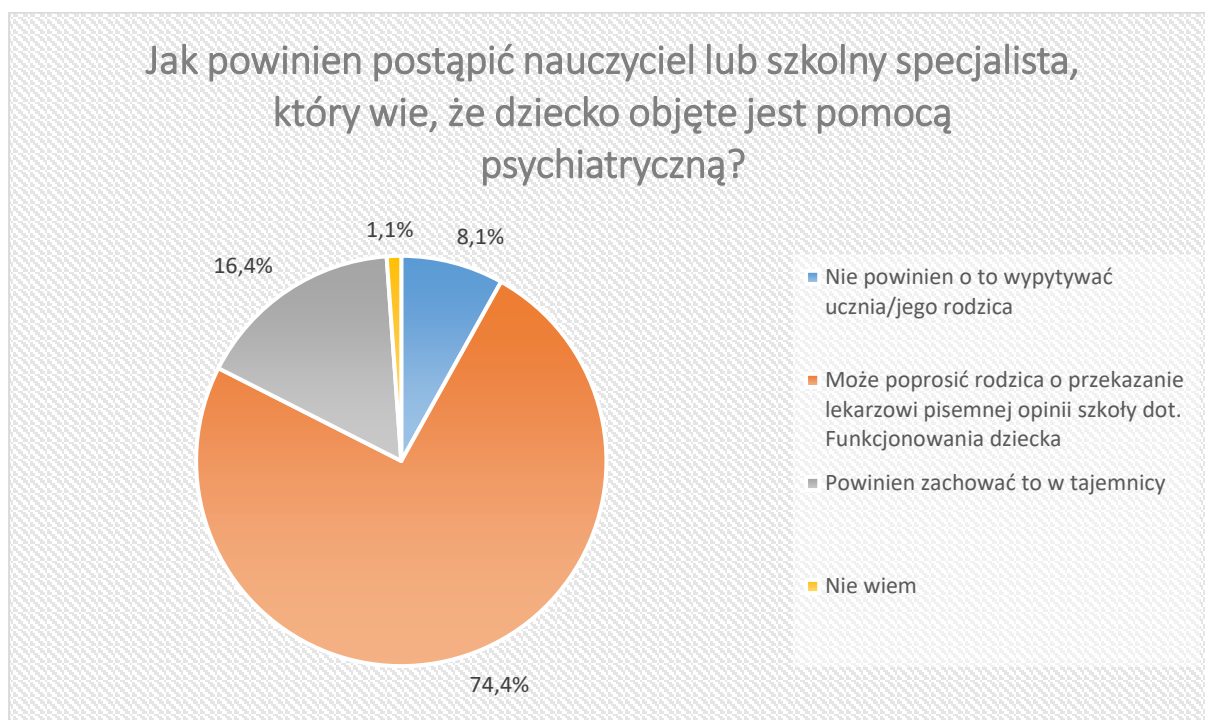


Respondentom zadano pytanie: „Co należy zrobić, jeśli rodzic ucznia zaprzecza potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, a także zewnętrzną pomocą specjalistyczną?”. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Okazać rodzicowi zrozumienie i wsparcie”, gdyż empatyczne podejście i budowanie relacji z rodzicem stanowią podstawę dalszej, skutecznej współpracy na rzecz dobra dziecka.

W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliło 41,7% respondentów (402 osoby). Odpowiedzi błędnych lub wskazania opcji „Nie wiem” udzieliło łącznie 58,3% badanych (562 osoby).

Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało jedynie 14,8% respondentów (156 osób), natomiast odpowiedzi błędnych lub deklaracji braku wiedzy udzieliło 85,2% badanych (897 osób).

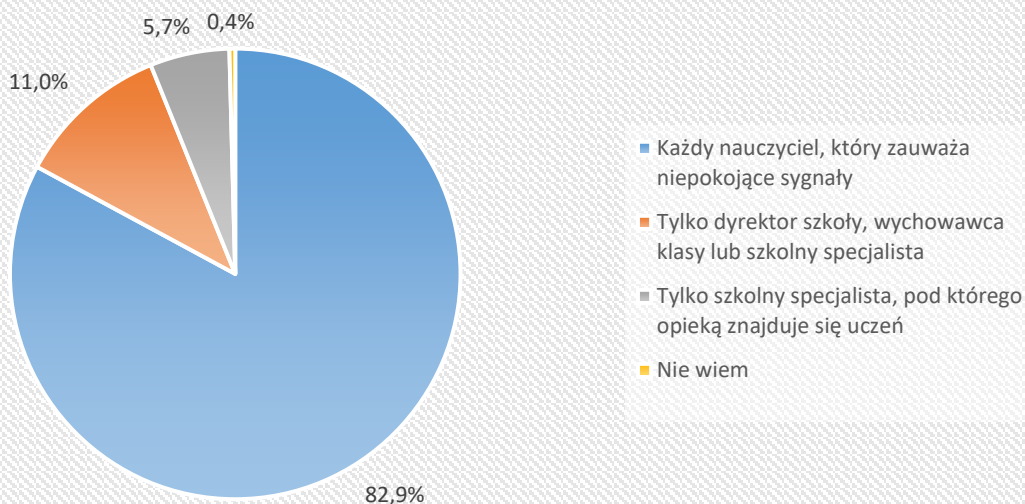
Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi o 26,9 punktu procentowego oraz wyraźny spadek liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy po szkoleniu. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w ankietach przed i po szkoleniu, zaobserwowane zmiany świadczą o istotnym pogłębieniu i uporządkowaniu wiedzy uczestników w zakresie właściwego postępowania w sytuacji trudnej współpracy z rodzicem, co potwierdza skuteczność przeprowadzonego szkolenia.



Respondentom zadano pytanie: „Jak powinien postąpić nauczyciel lub szkolny specjalista, który wie, że dziecko objęte jest pomocą psychiatryczną?”. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Może poprosić rodzica o przekazanie lekarzowi pisemnej opinii szkoły dotyczącej funkcjonowania dziecka”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliło 74,4% respondentów (717 osób). Odpowiedzi błędnych lub wskazania opcji „Nie wiem” udzieliło łącznie 25,6% badanych (247 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 61,3% respondentów (645 osób), natomiast odpowiedzi błędnych lub deklaracji braku wiedzy udzieliło 38,7% badanych (408 osób). Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi o 13,1 punktu procentowego oraz wyraźny spadek liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy po szkoleniu. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w ankietach przed i po szkoleniu, zaobserwowane zmiany świadczą o pogłębieniu i uporządkowaniu wiedzy uczestników w zakresie zasad współpracy szkoły z systemem ochrony zdrowia psychicznego dziecka, co potwierdza skuteczność przeprowadzonego szkolenia.



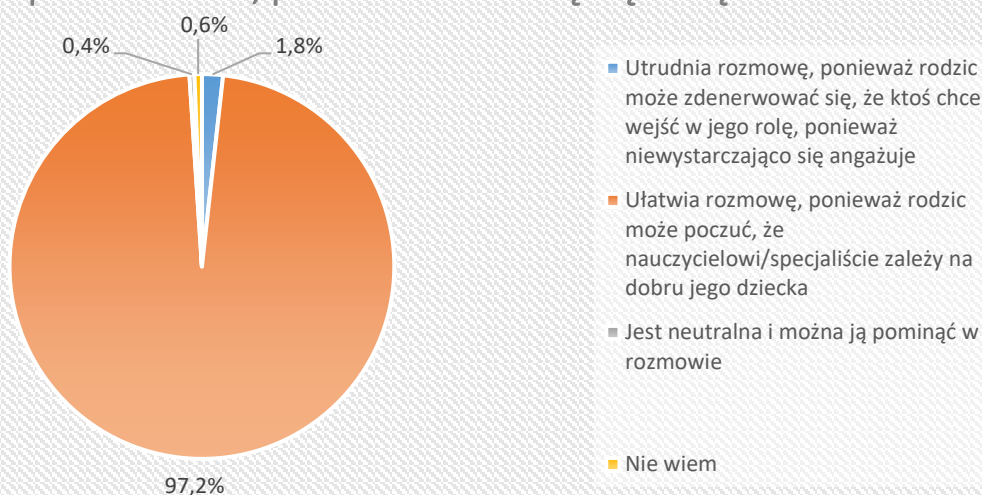
Kto może rozmawiać z rodzicem o podejrzeniu kryzysu emocjonalnego ucznia?



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Kto może rozmawiać z rodzicem o podejrzeniu kryzysu emocjonalnego ucznia?”. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Każdy nauczyciel, który zauważa niepokojące sygnały”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliło 82,9% respondentów (799 osób). Odpowiedzi błędnych lub wskazania opcji „Nie wiem” udzieliło łącznie 17,1% badanych (165 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 73,2% respondentów (771 osób), natomiast odpowiedzi błędnych lub deklaracji braku wiedzy udzieliło 26,8% badanych (282 osoby). Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi o 9,7 punktu procentowego oraz wyraźny spadek liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy po szkoleniu. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w ankietach przed i po szkoleniu, zaobserwowane zmiany świadczą o wzmocnieniu świadomości uczestników w zakresie ich roli i odpowiedzialności w reagowaniu na sygnały kryzysu emocjonalnego ucznia, co potwierdza skuteczność przeprowadzonego szkolenia.



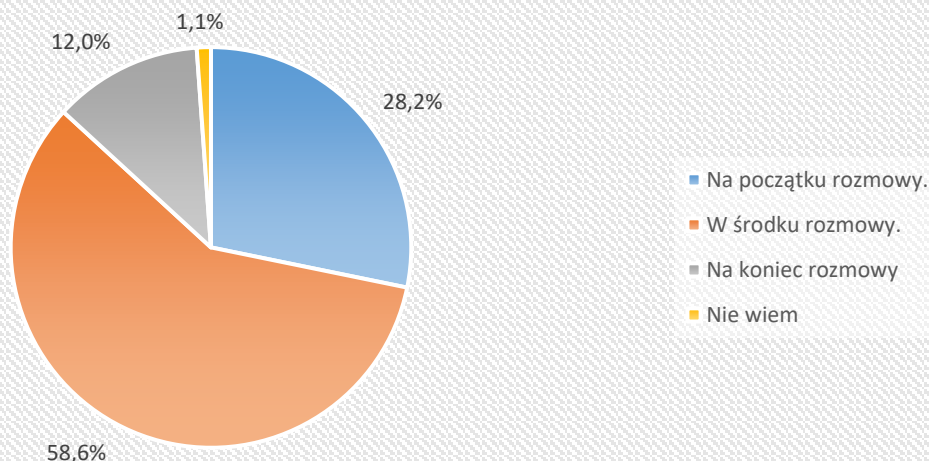
Jak wydzwięk ma wypowiedź „Cieszę się, że przyszła Pani na spotkanie. Wierzę, że zależy Pani na córce. Także dla mnie jej dobro jest ważne. Chcę z Panią porozmawiać, ponieważ martwię się o nią...”?



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Jaki wydzwięk ma wypowiedź: „Cieszę się, że przyszła Pani na spotkanie. Wierzę, że zależy Pani na córce. Także dla mnie jej dobro jest ważne. Chcę z Panią porozmawiać, ponieważ martwię się o nią...”?”. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Ułatwia rozmowę, ponieważ rodzic może poczuć, że nauczycielowi/specjaliście zależy na dobru jego dziecka”, gdyż taka forma komunikatu buduje relację, obniża napięcie i sprzyja współpracy z rodzicem. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość badanych – 97,2% respondentów (937 osób). Odpowiedzi błędnych lub wskazania opcji „Nie wiem” udzieliło łącznie 2,8% badanych (27 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 89,5% respondentów (942 osoby), natomiast odpowiedzi błędnych lub deklaracji braku wiedzy udzieliło 10,5% badanych (111 osób). Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi o 7,7 punktu procentowego oraz wyraźny spadek liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy po szkoleniu. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w ankietach przed i po szkoleniu, zaobserwowane zmiany świadczą o istotnym wzmocnieniu kompetencji komunikacyjnych uczestników, w szczególności w zakresie empatycznego i wspierającego prowadzenia rozmów z rodzicami, co potwierdza skuteczność przeprowadzonego szkolenia.



Kiedy powinno nastąpić przedstawienie rodzicowi oceny sytuacji jego dziecka przez nauczyciela lub nauczyciela specjalistę?



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Kiedy powinno nastąpić przedstawienie rodzicowi oceny sytuacji jego dziecka przez nauczyciela lub nauczyciela specjalistę?”. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „W środku rozmowy”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliło 58,6% respondentów (565 osób). Odpowiedzi błędnych lub wskazania opcji „Nie wiem” udzieliło łącznie 41,4% badanych (399 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 45,7% respondentów (481 osób), natomiast odpowiedzi błędnych lub deklaracji braku wiedzy udzieliło 54,3% badanych (572 osoby). Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi o 12,9 punktu procentowego oraz zauważalny spadek liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy po szkoleniu. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w ankietach przed i po szkoleniu, zaobserwowane zmiany świadczą o wzmocnieniu kompetencji komunikacyjnych uczestników, w szczególności w zakresie właściwego prowadzenia rozmów z rodzicami w sytuacjach wymagających przekazywania trudnych informacji, co potwierdza skuteczność przeprowadzonego szkolenia.

Podsumowanie

Analiza wyników ankiety sprawdzającej wiedzę, przeprowadzonej przed i po szkoleniu pt. „Rodzice ucznia w kryzysie psychicznym – jak ich motywować do współpracy?”, jednoznacznie wskazuje na istotny wzrost poziomu wiedzy oraz kompetencji uczestników w zakresie współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu psychicznego

Badanie wstępne wykazało, że uczestnicy relatywnie dobrze rozumieli znaczenie empatycznej postawy w kontakcie z rodzicem oraz w dużej mierze byli świadomi swojej roli w reagowaniu na sygnały kryzysu emocjonalnego ucznia. Jednocześnie ujawniło ono wyraźne luki w wiedzy dotyczące praktycznych aspektów prowadzenia rozmowy z rodzicem, w szczególności w sytuacjach trudnych i potencjalnie konfliktowych, takich jak zaprzeczanie przez rodzica potrzeby pomocy dziecku, zasady współpracy szkoły z systemem ochrony zdrowia psychicznego czy właściwy moment przekazywania rodzicowi oceny sytuacji ucznia.

Porównanie wyników obu pomiarów pokazuje, że po szkoleniu nastąpił systematyczny wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi we wszystkich analizowanych obszarach, przy jednoczesnym spadku liczby odpowiedzi błędnych oraz deklaracji braku wiedzy. Największe przyrosty odnotowano w obszarach wymagających szczególnych kompetencji komunikacyjnych i relacyjnych, takich jak: właściwe reagowanie w sytuacji zaprzeczania przez rodzica trudnościom dziecka, rozumienie zasad współpracy szkoły z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży, prowadzenie rozmowy z rodzicem w sposób sprzyjający budowaniu relacji, obniżaniu napięcia i motywowaniu do współpracy.



Uzyskane wyniki wskazują, że szkolenie przyczyniło się nie tylko do zwiększenia wiedzy deklaratywnej, lecz także do uporządkowania rozumienia ról, odpowiedzialności oraz zasad komunikacji w pracy z rodzicami uczniów w kryzysie psychicznym. Szczególnie istotne jest wzmocnienie kompetencji związanych z empatycznym formułowaniem komunikatów, świadomym planowaniem rozmowy oraz wyborem strategii opartych na współpracy, a nie eskalowaniu konfliktu.

Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w badaniach przed i po szkoleniu, struktura badanych grup pozostaje porównywalna, co pozwala uznać zaobserwowane zmiany za wiarygodne i związane bezpośrednio z oddziaływaniem szkolenia. Całość wyników jednoznacznie potwierdza skuteczność przeprowadzonego szkolenia w zakresie przygotowania kadry pedagogicznej do pracy z rodzicami uczniów w kryzysie psychicznym oraz wzmocnienia ich gotowości do podejmowania konstruktywnej współpracy na rzecz dobra dziecka.

Z wyników ankiet można wywnioskować, że ze szkolenia pt. „Rodzice ucznia w kryzysie psychicznym – jak go motywować do współpracy?”, 52,7% uczestników (biorąc pod uwagę wszystkie 55 szkół) zdało test sprawdzający wiedzę po szkoleniu na ponad 75%. Natomiast biorąc pod uwagę szkoły, których udział był możliwy dzięki dofinansowaniu z MEN (35 szkół) to 55,9% uczestników zdało test sprawdzający wiedzę po szkoleniu na ponad 75%.





„Uczeń po próbie samobójczej – jak go wspierać w powrocie do szkoły?”

Szkolenie miało na celu omówienie działań podejmowanych przez grono pedagogiczne wobec uczniów po próbie samobójczej. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jaką rolę w takiej sytuacji pełni zespół kryzysowy oraz jakie praktyczne narzędzia można wykorzystać w kontakcie z uczniem po próbie samobójczej (m.in. jak rozmawiać o myślach i tendencjach samobójczych, jak wdrożyć plan bezpieczeństwa). Otrzymali również wskazówki do przeprowadzenia rozmów z rodzicami oraz opracowania dostosowań procesu edukacyjnego do aktualnego poziomu funkcjonowania ucznia po próbie samobójczej.

W szkoleniu pt. „Uczeń po próbie samobójczej – jak go wspierać w powrocie do szkoły?” wzięło udział 1214 osób. Poniżej lista szkół wraz z liczbą osób, która wzięła udział w szkoleniu dla kadry pedagogicznej:

l.p.	NAZWA SZKOŁY	LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie	35
2	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu	24
3	I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu	21
4	II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie	17
5	IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu	16
6	IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze	11
7	VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie	25
8	IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie	9
9	Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku	31
10	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Perpetuum Mobile w Bydgoszczy	22
11	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowa Akademia” w Lublinie	20
12	Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie	25
13	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długowoli	15
14	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orłat Lwowskich w Opolu	31
15	Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu	25
16	Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie	17
17	Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym	15
18	Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie	16
19	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie	20
20	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi	15
21	Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich	22
22	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni	31
23	Szkoła Podstawowa im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie	18
24	Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Mierzynie	21
25	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie	24
26	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu	18
27	Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym	58
28	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach	19
29	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach	31
30	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie	41
31	Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowej Soli	12
32	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku	30
33	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4PP „Czwartaków” w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach	25
34	Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich w Łodzi	30
35	Szkoła Podstawowa w Złotorii	26
36	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pawła Adamowicza w Gdańsku	11
37	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie	9
38	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy	8
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni	20
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie	18



41	Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim	16
42	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie	17
43	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	19
44	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	27
45	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne	24
46	Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku	25
47	Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach	15
48	Zespół Szkół nr 21 w Warszawie	30
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie	41
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu	23
51	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach	17
52	Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie	22
53	Zespół Szkół w Szczurowej	16
54	Zespół Szkół w Szumowie	22
55	Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni	18

Ankieta sprawdzająca wiedzę przed szkoleniem

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę przed szkoleniem pt. „Uczeń po próbie samobójczej – jak go wspierać w powrocie do szkoły?” zawierał: metryczkę składającą się z 6 pytań dotyczących: imienia, nazwiska, adresu e-mail, stanowiska pracy, stażu pracy oraz nazwy szkoły, którą reprezentuje ankietowany. Dane te były pobierane uczestników celach statystycznych oraz umożliwiały późniejsze wystawienie imiennego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla każdego z uczestników. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły przed realizacją szkolenia.

Formularz wypełniło 1086 osób, co daje ok. 89,5% zwrotu z ankiet.

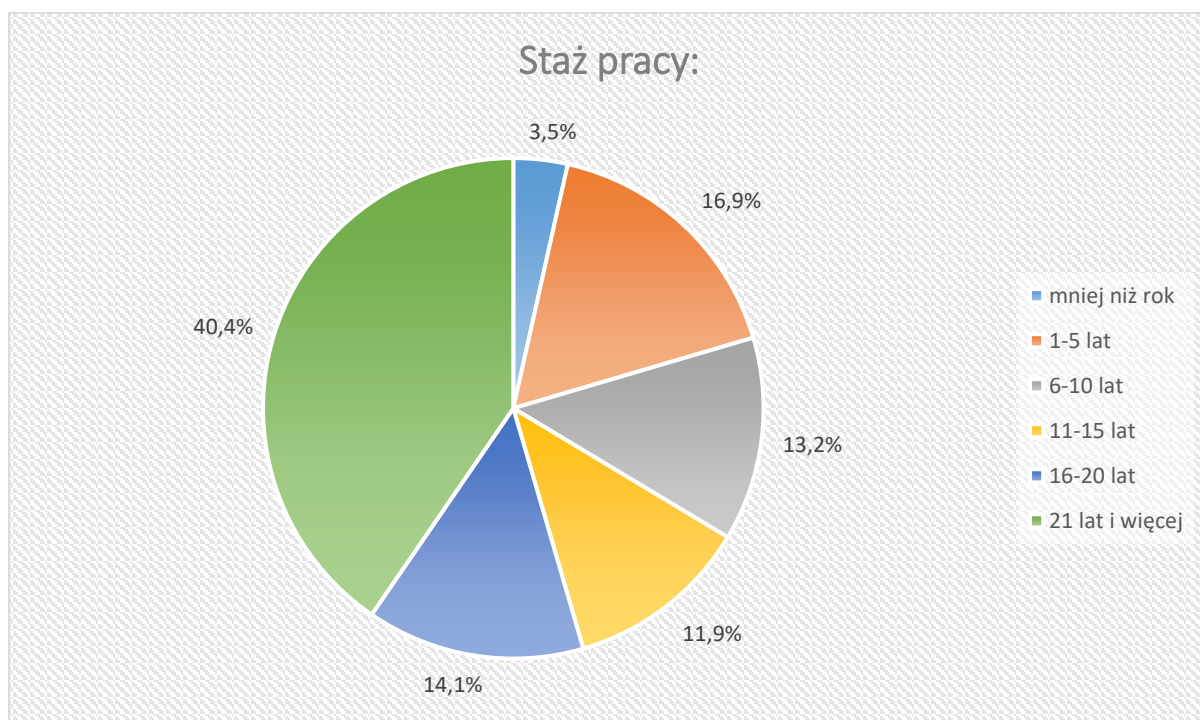
l.p.	Stanowisko	Liczba osób	Procent [%]
1	Nauczyciel	874	80,5
2	Pedagog	63	5,8
3	Dyrektor/wicedyrektor	59	5,4
4	Psycholog	50	4,6
5	Nauczyciel wspomagający/współorganizujący	11	1,0
6	Wychowawca w internacie	10	0,9
7	Pedagog specjalny	5	0,5
8	Terapia pedagogiczna	4	0,4
9	Pielęgniarka	3	0,3
10	Kierownik internatu	2	0,2
11	Sekretarz	2	0,2
12	Pomoc nauczycielska	1	0,1
13	Kierownik świetlicy	1	0,1
14	Doradca zawodowy	1	0,1

Tabela przedstawia strukturę stanowisk osób, które wypełniły ankietę przed szkoleniem. Formularz został wypełniony przez 1086 osób, co stanowi ok. 89,5% zwrotu ankiet. Zdecydowaną większość respondentów stanowią nauczyciele – 874 osoby, co odpowiada 80,5% wszystkich badanych.

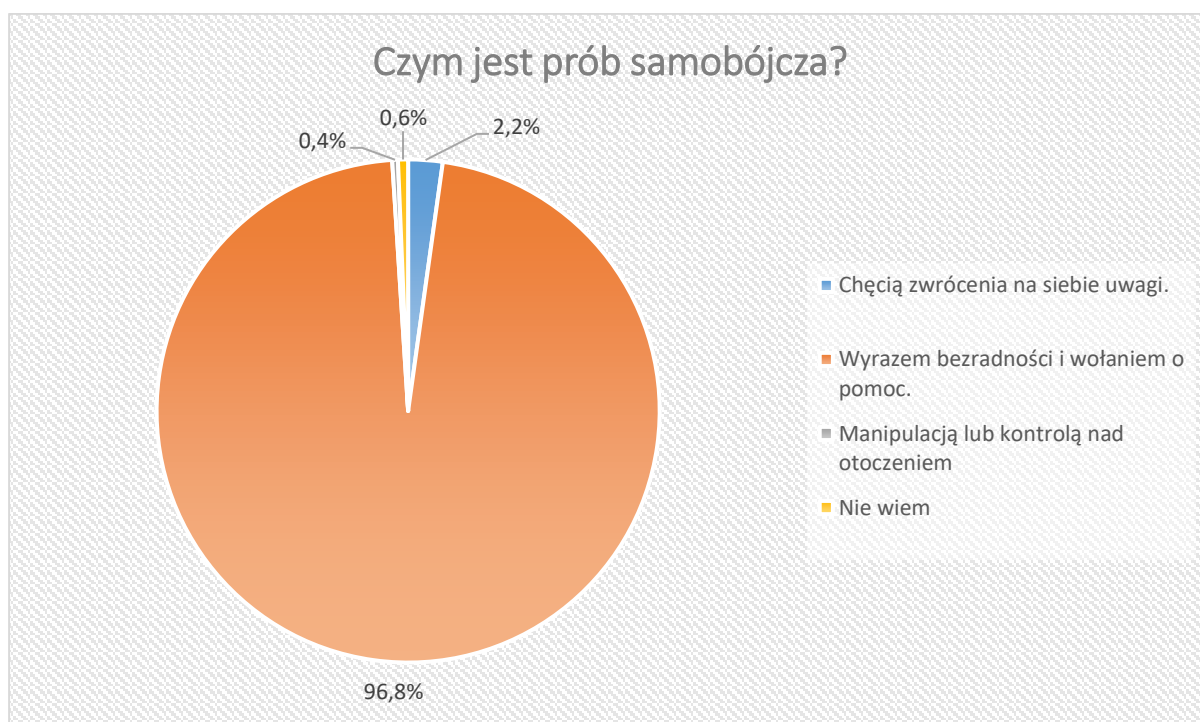
Kolejne pod względem liczebności grupy to pedagodzy (5,8%), dyrektorzy i wicedyrektorzy (5,4%) oraz psychologowie (4,6%).

Pozostałe stanowiska reprezentowane są przez znacznie mniejszą liczbę respondentów i łącznie stanowią niewielki odsetek próby. Wśród nich znajdują się m.in. nauczyciele wspomagający/współorganizujący, wychowawcy w internatach, pedagodzy specjaliści, terapeuci pedagogiczni, pielęgniarki oraz kierownicy internatów. Pojedyncze osoby pełniły funkcje sekretarza, pomocy nauczycielskiej, kierownika świetlicy oraz doradcy zawodowego.

Uzyskana struktura wskazuje, że badanie przed rozpoczęciem szkolenia było wyraźnie zdominowane przez kadrę nauczycielską, przy jednoczesnym udziale przedstawicieli innych, wyspecjalizowanych ról funkcjonujących w środowisku oświatowym.

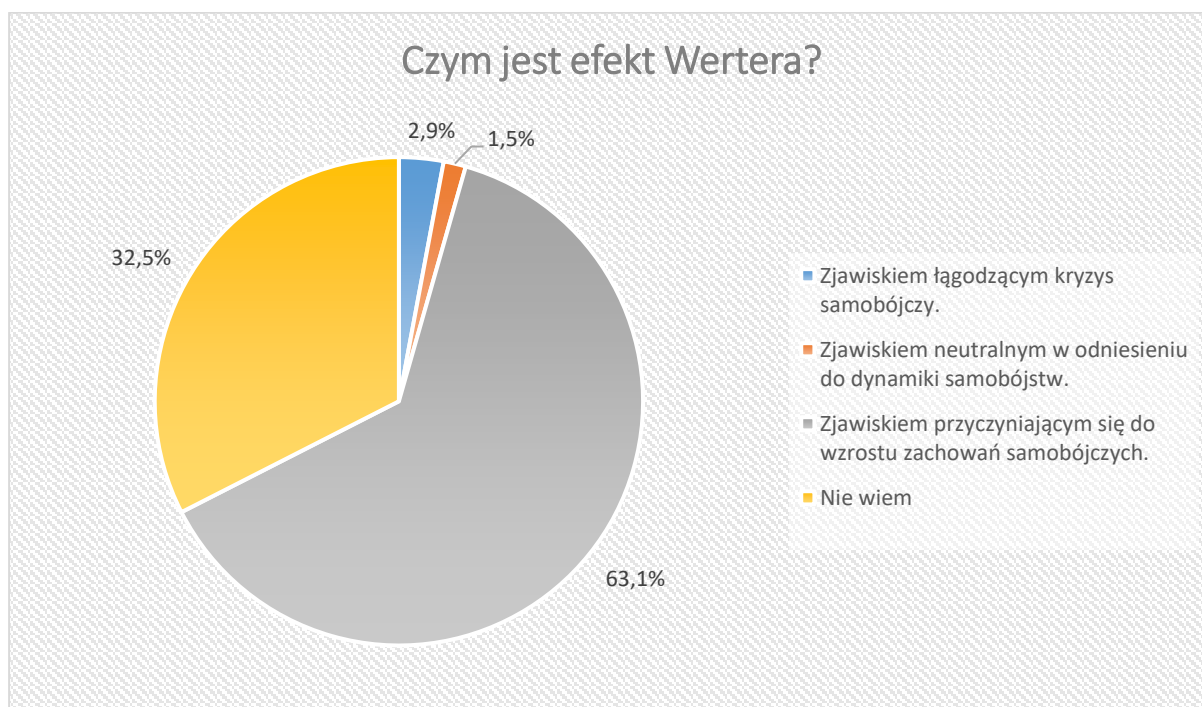


Wykres przedstawia strukturę stażu pracy osób wypełniających ankietę przed rozpoczęciem szkolenia. Najliczniejszą grupę respondentów stanowią osoby z bardzo długim doświadczeniem zawodowym – 40,4% badanych (439 osób) posiada staż pracy wynoszący 21 lat i więcej. Kolejną grupą są respondenci ze stażem 1–5 lat, którzy stanowią 16,9% próby (184 osoby). Osoby z doświadczeniem zawodowym wynoszącym 16–20 lat to 14,1% ankietowanych (153 osoby), natomiast respondenci pracujący 6–10 lat stanowią 13,2% badanych (143 osoby). Staż pracy w przedziale 11–15 lat deklaruje 11,9% respondentów (129 osób). Najmniej liczną grupę tworzą osoby ze stażem krótszym niż rok – 3,5% próby (38 osób). Uzyskane wyniki wskazują, że w badanej grupie dominują osoby o długim i bardzo długim doświadczeniu zawodowym.





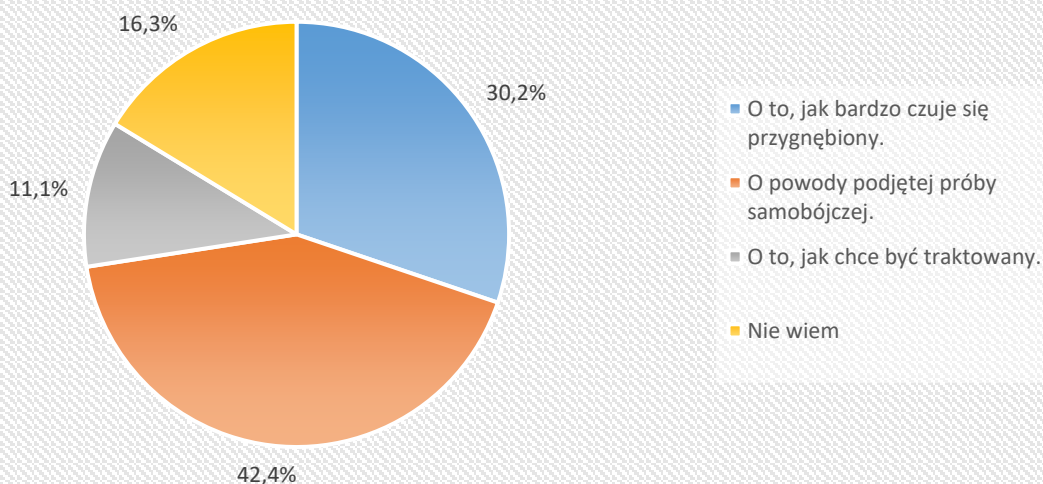
Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czym jest próba samobójcza?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Wyrazem bezradności i wołaniem o pomoc”. Zdecydowana większość badanych, tj. 96,8% respondentów (1051 osób), prawidłowo wskazała właściwą odpowiedź. Łącznie 35 osób, czyli 3,2% ankietowanych, udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują, że przed rozpoczęciem szkolenia zdecydowana większość uczestników posiadała prawidłową wiedzę na temat znaczenia prób samobójczych, jednak obecność odpowiedzi błędnych potwierdza zasadność realizacji działań edukacyjnych w celu utrwalania rzetelnego i empatycznego rozumienia zachowań samobójczych.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czym jest efekt Wertera?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Zjawiskiem przyczyniającym się do wzrostu zachowań samobójczych”. Prawidłowej odpowiedzi udzieliła większość respondentów, tj. 63,1% badanych (685 osób). Łącznie 36,9% ankietowanych (401 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują, że mimo dominacji poprawnych odpowiedzi, ponad jedna trzecia uczestników badania przed rozpoczęciem szkolenia nie posiadała pełnej i prawidłowej wiedzy na temat efektu Wertera, co potwierdza zasadność realizacji szkolenia w zakresie odpowiedzialnego mówienia o zachowaniach samobójczych i ich społecznych konsekwencjach.

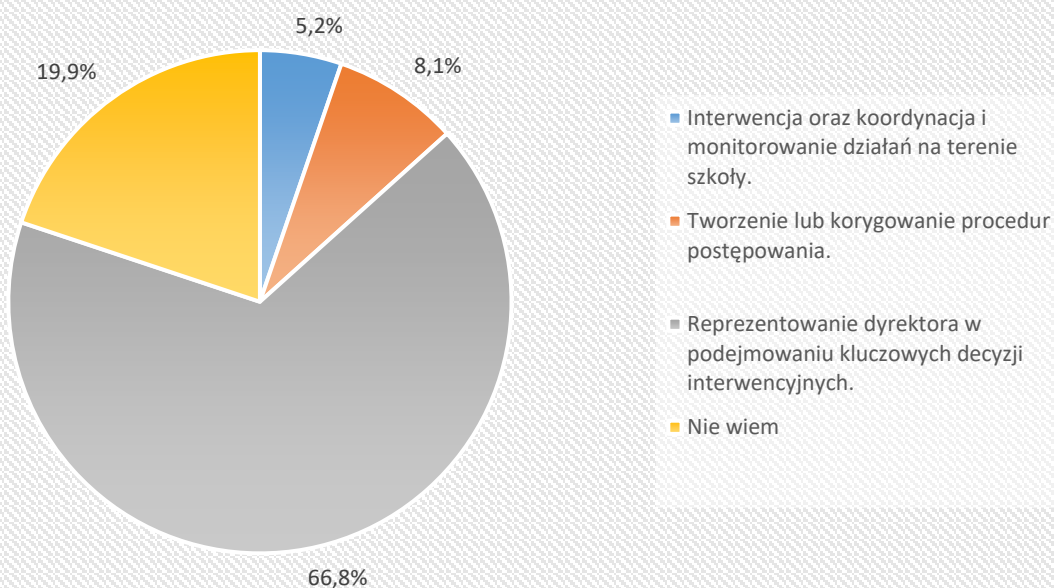


O co NIE należy pytać w kontakcie z uczniem po próbie samobójczej?:



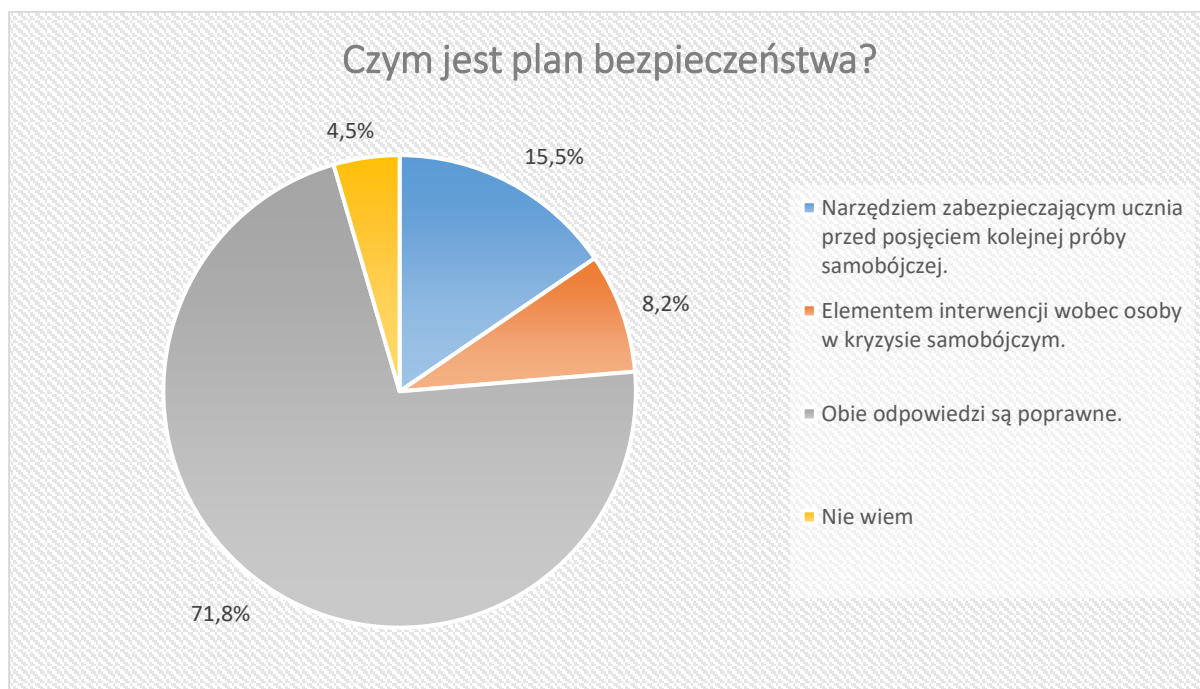
Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „O co NIE należy pytać w kontakcie z uczniem po próbie samobójczej?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „o powody podjętej próby samobójczej”. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło 42,4% respondentów (460 osób). Łącznie 57,6% ankietowanych (626 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują, że przed rozpoczęciem szkolenia ponad połowa uczestników badania nie posiadała pełnej i prawidłowej wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznej i wspierającej komunikacji z uczniem po próbie samobójczej, co potwierdza zasadność realizacji szkolenia ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji w obszarze interwencji kryzysowej i postwencyjnej w środowisku szkolnym.

Co NIE jest rolą zespołu kryzysowego w szkole?





Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Co NIE jest rolą zespołu kryzysowego w szkole?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „reprezentowanie dyrektora w podejmowaniu kluczowych decyzji interwencyjnych”. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło 66,8% respondentów (725 osób). Łącznie 33,2% ankietowanych (361 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują, że mimo dominacji poprawnych odpowiedzi, co trzeci uczestnik badania przed rozpoczęciem szkolenia nie posiadał pełnej i prawidłowej wiedzy dotyczącej zakresu kompetencji zespołu kryzysowego w szkole, co potwierdza zasadność realizacji szkolenia ukierunkowanego na doprecyzowanie ról i odpowiedzialności w sytuacjach kryzysowych.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czym jest plan bezpieczeństwa?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „elementem interwencji wobec osoby w kryzysie samobójczym”. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło 8,2% respondentów (89 osób). Łącznie 91,8% ankietowanych (997 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują, że przed rozpoczęciem szkolenia zdecydowana większość uczestników badania nie posiadała prawidłowej wiedzy na temat roli i znaczenia planu bezpieczeństwa w interwencji wobec osoby w kryzysie samobójczym, co jednoznacznie potwierdza zasadność realizacji szkolenia w tym obszarze.



Ankieta sprawdzająca wiedzę po szkoleniu

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę po szkoleniu pt. „Uczeń po próbie samobójczej – jak go wspierać w powrocie do szkoły?” zawierał, metryczkę składającą się z 6 pytań dotyczących: imienia, nazwiska, adresu e-mail, stanowiska pracy, stażu pracy oraz nazwy szkoły, którą reprezentuje ankietowany. Dane te były pobierane uczestników celach statystycznych oraz umożliwiały późniejsze wystawienie imiennego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla każdego z uczestników. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły przed realizacją spotkania edukacyjnego.

Formularz wypełniło 950 osób, co daje ok. 78,3% zwrotu z ankiet.

I.p.	Stanowisko	Liczba osób	Procent [%]
1	Nauczyciel	751	79,1
2	Pedagog	62	6,5
3	Dyrektor/wicedyrektor	52	5,5
4	Psycholog	50	5,3
5	Wychowawca w internacie	9	0,9
6	Nauczyciel wspomagający/współorganizujący	7	0,7
7	Pedagog specjalny	5	0,5
8	Terapia pedagogiczna	3	0,3
9	Pielęgniarka	3	0,3
10	Kierownik internatu	2	0,2
11	Sekretarz	2	0,2
12	Pomoc nauczycielska	1	0,1
13	Kierownik świetlicy	1	0,1
14	Doradca zawodowy	1	0,1

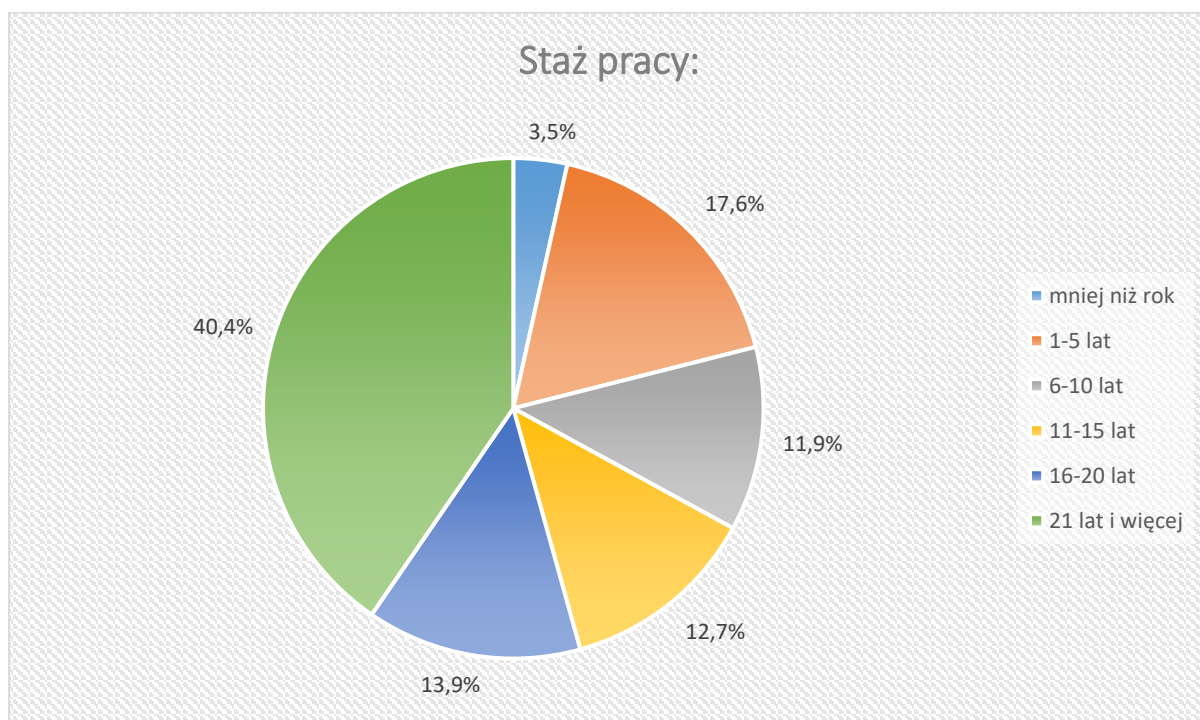
Ankieta po szkoleniu została wypełniona przez 950 osób, co stanowi ok. 78,3% zwrotu ankiet. Ankietę przed rozpoczęciem szkolenia wypełniło natomiast 1086 respondentów, co odpowiada ok. 89,5% zwrotu ankiet.

W obu pomiarach zdecydowanie najliczniejszą grupę respondentów stanowili nauczyciele. Po szkoleniu ich udział wynosił 79,1% badanych (751 osób), natomiast przed szkoleniem 80,5% (874 osoby), co wskazuje na niewielkie zmniejszenie udziału procentowego tej grupy przy jednoczesnym spadku liczby respondentów.

Struktura pozostałych stanowisk po szkoleniu pozostaje w dużej mierze zbliżona do tej obserwowanej w badaniu wstępnym. Pedagodzy stanowili 6,5% respondentów po szkoleniu (62 osoby) oraz 5,8% przed szkoleniem (63 osoby). Udział dyrektorów i wicedyrektorów był niemal identyczny w obu pomiarach i wynosił 5,5% po szkoleniu (52 osoby) oraz 5,4% przed szkoleniem (59 osób). Psychologowie reprezentowali 5,3% badanych po szkoleniu (50 osób) i 4,6% przed szkoleniem (50 osób).

Pozostałe grupy zawodowe, takie jak nauczyciele wspomagający/współorganizujący, wychowawcy w internatach, pedagodzy specjaliści, osoby prowadzące terapię pedagogiczną, pielęgniarki, kierownicy internatów, sekretarze, pomoce nauczycielskie, kierownicy świetlic oraz doradcy zawodowi, łącznie stanowiły niewielki odsetek próby zarówno po, jak i przed szkoleniem, a ich udział procentowy nie uległ istotnym zmianom.

Porównanie struktury respondentów w obu pomiarach wskazuje, że ankiety po i przed szkoleniem były wypełniane przez w dużej mierze porównywalne grupy zawodowe, co pozwala uznać uzyskane wyniki za wiarygodne i umożliwia rzetelną ocenę efektów szkolenia. Jednocześnie różnice w liczebności respondentów między pomiarami są zjawiskiem typowym dla badań ewaluacyjnych tego typu.



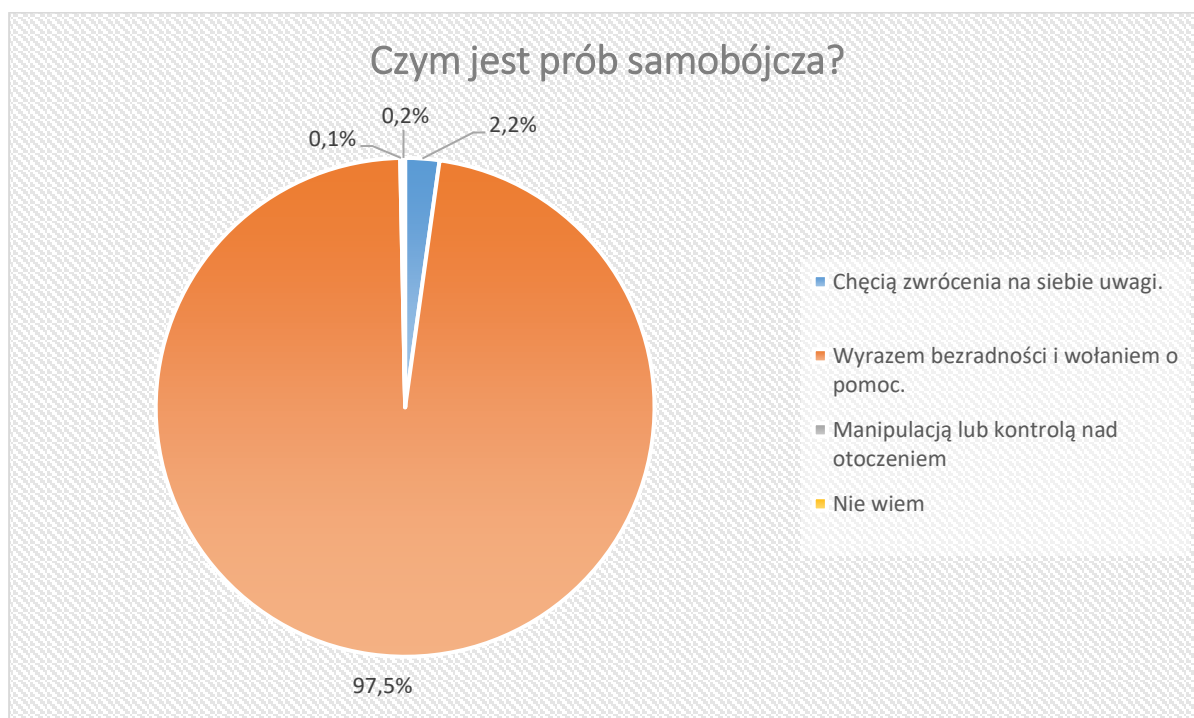
Analiza stażu pracy osób, które wypełniły ankietę sprawdzającą wiedzę po zakończeniu szkolenia, wskazuje, że struktura doświadczenia zawodowego respondentów pozostaje bardzo zbliżona do tej obserwowanej w badaniu przeprowadzonym przed szkoleniem, mimo różnic w liczbie udzielonych odpowiedzi.

W ankiecie po szkoleniu najliczniejszą grupę stanowili respondenci ze stażem pracy 21 lat i więcej, którzy stanowili 40,4% badanych (384 osoby). W badaniu przeprowadzonym przed szkoleniem odsetek ten był identyczny i wynosił również 40,4% (439 osób). Respondenci ze stażem 1–5 lat stanowili 17,6% próby po szkoleniu (167 osób) wobec 16,9% (184 osoby) w badaniu wstępnym.

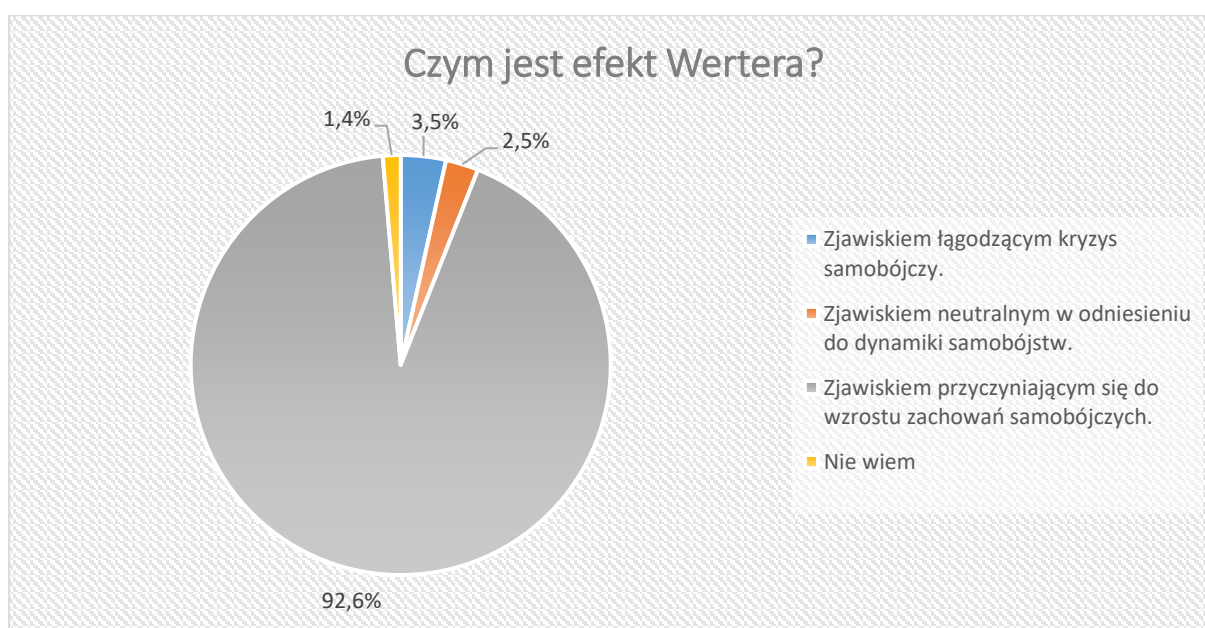
Osoby pracujące 6–10 lat stanowiły 11,9% respondentów po szkoleniu (113 osób) oraz 13,2% przed szkoleniem (143 osoby). Staż pracy w przedziale 11–15 lat deklarowało 12,7% badanych po szkoleniu (121 osób) oraz 11,9% respondentów przed szkoleniem (129 osób). Udział osób ze stażem 16–20 lat był również zbliżony i wynosił 13,9% po szkoleniu (132 osoby) oraz 14,1% przed szkoleniem (153 osoby).

Najmniej liczną grupę w obu pomiarach stanowiły osoby ze stażem pracy krótszym niż rok – 3,5% respondentów po szkoleniu (33 osoby) oraz 3,5% przed szkoleniem (38 osób).

Pomimo zauważalnych różnic w liczbie respondentów biorących udział w ankiecie przed i po szkoleniu, rozkład stażu pracy w obu pomiarach pozostaje bardzo zbliżony. Wskazuje to, że ankietę końcową została wypełniona przez grupę o porównywalnym poziomie doświadczenia zawodowego jak w badaniu wstępnym. Różnice w liczbie odpowiedzi sugerują, że nie wszyscy uczestnicy szkolenia wzięli udział w post-teście, jednak nie wpłynęło to istotnie na strukturę badanej próby, co pozwala na rzetelne porównanie wyników wiedzy uzyskanych przed i po szkoleniu.

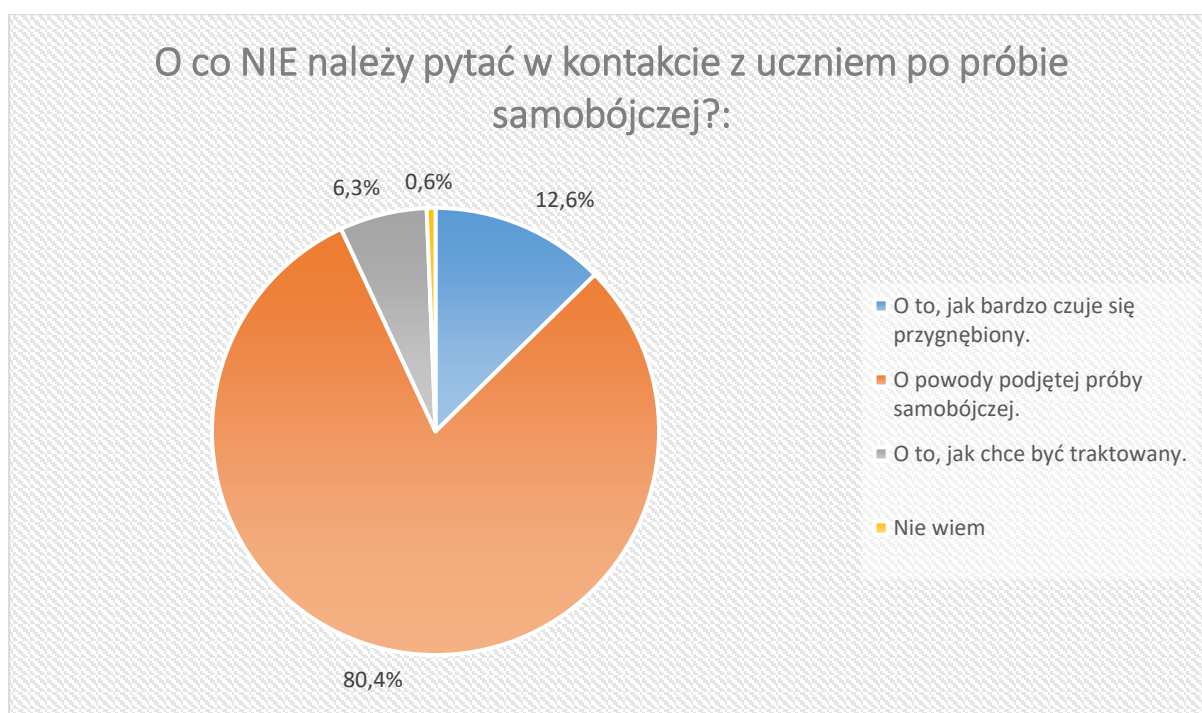


Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czym jest próba samobójcza?”, zadane przed i po zakończeniu szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Wyrazem bezradności i wołaniem o pomoc”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość respondentów, tj. 97,5% badanych (926 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie 2,5% respondentów (24 osoby). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 96,8% badanych (1051 osób), natomiast 3,2% respondentów (35 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na dalsze wzmocnienie już wysokiego poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie rozumienia istoty prób samobójczych. Odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł o 0,7 punktu procentowego, przy jednoczesnym spadku liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy. Pomimo różnic w liczbie respondentów biorących udział w ankietach przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność szkolenia w utrwalaniu prawidłowego, empatycznego i adekwatnego podejścia do interpretacji zachowań samobójczych.





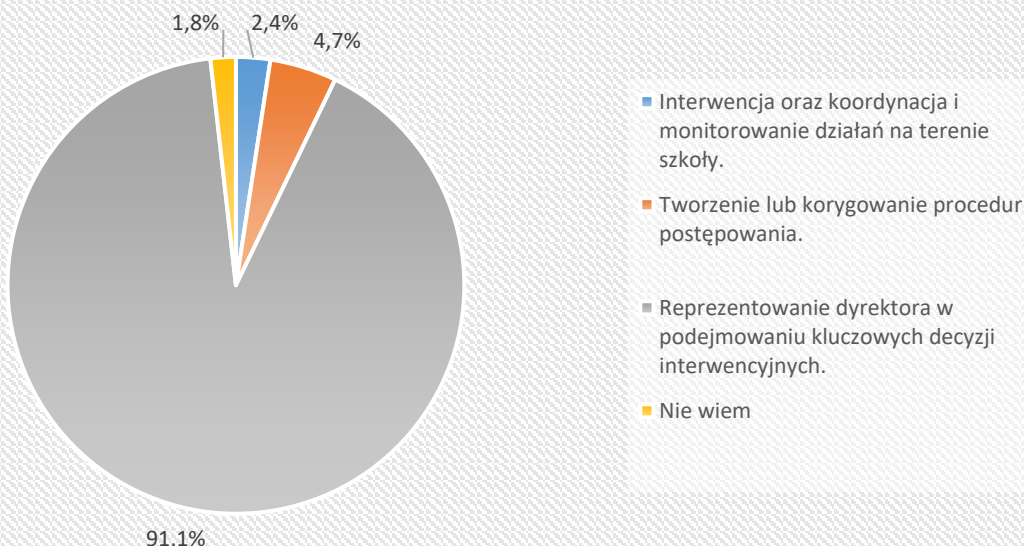
Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czym jest efekt Wertera?”, zadane przed i po zakończeniu szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Zjawiskiem przyczyniającym się do wzrostu zachowań samobójczych”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość respondentów, tj. 92,6% badanych (880 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie 7,4% respondentów (70 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 63,1% badanych (685 osób), natomiast 36,9% respondentów (401 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na bardzo wyraźny wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie rozumienia efektu Wertera. Odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł o 29,5 punktu procentowego, przy jednoczesnym znaczącym spadku liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy po szkoleniu. Pomimo różnic w liczbie respondentów biorących udział w ankietach przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają skuteczność szkolenia w obszarze odpowiedzialnego mówienia o zachowaniach samobójczych i ich konsekwencjach społecznych.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „O co NIE należy pytać w kontakcie z uczniem po próbie samobójczej?”, zadane przed i po zakończeniu szkolenia. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „o powody podjętej próby samobójczej”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliło 80,4% respondentów (764 osoby). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie 19,6% badanych (186 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 42,4% respondentów (460 osób), natomiast 57,6% badanych (626 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na bardzo wyraźny wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zasad bezpiecznej komunikacji z uczniem po próbie samobójczej. Odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł o 38,0 punktu procentowego, przy jednoczesnym znaczącym spadku liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w badaniach przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają skuteczność szkolenia w obszarze interwencji postwencyjnej w środowisku szkolnym.

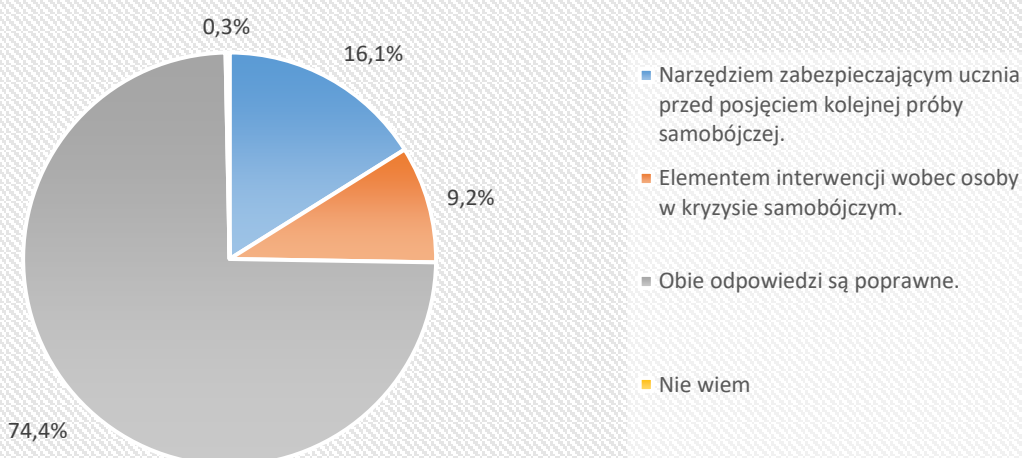


Co NIE jest rolą zespołu kryzysowego w szkole?



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Co NIE jest rolą zespołu kryzysowego w szkole?”, zadane przed i po zakończeniu szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „reprezentowanie dyrektora w podejmowaniu kluczowych decyzji interwencyjnych”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość respondentów, tj. 91,1% badanych (865 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie 8,9% respondentów (84 osoby). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 66,8% respondentów (725 osób), natomiast 33,2% badanych (361 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wyraźny wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zakresu kompetencji zespołu kryzysowego w szkole. Odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł o 24,3 punktu procentowego, przy jednoczesnym znaczącym spadku liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy po szkoleniu. Pomimo różnic w liczebności respondentów uczestniczących w badaniach przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność szkolenia w obszarze doprecyzowania ról i odpowiedzialności w sytuacjach kryzysowych w środowisku szkolnym.

Czym jest plan bezpieczeństwa?





Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czym jest plan bezpieczeństwa?”, zadane przed i po zakończeniu szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „elementem interwencji wobec osoby w kryzysie samobójczym”. W ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem prawidłowej odpowiedzi udzieliło 8,2% respondentów (89 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie 91,8% badanych (997 osób), przy czym najczęściej wybieraną odpowiedzią błędną było stwierdzenie, że obie odpowiedzi są poprawne. Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu poprawną odpowiedź wskazało 9,2% respondentów (87 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklaracji braku wiedzy udzieliło 90,8% badanych (863 osoby). Podobnie jak w badaniu wstępnym, dominowały odpowiedzi wskazujące na nieprawidłowe rozumienie roli planu bezpieczeństwa, polegające na traktowaniu go wyłącznie jako narzędzia zabezpieczającego lub łączeniu obu funkcji w jedną. Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje, że mimo przeprowadzonego szkolenia poziom wiedzy uczestników w zakresie rozumienia planu bezpieczeństwa jako elementu interwencji kryzysowej uległ jedynie nieznacznej zmianie. Niewielki wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi nie przełożył się na istotne ograniczenie odpowiedzi błędnych, co sugeruje, że zagadnienie to pozostaje trudne i wymaga dalszego pogłębiania w ramach działań szkoleniowych i superwizyjnych.

Podsumowanie

Analiza wyników ankiety sprawdzającej wiedzę uczestników szkolenia pt. „Uczeń po próbie samobójczej – jak go wspierać w powrocie do szkoły?” wskazuje na istotny wzrost poziomu wiedzy w kluczowych obszarach związanych z postwencją, bezpieczną komunikacją z uczniem oraz rolą szkoły w procesie jego powrotu do funkcjonowania edukacyjnego. Pomimo różnic w liczbie respondentów biorących udział w badaniu przed i po szkoleniu, struktura badanej próby pod względem stanowisk oraz stażu pracy pozostaje porównywalna, co pozwala na rzetelną interpretację uzyskanych wyników.

W badaniu wstępnym uczestnicy wykazywali stosunkowo wysoki poziom wiedzy w zakresie rozumienia istoty próby samobójczej jako wyrazu bezradności i wołania o pomoc. Po szkoleniu odnotowano dalsze wzmocnienie tego obszaru wiedzy, przy jednoczesnym spadku liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy. Szczególnie wyraźną poprawę zaobserwowano w odniesieniu do zagadnień dotyczących efektu Wertera, gdzie odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł o blisko 30 punktów procentowych, co wskazuje na skuteczność szkolenia w obszarze odpowiedzialnego mówienia o zachowaniach samobójczych i ich konsekwencjach społecznych.

Znaczący wzrost poziomu wiedzy dotyczył również zasad bezpiecznej komunikacji z uczniem po próbie samobójczej. Odsetek respondentów prawidłowo wskazujących, że nie należy pytać ucznia o powody podjętej próby samobójczej, wzrósł o 38 punktów procentowych. Wynik ten potwierdza skuteczność szkolenia w rozwijaniu kompetencji interwencyjnych i postwencyjnych kadry pedagogicznej.

Poprawie uległo także rozumienie roli zespołu kryzysowego w szkole. Po szkoleniu zdecydowana większość uczestników prawidłowo identyfikowała zakres kompetencji zespołu, co wskazuje na lepsze uporządkowanie wiedzy dotyczącej podziału ról i odpowiedzialności w sytuacjach kryzysowych.

Jednocześnie analiza wyników ujawniła obszary wymagające dalszego pogłębiania, w szczególności dotyczące planu bezpieczeństwa. Zarówno przed, jak i po szkoleniu, znaczna część respondentów nie identyfikowała planu bezpieczeństwa jako elementu interwencji wobec osoby w kryzysie samobójczym, co sugeruje potrzebę bardziej pogłębionej pracy szkoleniowej i superwizyjnej w tym zakresie.

Z wyników ankiet można wywnioskować, że ze szkolenia pt. „Uczeń po próbie samobójczej – jak go wspierać w powrocie do szkoły”, aż 72,8% uczestników (biorąc pod uwagę wszystkie 55 szkół) zdało test sprawdzający wiedzę po szkoleniu na ponad 75%. Natomiast biorąc pod uwagę szkoły, których udział był możliwy dzięki dofinansowaniu z MEN (35 szkół) to aż 71,7% uczestników zdało test sprawdzający wiedzę po szkoleniu na ponad 75%.

Podsumowując, wyniki ankiety potwierdzają, że szkolenie „Uczeń po próbie samobójczej – jak go wspierać w powrocie do szkoły?” przyczyniło się do istotnego podniesienia poziomu wiedzy uczestników w kluczowych obszarach postwencji szkolnej. Uzyskane rezultaty wskazują na wysoką skuteczność szkolenia, przy jednoczesnym zidentyfikowaniu zagadnień, które wymagają dalszego utrwalania i pogłębiania w przyszłych działaniach edukacyjnych.



„Dobrostan psychiczny nauczyciela – jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami?”

Szkolenie to skupiło się na zrozumieniu i zarządzaniu emocjami, ze szczególnym uwzględnieniem tych trudnych i nieprzyjemnych. Uczestnicy nauczyli się, jak identyfikować i rozumieć własne emocje, aby lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i wyzwaniach życiowych. Poruszane były techniki szybkiego łagodzenia negatywnych emocji, które mogą być stosowane w codziennych sytuacjach, by zapobiegać ich eskalacji i negatywnemu wpływowi na zdrowie psychiczne. Dodatkowo, szkolenie przedstawiło wskazówki dotyczące długoterminowych strategii zmniejszania podatności na nieprzyjemne stany emocjonalne. Celem było wyposażenie uczestników w narzędzia do lepszego radzenia sobie z emocjami, co przekłada się na poprawę jakości życia i zdrowia psychicznego.

W szkoleniu pt. „Dobrostan psychiczny nauczyciela – jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami?” wzięło udział 1196 osób. Poniżej lista szkół wraz z liczbą osób, która wzięła udział w szkoleniu dla kadry pedagogicznej:

l.p.	NAZWA SZKOŁY	LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie	35
2	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu	17
3	I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu	20
4	II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie	18
5	IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu	15
6	IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze	11
7	VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie	31
8	IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie	10
9	Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku	31
10	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Perpetuum Mobile w Bydgoszczy	26
11	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowa Akademia” w Lublinie	19
12	Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie	22
13	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długowoli	15
14	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orłat Lwowskich w Opolu	19
15	Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu	18
16	Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie	15
17	Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym	15
18	Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie	16
19	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie	20
20	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi	15
21	Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich	21
22	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni	37
23	Szkoła Podstawowa im. ppłk. Stanisława Sienkiewicza w Milejowie	16
24	Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Mierzynie	21
25	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie	23
26	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Żegrzu	18
27	Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym	60
28	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczynskiego w Komornikach	19
29	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach	32
30	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie	44
31	Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowej Soli	8
32	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku	30
33	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4PP „Czwartaków” w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach	17
34	Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich w Łodzi	22
35	Szkoła Podstawowa w Złotorii	30
36	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pawła Adamowicza w Gdańsku	14
37	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie	7
38	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy	13
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni	21



40	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie	16
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim	14
42	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie	18
43	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	19
44	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	25
45	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne	31
46	Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku	25
47	Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach	17
48	Zespół Szkół nr 21 w Warszawie	26
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie	50
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu	23
51	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach	14
52	Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie	22
53	Zespół Szkół w Szczurowej	18
54	Zespół Szkół w Szumowie	22
55	Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni	15

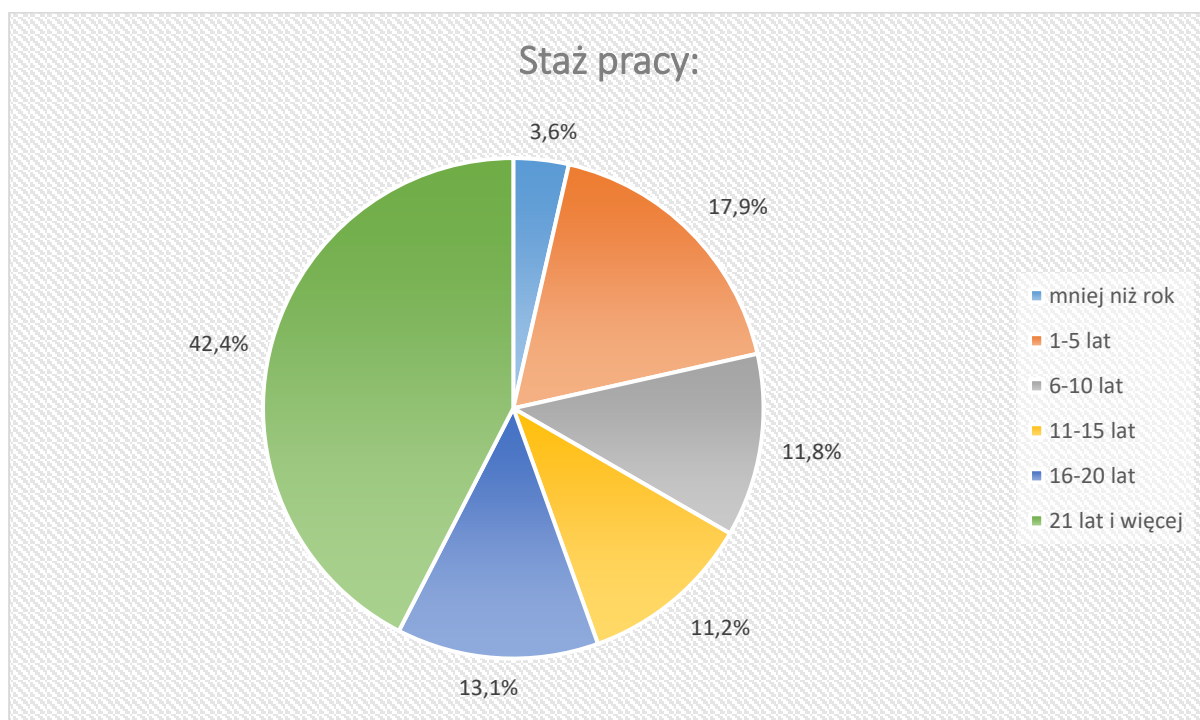
Ankieta sprawdzająca wiedzę przed szkoleniem

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę przed szkoleniem pt. „Dobrostan psychiczny nauczyciela – jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami?” zawierał: metryczkę składającą się z 6 pytań dotyczących: imienia, nazwiska, adresu e-mail, stanowiska pracy, stażu pracy oraz nazwy szkoły, którą reprezentuje ankietowany. Dane te były pobierane uczestników celach statystycznych oraz umożliwiały późniejsze wystawienie imiennego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla każdego z uczestników. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły przed realizacją szkolenia.

Formularz wypełniło 1065 osób, co daje ok. 89,0% zwrotu z ankiet.

l.p.	Stanowisko	Liczba osób	Procent [%]
1	Nauczyciel	849	79,7
2	Pedagog	65	6,1
3	Dyrektor/wicedyrektor	56	5,3
4	Psycholog	50	4,7
5	Nauczyciel wspomagający/współorganizujący	13	1,2
6	Wychowawca w internacie	10	0,9
7	Pedagog specjalny	6	0,6
8	Terapia pedagogiczna	5	0,5
9	Pielęgniarka	4	0,4
10	Kierownik internatu	2	0,2
11	Pomoc nauczycielska	2	0,2
12	Sekretarz	1	0,1
13	Kierownik świetlicy	1	0,1
14	Doradca zawodowy	1	0,1

Tabela przedstawia strukturę stanowisk osób, które wypełniły ankietę. Formularz został wypełniony przez 1065 osób, co stanowi ok. 89,0% zwrotu ankiet. Zdecydowaną większość respondentów stanowią nauczyciele – 849 osób, co odpowiada 79,7% wszystkich badanych. Kolejne pod względem liczebności grupy to pedagodzy (6,1%), dyrektorzy i wicedyrektorzy (5,3%) oraz psychologowie (4,7%). Pozostałe stanowiska reprezentowane są przez znacznie mniejszą liczbę respondentów i łącznie stanowią niewielki odsetek próby. Wśród nich znajdują się m.in. nauczyciele wspomagający/współorganizujący, wychowawcy w internatach, pedagodzy specjaliści, terapeuci pedagogiczni, pielęgniarki, kierownicy internatów, a także pojedyncze osoby pełniące funkcje pomocy nauczycielskiej, sekretarza, kierownika świetlicy oraz doradcy zawodowego. Struktura ta wskazuje, że badanie było zdominowane przez kadrę nauczycielską, przy jednoczesnym udziale przedstawicieli innych specjalistycznych ról funkcjonujących w środowisku oświatowym.



Analiza stażu pracy osób, które wypełniły ankietę sprawdzającą wiedzę po zakończeniu szkolenia, wskazuje, że struktura doświadczenia zawodowego respondentów pozostaje bardzo zbliżona do tej obserwowanej w badaniu przeprowadzonym przed szkoleniem, mimo różnic w liczbie udzielonych odpowiedzi.

W ankiecie po szkoleniu najliczniejszą grupę stanowili respondenci ze stażem pracy 21 lat i więcej – 42,6% badanych (376 osób), podczas gdy w badaniu przed szkoleniem odsetek ten wynosił 42,4% (452 osoby). Respondenci ze stażem 1–5 lat stanowili 18,6% próby po szkoleniu (164 osoby) wobec 17,9% (191 osób) przed szkoleniem.

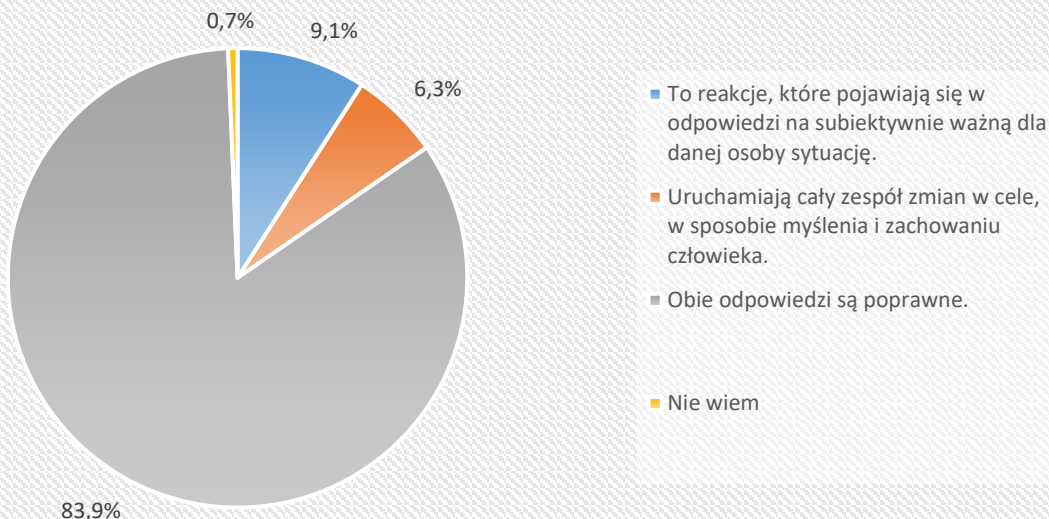
Osoby pracujące 6–10 lat stanowiły 10,2% respondentów po szkoleniu (90 osób) oraz 11,8% w badaniu wstępnym (126 osób). Staż 11–15 lat deklarowało 11,7% badanych po szkoleniu (103 osoby) oraz 11,2% przed szkoleniem (119 osób). Udział osób ze stażem 16–20 lat był również zbliżony i wynosił 12,9% po szkoleniu (114 osób) oraz 13,1% przed szkoleniem (139 osób).

Najmniej liczną grupę w obu pomiarach stanowiły osoby ze stażem pracy krótszym niż rok – 4,0% respondentów po szkoleniu (35 osób) oraz 3,6% przed szkoleniem (38 osób).

Pomimo zauważalnych różnic w liczbie respondentów biorących udział w ankiecie przed i po szkoleniu, rozkład stażu pracy w obu pomiarach pozostaje bardzo zbliżony. Wskazuje to, że ankieta końcowa została wypełniona przez grupę o porównywalnym poziomie doświadczenia zawodowego jak w badaniu wstępnym. Różnice w liczbie odpowiedzi sugerują, że nie wszyscy uczestnicy szkolenia wzięli udział w post-teście, jednak nie wpłynęło to istotnie na strukturę badanej próby, co pozwala na rzetelne porównanie wyników uzyskanych przed i po szkoleniu.

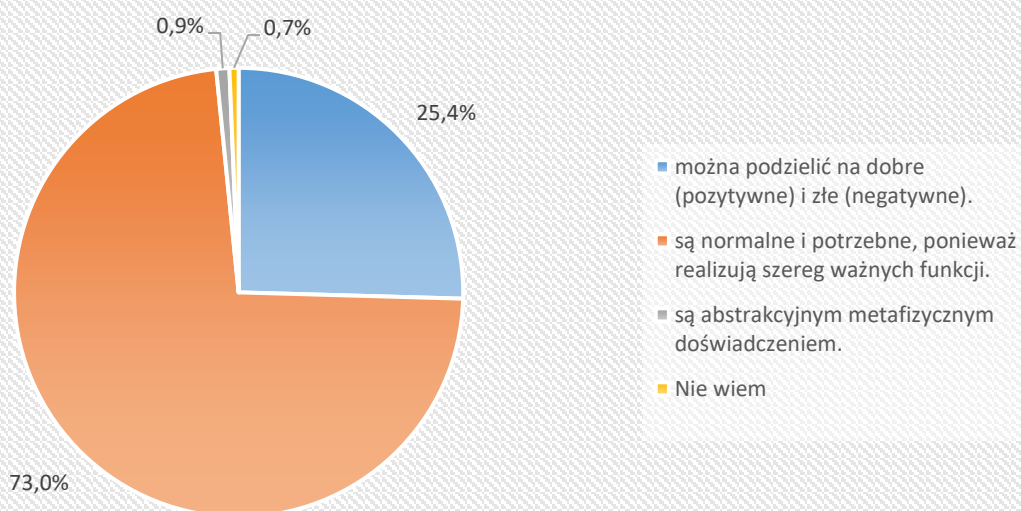


Co jest prawdą o emocjach?



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Co jest prawdą o emocjach?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Obie odpowiedzi są poprawne”. Zdecydowana większość respondentów (83,9%; 894 osoby) udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Jednocześnie 171 osób, czyli 16,1% badanych, udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Uzyskane wyniki wskazują, że mimo dominacji poprawnych odpowiedzi, część uczestników badania przed rozpoczęciem szkolenia nie posiadała pełnej i prawidłowej wiedzy na temat istoty emocji, co potwierdza zasadność realizacji szkolenia w tym zakresie.

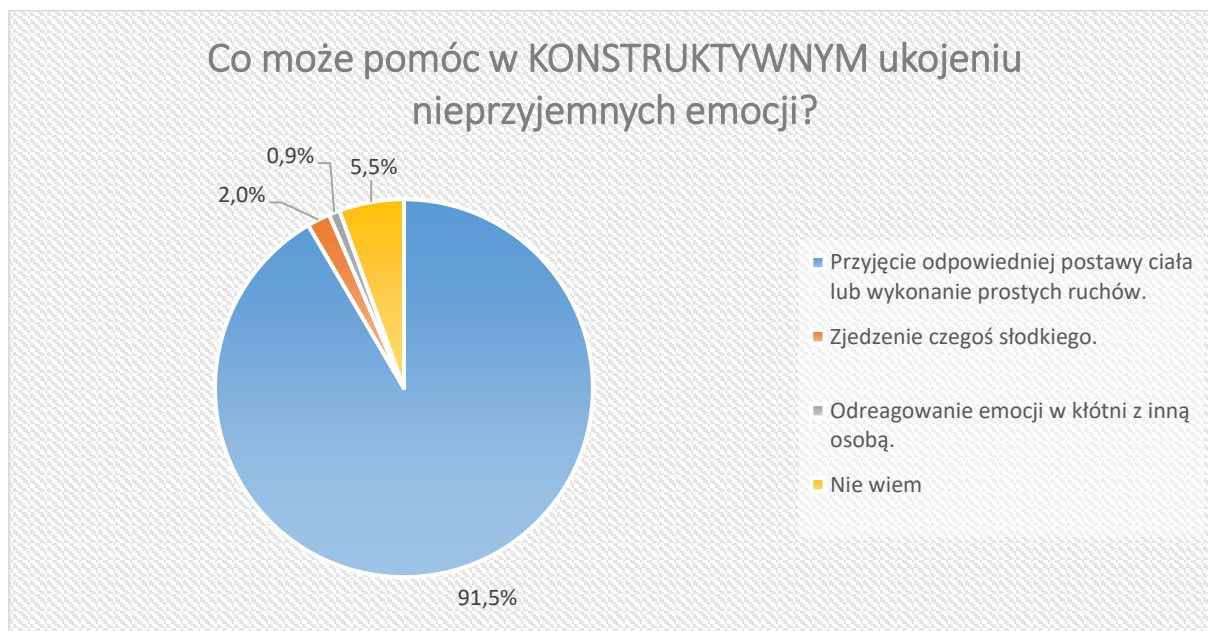
Z psychologicznego punktu widzenia emocje:



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Z psychologicznego punktu widzenia emocje:”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Są normalne i potrzebne, ponieważ realizują szereg ważnych funkcji”. Większość badanych udzieliła prawidłowej odpowiedzi – 73,0% respondentów (777 osób). Jednocześnie 288 osób, czyli 27,0% badanych, udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. W tej grupie znalazły się osoby postrzegające emocje wyłącznie w kategoriach pozytywnych i negatywnych, uznające je za



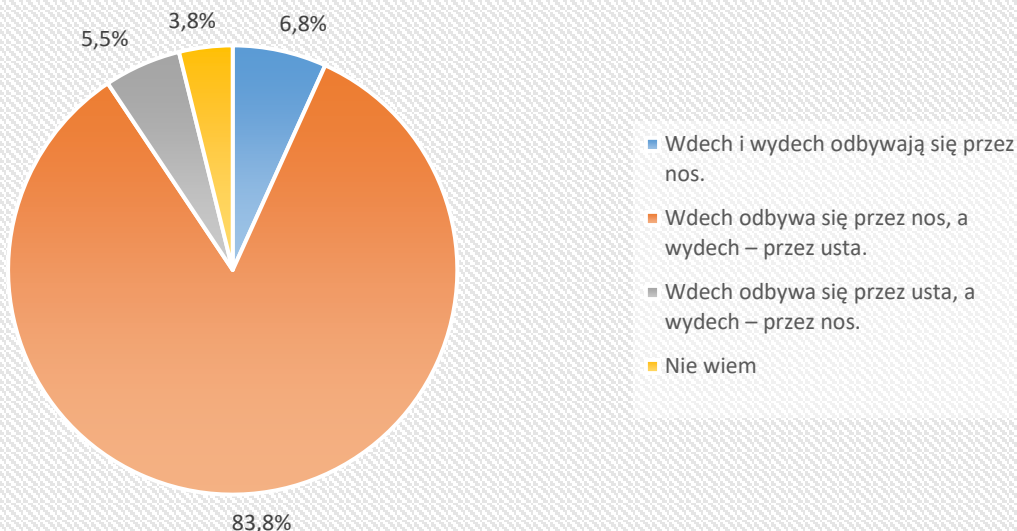
abstrakcyjne metafizyczne doświadczenie, a także respondenci, którzy nie potrafili jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Uzyskane wyniki wskazują, że mimo dominacji poprawnych odpowiedzi, ponad jedna czwarta uczestników badania przed rozpoczęciem szkolenia nie posiadała pełnej i zgodnej z wiedzą psychologiczną świadomości roli emocji, co potwierdza zasadność realizacji szkolenia w tym obszarze.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Co może pomóc w konstruktywnym ukojeniu nieprzyjemnych emocji?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „Przyjęcie odpowiedniej postawy ciała lub wykonanie prostych ruchów”. Zdecydowana większość badanych – 91,5% respondentów (975 osób) – udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Jednocześnie 90 osób, czyli 8,5% badanych, udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. W tej grupie znalazły się osoby wskazujące na zjedzenie czegoś słodkiego, odreagowanie emocji w kłótni z inną osobą oraz respondenci, którzy nie potrafili jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Uzyskane wyniki wskazują, że uczestnicy badania w zdecydowanej większości dysponowali prawidłową wiedzą na temat konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, jednak niewielki odsetek badanych wymagał w tym zakresie dalszego wsparcia edukacyjnego, co uzasadnia realizację szkolenia.

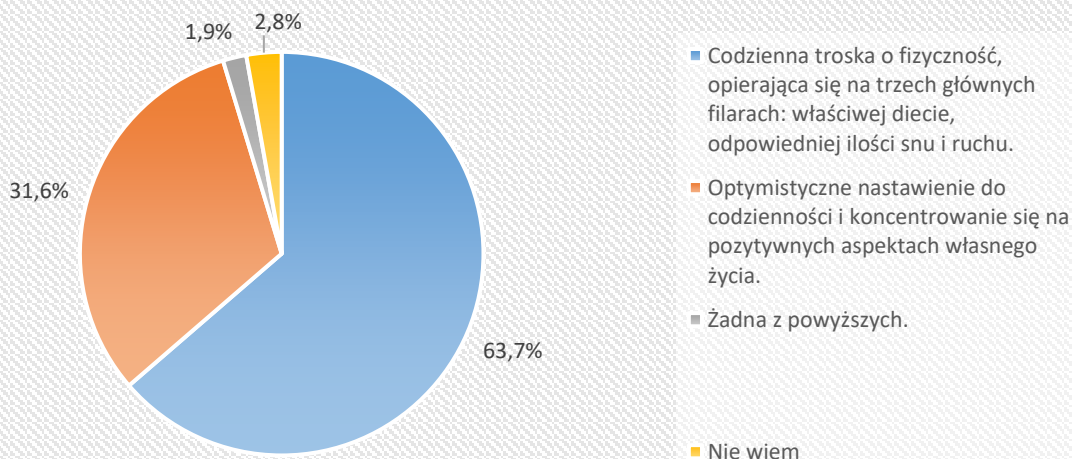


Jak wykonuje się poprawny oddech przeponowy?



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Jak wykonuje się poprawny oddech przeponowy?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Wdech odbywa się przez nos, a wydech – przez usta”. Zdecydowana większość badanych udzieliła prawidłowej odpowiedzi – 83,8% respondentów (893 osoby) poprawnie wskazało właściwy sposób oddychania przeponowego. Jednocześnie 172 osoby, czyli 16,2% badanych, udzieliły odpowiedzi błędnych lub zadeklarowały brak wiedzy. W tej grupie znalazły się osoby wskazujące, że zarówno wdech, jak i wydech odbywają się przez nos, respondenci zamieniający drogi oddechu miejscami, a także osoby, które nie potrafiły jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Uzyskane wyniki wskazują, że mimo dominacji poprawnych odpowiedzi, część uczestników badania przed rozpoczęciem szkolenia nie posiadała pełnej i prawidłowej wiedzy dotyczącej techniki oddechu przeponowego, co potwierdza zasadność realizacji szkolenia w zakresie nauki praktycznych metod regulacji napięcia i emocji.

Co jest sposobem na zmniejszenie podatności na odczuwanie nieprzyjemnych stanów emocjonalnych?:





Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Co jest sposobem na zmniejszenie podatności na odczuwanie nieprzyjemnych stanów emocjonalnych?”, zadane przed rozpoczęciem szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Codzienna troska o fizyczność, opierająca się na trzech głównych filarach: właściwej diecie, odpowiedniej ilości snu i ruchu”. Większość badanych udzieliła prawidłowej odpowiedzi – 63,7% respondentów (678 osób) poprawnie wskazało ten sposób. Jednocześnie 387 osób, czyli 36,3% badanych, udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. W tej grupie znalazły się osoby wskazujące wyłącznie na optymistyczne nastawienie do codzienności i koncentrację na pozytywnych aspektach życia, respondenci uznający, że żadna z zaproponowanych odpowiedzi nie jest właściwa, a także osoby, które nie potrafiły jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Uzyskane wyniki wskazują, że choć większość uczestników badania przed rozpoczęciem szkolenia posiadała prawidłową wiedzę na temat znaczenia codziennej dbałości o fizyczne podstawy dobrostanu emocjonalnego, to ponad jedna trzecia badanych nie dysponowała pełną i adekwatną wiedzą w tym zakresie, co potwierdza zasadność realizacji szkolenia.

Ankieta sprawdzająca wiedzę po szkoleniu

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę po szkoleniu pt. „Dobrostan psychiczny nauczyciela – jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami?” zawierał, metryczkę składającą się z 6 pytań dotyczących: imienia, nazwiska, adresu e-mail, stanowiska pracy, stażu pracy oraz nazwy szkoły, którą reprezentuje ankietowany. Dane te były pobierane uczestników celach statystycznych oraz umożliwiały późniejsze wystawienie imiennego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla każdego z uczestników. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły po realizacji szkolenia.

Formularz wypełniło 882 osób, co daje ok. 73,7% zwrotu z ankiet.

l.p.	Stanowisko	Liczba osób	Procent [%]
1	Nauczyciel	698	79,1
2	Pedagog	51	5,8
3	Dyrektor/wicedyrektor	48	5,4
4	Psycholog	45	5,1
5	Nauczyciel wspomagający/współorganizujący	12	1,4
6	Wychowawca w internacie	8	0,9
7	Pedagog specjalny	5	0,6
8	Terapia pedagogiczna	5	0,6
9	Pielęgniarka	2	0,2
10	Kierownik internatu	2	0,2
11	Pomoc nauczycielska	2	0,2
12	Sekretarz	2	0,2
13	Kierownik świetlicy	1	0,1
14	Doradca zawodowy	1	0,1

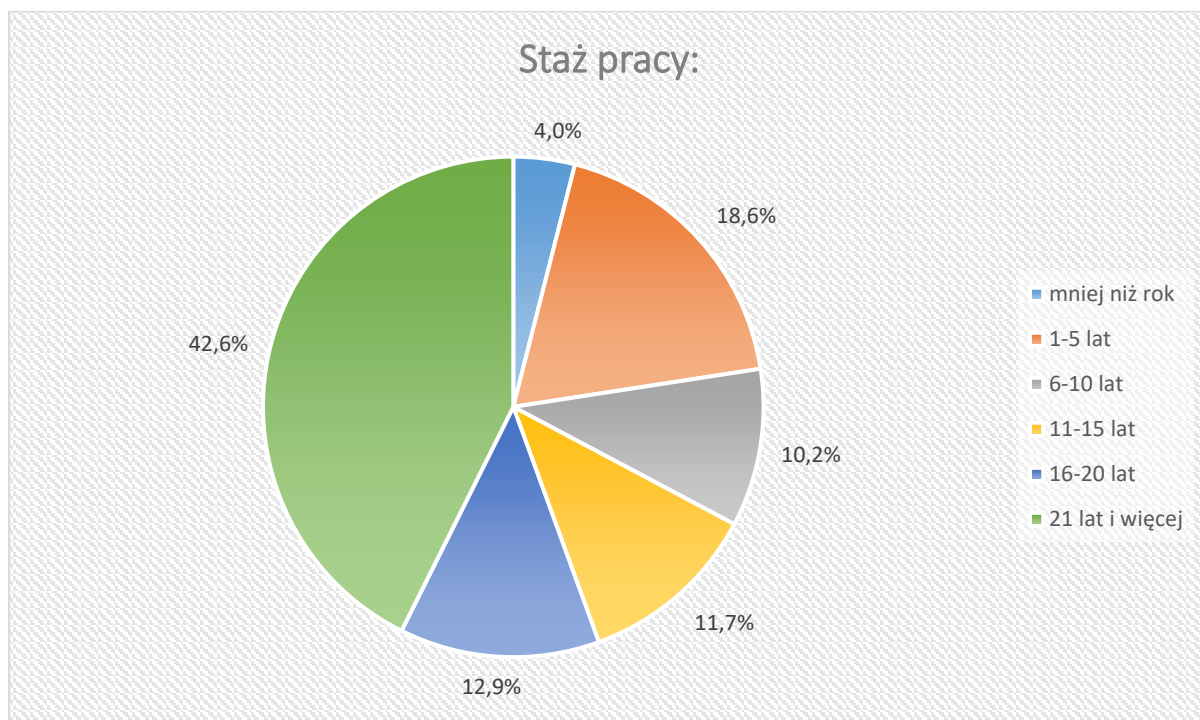
Ankieta sprawdzająca wiedzę po szkoleniu została wypełniona przez 882 osoby, co stanowi ok. 73,7% zwrotu ankiet. Natomiast ankietę przed rozpoczęciem szkolenia wypełniło 1065 uczestników, co odpowiada ok. 89,0% zwrotu ankiet. W obu pomiarach największą grupę respondentów stanowili nauczyciele. Po szkoleniu ich udział wynosił 79,1% badanych (698 osób), natomiast przed szkoleniem 79,7% (849 osób), co wskazuje na bardzo zbliżony udział procentowy tej grupy przy jednoczesnym spadku liczby respondentów w badaniu końcowym.

Struktura pozostałych stanowisk po szkoleniu pozostaje w dużej mierze zbliżona do tej obserwowanej w badaniu wstępnym. Pedagodzy stanowili 5,8% respondentów po szkoleniu (51 osób) oraz 6,1% przed szkoleniem (65 osób). Psychologowie reprezentowali 5,1% badanych po szkoleniu (45 osób) i 4,7% przed szkoleniem (50 osób). Udział dyrektorów i wicedyrektorów był niemal identyczny w obu pomiarach i wynosił 5,4% po szkoleniu (48 osób) oraz 5,3% przed szkoleniem (56 osób).

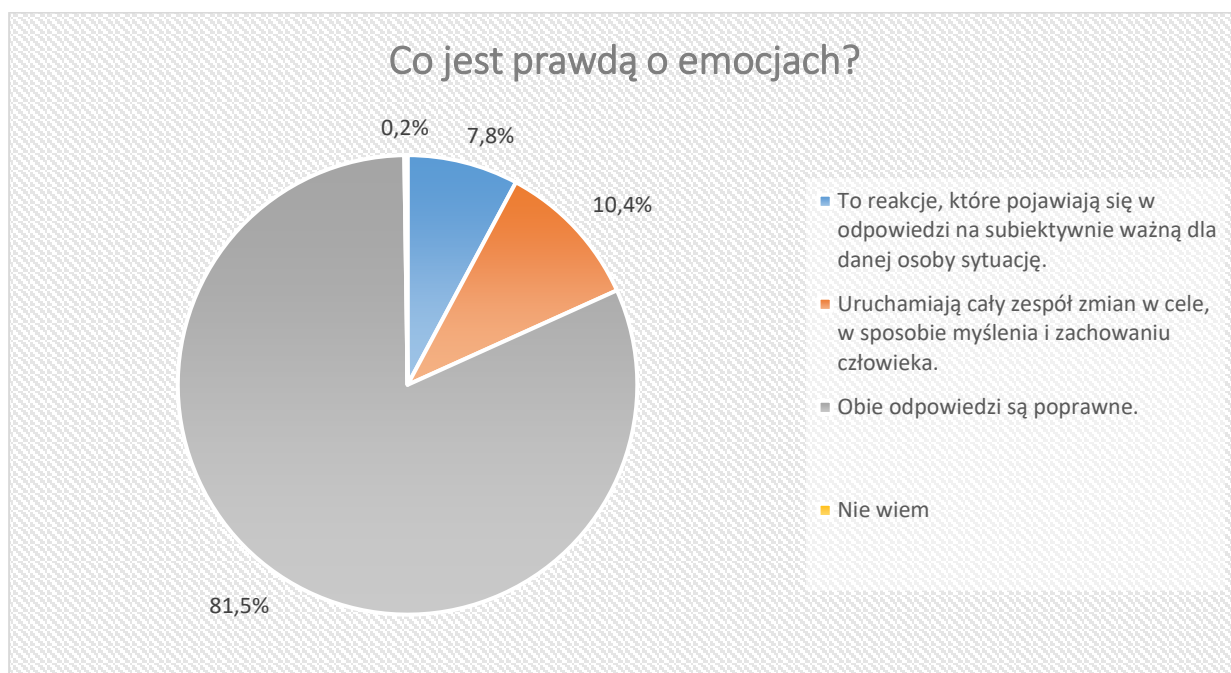
Pozostałe grupy zawodowe, takie jak nauczyciele wspomagający/współorganizujący, wychowawcy w internatach, pedagogi specjaliści, osoby prowadzące terapię pedagogiczną, pielęgniarki, kierownicy internatów, kierownicy świetlic, doradcy zawodowi, pomoce nauczycielskie oraz sekretarze, łącznie stanowiły niewielki odsetek próby zarówno przed, jak i po szkoleniu, a ich udział procentowy nie uległ istotnym zmianom. Porównanie struktury respondentów w obu



porównaniach wskazuje, że ankiety przed i po szkoleniu były wypełniane przez w dużej mierze porównywalne grupy zawodowe, co pozwala uznać uzyskane wyniki za wiarygodne i umożliwia rzetelną ocenę zmian poziomu wiedzy uczestników szkolenia. Jednocześnie różnice w liczebności respondentów między pomiarami sugerują, że część uczestników nie wzięła udziału w jednym z etapów badania, co jest zjawiskiem typowym w badaniach ewaluacyjnych tego typu.



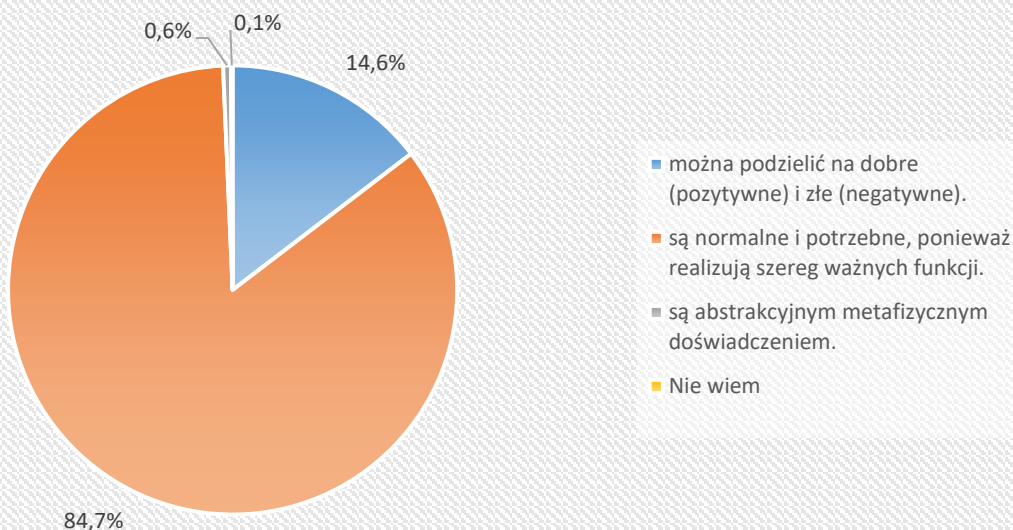
Wykres przedstawia strukturę stażu pracy osób wypełniających ankietę. Najliczniejszą grupę stanowią respondenci z bardzo długim doświadczeniem zawodowym – 42,4% badanych (452 osoby) posiada staż pracy wynoszący 21 lat i więcej. Kolejną pod względem liczebności grupą są osoby ze stażem 1–5 lat, które stanowią 17,9% próby (191 osób). Następnie plasują się respondenci ze stażem 16–20 lat – 13,1% (139 osób), a także osoby pracujące od 6 do 10 lat – 11,8% (126 osób). Staż pracy w przedziale 11–15 lat deklaruje 11,2% ankietowanych (119 osób). Najmniej liczną grupę tworzą osoby ze stażem krótszym niż rok – 3,6% badanych (38 osób). Uzyskane dane wskazują, że w badaniu dominowały osoby o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, co potwierdza wysoki udział respondentów z najdłuższym stażem pracy.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Co jest prawdą o emocjach?”. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Obie odpowiedzi są poprawne”, wskazujące na całościowe rozumienie emocji jako reakcji na subiektywnie ważne sytuacje, które jednocześnie uruchamiają zmiany w ciele, myśleniu i zachowaniu człowieka. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość respondentów – 81,5% badanych (719 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie 18,5% respondentów (163 osoby). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 83,9% badanych (894 osoby), natomiast 16,1% respondentów (171 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie rozumienia istoty emocji. Niewielki spadek odsetka poprawnych odpowiedzi po szkoleniu należy interpretować w kontekście różnic w liczbie respondentów biorących udział w pomiarze końcowym. Pomimo tych różnic uzyskane wyniki potwierdzają, że zarówno przed, jak i po szkoleniu większość uczestników dysponowała prawidłowym, całościowym rozumieniem emocji. Szkolenie mogło pełnić przede wszystkim funkcję utrwalającą i porządkującą wiedzę, a nie kompensującą jej istotne braki.

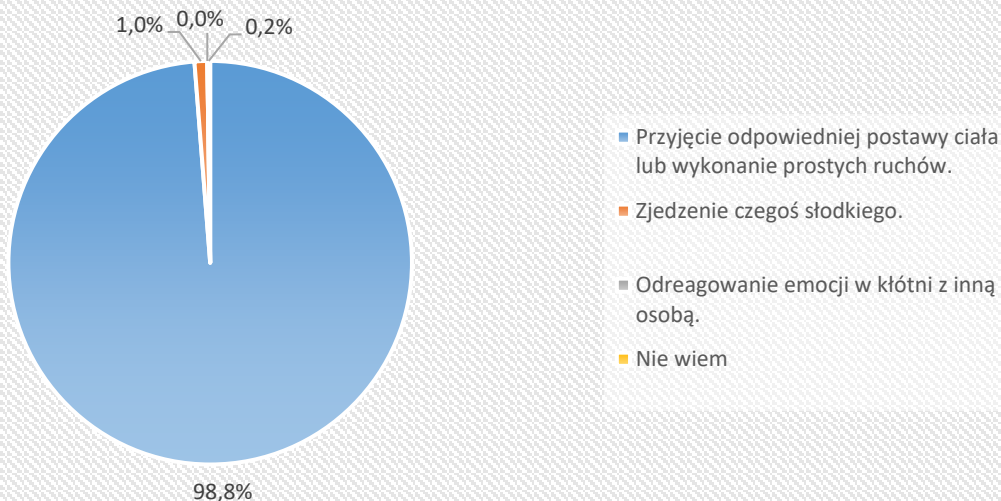


Z psychologicznego punktu widzenia emocje:



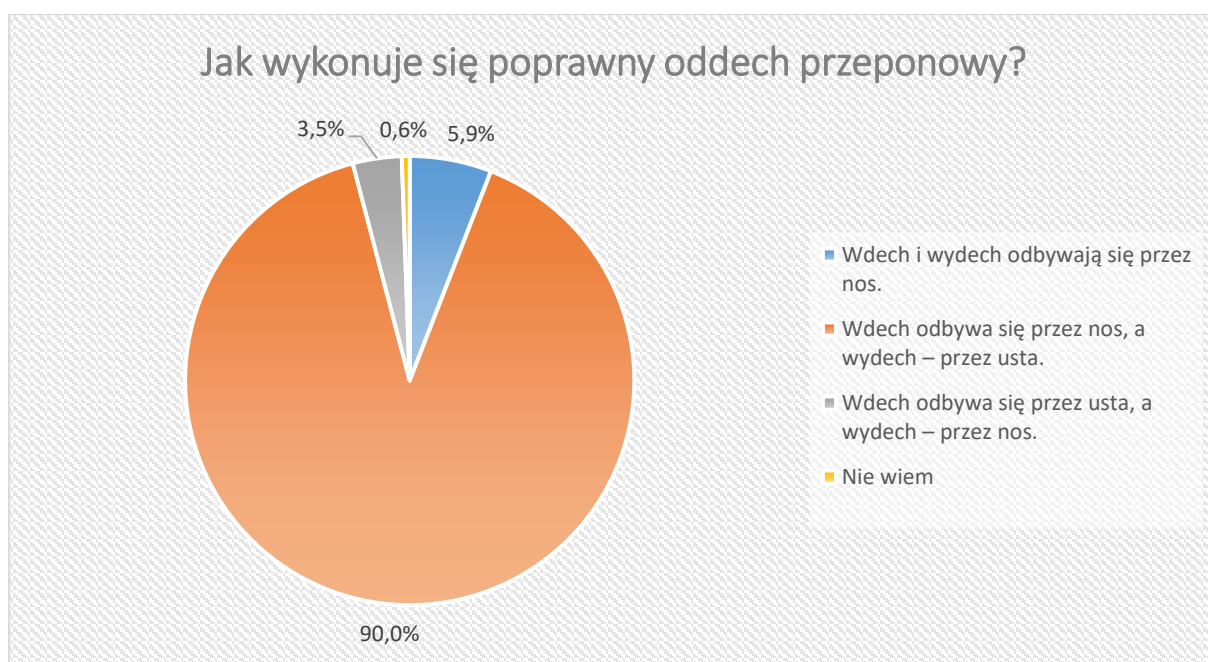
Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Z psychologicznego punktu widzenia emocje:”. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Są normalne i potrzebne, ponieważ realizują szereg ważnych funkcji”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość respondentów – 84,7% badanych (747 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie 15,3% respondentów (135 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 73,0% badanych (777 osób), natomiast 27,0% respondentów (288 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wyraźny wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie psychologicznego rozumienia emocji. Odsetek poprawnych odpowiedzi zwiększył się o 11,7 punktu procentowego, przy jednoczesnym istotnym spadku liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy. Pomimo różnic w liczbie respondentów biorących udział w ankietach przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają skuteczność szkolenia w kształtowaniu adekwatnego, funkcjonalnego i zgodnego z wiedzą psychologiczną podejścia do emocji.

Co może pomóc w KONSTRUKTYWNYM ukojeniu nieprzyjemnych emocji?





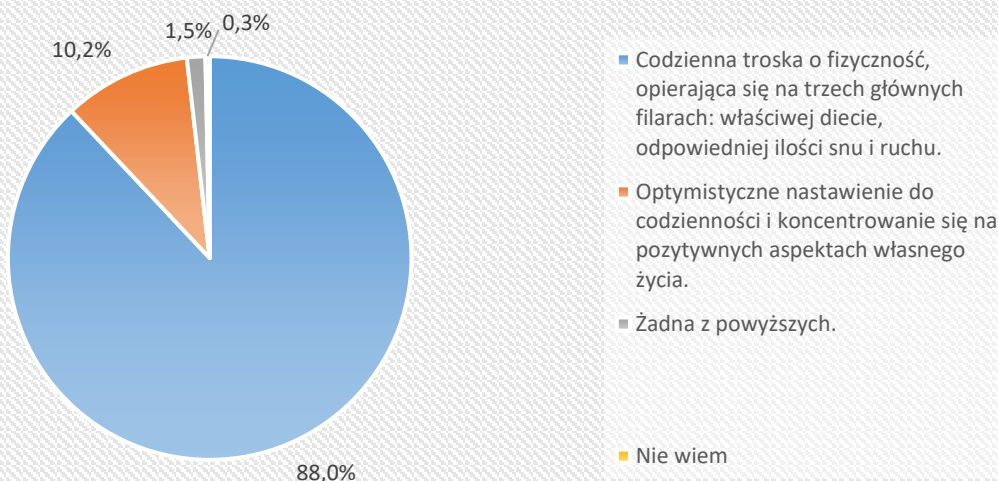
Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Co może pomóc w konstruktywnym ukojeniu nieprzyjemnych emocji?”. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Przyjęcie odpowiedniej postawy ciała lub wykonanie prostych ruchów”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła niemal cała badana grupa – 98,8% respondentów (871 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie jedynie 1,2% badanych (11 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 91,5% respondentów (975 osób), natomiast 8,5% badanych (90 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na bardzo wyraźny wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie rozumienia konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami. Odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł o 7,3 punktu procentowego, przy jednoczesnym znaczącym spadku liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w pomiarach przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają wysoką skuteczność szkolenia w kształtowaniu praktycznych kompetencji z zakresu regulacji emocji.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Jak wykonuje się poprawny oddech przeponowy?”. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Wdech odbywa się przez nos, a wydech – przez usta”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość respondentów – 90,0% badanych (794 osoby). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie 10,0% respondentów (88 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 83,8% badanych (893 osoby), natomiast 16,2% respondentów (172 osoby) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wyraźny wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie prawidłowego wykonywania oddechu przeponowego. Odsetek poprawnych odpowiedzi zwiększył się o 6,2 punktu procentowego, przy jednoczesnym spadku liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w badaniach przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność szkolenia w przekazywaniu praktycznych umiejętności związanych z regulacją napięcia i emocji poprzez techniki oddechowe.



Co jest sposobem na zmniejszenie podatności na odczuwanie nieprzyjemnych stanów emocjonalnych?:



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Co jest sposobem na zmniejszenie podatności na odczuwanie nieprzyjemnych stanów emocjonalnych?”. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Codzienna troska o fizyczność, opierająca się na trzech głównych filarach: właściwej diecie, odpowiedniej ilości snu i ruchu”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość respondentów – 88,0% badanych (776 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie 12,0% respondentów (106 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 63,7% badanych (678 osób), natomiast 36,3% respondentów (387 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na bardzo wyraźny wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie rozumienia roli codziennej dbałości o fizyczne podstawy funkcjonowania emocjonalnego. Odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł o 24,3 punktu procentowego, przy jednoczesnym znaczącym spadku liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy. Pomimo różnic w liczbie respondentów biorących udział w badaniach przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają wysoką skuteczność szkolenia w kształtowaniu całościowego i zgodnego z aktualną wiedzą psychologiczną podejścia do profilaktyki trudnych stanów emocjonalnych.

Podsumowanie

Analiza wyników ankiet sprawdzających wiedzę przeprowadzonych przed szkoleniem oraz po jego zakończeniu w ramach tematu „Dobrostan psychiczny nauczyciela – jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami?” wskazuje jednoznacznie na wysoką skuteczność szkolenia w podnoszeniu i utrwalaniu wiedzy uczestników, zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym.

Już na etapie badania wstępnego uczestnicy wykazywali relatywnie wysoki poziom wiedzy w obszarze podstawowych zagadnień związanych z emocjami i regulacją stresu. Dotyczyło to w szczególności ogólnego rozumienia istoty emocji, konstruktywnych sposobów ich krótkoterminowego ukojeniu oraz podstawowych technik regulacyjnych, takich jak oddech przeponowy. Jednocześnie wyniki ankiety przed szkoleniem ujawniły istotne luki w wiedzy, zwłaszcza w zakresie psychologicznego rozumienia funkcji emocji oraz znaczenia długoterminowej dbałości o fizyczne podstawy dobrostanu emocjonalnego (sen, dieta, ruch).

Porównanie wyników przed i po szkoleniu pokazuje wyraźny wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi we wszystkich analizowanych obszarach, przy jednoczesnym znaczącym spadku liczby odpowiedzi błędnych oraz deklaracji braku wiedzy. Największą poprawę odnotowano w pytaniach dotyczących:

- psychologicznego rozumienia emocji jako zjawisk normalnych i pełniących istotne funkcje adaptacyjne,
- znaczenia codziennej troski o fizyczność jako kluczowego czynnika zmniejszającego podatność na trudne stany emocjonalne,



- praktycznych metod regulacji napięcia, takich jak techniki oddechowe oraz praca z ciałem.

Wysoki poziom poprawnych odpowiedzi po szkoleniu (sięgający w niektórych pytaniach niemal 100%) wskazuje, że uczestnicy nie tylko przyswoili przekazywaną wiedzę, ale również zintegrowali ją z praktycznym rozumieniem własnego funkcjonowania emocjonalnego. W obszarach, w których poziom wiedzy był już wysoki przed szkoleniem, szkolenie pełniło przede wszystkim funkcję porządkującą i utrwalającą, natomiast tam, gdzie zidentyfikowano istotne deficyty, doprowadziło do wyraźnej i mierzalnej poprawy.

Pomimo różnic w liczbie respondentów biorących udział w ankiecie przed i po szkoleniu, struktura badanej próby (zarówno pod względem stanowisk, jak i stażu pracy) pozostała porównywalna, co pozwala uznać uzyskane wyniki za wiarygodne i rzetelne. Spadek liczby odpowiedzi w pomiarze końcowym należy traktować jako zjawisko typowe dla badań ewaluacyjnych i nie wpływające istotnie na interpretację rezultatów.

Z wyników ankiet można wywnioskować, że ze szkolenia pt. „Dobrostan psychiczny nauczyciela – jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami?”, aż 90,4% uczestników (biorąc pod uwagę wszystkie 55 szkół) zdało test sprawdzający wiedzę po szkoleniu na ponad 75%. Natomiast biorąc pod uwagę szkoły, których udział był możliwy dzięki dofinansowaniu z MEN (35 szkół), to aż 89,9% uczestników zdało test sprawdzający wiedzę po szkoleniu na ponad 75%.

Podsumowując, wyniki ankiet jednoznacznie potwierdzają, że szkolenie skutecznie wzmacnia kompetencje nauczycieli w zakresie rozumienia emocji, radzenia sobie ze stresem oraz dbania o własny dobrostan psychiczny. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią istotny zasób nie tylko dla samych nauczycieli, ale również dla całego środowiska szkolnego, sprzyjając budowaniu bardziej wspierającej, świadomej i odpornej psychicznie kadry pedagogicznej.



„Pierwsza pomoc emocjonalna: jak rozpoznać kryzys samobójczy u ucznia i jak powołać zespół kryzysowy w szkole”

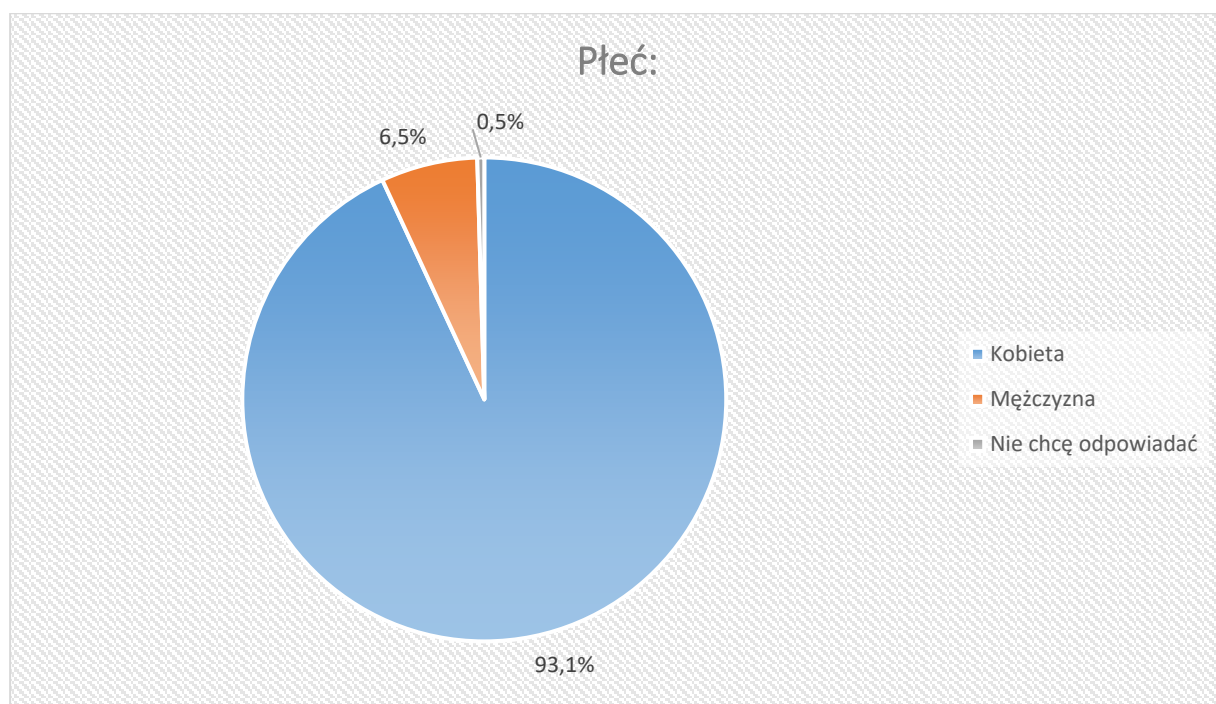
„Pierwsza pomoc emocjonalna: jak rozpoznać kryzys samobójczy u ucznia i jak powołać zespół kryzysowy w szkole?” to otwarte webinary realizowane w ramach programu Wsparająca Szkoła skierowane do wszystkich pracowników szkół chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat kryzysu psychicznego u dziecka i nastolatka, a także zrozumieć rolę i kompetencje szkoły w tym trudnym momencie. Podczas spotkania edukacyjnego uczestnicy dowiedzieli się po czym rozpoznać kryzys emocjonalny u młodej osoby, a także jak wpływa on na jej szkolne funkcjonowanie. Webinar poświęcony był pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli temu, co każdy z nas może zrobić dla osoby w kryzysie. Uczestnicy poznali zasadę 4 x Z, czyli efektywnego i wspierającego sposobu reagowania w sytuacji zauważenia kryzysu emocjonalnego u dziecka lub nastolatka. Dodatkowo przedstawiona została rola i zasady powoływania zespołu kryzysowego w szkole, a także schemat jego działania. Uczestnicy zdobyli kompetencje w zakresie reagowania na wystąpienie w szkole sytuacji kryzysowej.

Odbyło się 6 webinarów otwartych dla nauczycieli, w których łącznie wzięło udział 1401 osób.

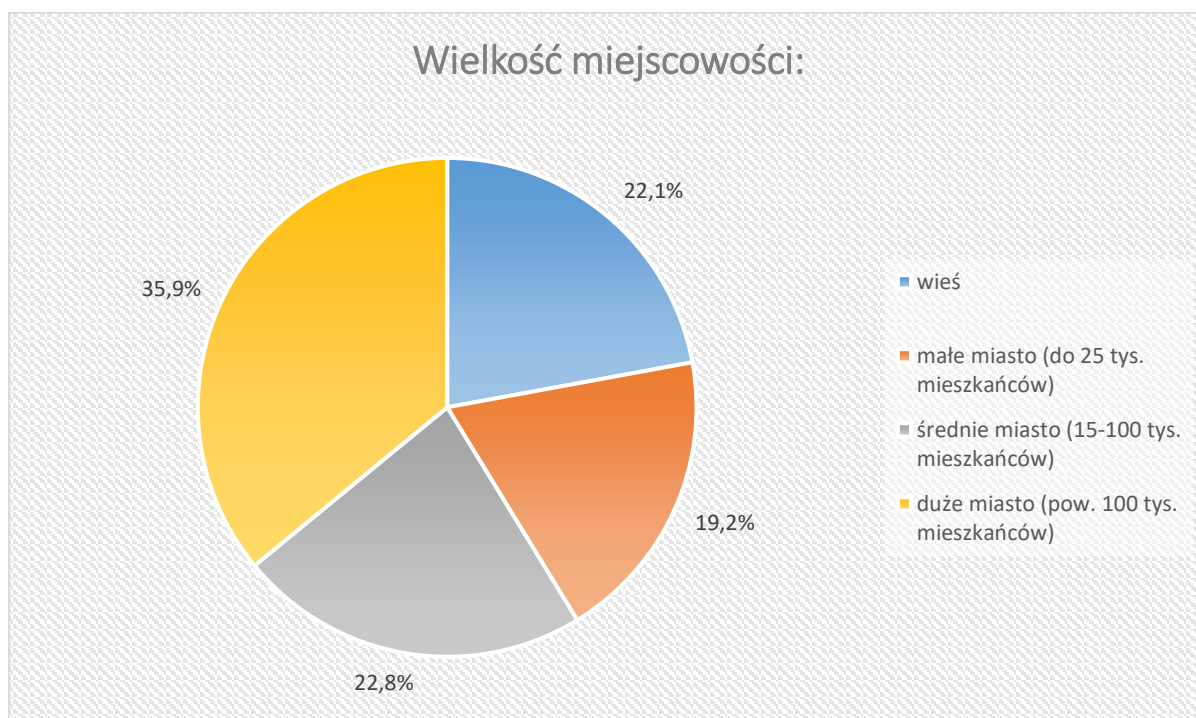
Ankieta sprawdzająca wiedzę przed otwartym webinarium dla pracowników szkół

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę przed webinarium pt. „Pierwsza pomoc emocjonalna: jak rozpoznać kryzys samobójczy u ucznia i jak powołać zespół kryzysowy w szkole?” zawierał: metryczkę składającą się z 4 pytań. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły przed realizacją webinaru.

Preankieta została wypełniona przez 2370 osób.



Wykres przedstawia strukturę płci uczestników na podstawie danych z preankiety wypełnianej podczas rejestracji na otwarte webinary pt. „Pierwsza pomoc emocjonalna: jak rozpoznać kryzys samobójczy u ucznia i jak powołać zespół kryzysowy w szkole?”, realizowane w ramach programu Wsparająca Szkoła. Z danych zebranych w preankiecie wynika, że zdecydowaną większość osób zapisujących się na webinary stanowiły kobiety – 93,1% (2206 osób). Mężczyźni stanowili 6,5% uczestników (153 osoby), natomiast 0,5% osób (11) zadeklarowało odpowiedź „nie chcę odpowiadać”. Łącznie w sześciu otwartych webinarach udział wzięło 1401 uczestników. Wynika z tego, że zdecydowanie więcej osób zapisuje się na webinary, niż ostatecznie bierze w nich udział.



Wykres przedstawia strukturę uczestników, ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania, na podstawie danych z preankiety wypełnianej podczas rejestracji na wydarzenie. Z danych wynika, że największą grupę osób zapisujących się na webinary stanowili uczestnicy mieszkający w dużych miastach powyżej 100 tys. mieszkańców – 35,9% (852 osoby). Porównywalny odsetek respondentów pochodził ze wsi – 22,1% (524 osoby) oraz ze średnich miast liczących od 15 do 100 tys. mieszkańców – 22,8% (540 osób). Mniejszy udział miały osoby zamieszkujące małe miasta do 25 tys. mieszkańców – 19,2% (454 osoby). Struktura ta wskazuje, że webinary cieszyły się zainteresowaniem pracowników szkół z różnych typów miejscowości, przy czym największą reprezentację stanowili uczestnicy z dużych ośrodków miejskich.

l.p.	Jestem	Liczba osób	Procent [%]
1	Nauczycielem	1235	52,1
2	Pedagogiem	464	19,6
3	Psychologiem	449	18,9
4	Dyrektorem/wicedyrektorem	67	2,8
5	Pielęgniarką	6	0,3
6	Inne	149	6,3

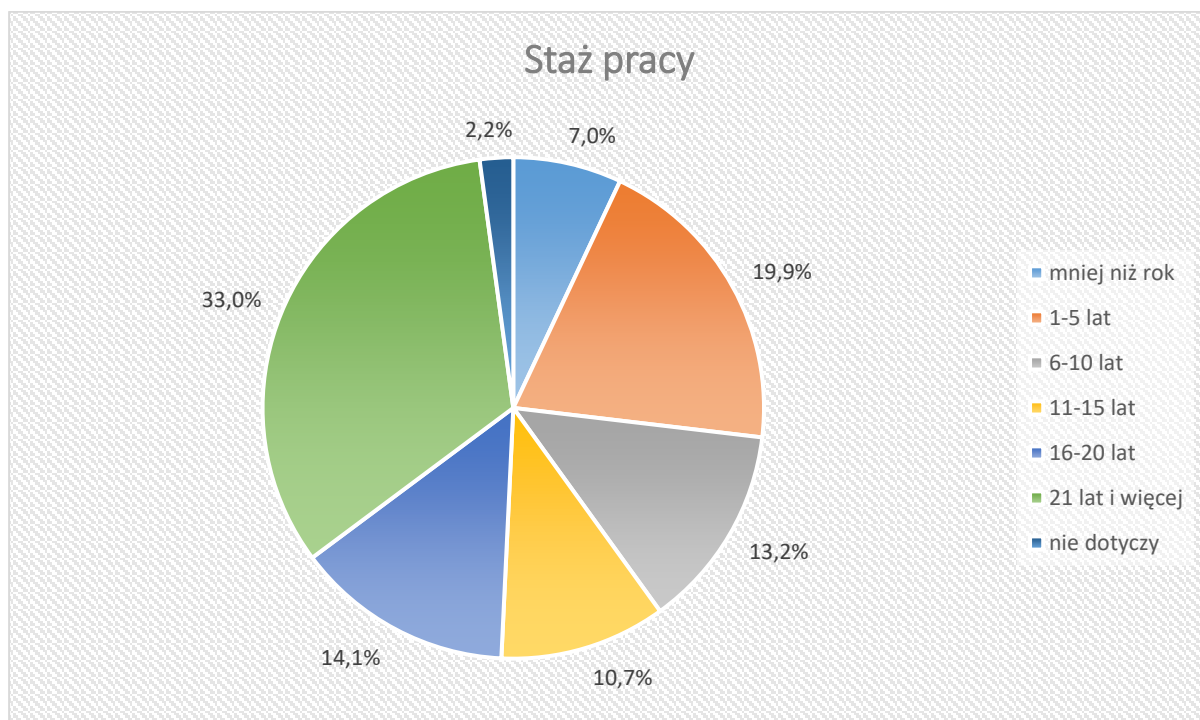
Tabela przedstawia strukturę zawodową uczestników otwartych webinarów realizowanych w ramach programu Wsparająca Szkoła, na podstawie danych z preankiety wypełnianej podczas rejestracji. Łącznie analizą objęto 2370 odpowiedzi.

Najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele – 52,1% (1235 osób). Kolejnymi grupami byli pedagodzy – 19,6% (464 osoby) oraz psychologowie – 18,9% (449 osób). Funkcję dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełniło 2,8% respondentów (67 osób), natomiast pielęgniarki szkolne stanowiły 0,3% badanej grupy (6 osób).

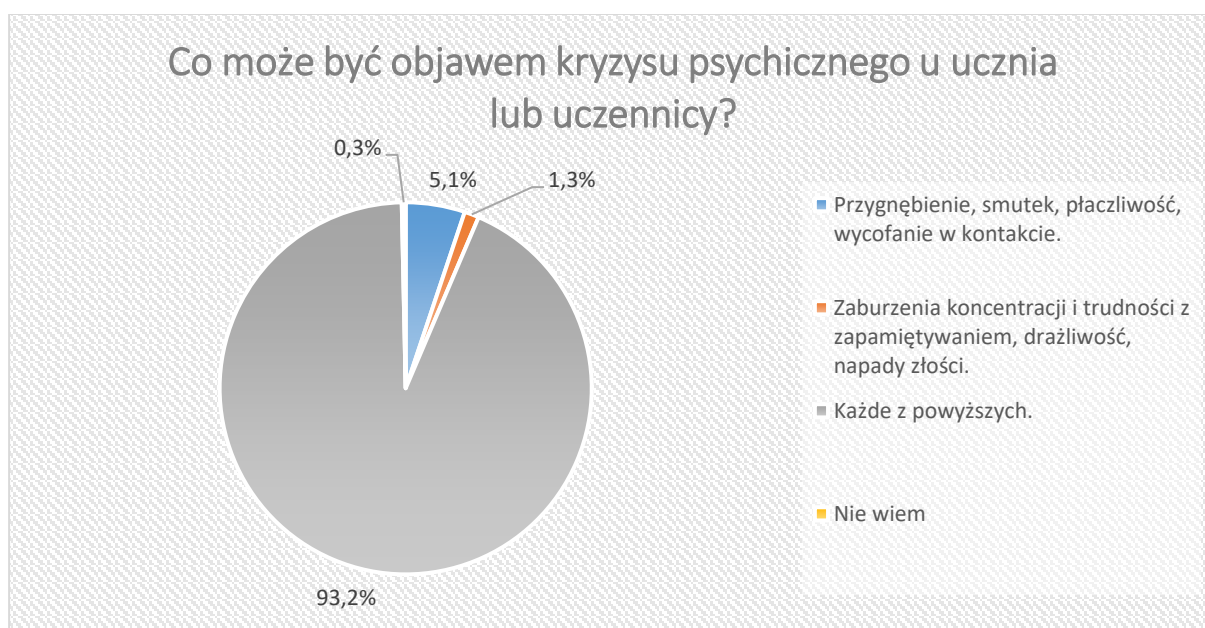
Kategoria „Inne” obejmowała łącznie 6,3% uczestników (149 osób) i skupiała osoby wykonujące zawody lub pełniące role inne niż wskazane powyżej. Wśród nich znaleźli się m.in.: studenci i studentki (psychologii, pedagogiki oraz kierunków pokrewnych), rodzice, wychowawcy (burs, internatów, grup wychowawczych), logopedzi, bibliotekarze szkolni, pracownicy administracyjni i obsługi, asystenci rodziny, koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, terapeuci (m.in. psychoterapeuci, socjoterapeuci, rewalidatorzy), przedstawiciele innych zawodów wspierających dzieci, młodzież i rodziny (np. lekarz, ratownik medyczny, asystent międzykulturowy). Kategoria „Inne”



ma charakter zbiorczy i obejmuje zróżnicowane role zawodowe oraz społeczne, których liczebność jednostkowa była zbyt mała, aby uzasadniać ich wyodrębnienie jako osobnych kategorii w tabeli.

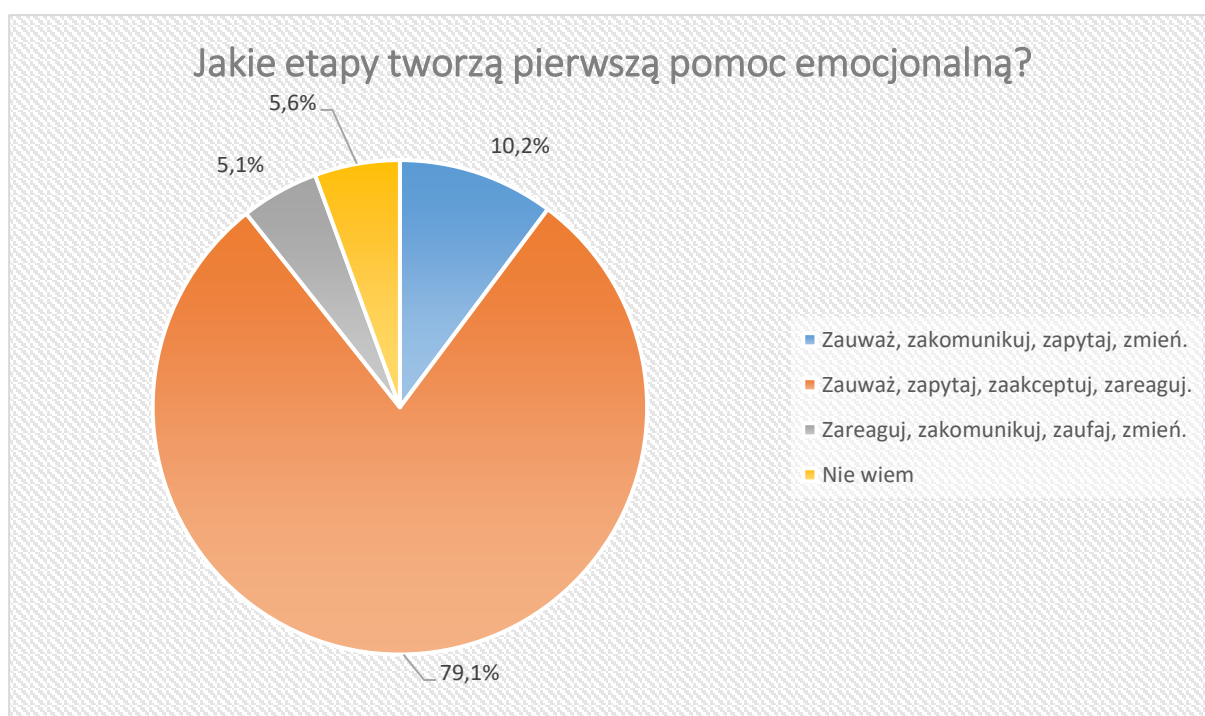


Z danych z wykresu wynika, że największą grupę stanowili uczestnicy z najdłuższym stażem pracy – 21 lat i więcej, którzy stanowili 33,0% badanych (783 osoby). Znaczący odsetek respondentów posiadał również staż od 1 do 5 lat – 19,9% (471 osób) oraz od 16 do 20 lat – 14,1% (333 osoby). Osoby ze stażem 6–10 lat stanowiły 13,2% uczestników (312 osób), natomiast ze stażem 11–15 lat – 10,7% (254 osoby). Najmniej liczną grupą były osoby z doświadczeniem zawodowym krótszym niż rok – 7,0% (166 osób). Kategorię „nie dotyczy” wskazało 2,2% respondentów (51 osób). Rozkład stażu pracy wskazuje, że w webinarach uczestniczyły zarówno osoby rozpoczynające swoją drogę zawodową, jak i bardzo doświadczeni pracownicy oświaty oraz specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą, co potwierdza szeroki i zróżnicowany odbiór działań edukacyjnych programu.





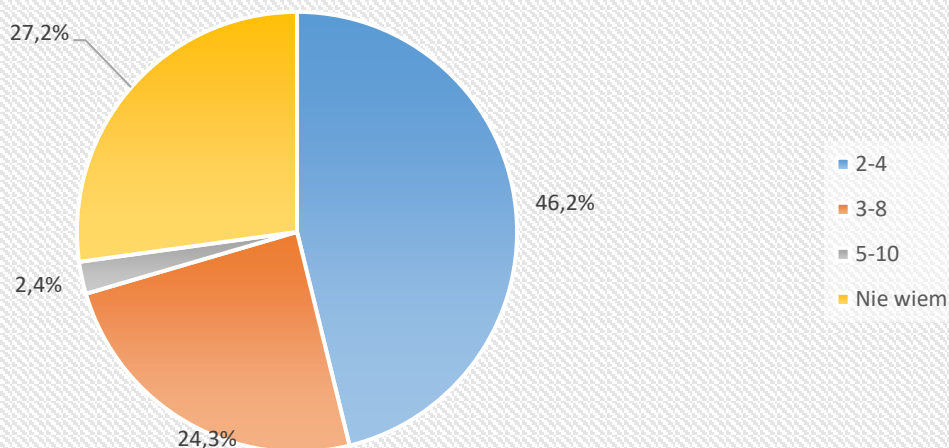
Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników webinarów na pytanie sprawdzające wiedzę: „Co może być objawem kryzysu psychicznego u ucznia lub uczennicy?”. Poprawną odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź „Każde z powyższych”, wskazująca, że kryzys psychiczny u dziecka lub nastolatka może przejawiać się zarówno obniżonym nastrojem, smutkiem, płaczliwością i wycofaniem w relacjach, jak i trudnościami w koncentracji, drażliwością czy napadami złości. Zdecydowana większość respondentów – 93,2% (2210 osób) – udzieliła poprawnej odpowiedzi. Odpowiedzi częściowe wskazało 5,1% uczestników (122 osoby), 1,3% (30 osób) wybrało inną niepełną odpowiedź, natomiast 0,3% respondentów (8 osób) zadeklarowało brak wiedzy („Nie wiem”). Uzyskane wyniki świadczą o wysokim poziomie wstępnej świadomości uczestników w zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego u uczniów, przy jednoczesnym istnieniu niewielkiej grupy osób wymagających dalszego wsparcia edukacyjnego w tym obszarze.



Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników webinarów na pytanie sprawdzające wiedzę: „Jakie etapy tworzą pierwszą pomoc emocjonalną?”, zadane w preankiecie wypełnianej podczas rejestracji na wydarzenie. Poprawną odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź „Zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj”, odpowiadająca zasadzie 4 × Z, omawianej podczas webinaru. Prawidłową odpowiedź wskazało 79,1% respondentów (1875 osób). Pozostali uczestnicy wybierali odpowiedzi niepełne lub nieprawidłowe: 10,2% (242 osoby) zaznaczyło sekwencję „Zauważ, zakomunikuj, zapytaj, zmień”, 5,1% (121 osób) – „Zareaguj, zakomunikuj, zaufaj, zmień”, natomiast 5,6% badanych (132 osoby) zadeklarowało brak wiedzy („Nie wiem”). Uzyskane wyniki wskazują na stosunkowo wysoki poziom wstępnej znajomości zasad pierwszej pomocy emocjonalnej wśród uczestników, przy jednoczesnej potrzebie dalszego wzmocnienia wiedzy w zakresie prawidłowej sekwencji działań.

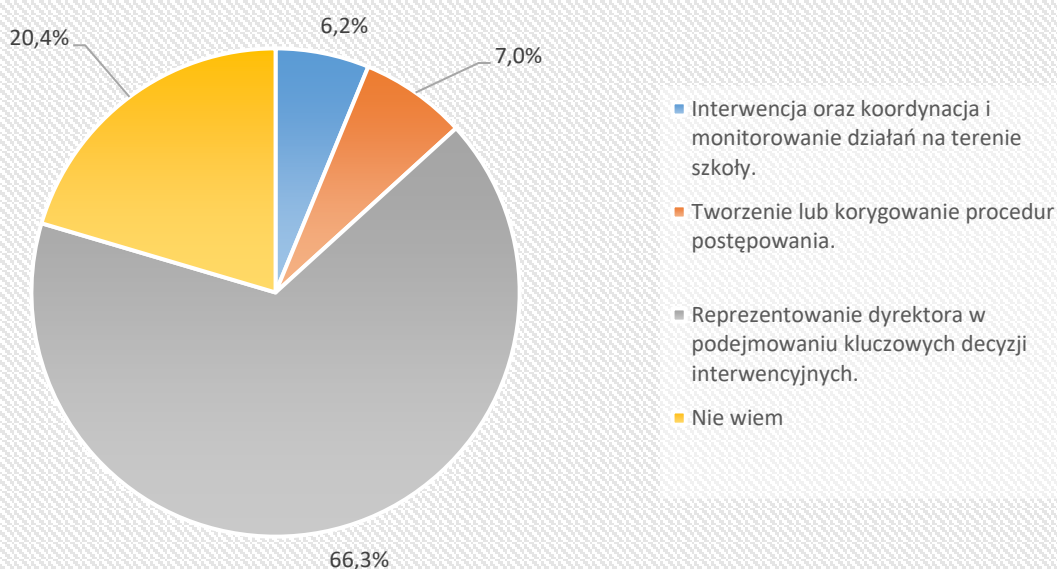


Ile osób powinno wchodzić w skład zespołu kryzysowego?



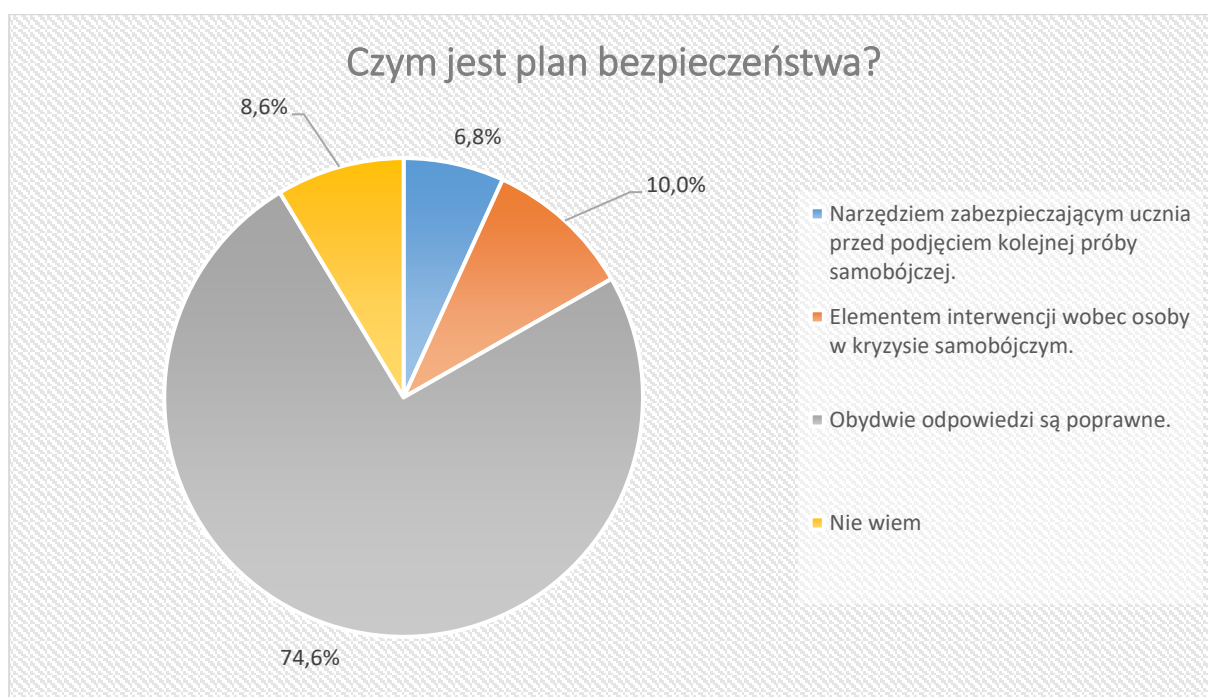
Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników webinarów na pytanie sprawdzające wiedzę: „Ile osób powinno wchodzić w skład zespołu kryzysowego?”, zadane w preankiecie wypełnianej podczas rejestracji na wydarzenie. Poprawną odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź „3–8 osób”. Prawidłową odpowiedź wskazało 24,3% respondentów (576 osób). Największa grupa uczestników – 46,2% (1094 osoby) – błędnie uznała, że zespół kryzysowy powinien liczyć 2–4 osoby, natomiast 2,4% badanych (56 osób) wskazało przedział 5–10 osób. Brak wiedzy w tym zakresie zadeklarowało 27,2% respondentów (644 osoby), wybierając odpowiedź „Nie wiem”. Uzyskane wyniki wskazują na istotne rozbieżności w zakresie wiedzy dotyczącej organizacji zespołu kryzysowego w szkołach, co potwierdza zasadność podejmowania działań edukacyjnych poświęconych zasadom jego prawidłowego składu i funkcjonowania.

Co nie jest rolą zespołu kryzysowego w szkole?





Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników webinarów na pytanie sprawdzające wiedzę: „Co nie jest rolą zespołu kryzysowego w szkole?”, zadane w preankiecie wypełnianej podczas rejestracji na wydarzenie. Poprawną odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź „Reprezentowanie dyrektora w podejmowaniu kluczowych decyzji interwencyjnych”, gdyż odpowiedzialność za podejmowanie kluczowych decyzji w sytuacjach kryzysowych spoczywa na dyrektorze szkoły, a zespół kryzysowy pełni wobec niego funkcję doradczą, koordynacyjną i wykonawczą. Prawidłową odpowiedź wskazało 66,3% respondentów (1572 osoby). Pozostali uczestnicy wybierali odpowiedzi nieprawidłowe: 7,0% (167 osób) uznało, że zespół kryzysowy nie odpowiada za tworzenie lub korygowanie procedur postępowania, natomiast 6,2% (147 osób) wskazało, że jego rolą nie jest interwencja, koordynacja i monitorowanie działań na terenie szkoły. Brak wiedzy w tym zakresie zadeklarowało 20,4% badanych (484 osoby), wybierając odpowiedź „Nie wiem”. Uzyskane wyniki wskazują, że większość uczestników posiada podstawową wiedzę na temat kompetencji zespołu kryzysowego w szkole, jednak istotny odsetek respondentów wymaga dalszego wsparcia edukacyjnego w zakresie podziału ról i odpowiedzialności w sytuacjach kryzysowych.



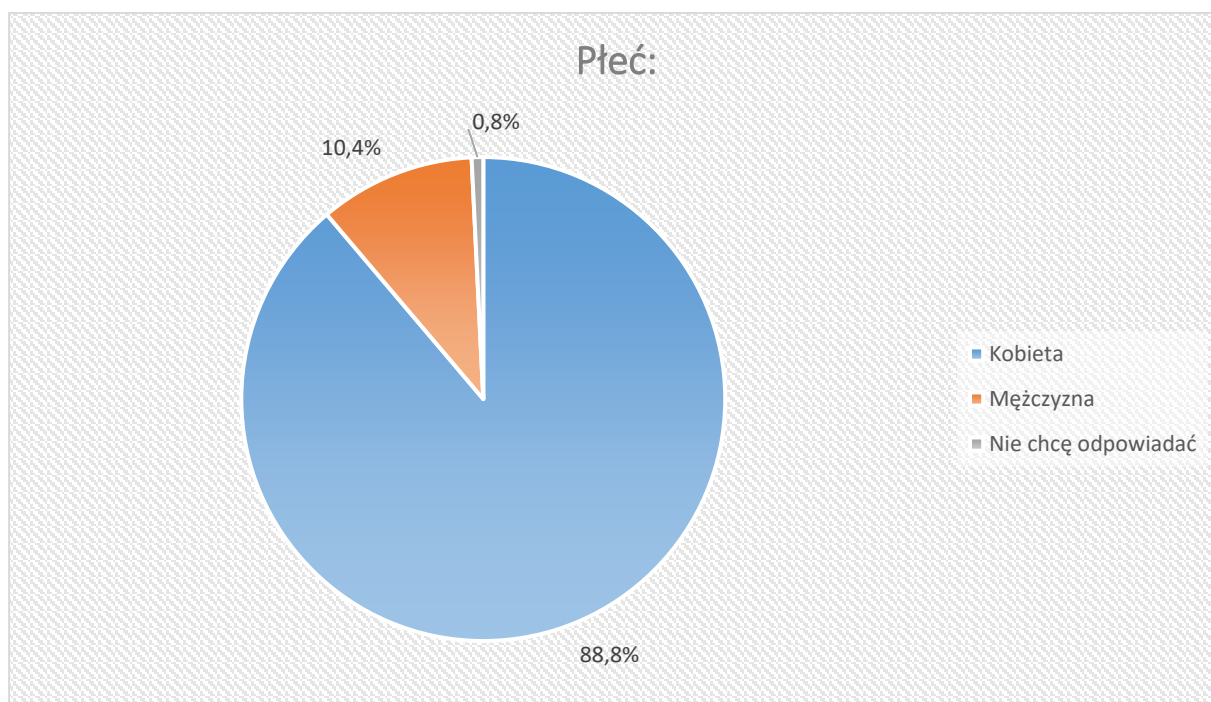
Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników webinarów na pytanie sprawdzające wiedzę: „Czym jest plan bezpieczeństwa?”, zadane w preankiecie wypełnianej podczas rejestracji na wydarzenie. Poprawną odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź „Elementem interwencyjnym wobec osoby w kryzysie samobójczym”. Prawidłową odpowiedź wskazało 74,6% respondentów (1768 osób). Pozostali uczestnicy wybierali odpowiedzi nieprawidłowe lub niepełne: 6,8% (161 osób) uznało, że plan bezpieczeństwa jest narzędziem zabezpieczającym ucznia przed podjęciem kolejnej próby samobójczej, 10,0% (236 osób) wskazało odpowiedź częściową, traktując plan bezpieczeństwa jako jedynie element interwencji, natomiast 8,6% badanych (205 osób) zadeklarowało brak wiedzy w tym zakresie („Nie wiem”). Uzyskane wyniki wskazują, że większość uczestników prawidłowo rozumie rolę planu bezpieczeństwa w pracy z osobą w kryzysie samobójczym, jednak część respondentów wymaga dalszego doprecyzowania różnicy pomiędzy działaniami interwencyjnymi a długofalowym zabezpieczeniem i wsparciem ucznia.



Ankieta sprawdzająca wiedzę po otwartym webinarze dla pracowników szkół

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę po webinarze pt. „Pierwsza pomoc emocjonalna: jak rozpoznać kryzys samobójczy u ucznia i jak powołać zespół kryzysowy w szkole?” zawierał: metryczkę składającą się z 4 pytań. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły po realizacji webinaru.

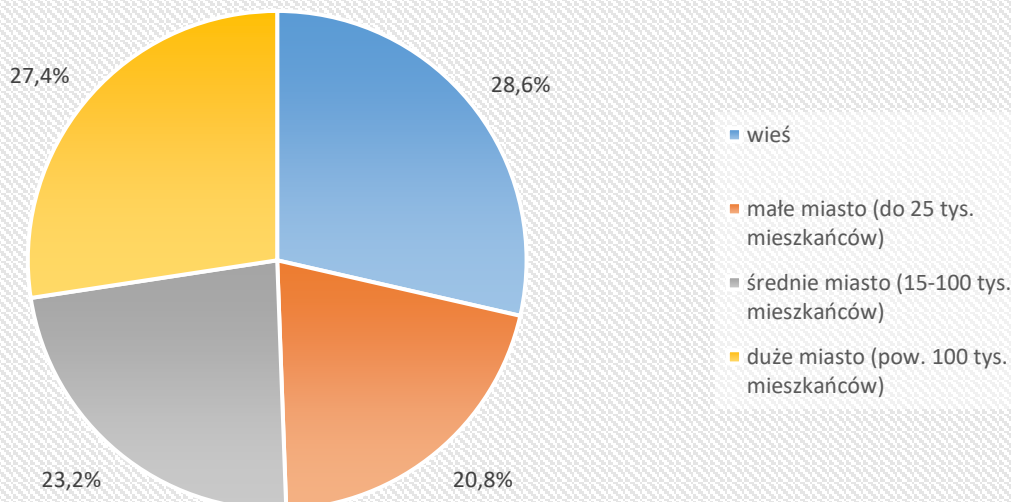
Postankieta została wypełniona przez 259 osób, co w porównaniu do preankiety (2370 osób) świadczy o znacznym spadku liczby respondentów. Należy jednak podkreślić, że udział w webinarach miał charakter dobrowolny, podobnie jak udział w badaniu ewaluacyjnym, co mogło wpływać na mniejszą gotowość części uczestników do podejmowania dalszych działań po zakończeniu spotkania. Dodatkowo webinary odbywały się w godzinach wieczornych (19:00–20:30), co mogło skutkować wcześniejszym opuszczaniem spotkania przez część uczestników, a tym samym brakiem wypełnienia ankiety sprawdzającej wiedzę po webinarze.



Porównanie danych zebranych w ankiecie przed szkoleniem oraz po jego zakończeniu pokazuje, że w obu pomiarach dominującą grupę respondentów stanowiły kobiety. W ankiecie wypełnianej po szkoleniu udział wzięło 259 osób. W tej grupie kobiety stanowiły 88,8% respondentów (230 osób), a mężczyźni 10,4% (27 osób). Odpowiedź „nie chcę odpowiadać” wybrało 0,8% badanych (2 osoby). W badaniu poprzedzającym szkolenie, w którym udział wzięło 2370 osób, kobiety stanowiły 93,1% uczestników (2206 osób), natomiast mężczyźni 6,5% (153 osoby). Niewielki odsetek respondentów (0,5%; 11 osób) nie zadeklarował swojej płci.



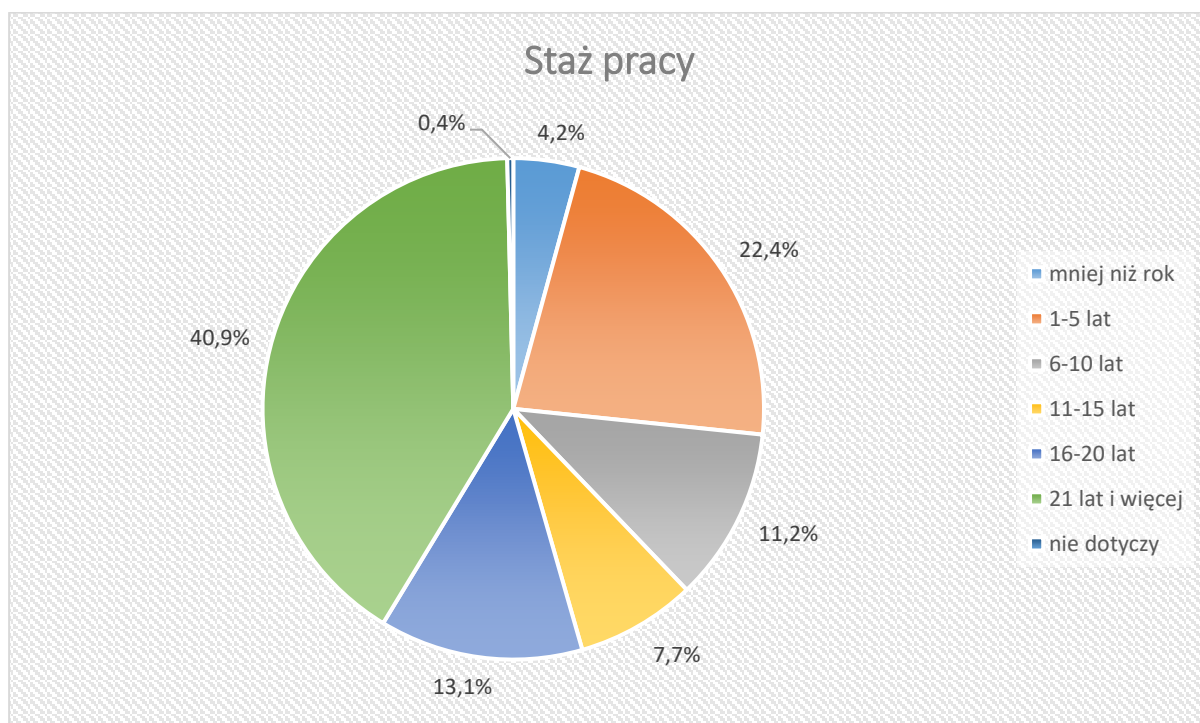
Wielkość miejscowości:



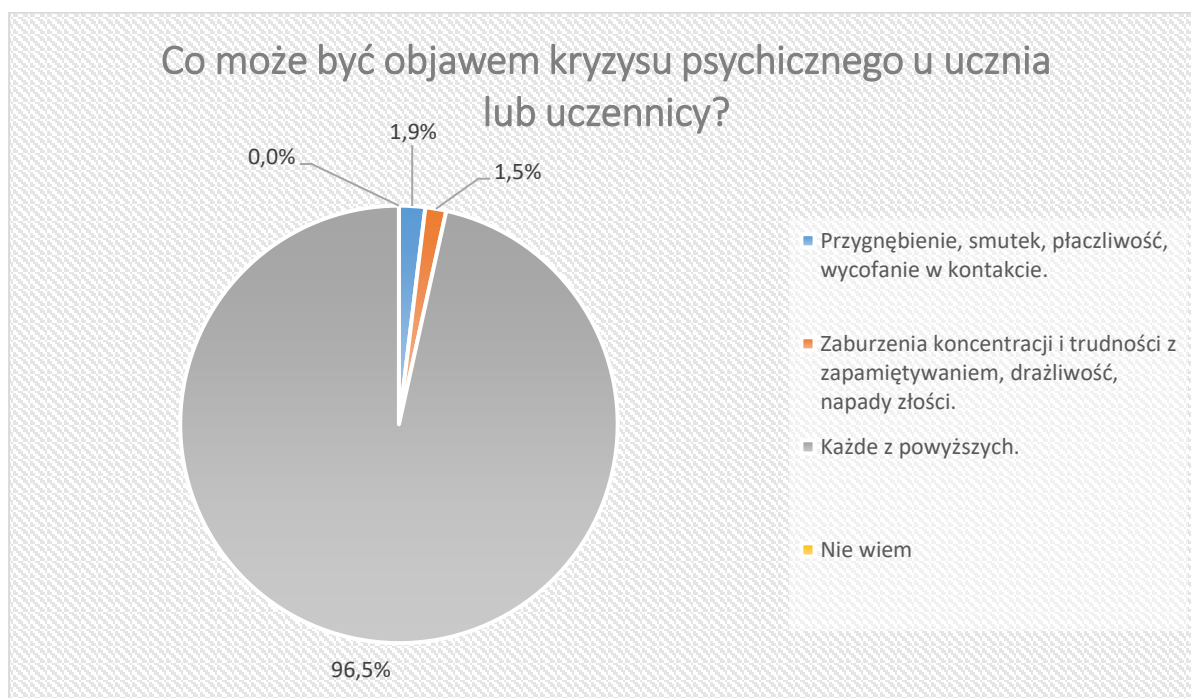
Wyniki postankiety sprawdzającej wiedzę po szkoleniu pokazują, że respondenci reprezentowali zróżnicowane typy miejscowości zamieszkania. Ankietę końcową wypełniło 259 osób, przy czym największy odsetek stanowili uczestnicy mieszkający na wsi – 28,6% (74 osoby) oraz w dużych miastach powyżej 100 tys. mieszkańców – 27,4% (71 osób). Osoby zamieszkujące średnie miasta (15–100 tys. mieszkańców) stanowiły 23,2% respondentów (60 osób), natomiast małe miasta do 25 tys. mieszkańców – 20,8% (54 osoby). Struktura respondentów w postankiecie jest zbliżona do rozkładu obserwowanego w badaniu wstępnym, w którym uczestniczyło więcej osób (2370 respondentów), jednak widoczne są niewielkie różnice w udziałach procentowych poszczególnych kategorii. W szczególności w postankiecie zaznacza się relatywnie wyższy udział osób mieszkających na wsi, przy jednoczesnym nieco mniejszym udziale respondentów z dużych miast. Zaobserwowane różnice należy interpretować w kontekście znacznie mniejszej liczebności próby w badaniu końcowym oraz dobrowolnego charakteru udziału w postankie końcowej. Nie wskazują one na istotne zmiany w profilu uczestników szkolenia, lecz raczej odzwierciedlają selektywny udział osób, które zdecydowały się na wypełnienie ankiety po zakończeniu szkolenia.

l.p.	Jestem	Liczba osób	Procent [%]
1	Nauczycielem	131	50,6
2	Pedagogiem	58	22,4
3	Psychologiem	49	18,9
4	Dyrektorem/wicedyrektorem	9	3,5
5	Inne	12	4,6

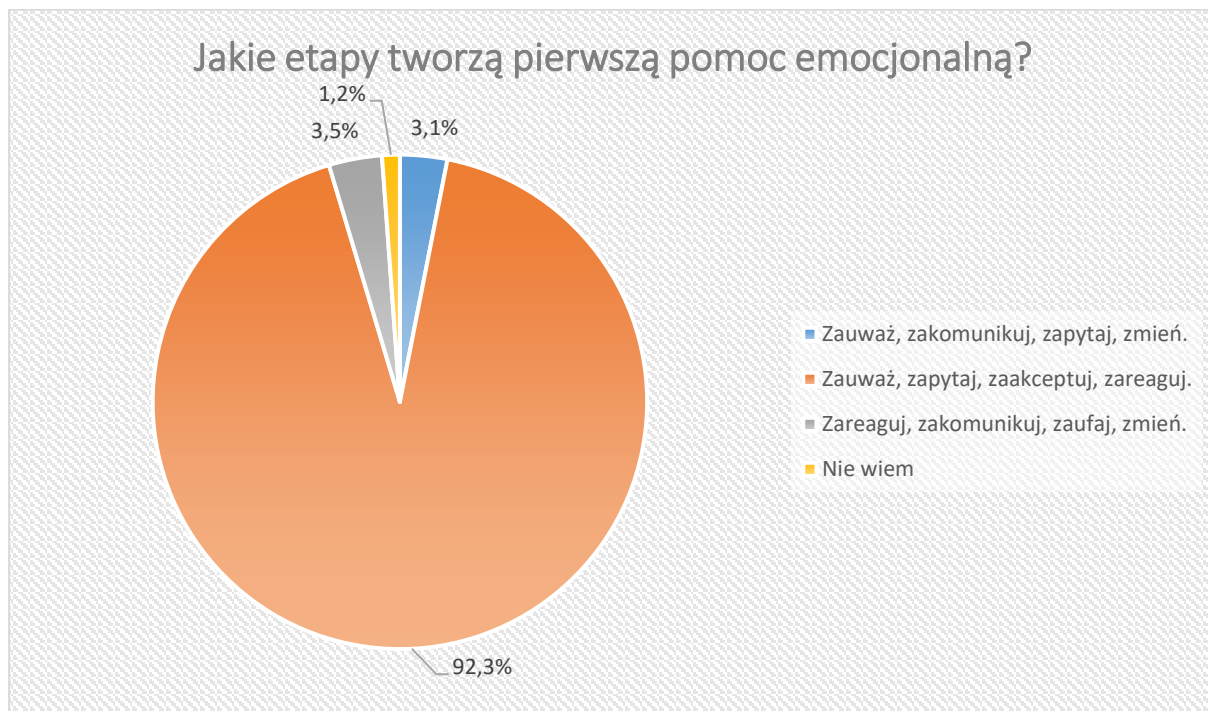
Struktura respondentów postankiety sprawdzającej wiedzę po szkoleniu wskazuje, że w badaniu końcowym uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele zawodów bezpośrednio związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą. Najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele, którzy odpowiadali za 50,6% respondentów (131 osób). Istotny udział miały również osoby pełniące funkcję pedagogów szkolnych – 22,4% (58 osób) oraz psychologów – 18,9% (49 osób). Kadre zarządzającą szkołami, tj. dyrektorów i wicedyrektorów, reprezentowało 3,5% badanych (9 osób). Kategoria „Inne”, obejmująca m.in. studentów, rodziców, wychowawców, logopedów, bibliotekarzy oraz pracowników socjalnych i administracyjnych, stanowiła 4,6% respondentów (12 osób). Porównanie struktury zawodowej postankiety z danymi zebranymi w preankiecie wskazuje na zachowanie podobnego profilu uczestników, mimo wyraźnie mniejszej liczebności próby w badaniu końcowym. W obu pomiarach dominowali nauczyciele oraz specjaliści pracujący bezpośrednio z uczniami, co pozwala uznać, że postankieta została wypełniona przez grupę odpowiadającą kluczowej grupie docelowej szkolenia.



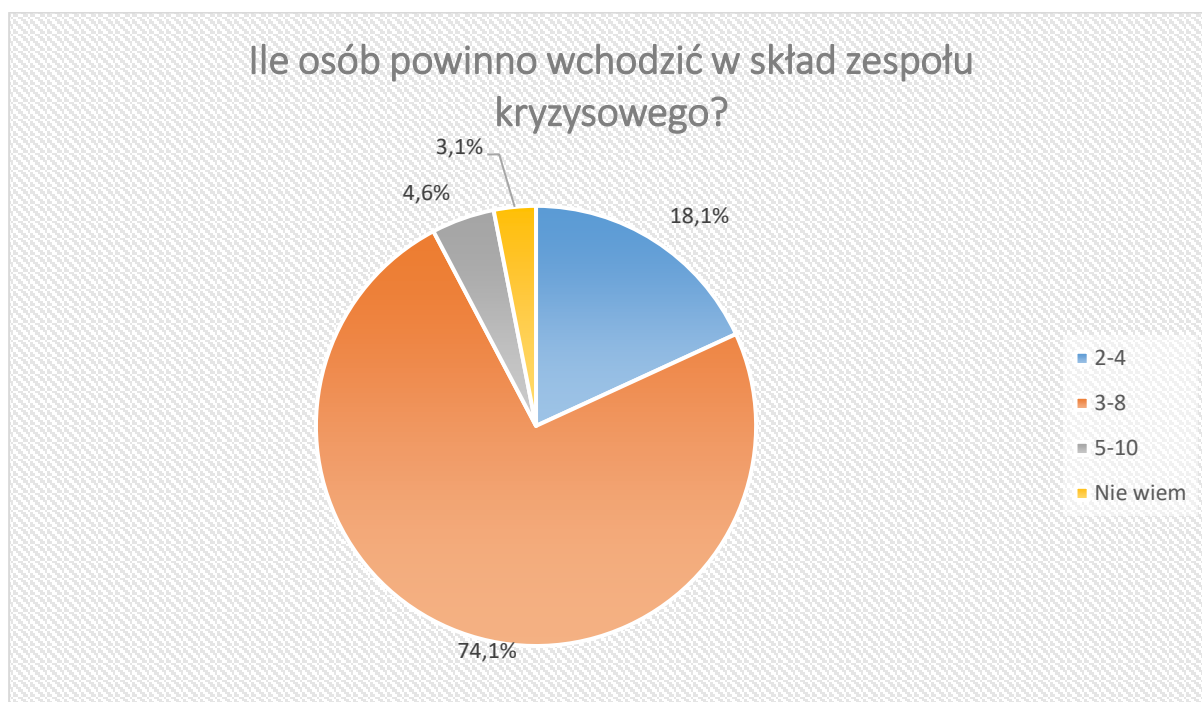
Wyniki postankiety sprawdzającej wiedzę po szkoleniu, wypełnionej przez 259 osób, wskazują, że w badaniu końcowym dominowali respondenci z najdłuższym stażem pracy (21 lat i więcej), którzy stanowili 40,9% badanych (106 osób). Istotny udział miały również osoby ze stażem 1–5 lat – 22,4% (58 osób). Respondenci z doświadczeniem zawodowym 16–20 lat stanowili 13,1% (34 osoby), natomiast ze stażem 6–10 lat – 11,2% (29 osób). Mniejsze grupy tworzyły osoby ze stażem 11–15 lat – 7,7% (20 osób) oraz z doświadczeniem krótszym niż rok – 4,2% (11 osób). Odpowiedź „nie dotyczy” wskazała 0,4% respondentów (1 osoba). Dla porównania, w preankiecie sprawdzającej wiedzę przed szkoleniem, wypełnionej przez 2370 osób, również największą grupę stanowili respondenci z najdłuższym stażem pracy (21 lat i więcej) – 33,0% badanych (783 osoby). Kolejne grupy to osoby ze stażem 1–5 lat – 19,9% (471 osób) oraz 16–20 lat – 14,1% (333 osoby). Respondenci ze stażem 6–10 lat stanowili 13,2% (312 osób), a ze stażem 11–15 lat – 10,7% (254 osoby). Osoby z doświadczeniem zawodowym krótszym niż rok stanowiły 7,0% badanych (166 osób), natomiast odpowiedź „nie dotyczy” wskazało 2,2% respondentów (51 osób). Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje, że w postanekiecie relatywnie wzrósł udział osób z bardzo długim stażem pracy, przy jednoczesnym spadku odsetka respondentów z najkrótszym doświadczeniem zawodowym. Różnice te należy interpretować przede wszystkim w kontekście znacznie mniejszej liczebności próby w badaniu końcowym oraz dobrowolnego charakteru udziału w postanekiecie, co mogło sprzyjać większemu zaangażowaniu osób o dłuższym doświadczeniu zawodowym.



W postankiecie sprawdzającej wiedzę po szkoleniu, wypełnionej przez 259 osób, poprawną odpowiedź na pytanie „Co może być objawem kryzysu psychicznego u ucznia lub uczennicy?” – „Każde z powyższych” – wskazało 96,5% respondentów (250 osób). Odpowiedzi błędne udzieliło łącznie 3,5% badanych (9 osób), w tym 1,9% (5 osób) wskazało wyłącznie objawy obniżonego nastroju i wycofania, a 1,5% (4 osoby) – trudności w koncentracji i drażliwość. Żaden z respondentów nie zaznaczył odpowiedzi „Nie wiem”. Dla porównania, w preankiecie sprawdzającej wiedzę przed szkoleniem, wypełnionej przez 2370 osób, poprawną odpowiedź wskazało 93,2% respondentów (2210 osób). Odpowiedzi częściowe lub błędne zaznaczyło łącznie 6,8% badanych (160 osób), w tym 5,1% (122 osoby) oraz 1,3% (30 osób), natomiast 0,3% respondentów (8 osób) deklarowało brak wiedzy, wybierając odpowiedź „Nie wiem”. Porównanie obu pomiarów wskazuje, że odsetek poprawnych odpowiedzi w postankiecie był wyższy o 3,3 punktu procentowego w porównaniu z preankietą (wzrost z 93,2% do 96,5%). Jednocześnie nastąpiła redukcja łącznego odsetka odpowiedzi błędnych i niepełnych o 3,3 punktu procentowego – z 6,8% przed szkoleniem do 3,5% po szkoleniu – oraz całkowite wyeliminowanie odpowiedzi „Nie wiem” w badaniu końcowym. Uzyskane wyniki świadczą o wzmocnieniu i ugruntowaniu wiedzy uczestników w zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego u dzieci i młodzieży. Przy interpretacji danych należy uwzględnić mniejszą liczebność próby w postankiecie oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu końcowym, które mogły sprzyjać wyższemu poziomowi uzyskiwanych wyników, jednak kierunek i spójność zmian pozostają jednoznacznie pozytywne.



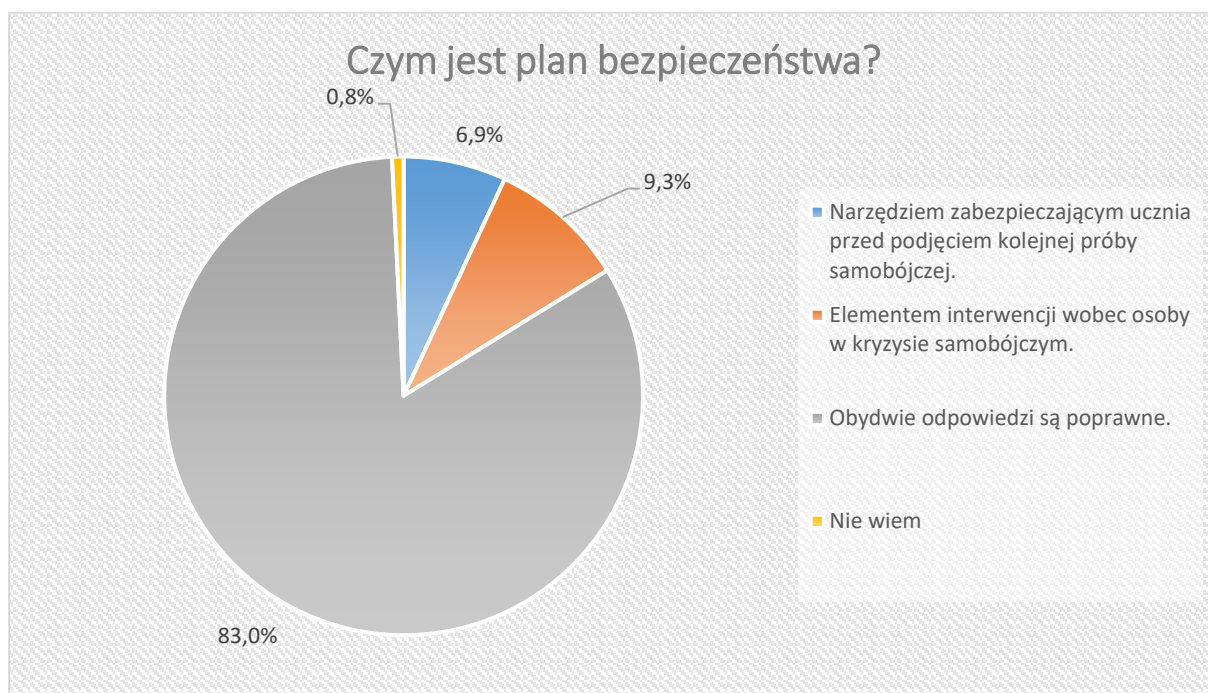
W postankiecie sprawdzającej wiedzę po szkoleniu poprawną odpowiedź („Zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj”) wskazało 92,3% respondentów (239 osób). Odpowiedzi błędne lub deklarację braku wiedzy zaznaczyło łącznie 7,7% badanych (20 osób). Dla porównania, w preankiecie sprawdzającej wiedzę przed szkoleniem poprawnej odpowiedzi udzieliło 79,1% respondentów (1875 osób), natomiast 20,9% badanych (495 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Porównanie obu pomiarów wskazuje, że odsetek poprawnych odpowiedzi w postankiecie był wyższy o 13,2 punktu procentowego w stosunku do wyniku uzyskanego przed szkoleniem. Jednocześnie nastąpił spadek odsetka odpowiedzi błędnych o 13,2 punktu procentowego – z 20,9% w preankiecie do 7,7% w postankiecie. Uzyskane wyniki świadczą o wyraźnym wzroście poziomu wiedzy uczestników w zakresie etapów pierwszej pomocy emocjonalnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnej liczebności prób badawczych oraz dobrowolnego charakteru udziału w badaniu końcowym.



W postankiecie sprawdzającej wiedzę po szkoleniu, wypełnionej przez 259 osób, poprawną odpowiedź na pytanie „Ile osób powinno wchodzić w skład zespołu kryzysowego?” – „3–8 osób” – wskazało 74,1% respondentów (192 osoby). Odpowiedzi błędne lub deklarację braku wiedzy zaznaczyło łącznie 25,9% badanych (67 osób). Dla porównania, w preankiecie sprawdzającej wiedzę przed szkoleniem, wypełnionej przez 2370 osób, poprawną odpowiedź „3–8” wskazało 24,3% respondentów (576 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklaracji braku wiedzy udzieliło łącznie 75,7% badanych (1794 osoby). Porównanie obu pomiarów wskazuje na bardzo wyraźny wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi w postankiecie – o 49,8 punktu procentowego (z 24,3% do 74,1%). Jednocześnie nastąpiła istotna redukcja łącznego odsetka odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy – z 75,7% w preankiecie do 25,9% w postankiecie, co oznacza spadek o 49,8 punktu procentowego. Szczególnie istotna jest redukcja odpowiedzi „Nie wiem” – z 27,2% przed szkoleniem do 3,1% po szkoleniu, co świadczy o znacznym uzupełnieniu wiedzy uczestników w zakresie zasad organizacji zespołu kryzysowego w szkole. Pomimo mniejszej liczby próby w postankiecie oraz jej dobrowolnego charakteru, skala zaobserwowanej zmiany jednoznacznie wskazuje na wysoką skuteczność przekazu szkoleniowego w tym obszarze.



W postankiecie sprawdzającej wiedzę po szkoleniu, wypełnionej przez 259 osób, poprawną odpowiedź na pytanie „Co nie jest rolą zespołu kryzysowego w szkole?” – „Reprezentowanie dyrektora w podejmowaniu kluczowych decyzji interwencyjnych” – wskazało 89,6% respondentów (232 osoby). Odpowiedzi błędne lub deklarację braku wiedzy zaznaczyło łącznie 10,4% badanych (27 osób). Dla porównania, w preankiecie sprawdzającej wiedzę przed szkoleniem, wypełnionej przez 2370 osób, poprawną odpowiedź wskazało 66,3% respondentów (1572 osoby). Odpowiedzi błędnych lub deklaracji braku wiedzy udzieliło łącznie 33,7% badanych (798 osób). Porównanie obu pomiarów wskazuje na wyraźny wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi w postankiecie – o 23,3 punktu procentowego (z 66,3% przed szkoleniem do 89,6% po szkoleniu). Jednocześnie nastąpiła redukcja łącznego odsetka odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy – z 33,7% do 10,4%, co oznacza spadek o 23,3 punktu procentowego. Szczególnie istotna jest znaczna redukcja odpowiedzi „Nie wiem” – z 20,4% w preankiecie do 2,7% w postankiecie, co świadczy o wyraźnym uporządkowaniu wiedzy uczestników w zakresie rzeczywistych kompetencji zespołu kryzysowego w szkole. Pomimo mniejszej liczby próby w badaniu końcowym oraz jego dobrowolnego charakteru, skala zaobserwowanych zmian jednoznacznie wskazuje na wysoką skuteczność szkolenia w tym obszarze wiedzy.



W postankiecie sprawdzającej wiedzę po szkoleniu, wypełnionej przez 259 osób, poprawną odpowiedź na pytanie „Czym jest plan bezpieczeństwa?” – „Elementem interwencji wobec osoby w kryzysie samobójczym” – wskazało 83,0% respondentów (215 osób). Odpowiedzi błędne lub deklarację braku wiedzy zaznaczyło łącznie 17,0% badanych (44 osoby). Dla porównania, w preankiecie sprawdzającej wiedzę przed szkoleniem, wypełnionej przez 2370 osób, poprawną odpowiedź wskazało 74,6% respondentów (1768 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklaracji braku wiedzy udzieliło łącznie 25,4% badanych (602 osoby). Porównanie obu pomiarów wskazuje na wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi w postankiecie o 8,4 punktu procentowego (z 74,6% przed szkoleniem do 83,0% po szkoleniu). Jednocześnie nastąpiła redukcja łącznego odsetka odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy o 8,4 punktu procentowego – z 25,4% w preankiecie do 17,0% w postankiecie. Szczególnie istotna jest znaczna redukcja odpowiedzi „Nie wiem” – z 8,6% przed szkoleniem do 0,8% po szkoleniu, co świadczy o lepszym uporządkowaniu wiedzy uczestników na temat roli i znaczenia planu bezpieczeństwa w pracy z osobą w kryzysie samobójczym. Pomimo mniejszej liczebności próby w badaniu końcowym oraz jego dobrowolnego charakteru, zaobserwowany kierunek zmian jednoznacznie wskazuje na pozytywny efekt edukacyjny szkolenia w tym obszarze.

Podsumowanie

Webinar „Pierwsza pomoc emocjonalna: jak rozpoznać kryzys samobójczy u ucznia i jak powołać zespół kryzysowy w szkole” był elementem programu Wsparająca Szkoła i miał na celu wzmocnienie kompetencji pracowników szkół w zakresie wczesnego rozpoznawania kryzysu samobójczego u dzieci i młodzieży oraz podejmowania adekwatnych działań interwencyjnych na poziomie placówki. W sześciu otwartych webinarach wzięło udział łącznie 1401 osób, reprezentujących różne role zawodowe w środowisku szkolnym.

Analiza wyników ankiet sprawdzających wiedzę przed i po szkoleniu wskazuje na wyraźny wzrost poziomu wiedzy uczestników w kluczowych obszarach poruszanych podczas webinaru. Największą poprawę odnotowano w zakresie znajomości etapów pierwszej pomocy emocjonalnej, zasad powoływania i funkcjonowania zespołu kryzysowego w szkole, a także rozumienia roli zespołu kryzysowego i planu bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia samobójczego. W każdym z tych obszarów nastąpił istotny wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi w postankiecie oraz znaczący spadek liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy.

Szczególnie istotne jest ograniczenie odpowiedzi typu „Nie wiem” w badaniu końcowym, co świadczy nie tylko o zwiększeniu zasobu wiedzy, ale także o większej pewności uczestników w podejmowaniu decyzji i działań interwencyjnych. Pomimo że postankieta została wypełniona przez mniejszą, dobrowolnie uczestniczącą grupę respondentów, a webinar odbywał się w godzinach wieczornych (19:00–20:30), co mogło wpływać na frekwencję w badaniu końcowym, kierunek i skala zaobserwowanych zmian pozostają jednoznacznie pozytywne.



Wspierająca Szkoła

Uzyskane wyniki potwierdzają, że webinar skutecznie przyczynił się do uporządkowania, pogłębienia i ugruntowania wiedzy pracowników szkół w zakresie pierwszej pomocy emocjonalnej oraz systemowego reagowania na sytuacje kryzysowe związane z ryzykiem samobójczym uczniów. Szkolenie odpowiadało na realne potrzeby środowiska oświatowego i stanowiło istotny element budowania gotowości szkół do podejmowania odpowiedzialnych, skoordynowanych działań w sytuacjach kryzysowych.

PROGRAM



**Wspierająca
Szkoła**
FUNDACJA ADAMED

WSPÓLFINANSOWANIE



Ministerstwo
Edukacji Narodowej

Zadanie dofinansowane z budżetu Państwa ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

REALIZATOR



życie warte
jest rozmowy

WSPÓLORGANIZATOR





„Jak rozpoznać kryzys emocjonalny u nastolatka i jak zareagować?” – spotkanie edukacyjne dla rodziców

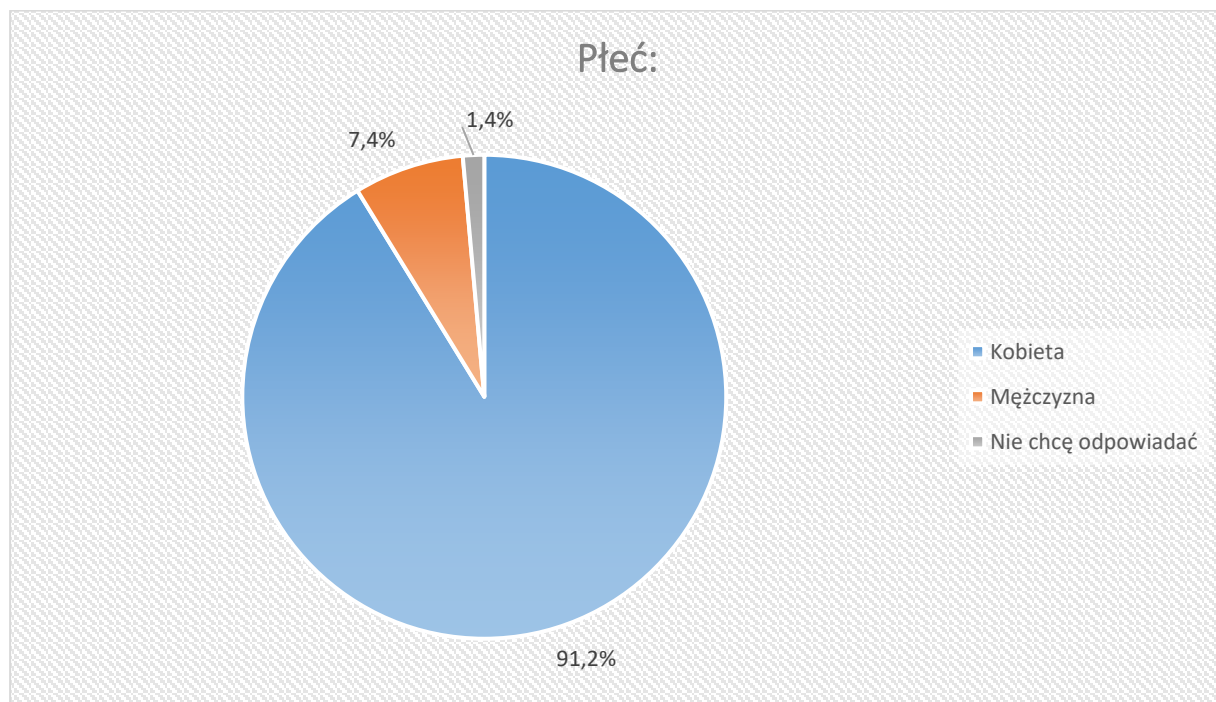
Celem spotkania edukacyjnego dla rodziców było poszerzenie ich wiedzy na temat przebiegu kryzysu emocjonalnego u dzieci i nastolatków. Udział w spotkaniu stwarzał możliwość zrozumienia tego, co dzieje się z młodą osobą przeżywającą trudności oraz znalezienia odpowiedzi na pytania, które nurtują dorosłych. Rodzice otrzymali również informacje na temat różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami dziecka i możliwych form wsparcia go, a także uzyskania pomocy dla siebie.

Odbyło się łącznie 15 spotkań edukacyjnych dla rodziców i opiekunów, w których wzięły udział 584 osoby. Spotkania te były organizowane dla rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do szkół, które dostały się do II edycji programu Wsparająca Szkoła.

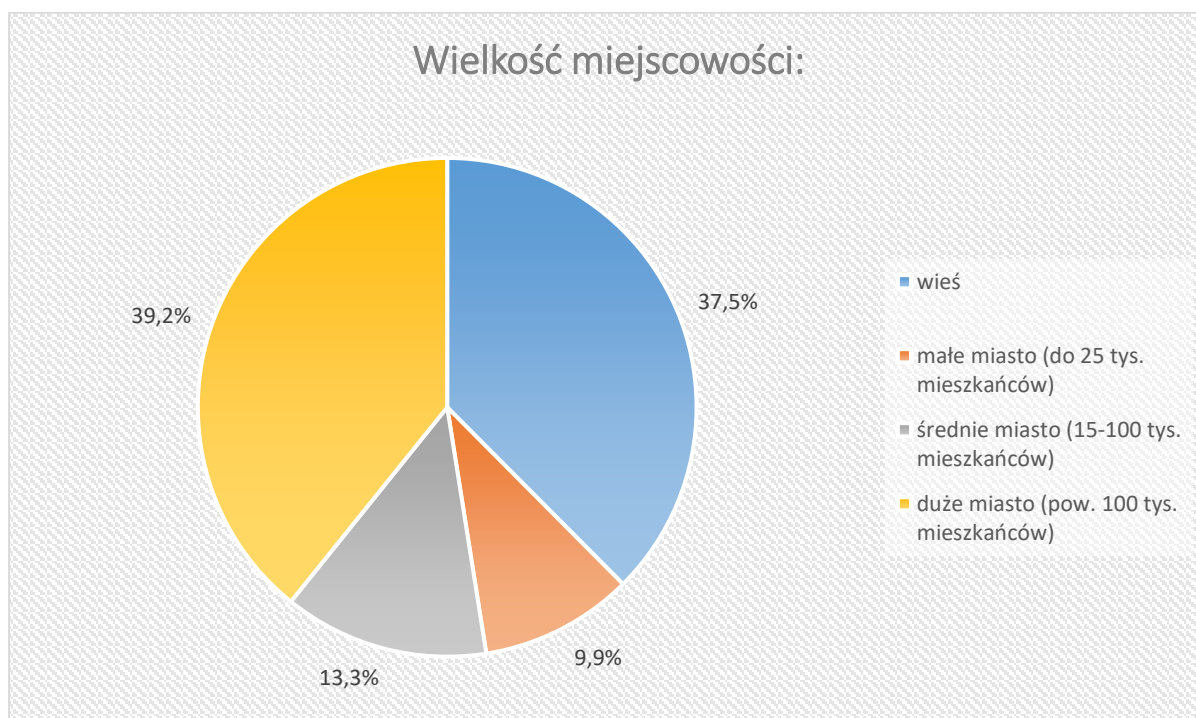
Ankieta sprawdzająca wiedzę przed spotkaniem edukacyjnym

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę przed spotkaniem edukacyjnym dla rodziców i opiekunów pt. „Jak rozpoznać kryzys emocjonalny u nastolatka i jak zareagować?” – spotkanie edukacyjne dla rodziców” zawierał: metryczkę składającą się z 3 pytań. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły przed realizacją spotkania w formie webinaru.

Preankieta została wypełniona przez 1196 osób. Preankieta (ankieta sprawdzająca wiedzę przed webinarzem) była wypełniana przez uczestników na etapie zapisywania się na wydarzenie.



Wykres przedstawia strukturę płci respondentów ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarzem. Zebrane dane pokazują wyraźną przewagę kobiet, które stanowiły 91,2% badanych (1091 osób). Mężczyźni stanowili 7,4% respondentów (88 osób), natomiast 1,4% ankietowanych (17 osób) zdecydowało się nie udzielać odpowiedzi na pytanie o płeć. Uzyskane wyniki wskazują, że w badaniu wstępnym przed webinarzem dominował udział kobiet.

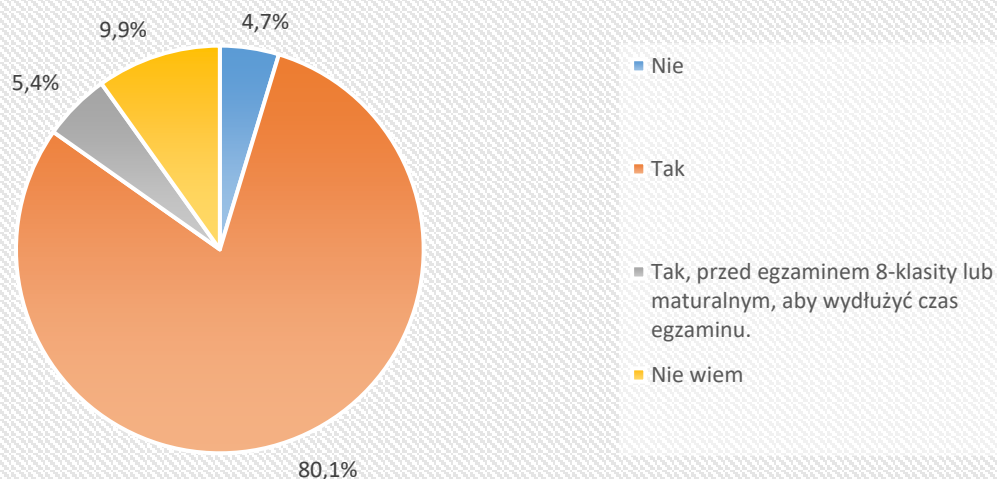


Wykres przedstawia strukturę respondentów ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby mieszkające w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) – 39,2% (469 osób). Niewiele mniejszy odsetek respondentów pochodził ze wsi – 37,5% (449 osób). Uczestnicy ze średnich miast (15–100 tys. mieszkańców) stanowili 13,3% (159 osób), natomiast osoby z małych miast (do 25 tys. mieszkańców) – 9,9% (119 osób). Wyniki wskazują na zróżnicowany udział respondentów pod względem miejsca zamieszkania, z przewagą mieszkańców dużych miast i obszarów wiejskich.

Kolejne pytanie dotyczyło wskazania szkoły. Ze względu na to, że liczba osób zapisujących się na wydarzenie, liczba osób faktycznie obecnych na szkoleniu oraz liczba osób wypełniających ankietę były różne, nie ma zasadnego uzasadnienia dla prezentowania wyników pytania o wskazanie szkoły. Odpowiedzi są zbyt rozproszone (wiele placówek pojawia się pojedynczo lub sporadycznie), a liczebności w poszczególnych kategoriach są małe i nieporównywalne pomiędzy etapami. W efekcie takie zestawienie nie dawałoby wiarygodnych wniosków i mogłoby prowadzić do nadinterpretacji danych.



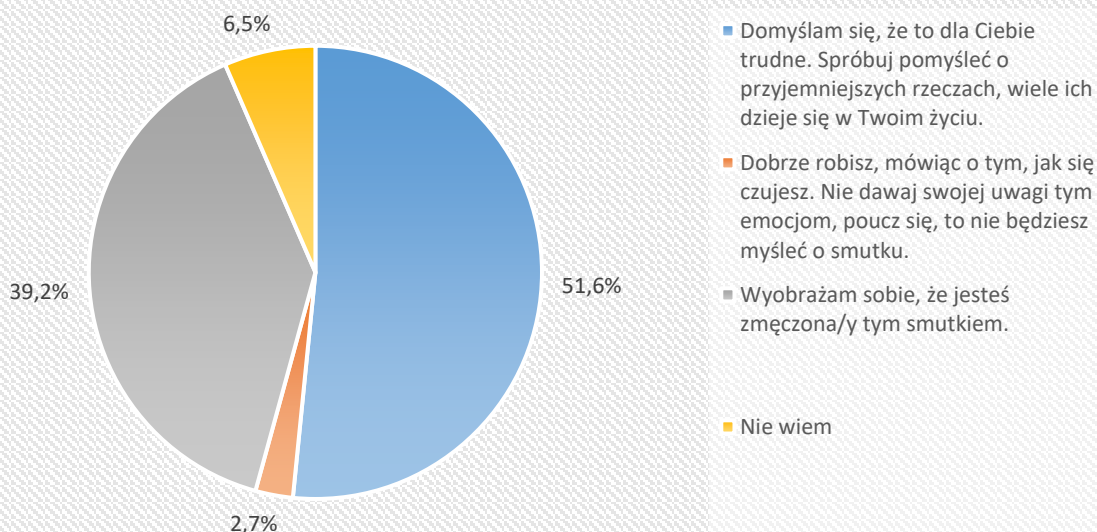
Czy szkoła powinna wiedzieć o tym, że dziecko objęte jest zewnętrzną pomocą psychoterapeutyczną lub psychiatryczną?



Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium na pytanie, czy szkoła powinna wiedzieć, że dziecko jest objęte zewnętrzną pomocą psychoterapeutyczną lub psychiatryczną. Poprawną odpowiedzią była odpowiedź „Tak”, którą wskazała zdecydowana większość respondentów – 80,1% (958 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za błędne – łącznie stanowiły one 20,0% wskazań (238 osób). Odpowiedź „Nie” wybrało 4,7% badanych (56 osób), 5,4% (64 osoby) uznało, że informacja ta powinna być przekazywana jedynie przed egzaminem ósmoklasisty lub maturalnym, natomiast 9,9% respondentów (118 osób) zadeklarowało brak wiedzy w tym zakresie. Wyniki te pokazują, że choć większość uczestników posiada prawidłową wiedzę, co piąty respondent wymaga dalszego wsparcia edukacyjnego w zakresie roli szkoły i zasad współpracy z rodziną w sytuacji korzystania przez dziecko z pomocy psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej.

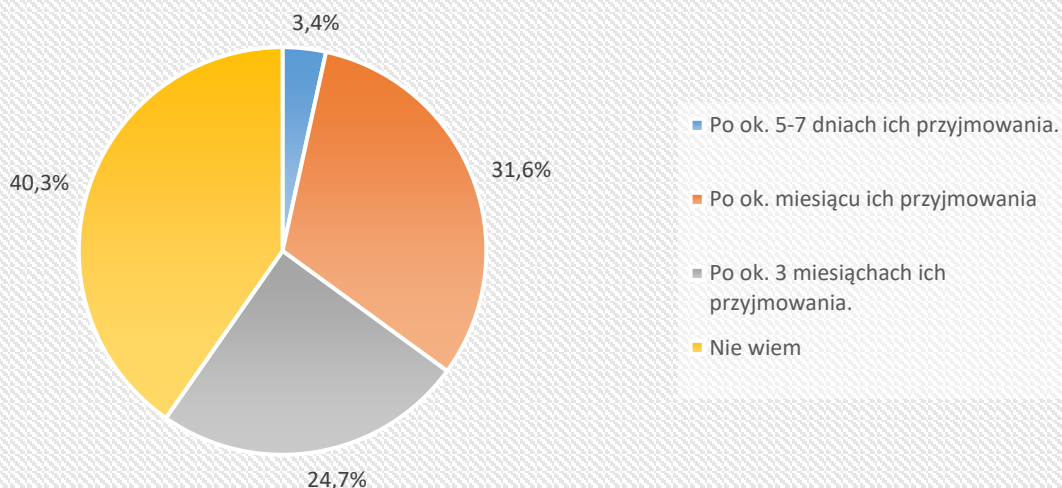


Jaka powinna być wypowiedź rodzica do dziecka, które mówi, że czuje dużo smutku?



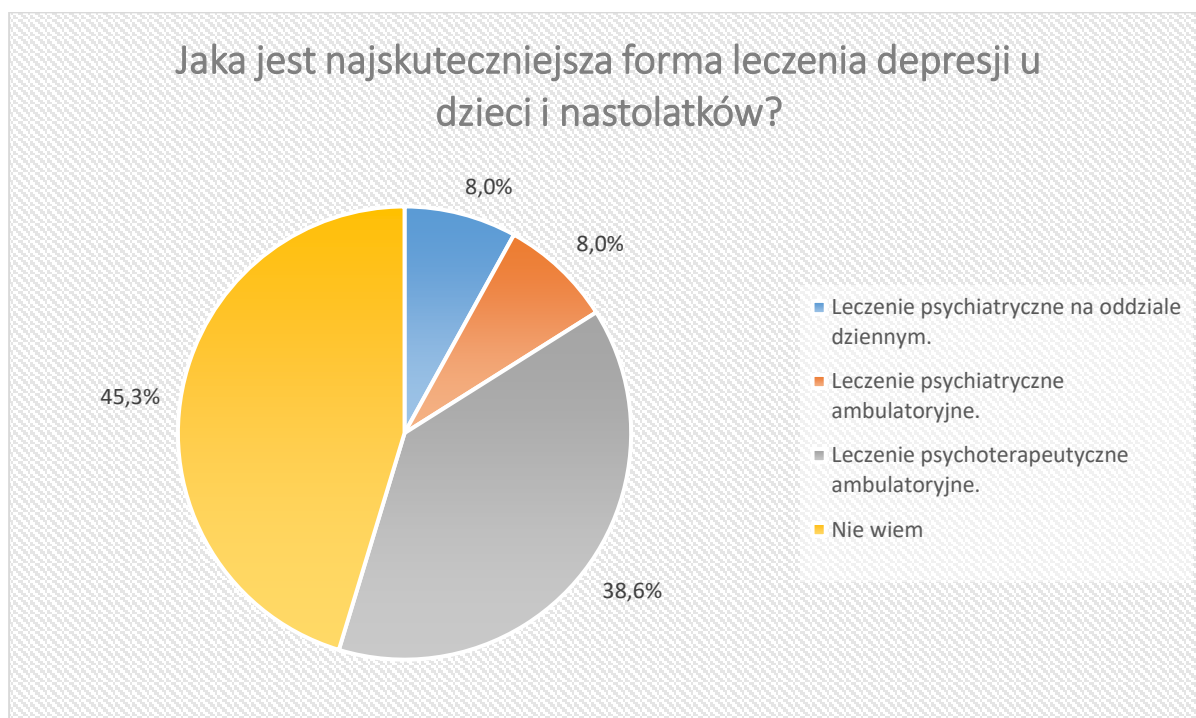
Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium na pytanie: „Jaka powinna być wypowiedź rodzica do dziecka, które mówi, że czuje dużo smutku?”. Poprawną odpowiedzią była wypowiedź empatyczna: „Wyobrażam sobie, że jesteś zmęczona/y tym smutkiem”, którą wskazało 39,2% respondentów (469 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za błędne – łącznie stanowiły one 60,8% wskazań (727 osób). Uzyskane wyniki wskazują, że większość respondentów miała trudność z rozpoznaniem właściwej, empatycznej reakcji rodzica, co podkreśla potrzebę dalszej psychoedukacji w zakresie wspierającej komunikacji z dzieckiem przeżywającym trudne emocje.

Po jakim czasie można spodziewać się poprawy funkcjonowania dziecka we wszystkich obszarach, jeśli przyjmuje ono leki antydepresyjne lub przeciwłukowe?

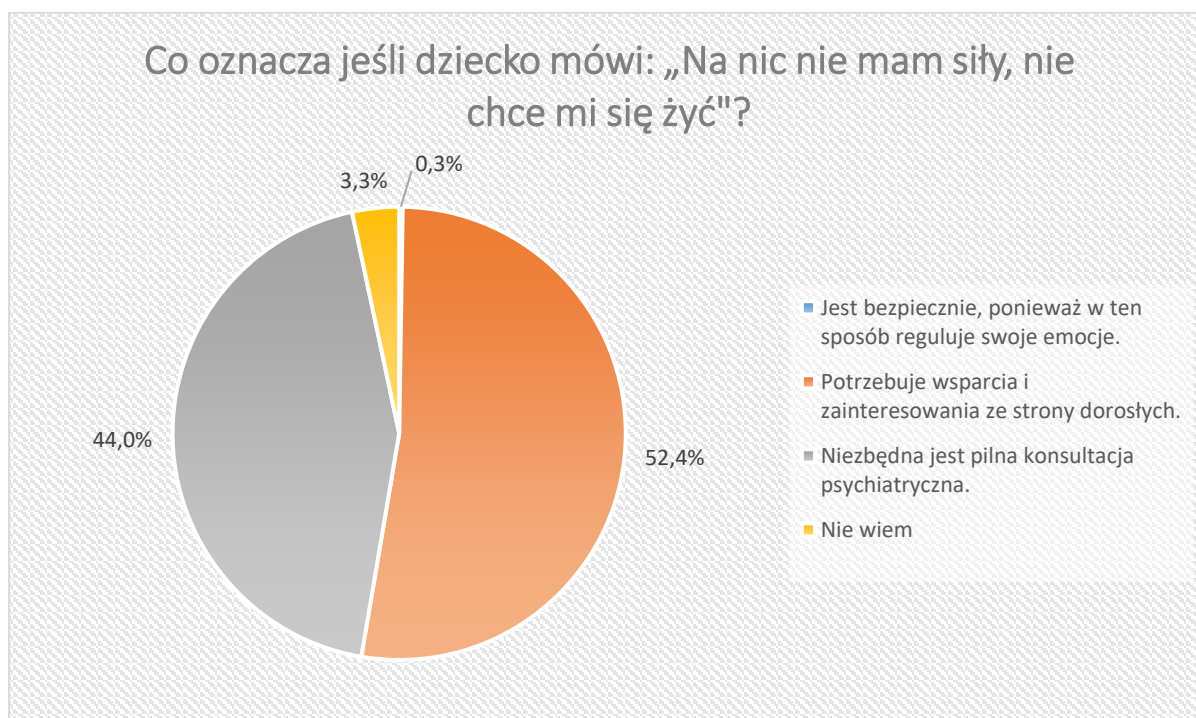




Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium na pytanie: „Po jakim czasie można spodziewać się poprawy funkcjonowania dziecka we wszystkich obszarach, jeśli przyjmuje ono leki antydepresyjne lub przeciwłękowe?”. Poprawną odpowiedzią była odpowiedź „po ok. 3 miesiącach ich przyjmowania”, którą wskazało 24,7% respondentów (295 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za błędne – łącznie stanowiły one 75,3% wskazań (901 osób). Wyniki te pokazują, że większość respondentów nie posiadała prawidłowej wiedzy na temat czasu działania farmakoterapii, co podkreśla potrzebę rzetelnej psychoedukacji rodziców w zakresie realistycznych oczekiwań wobec leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży.



Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium na pytanie: jaka jest najskuteczniejsza forma leczenia depresji u dzieci i nastolatków. Poprawną odpowiedzią było „leczenie psychoterapeutyczne ambulatoryjne”, które wskazało 38,6% respondentów (462 osoby). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za błędne – łącznie stanowiły one 61,4% wskazań (734 osoby). Wyniki te pokazują, że większość uczestników nie posiadała prawidłowej wiedzy na temat podstawowej i najskuteczniejszej formy leczenia depresji u dzieci i młodzieży, co podkreśla potrzebę wzmacniania kompetencji rodziców w obszarze psychoedukacji dotyczącej metod leczenia zaburzeń nastroju.

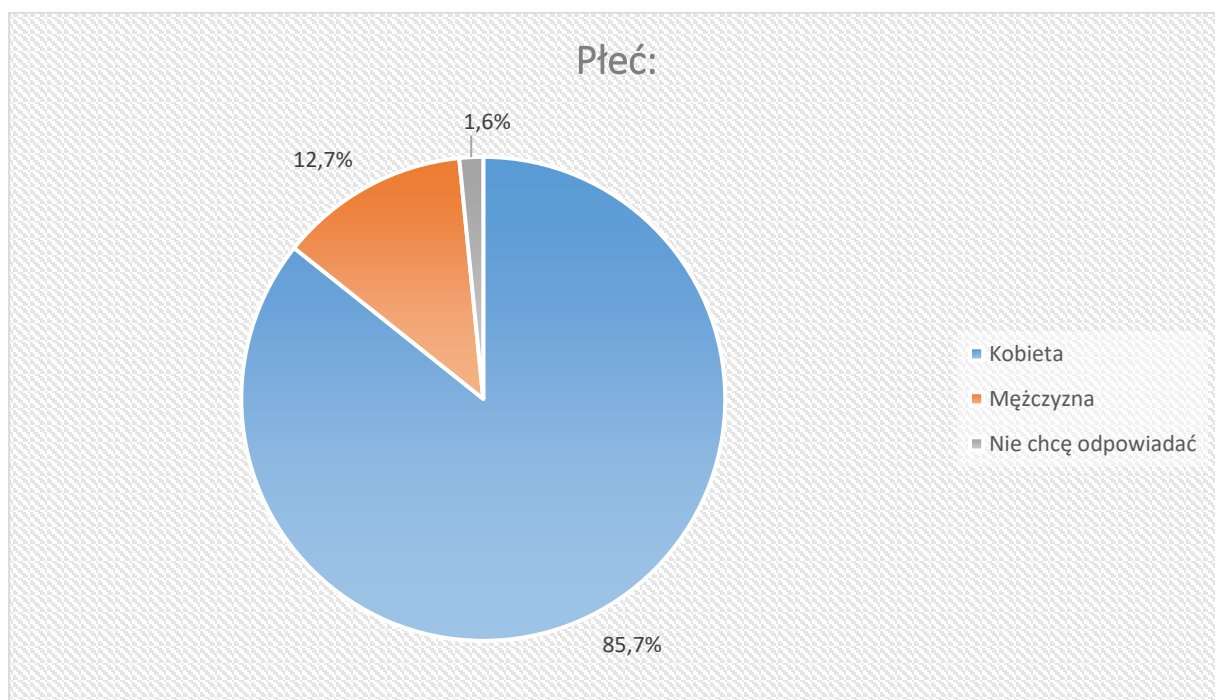


Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium na pytanie: co oznacza, jeśli dziecko mówi: „Na nic nie mam siły, nie chce mi się żyć”. Poprawną odpowiedzią było wskazanie, że dziecko potrzebuje wsparcia i zainteresowania ze strony dorosłych, którą zaznaczyło 52,4% respondentów (627 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za błędne – łącznie stanowiły one 47,6% wskazań (569 osób). Wyniki te pokazują, że choć ponad połowa uczestników potrafi prawidłowo zinterpretować sygnał wysyłany przez dziecko, niemal co drugi respondent wymaga dalszej psychoedukacji w zakresie rozróżniania pomiędzy potrzebą natychmiastowej interwencji specjalistycznej a koniecznością uważnej, wspierającej reakcji dorosłych.

Ankieta sprawdzająca wiedzę po spotkaniu edukacyjnym

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę po spotkaniu edukacyjnym dla rodziców i opiekunów pt. „Jak rozpoznać kryzys emocjonalny u nastolatka i jak zareagować?” – spotkanie edukacyjne dla rodziców” zawierało: metryczkę składającą się z 3 pytań. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły przed realizacją webinaru.

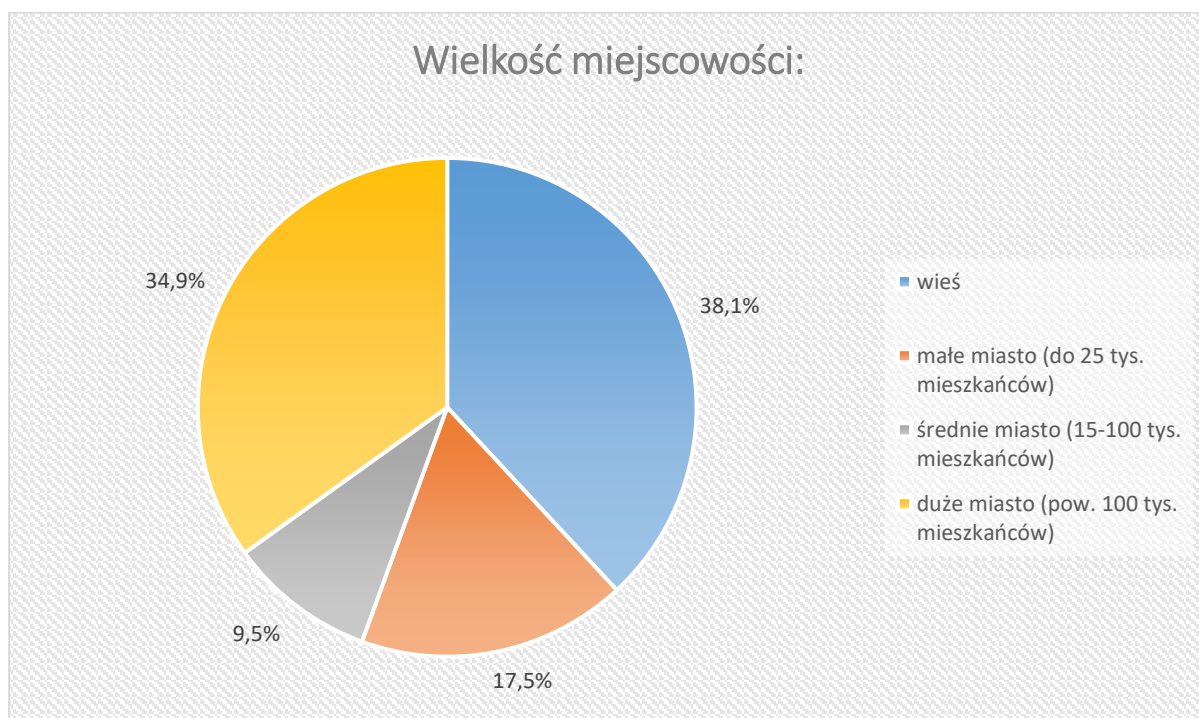
Postankieta została wypełniona przez 63 osoby, co stanowi wyraźnie mniejszą liczbę w porównaniu do liczby osób zapisanych oraz uczestniczących w spotkaniu. Należy podkreślić, że udział w ankiecie miał charakter dobrowolny, co mogło istotnie wpłynąć na poziom responsywności. Dodatkowo webinar odbywał się w godzinach popołudniowo-wieczornych, a jego późna godzina zakończenia mogła ograniczać gotowość rodziców do pozostania do końca spotkania i wypełnienia ankiety. Istotnym czynnikiem była również konieczność wcześniejszego opuszczania webinaru przez część uczestników z uwagi na inne obowiązki rodzinne i zawodowe. W związku z powyższym niska liczebność postankiety nie powinna być interpretowana jako brak zaangażowania uczestników, lecz raczej jako efekt organizacyjnych i czasowych uwarunkowań udziału w spotkaniu oraz dobrowolnego charakteru badania ewaluacyjnego.



W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po spotkaniu edukacyjnym zdecydowaną większość respondentów stanowiły kobiety – 85,7% (54 osoby). Mężczyźni stanowili 12,7% badanych (8 osób), natomiast 1,6% respondentów (1 osoba) nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o płeć.

Porównując te wyniki z ankietą wstępną (preankietą), można zauważyć, że również przed spotkaniem edukacyjnym dominującą grupą respondentów były kobiety, które stanowiły 91,2% badanych (1091 osób). Udział mężczyzn w preankiecie był niższy i wyniósł 7,4% (88 osób), a 1,4% respondentów nie wskazało swojej płci.

Zestawienie obu pomiarów pokazuje, że struktura płci respondentów pozostaje spójna, z wyraźną przewagą kobiet zarówno przed, jak i po spotkaniu edukacyjnym. Jednocześnie w postankiecie widoczny jest nieznaczny wzrost udziału mężczyzn, co należy interpretować ostrożnie, mając na uwadze znacznie mniejszą liczebność próby po spotkaniu oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu.



W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po spotkaniu edukacyjnym największą grupę respondentów stanowiły osoby mieszkające na wsi – 38,1% (24 osoby). Niewiele mniejszy odsetek pochodził z dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) – 34,9% (22 osoby). Uczestnicy z małych miast (do 25 tys. mieszkańców) stanowili 17,5% badanych (11 osób), natomiast osoby ze średnich miast (15–100 tys. mieszkańców) – 9,5% (6 osób).

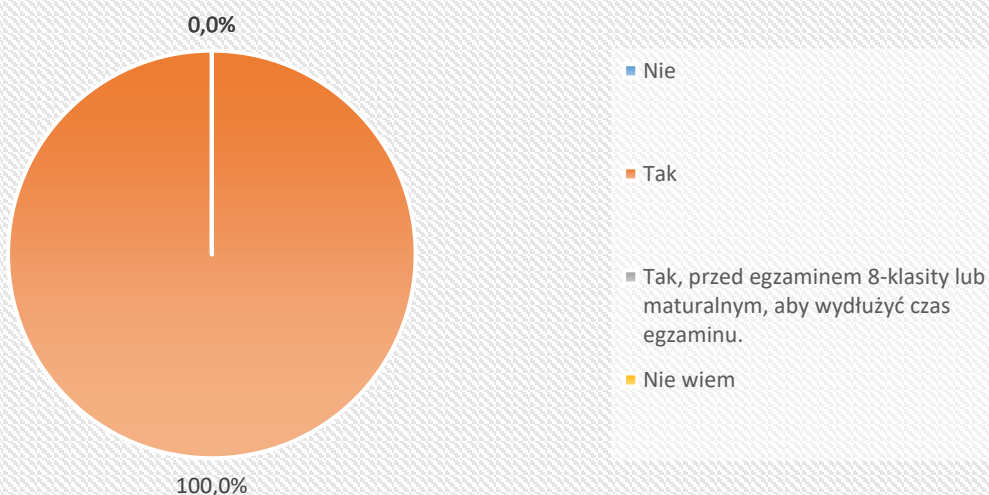
W porównaniu z ankietą wstępną (preankietą) struktura miejsca zamieszkania respondentów była bardziej wyrównana, choć również wówczas dominowały osoby ze wsi – 37,5% (449 osób) oraz z dużych miast – 39,2% (469 osób). Mniejszy udział odnotowano wśród mieszkańców średnich miast – 13,3% (159 osób) oraz małych miast – 9,9% (119 osób).

Porównanie obu pomiarów wskazuje, że rozkład respondentów ze względu na wielkość miejscowości pozostaje zasadniczo spójny, szczególnie w odniesieniu do dominującego udziału mieszkańców wsi i dużych miast. Jednocześnie w postankiecie widoczny jest nieco wyższy udział osób z małych miast oraz niższy udział mieszkańców miast średnich, co należy interpretować ostrożnie ze względu na znacznie mniejszą liczebność próby po spotkaniu edukacyjnym oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Kolejne pytanie dotyczyło wskazania szkoły. Ze względu na to, że liczba osób zapisujących się na wydarzenie, liczba osób faktycznie obecnych na szkoleniu oraz liczba osób wypełniających postankietę były różne, nie ma zasadnego uzasadnienia dla prezentowania wyników pytania o wskazanie szkoły. Odpowiedzi są zbyt rozproszone (wiele placówek pojawia się pojedynczo lub sporadycznie), a liczebności w poszczególnych kategoriach są małe i nieporównywalne pomiędzy etapami. W efekcie takie zestawienie nie dawałoby wiarygodnych wniosków i mogłoby prowadzić do nadinterpretacji danych.



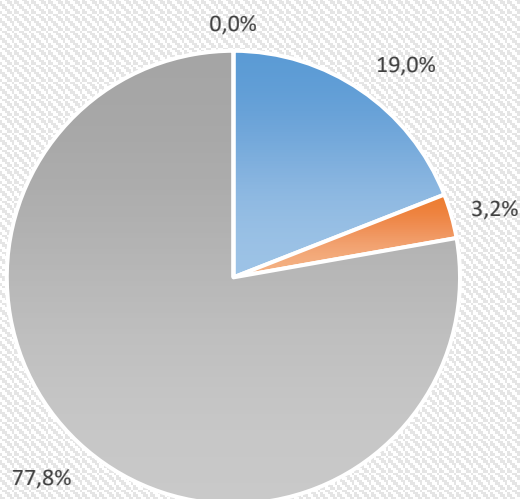
Czy szkoła powinna wiedzieć o tym, że dziecko objęte jest zewnętrzną pomocą psychoterapeutyczną lub psychiatryczną?



W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po spotkaniu edukacyjnym wszyscy respondenci udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie, czy szkoła powinna wiedzieć o tym, że dziecko jest objęte zewnętrzną pomocą psychoterapeutyczną lub psychiatryczną. Odpowiedź „Tak” wskazało 100,0% badanych (63 osoby). W porównaniu z ankietą wstępną (pre-ankietą) widać wyraźną poprawę. Przed spotkaniem edukacyjnym poprawną odpowiedź „Tak” zaznaczyło 80,1% respondentów (958 osób), natomiast błędne odpowiedzi łącznie stanowiły 20,0% (238 osób). Zestawienie wyników sugeruje, że po spotkaniu edukacyjnym uczestnicy, którzy wypełnili postankię, jednoznacznie przyswoili prawidłową informację w tym zakresie. Jednocześnie interpretując zmianę, warto uwzględnić znacznie mniejszą liczebność postankię oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu.



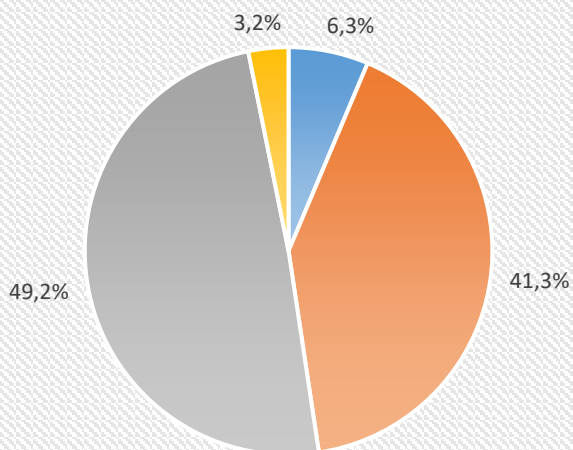
Jaka powinna być wypowiedź rodzica do dziecka, które mówi, że czuje dużo smutku?



- Domyślam się, że to dla Ciebie trudne. Spróbuj pomyśleć o przyjemniejszych rzeczach, wiele ich dzieje się w Twoim życiu.
- Dobrze robisz, mówiąc o tym, jak się czujesz. Nie dawaj swojej uwagi tym emocjom, poucz się, to nie będziesz myśleć o smutku.
- Wyobrażam sobie, że jesteś zmęczona/y tym smutkiem.
- Nie wiem

Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety sprawdzającej poziom wiedzy po spotkaniu edukacyjnym na pytanie: „Jaka powinna być wypowiedź rodzica do dziecka, które mówi, że czuje dużo smutku?”. Poprawną odpowiedzią była empatyczna reakcja: „Wyobrażam sobie, że jesteś zmęczona/y tym smutkiem”, którą wskazało 77,8% respondentów (49 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 22,2% wskazań (14 osób). Uzyskane wyniki wskazują na wyraźny wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi po spotkaniu edukacyjnym, co może świadczyć o zwiększeniu kompetencji uczestników w zakresie rozpoznawania empatycznej i wspierającej komunikacji z dzieckiem przeżywającym trudne emocje.

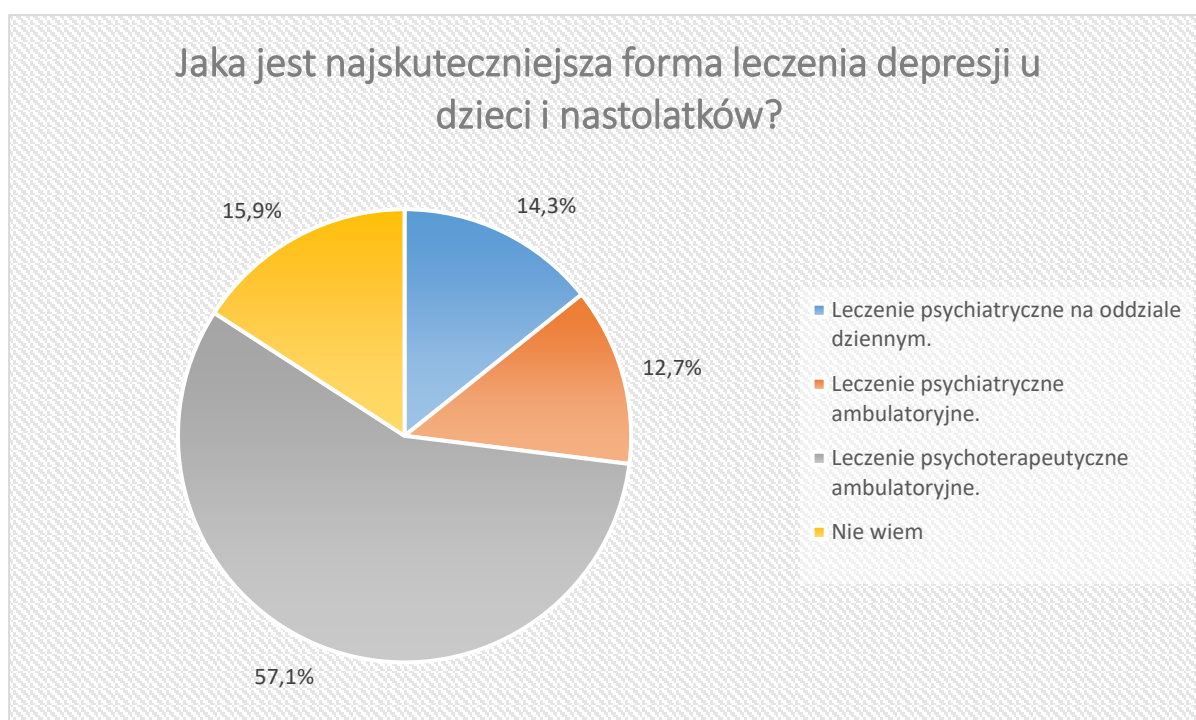
Po jakim czasie można spodziewać się poprawy funkcjonowania dziecka we wszystkich obszarach, jeśli przyjmuje ono leki antydepresyjne lub przeciwlękowe?



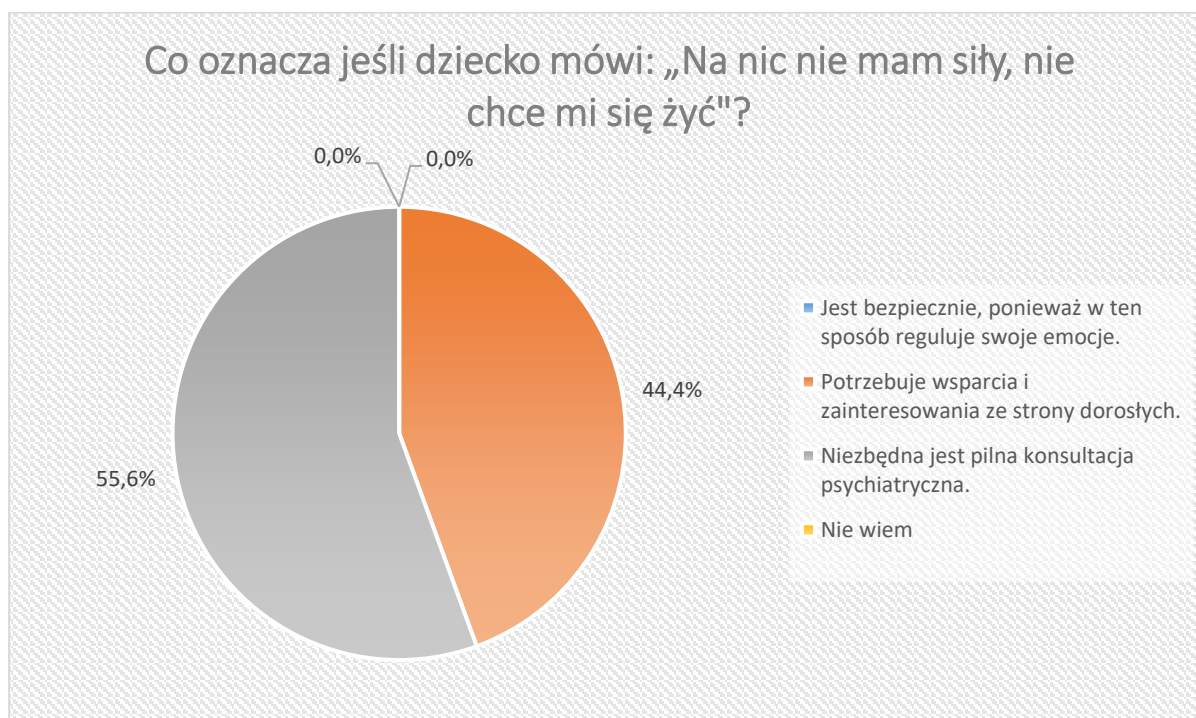
- Po ok. 5-7 dniach ich przyjmowania.
- Po ok. miesiącu ich przyjmowania
- Po ok. 3 miesiącach ich przyjmowania.
- Nie wiem



W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po spotkaniu edukacyjnym poprawną odpowiedź na pytanie, po jakim czasie można spodziewać się poprawy funkcjonowania dziecka we wszystkich obszarach przy stosowaniu leków antydepresyjnych lub przeciwłękowych, wskazało 49,2% respondentów (31 osób). Prawidłową odpowiedzią było wskazanie, że poprawy można oczekiwać po około 3 miesiącach ich przyjmowania. Błędne odpowiedzi łącznie stanowiły 50,8% wskazań (32 osoby). W porównaniu z ankietą wstępną (preankietą), w której poprawną odpowiedź wskazało 24,7% respondentów (295 osób), a błędne odpowiedzi łącznie stanowiły 75,3% (901 osób), wyniki postankiety pokazują wyraźny wzrost poziomu wiedzy uczestników, którzy zdecydowali się wypełnić ankietę po spotkaniu edukacyjnym. Jednocześnie, interpretując poprawę wyników, należy uwzględnić znacznie mniejszą liczebność próby po spotkaniu oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu ewaluacyjnym.



W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po spotkaniu edukacyjnym poprawną odpowiedź na pytanie o najskuteczniejszą formę leczenia depresji u dzieci i nastolatków wskazało 57,1% respondentów (36 osób). Prawidłową odpowiedzią było leczenie psychoterapeutyczne ambulatoryjne. Błędne odpowiedzi łącznie stanowiły 42,9% wskazań (27 osób). W porównaniu z ankietą wstępną (preankietą), w której poprawną odpowiedź wskazało 38,6% respondentów (462 osoby), a błędne odpowiedzi łącznie stanowiły 61,4% (734 osoby), wyniki postankiety pokazują wyraźny wzrost poziomu wiedzy wśród osób, które wzięły udział w ewaluacji po spotkaniu edukacyjnym. Jednocześnie interpretując tę poprawę, należy uwzględnić znacznie mniejszą liczebność próby po spotkaniu oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu.



W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po spotkaniu edukacyjnym poprawną odpowiedź na pytanie, co oznacza wypowiedź dziecka: „Na nic nie mam siły, nie chce mi się żyć”, wskazało 44,4% respondentów (28 osób). Prawidłową odpowiedzią było stwierdzenie, że dziecko potrzebuje wsparcia i zainteresowania ze strony dorosłych. Błędne odpowiedzi łącznie stanowiły 55,6% wskazań (35 osób). W porównaniu z ankietą wstępną (preankietą), w której poprawną odpowiedź wskazało 52,4% respondentów (627 osób), a błędne odpowiedzi łącznie stanowiły 47,6% (569 osób), wyniki postankiety pokazują niższy odsetek poprawnych odpowiedzi. Różnica ta powinna być jednak interpretowana z ostrożnością, ze względu na znacznie mniejszą liczebność próby po spotkaniu edukacyjnym oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Podsumowanie

Analiza wyników ankiet sprawdzających wiedzę przeprowadzonych przed i po spotkaniu edukacyjnym dla rodziców i opiekunów jednoznacznie wskazuje na wzrost poziomu wiedzy uczestników w kluczowych obszarach związanych z rozpoznawaniem kryzysu emocjonalnego u nastolatków oraz adekwatnym reagowaniem na sygnały ostrzegawcze. Porównanie wyników preankiety i postankiety pokazuje wyraźny wzrost odsetka odpowiedzi poprawnych oraz istotne ograniczenie liczby odpowiedzi błędnych i deklaracji „nie wiem”, co świadczy o skuteczności przekazu edukacyjnego.

Szczególnie widoczna poprawa dotyczyła zagadnień związanych z interpretacją wypowiedzi dziecka sygnalizujących obniżony nastrój i brak sił, rozumieniem znaczenia wsparcia emocjonalnego ze strony dorosłych, a także wiedzy dotyczącej leczenia depresji i czasu potrzebnego na zauważalną poprawę funkcjonowania dziecka. Po spotkaniu edukacyjnym rodzice częściej wybierali odpowiedzi wskazujące na empatyczne, wspierające reakcje oraz na potrzebę uważności i zainteresowania sytuacją emocjonalną nastolatka, zamiast bagatelizowania trudności lub poszukiwania szybkich, uproszczonych rozwiązań.

Wyniki postankiety pokazują również lepsze rozumienie roli szkoły, specjalistów oraz systemu pomocy zewnętrznej w procesie wspierania dziecka w kryzysie emocjonalnym. Rodzice po spotkaniu częściej wskazywali odpowiedzi zgodne z aktualną wiedzą psychologiczną i psychiatryczną, co sugeruje wzrost ich poczucia kompetencji oraz gotowości do podejmowania adekwatnych działań w sytuacjach trudnych.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że różnice pomiędzy liczbą osób zapisanych na spotkanie, liczbą faktycznych uczestników oraz liczbą osób wypełniających ankietę końcową – wynikające m.in. z dobrowolnego charakteru udziału, późnej



godziny zakończenia spotkania edukacyjnego oraz wcześniejszego opuszczania spotkania przez część rodziców z powodu innych obowiązków – ograniczają możliwość bardziej szczegółowych analiz porównawczych (np. według szkoły). Nie wpływa to jednak na ogólny kierunek i interpretację uzyskanych wyników.

Podsumowując, spotkanie edukacyjne „Jak rozpoznać kryzys emocjonalny u nastolatka i jak zareagować?” spełniło swój cel edukacyjny, przyczyniając się do zwiększenia wiedzy rodziców i opiekunów, uporządkowania kluczowych informacji oraz wzmocnienia postaw opartych na empatii, uważności i odpowiedzialnym reagowaniu na sygnały kryzysu emocjonalnego u dzieci i młodzieży.





„Pierwsza pomoc rodzicielska: jak rozpoznać kryzys emocjonalny u dziecka i nastolatka i jak zareagować?”

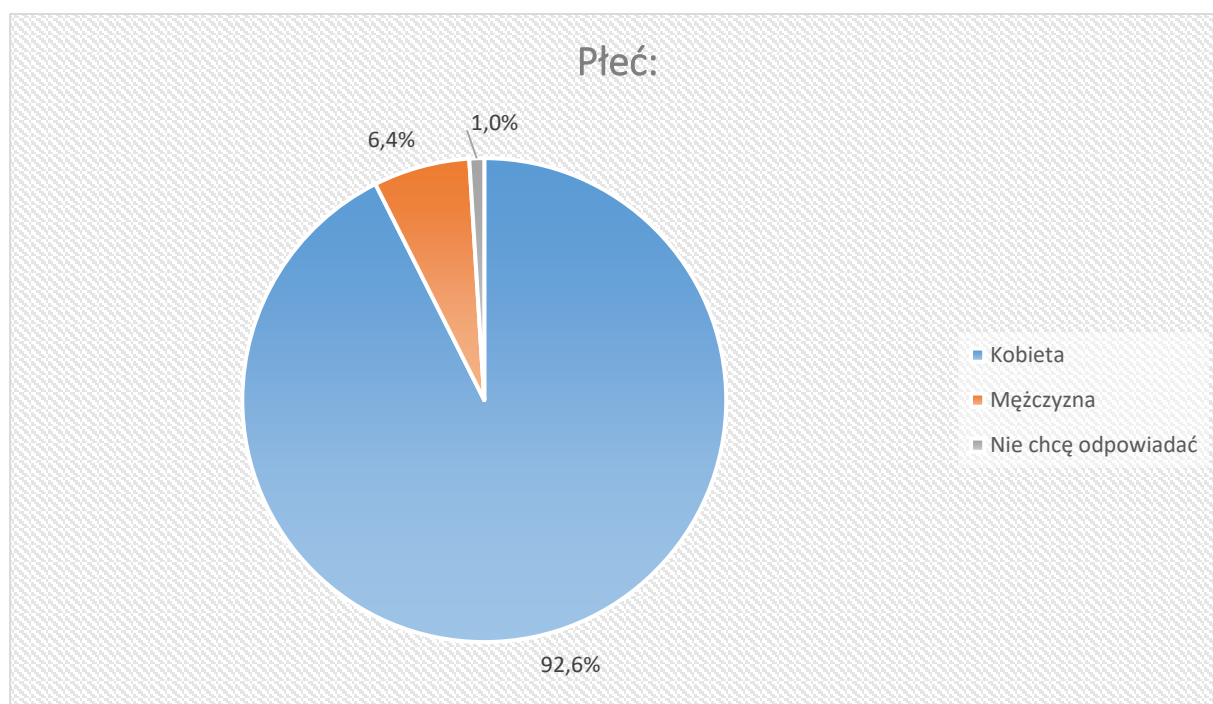
„Pierwsza pomoc rodzicielska”: Jak rozpoznać kryzys emocjonalny u dziecka i nastolatka i jak zareagować?” to otwarte webinary realizowane pod parasolem programu Wspierająca Szkoła skierowane do wszystkich rodziców i opiekunów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat kryzysu psychicznego u dziecka i nastolatka. Podczas spotkania edukacyjnego uczestnicy dowiedzieli się po czym rozpoznać kryzys emocjonalny u młodej osoby, a także jak wpływa on na jej szkolne funkcjonowanie. Webinar poświęcony był również pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli temu, co każdy z nas może zrobić dla osoby w kryzysie. Uczestnicy poznali zasadę 4 x Z, czyli efektywnego i wspierającego sposobu reagowania w sytuacji zauważenia kryzysu emocjonalnego u dziecka lub nastolatka, a także w sytuacji odmowy rozmowy, czyli oporu psychologicznego.

Odbyło się 6 webinarów otwartych, w których łącznie wzięło udział 1760 osób.

Ankieta sprawdzająca wiedzę przed otwartym webinarium dla rodziców i opiekunów

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę przed otwartym webinarium pt. „Pierwsza pomoc rodzicielska: jak rozpoznać kryzys u dziecka i nastolatka i jak zareagować?”: metryczkę składającą się z 2 pytań. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły przed realizacją webinaru.

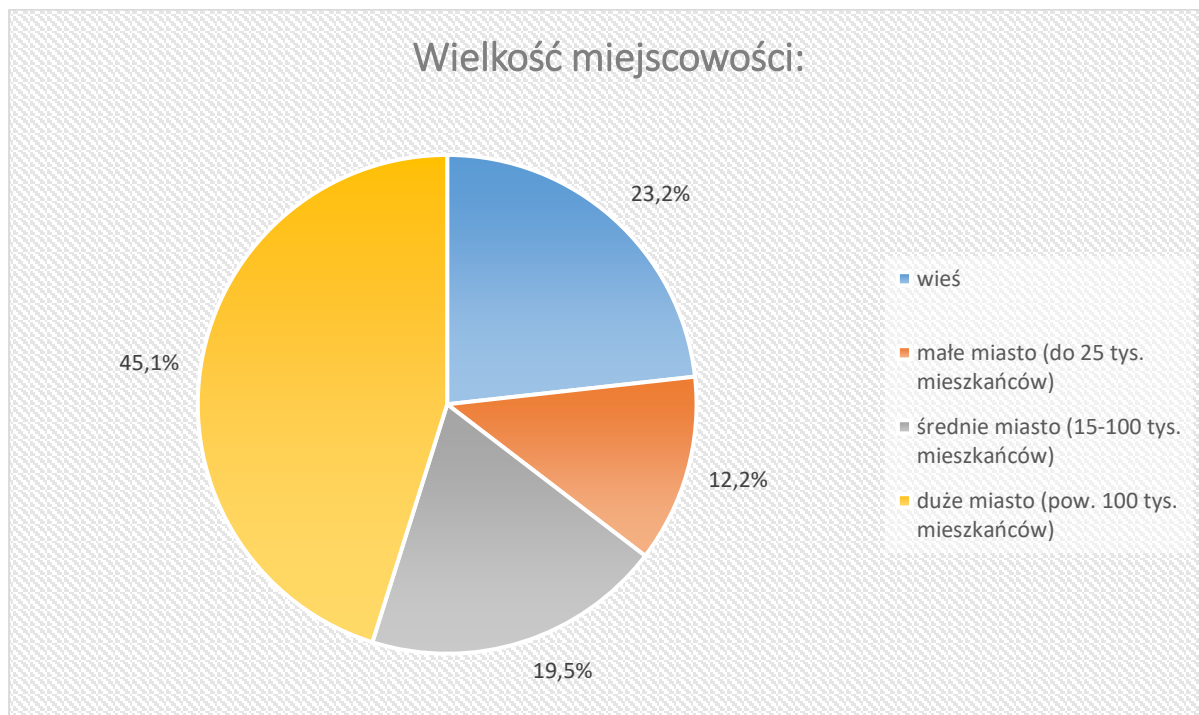
Preankieta została wypełniona przez 5 639 osób. Preankieta (ankieta sprawdzająca wiedzę przed webinarium) była wypełniana przez uczestników na etapie zapisywania się na wydarzenie. Wynik ten wskazuje, że zdecydowana większość osób zapisuje się na webinar, niż ostatecznie bierze w nim udział.



Wykres przedstawia strukturę płci respondentów ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium. Zebrane dane wskazują na wyraźną dominację kobiet, które stanowiły 92,6% badanych (5220 osób). Mężczyźni stanowili 6,4% respondentów (363 osoby), natomiast 1,0% ankietowanych (56 osób) zdecydowało się nie udzielać odpowiedzi na pytanie o płeć. Uzyskane wyniki pokazują, że w badaniu wstępnym przed webinarium zdecydowaną większość uczestników stanowiły kobiety.

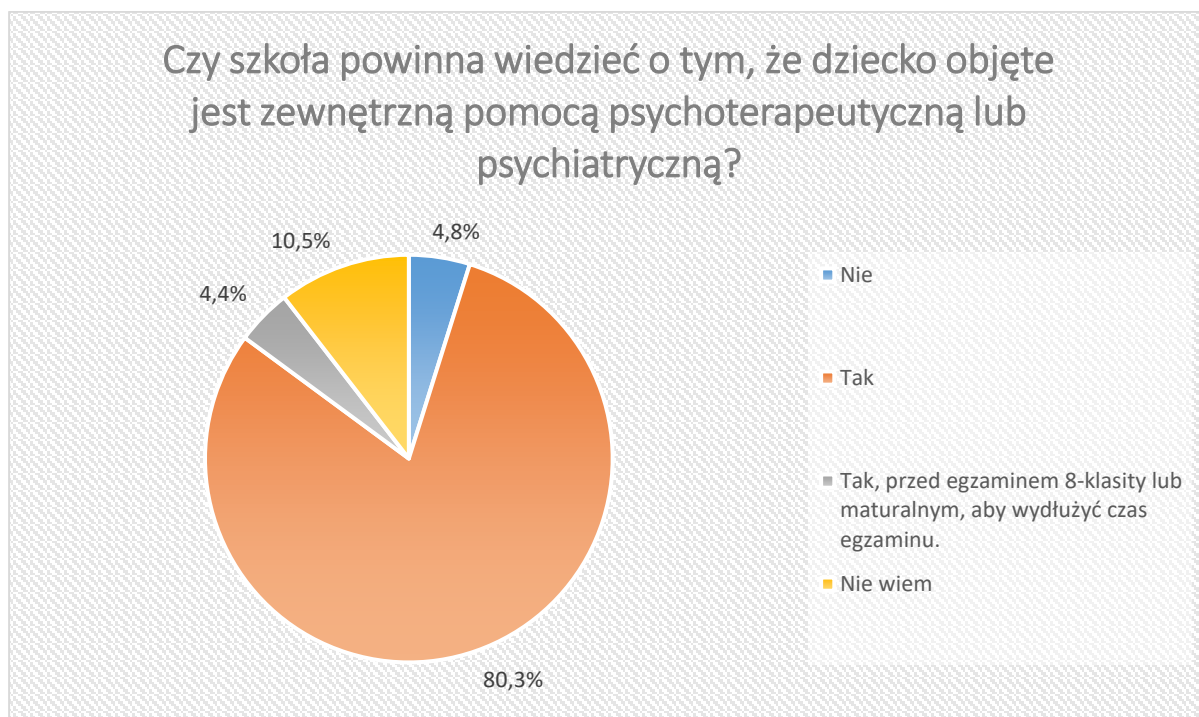


Wielkość miejscowości:



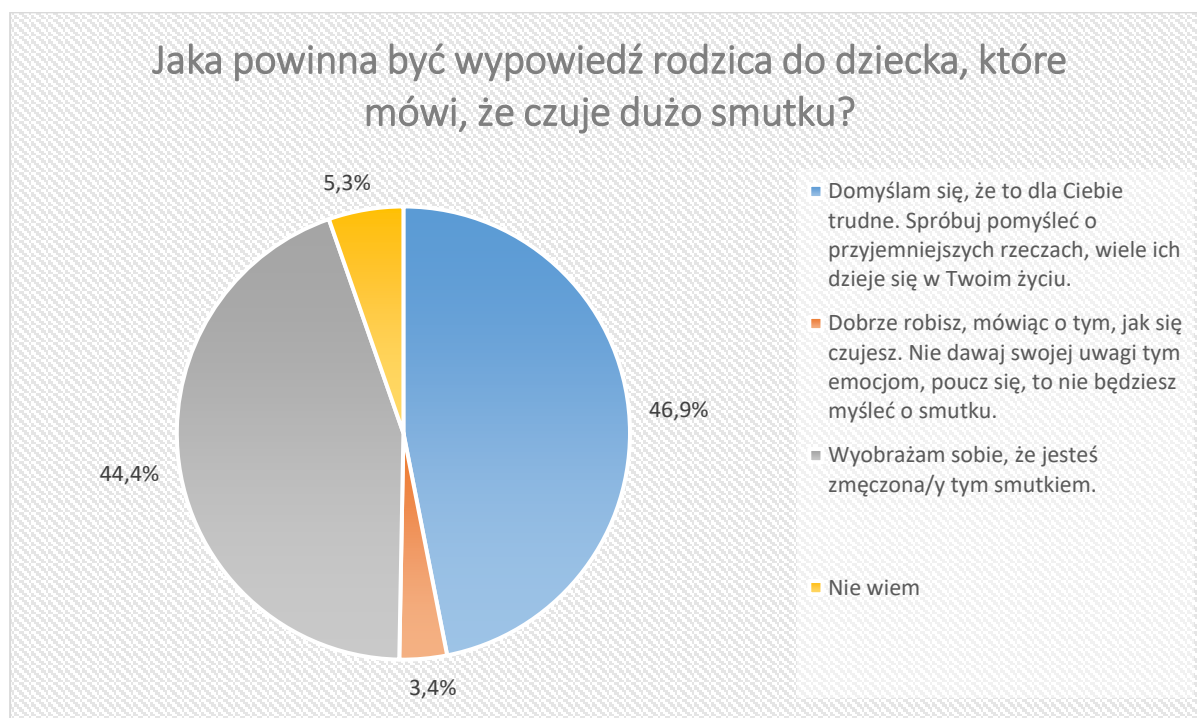
Wykres przedstawia strukturę respondentów ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania. Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) – 45,1% (2546 osób). Kolejną liczną grupą byli respondenci mieszkający na wsi, którzy stanowili 23,2% badanych (1310 osób). Uczestnicy ze średnich miast (15–100 tys. mieszkańców) stanowili 19,5% (1097 osób), natomiast osoby z małych miast (do 25 tys. mieszkańców) – 12,2% (686 osób). Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowaną strukturę respondentów pod względem miejsca zamieszkania, z wyraźną przewagą mieszkańców dużych miast.

Czy szkoła powinna wiedzieć o tym, że dziecko objęte jest zewnętrzną pomocą psychoterapeutyczną lub psychiatryczną?





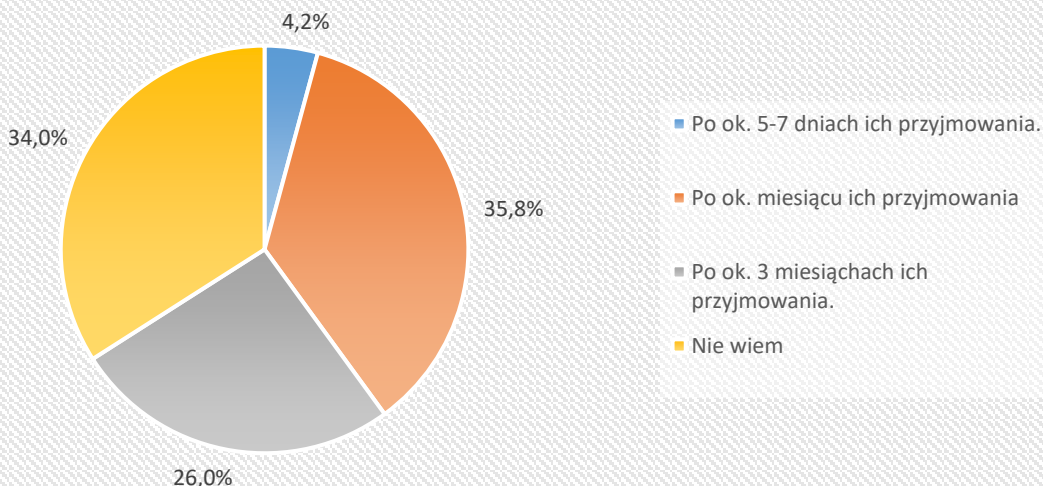
Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium na pytanie, czy szkoła powinna wiedzieć, że dziecko jest objęte zewnętrzną pomocą psychoterapeutyczną lub psychiatryczną. Poprawną odpowiedzią była odpowiedź „Tak”, którą wskazała zdecydowana większość respondentów – 80,3% (4526 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 19,7% wskazań. Uzyskane wyniki pokazują, że mimo iż większość uczestników posiada prawidłową wiedzę, niemal co piąty respondent wymaga dalszego wsparcia edukacyjnego w zakresie roli szkoły oraz zasad współpracy z rodziną w sytuacji korzystania przez dziecko z pomocy psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej.



Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium na pytanie: „Jaka powinna być wypowiedź rodzica do dziecka, które mówi, że czuje dużo smutku?”. Poprawną odpowiedzią była empatyczna wypowiedź: „Wyobrażam sobie, że jesteś zmęczona/y tym smutkiem”, którą wskazało 44,4% respondentów (2502 osoby). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 55,6% wskazań (3138 osób). Uzyskane wyniki pokazują, że mimo iż znaczna część uczestników deklarowała reakcje o charakterze wspierającym, ponad połowa respondentów nie wskazała w pełni prawidłowej, empatycznej wypowiedzi, co potwierdza potrzebę dalszego wsparcia edukacyjnego w zakresie komunikacji z dzieckiem przeżywającym trudne emocje.

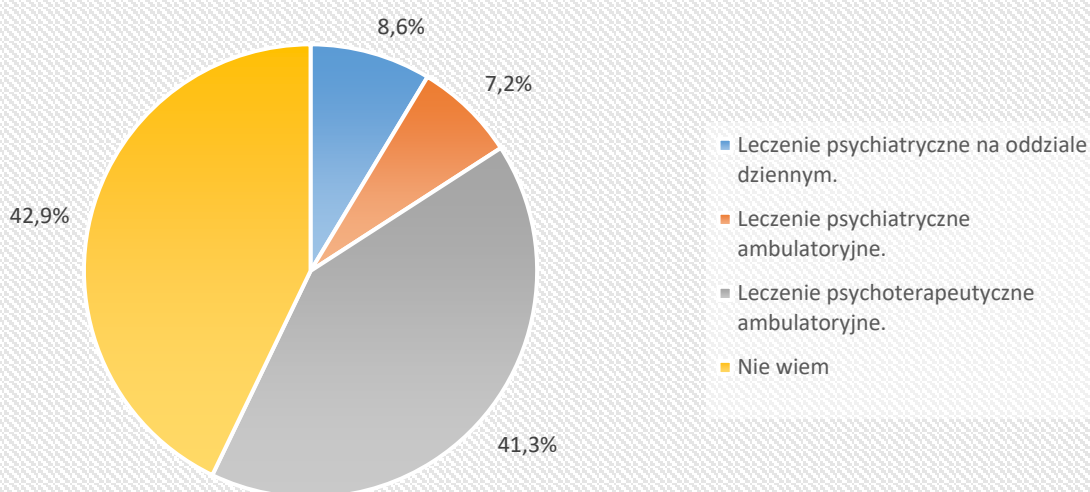


Po jakim czasie można spodziewać się poprawy funkcjonowania dziecka we wszystkich obszarach, jeśli przyjmuje ono leki antydepresyjne lub przeciwłukowe?



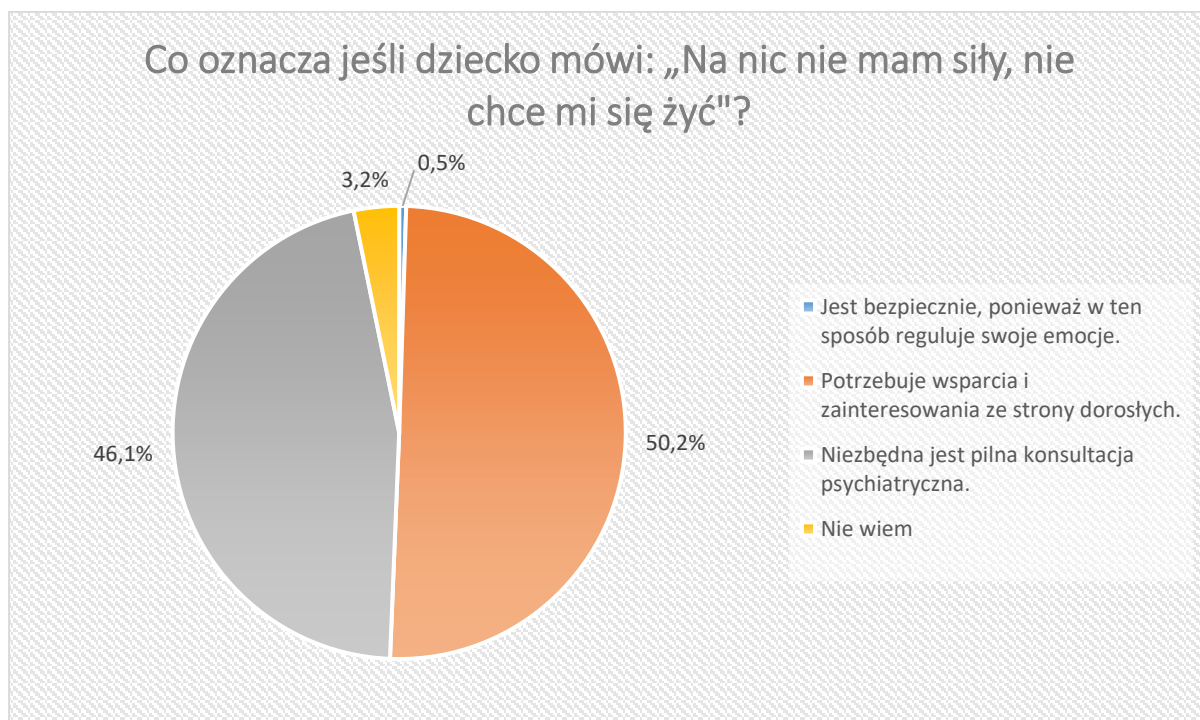
Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium na pytanie: „Po jakim czasie można spodziewać się poprawy funkcjonowania dziecka we wszystkich obszarach, jeśli przyjmuje ono leki antydepresyjne lub przeciwłukowe?”. Poprawną odpowiedzią była odpowiedź „po ok. 3 miesiącach ich przyjmowania”, którą wskazało 26,0% respondentów (1466 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 74,0% wskazań (4173 osoby). Uzyskane wyniki pokazują, że większość respondentów nie posiadała prawidłowej wiedzy na temat czasu działania farmakoterapii, co podkreśla potrzebę dalszej, rzetelnej psychoedukacji rodziców w zakresie realistycznych oczekiwań wobec leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży.

Jaka jest najskuteczniejsza forma leczenia depresji u dzieci i nastolatków?





Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarzem na pytanie: „Jaka jest najskuteczniejsza forma leczenia depresji u dzieci i nastolatków?”. Poprawną odpowiedzią było „leczenie psychoterapeutyczne ambulatoryjne”, które wskazało 41,3% respondentów (2327 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 58,7% wskazań (3312 osób). Uzyskane wyniki pokazują, że mimo iż największa grupa uczestników wskazała prawidłową formę leczenia, większość respondentów nie posiadała pełnej, rzetelnej wiedzy na temat podstawowej i najskuteczniejszej metody leczenia depresji u dzieci i młodzieży, co podkreśla potrzebę dalszego wzmacniania kompetencji rodziców w obszarze psychoedukacji dotyczącej leczenia zaburzeń nastroju.



Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarzem na pytanie: „Co oznacza, jeśli dziecko mówi: ‘Na nic nie mam siły, nie chce mi się żyć’?”. Poprawną odpowiedzią było wskazanie, że dziecko potrzebuje wsparcia i zainteresowania ze strony dorosłych, którą zaznaczyło 50,2% respondentów (2828 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 49,8% wskazań (2811 osób). Uzyskane wyniki pokazują, że mimo iż połowa uczestników potrafiła prawidłowo zinterpretować sygnał wysyłany przez dziecko, niemal połowa respondentów wymaga dalszej psychoedukacji w zakresie właściwego rozróżniania pomiędzy potrzebą uważnej, wspierającej reakcji dorosłych a koniecznością natychmiastowej interwencji specjalistycznej.

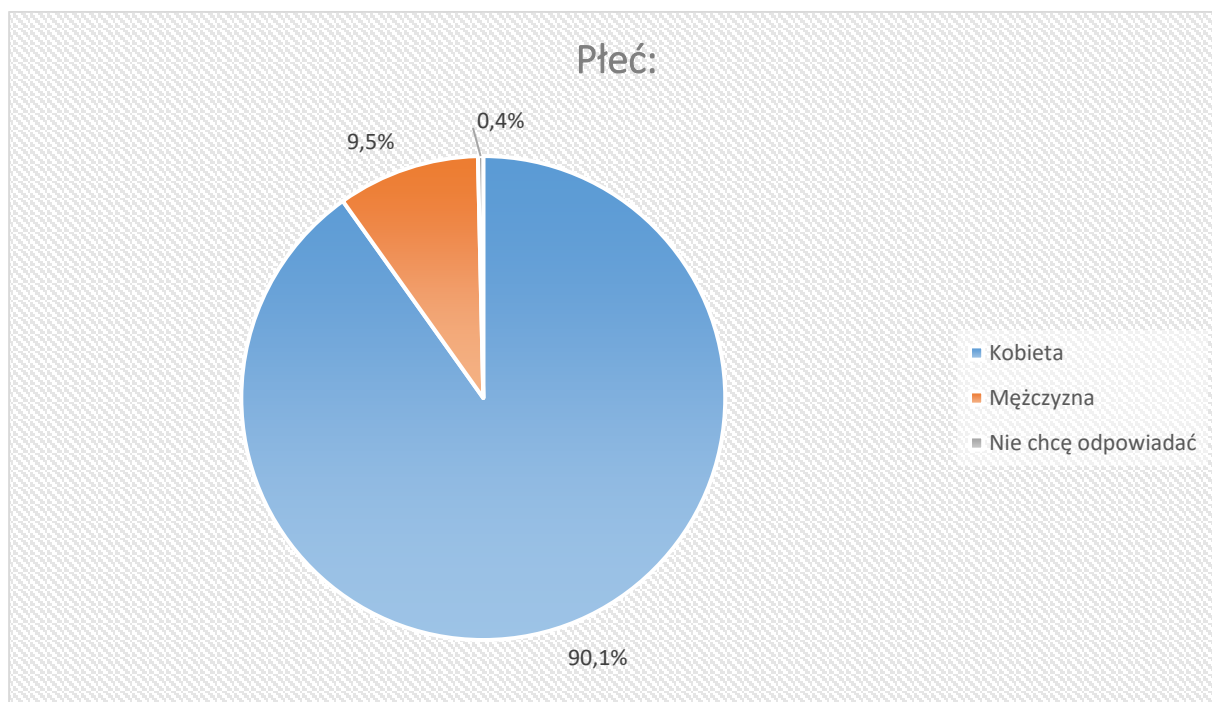
Ankieta sprawdzająca wiedzę po otwartym webinarze dla rodziców i opiekunów

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę po otwartym webinarze pt. „Pierwsza pomoc rodzicielska: jak rozpoznać kryzys u dziecka i nastolatka i jak zareagować?” zawierał: metryczkę składającą się z 2 pytań. Kolejne 5 pytań miało na celu zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników szkoły przed realizacją webinaru.

Post została wypełniona przez 284 osoby, co stanowi wyraźnie mniejszą liczbę w porównaniu do liczby osób zapisanych oraz uczestniczących w webinarze. Należy podkreślić, że udział w ankiecie miał charakter dobrowolny, co mogło istotnie wpłynąć na poziom responsywności. Dodatkowo webinar odbywał się w godzinach popołudniowo-wieczornych, a jego późna godzina zakończenia mogła ograniczać gotowość rodziców do pozostania do końca spotkania i wypełnienia ankiety. Istotnym czynnikiem była również konieczność wcześniejszego opuszczenia webinaru przez część uczestni-



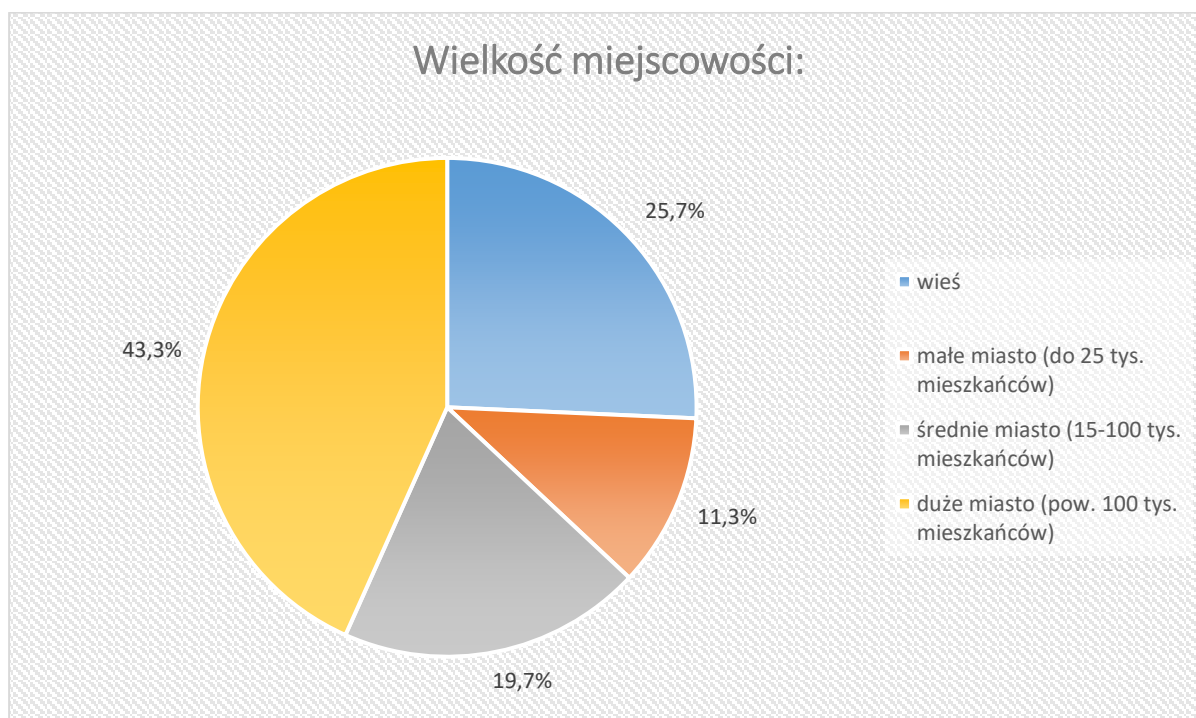
ków z uwagi na inne obowiązki rodzinne i zawodowe. W związku z powyższym niska liczebność postankiety nie powinna być interpretowana jako brak zaangażowania uczestników, lecz raczej jako efekt organizacyjnych i czasowych uwarunkowań udziału w spotkaniu oraz dobrowolnego charakteru badania ewaluacyjnego.



W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po spotkaniu edukacyjnym zdecydowaną większość respondentów stanowiły kobiety – 90,1% (256 osób). Mężczyźni stanowili 9,5% badanych (27 osób), natomiast 0,4% respondentów (1 osoba) nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o płeć.

Porównując te wyniki z ankietą wstępną (preankietą), można zauważyć, że również przed spotkaniem edukacyjnym dominującą grupą respondentów były kobiety, które stanowiły 92,6% badanych (5220 osób). Udział mężczyzn w preankiecie wyniósł 6,4% (363 osoby), natomiast 1,0% respondentów (56 osób) nie wskazało swojej płci.

Zestawienie obu pomiarów pokazuje, że struktura płci respondentów pozostaje spójna, z wyraźną przewagą kobiet zarówno przed, jak i po spotkaniu edukacyjnym. Jednocześnie w postankiecie widoczny jest nieznacznie wyższy udział mężczyzn, co należy interpretować z ostrożnością, ze względu na znacznie mniejszą liczebność próby po spotkaniu oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu.



W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po webinarze największą grupę respondentów stanowiły osoby mieszkające w dużych miastach – 43,3% (123 osoby). Niewiele mniejszy odsetek uczestników pochodził ze wsi – 25,7% (73 osoby). Respondenci ze średnich miast stanowili 19,7% badanych (56 osób), natomiast osoby z małych miast – 11,3% (32 osoby).

W ankiecie wstępnej (preankiecie) rozkład miejsca zamieszkania respondentów był bardziej zróżnicowany liczebnie. Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy dużych miast – 45,1% (2546 osób). Kolejną grupą byli respondenci mieszkający na wsi, którzy stanowili 23,2% badanych (1310 osób). Uczestnicy ze średnich miast stanowili 19,5% (1097 osób), natomiast osoby z małych miast – 12,2% (686 osób).

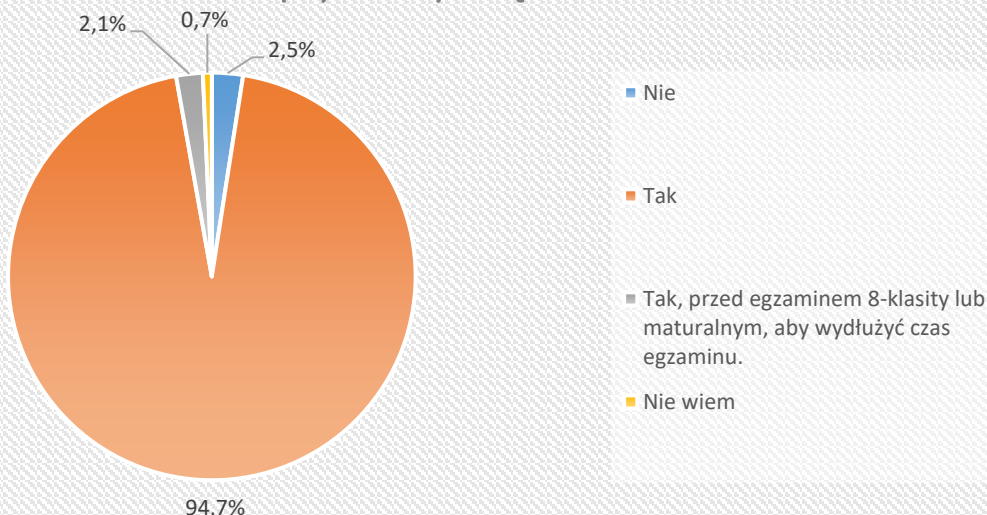
Porównanie wyników pre- i postankiety wskazuje, że struktura respondentów pod względem wielkości miejscowości zamieszkania pozostaje w dużej mierze spójna. Zarówno przed webinarzem, jak i po jego zakończeniu, najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy dużych miast, a kolejną – osoby mieszkające na obszarach wiejskich.

W postankiecie widoczny jest nieznacznie wyższy udział mieszkańców wsi oraz nieco niższy udział respondentów z małych miast w porównaniu z ankietą wstępną, jednak różnice te mają charakter niewielki i mogą wynikać z odmiennej liczebności próby oraz dobrowolnego charakteru udziału w badaniu po webinarze.

Uzyskane wyniki sugerują, że webinar dotarł do uczestników z różnych typów miejscowości, co potwierdza jego dostępność i potencjał do realizacji działań psychoedukacyjnych skierowanych do zróżnicowanych grup odbiorców, niezależnie od miejsca zamieszkania.

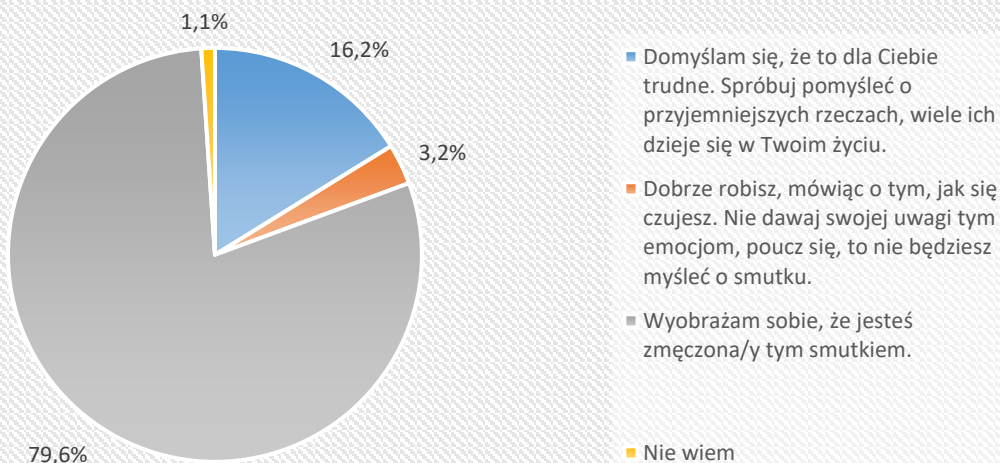


Czy szkoła powinna wiedzieć o tym, że dziecko objęte jest zewnętrzną pomocą psychoterapeutyczną lub psychiatryczną?



W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po webinarze zdecydowana większość respondentów udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie, czy szkoła powinna wiedzieć o tym, że dziecko jest objęte zewnętrzną pomocą psychoterapeutyczną lub psychiatryczną. Odpowiedź „Tak” wskazało 94,7% badanych (269 osób). Pozostałe odpowiedzi stanowiły łącznie 5,3% wskazań. W porównaniu z ankietą wstępną (preankietą) widoczna jest istotna poprawa poziomu wiedzy uczestników. Przed webinarzem poprawną odpowiedź „Tak” wskazało 80,3% respondentów (4526 osób), natomiast odpowiedzi nieprawidłowe łącznie stanowiły 19,7% wskazań (1113 osób). Zestawienie wyników sugeruje, że webinar przyczynił się do zwiększenia świadomości rodziców i opiekunów w zakresie roli szkoły oraz zasad współpracy z rodziną dziecka objętego pomocą psychoterapeutyczną lub psychiatryczną. Jednocześnie interpretując skalę zmiany, należy uwzględnić znacznie mniejszą liczebność próby w postankiecie oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu ewaluacyjnym.

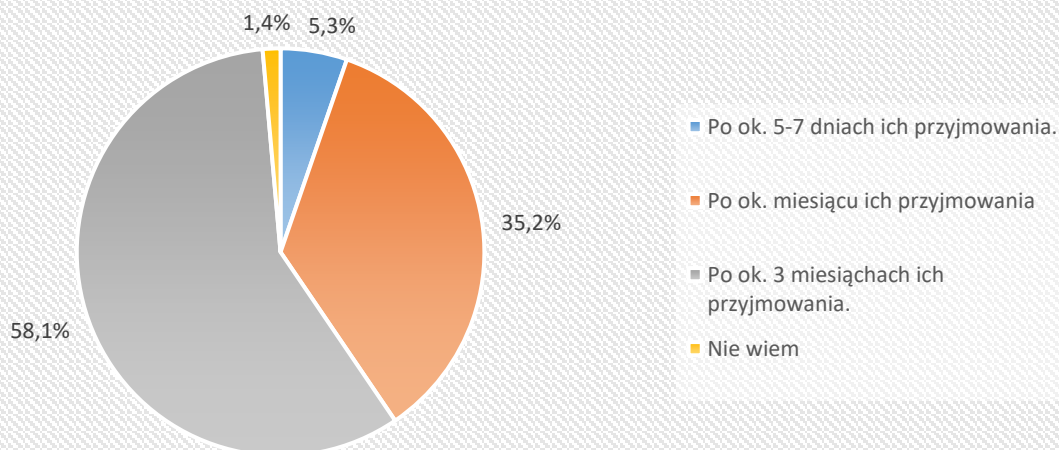
Jaka powinna być wypowiedź rodzica do dziecka, które mówi, że czuje dużo smutku?





W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po webinarze poprawną odpowiedź na pytanie o właściwą wypowiedź rodzica wobec dziecka mówiącego, że czuje dużo smutku wskazało 79,6% respondentów (226 osób). Za poprawną uznano empatyczną reakcję: „Wyobrażam sobie, że jesteś zmęczona/y tym smutkiem”. Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 20,4% wskazań (58 osób). W porównaniu z ankietą wstępną (preankietą), w której poprawną odpowiedź wskazało 44,4% respondentów (2502 osoby), a odpowiedzi nieprawidłowe stanowiły 55,6% (3138 osób), wyniki postankiety wskazują na wyraźny wzrost odsetka poprawnych wskazań. Uzyskane dane sugerują, że webinar przyczynił się do istotnego zwiększenia umiejętności rozpoznawania właściwej, empatycznej reakcji rodzica wobec dziecka doświadczającego trudnych emocji. Jednocześnie interpretując skalę zmiany, należy uwzględnić różnice w liczebności próby oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu ewaluacyjnym.

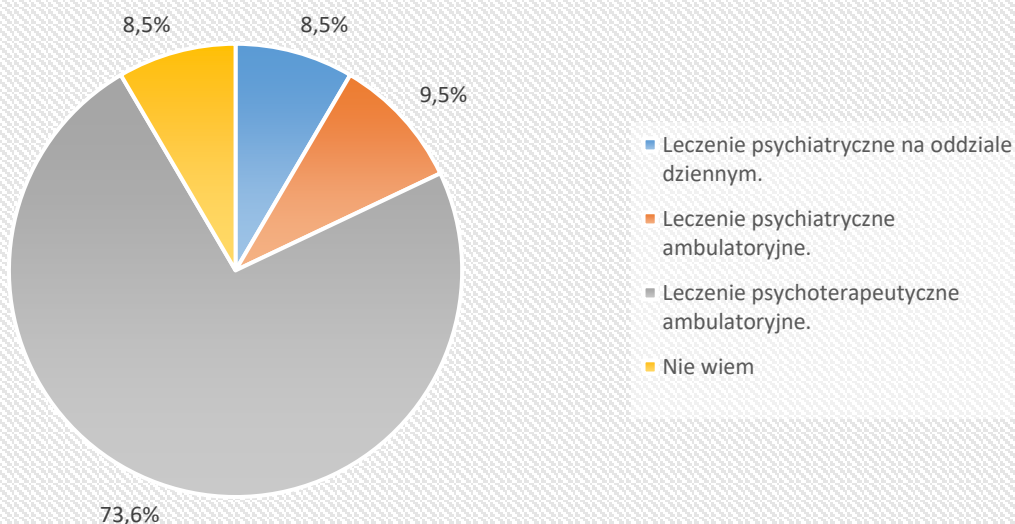
Po jakim czasie można spodziewać się poprawy funkcjonowania dziecka we wszystkich obszarach, jeśli przyjmuje ono leki antydepresyjne lub przeciwłękowe?



W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po webinarze poprawną odpowiedź na pytanie, po jakim czasie można spodziewać się poprawy funkcjonowania dziecka we wszystkich obszarach przy stosowaniu leków antydepresyjnych lub przeciwłękowych, wskazało 58,1% respondentów (165 osób). Prawidłową odpowiedzią było wskazanie, że poprawy można oczekiwać po około 3 miesiącach przyjmowania leków. Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 41,9% wskazań (119 osób). W porównaniu z ankietą wstępną (preankietą), w której poprawną odpowiedź wskazało 26,0% respondentów (1466 osób), a odpowiedzi nieprawidłowe stanowiły 74,0% (4173 osoby), wyniki postankiety pokazują wyraźny wzrost poziomu wiedzy wśród uczestników, którzy zdecydowali się wypełnić ankietę po webinarze. Jednocześnie interpretując poprawę wyników, należy uwzględnić znacznie mniejszą liczebność próby w postankiecie oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu ewaluacyjnym.

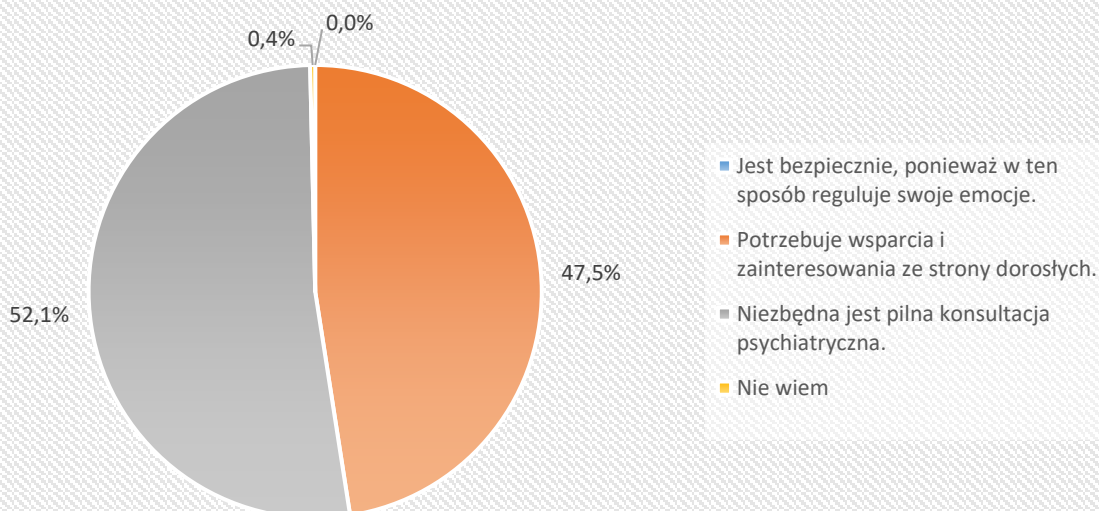


Jaka jest najskuteczniejsza forma leczenia depresji u dzieci i nastolatków?



W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po webinarze poprawną odpowiedź na pytanie o najskuteczniejszą formę leczenia depresji u dzieci i nastolatków wskazało 73,6% respondentów (209 osób). Prawidłową odpowiedzią było leczenie psychoterapeutyczne ambulatoryjne. Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 26,4% wskazań (75 osób). W porównaniu z ankietą wstępną (preankietą), w której poprawną odpowiedź wskazało 41,3% respondentów (2327 osób), a odpowiedzi nieprawidłowe stanowiły 58,7% (3312 osób), wyniki postankiety pokazują wyraźny wzrost poziomu wiedzy wśród uczestników, którzy zdecydowali się wypełnić ankietę po webinarze. Jednocześnie interpretując zaobserwowaną poprawę, należy uwzględnić znacznie mniejszą liczebność próby w postankiecie oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Co oznacza jeśli dziecko mówi: „Na nic nie mam siły, nie chce mi się żyć”?





W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po webinarze poprawną odpowiedź na pytanie, co oznacza wypowiedź dziecka: „Na nic nie mam siły, nie chce mi się żyć”, wskazało 47,5% respondentów (135 osób). Za prawidłową uznano odpowiedź, że dziecko potrzebuje wsparcia i zainteresowania ze strony dorosłych. Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 52,5% wskazań (149 osób). W porównaniu z ankietą wstępną (preankietą), w której poprawną odpowiedź wskazało 50,2% respondentów (2828 osób), a odpowiedzi nieprawidłowe stanowiły 49,8% (2811 osób), wyniki postankiety pokazują nieznacznie niższy odsetek poprawnych odpowiedzi. Różnica ta powinna być jednak interpretowana z ostrożnością, ze względu na znacznie mniejszą liczebność próby po webinarze oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu ewaluacyjnym. Jednocześnie brak odpowiedzi „Nie wiem” w postankiecie może wskazywać na większą skłonność uczestników do jednoznacznego interpretowania wypowiedzi dziecka po udziale w webinarze.

Podsumowanie

Analiza wyników ankiet sprawdzających poziom wiedzy przed i po webinarze „Pierwsza pomoc rodzicielska: jak rozpoznać kryzys emocjonalny u dziecka i nastolatka i jak zareagować?” wskazuje, że wydarzenie to dotarło do szerokiego i zróżnicowanego grona rodziców i opiekunów, głównie kobiet, zamieszkujących zarówno duże miasta, jak i obszary wiejskie. Struktura socjodemograficzna uczestników pre- i postankiety pozostawała zasadniczo spójna, przy jednoczesnym uwzględnieniu znacznie mniejszej liczebności próby po webinarze.

Wyniki ankiety wstępnej pokazały, że rodzice i opiekunowie dysponowali częściową wiedzą w zakresie rozpoznawania kryzysu emocjonalnego u dzieci i nastolatków, jednak w wielu kluczowych obszarach – takich jak prawidłowa komunikacja z dzieckiem przeżywającym trudne emocje, rozumienie znaczenia wypowiedzi o rezygnacji z życia, realistyczne oczekiwania wobec farmakoterapii czy znajomość podstawowych zasad leczenia depresji – widoczne były istotne luki wiedzy.

Porównanie wyników pre- i postankiety wskazuje na poprawę poziomu wiedzy uczestników w kilku istotnych obszarach, w szczególności dotyczących roli szkoły we współpracy z rodziną dziecka objętego pomocą psychoterapeutyczną lub psychiatryczną oraz czasu działania leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych. Jednocześnie analiza odpowiedzi ujawnia, że nie wszystkie zagadnienia zostały w jednakowym stopniu przyswojone przez uczestników webinaru. W obszarach wymagających bardziej subtelnych kompetencji, takich jak empatyczna komunikacja z dzieckiem czy właściwa interpretacja sygnałów świadczących o głębokim kryzysie emocjonalnym, część respondentów nadal udzielała odpowiedzi nie w pełni prawidłowych.

Uzyskane wyniki należy interpretować z ostrożnością, mając na uwadze mniejszą liczebność postankiety oraz fakt, że wypełniły ją osoby szczególnie zmotywowane do dalszego pogłębiania wiedzy. Jednocześnie całkowity lub znaczący spadek odpowiedzi „Nie wiem” w części pytań może świadczyć o wzroście gotowości uczestników do podejmowania refleksji i zajmowania stanowiska wobec poruszanych zagadnień.

Podsumowując, webinar stanowił wartościową formę edukacji rodziców i opiekunów, przyczyniając się do zwiększenia ich świadomości w zakresie rozpoznawania kryzysu emocjonalnego u dzieci i nastolatków oraz zasad reagowania w sytuacjach trudnych. Wyniki ankiet potwierdzają jednocześnie potrzebę dalszych działań edukacyjnych, szczególnie ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności empatycznej komunikacji, właściwej interpretacji sygnałów alarmowych oraz budowania realistycznych oczekiwań wobec procesu leczenia i wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży.



„Pierwsza pomoc rodzicielska: Uzależnienia dzieci i młodzieży”

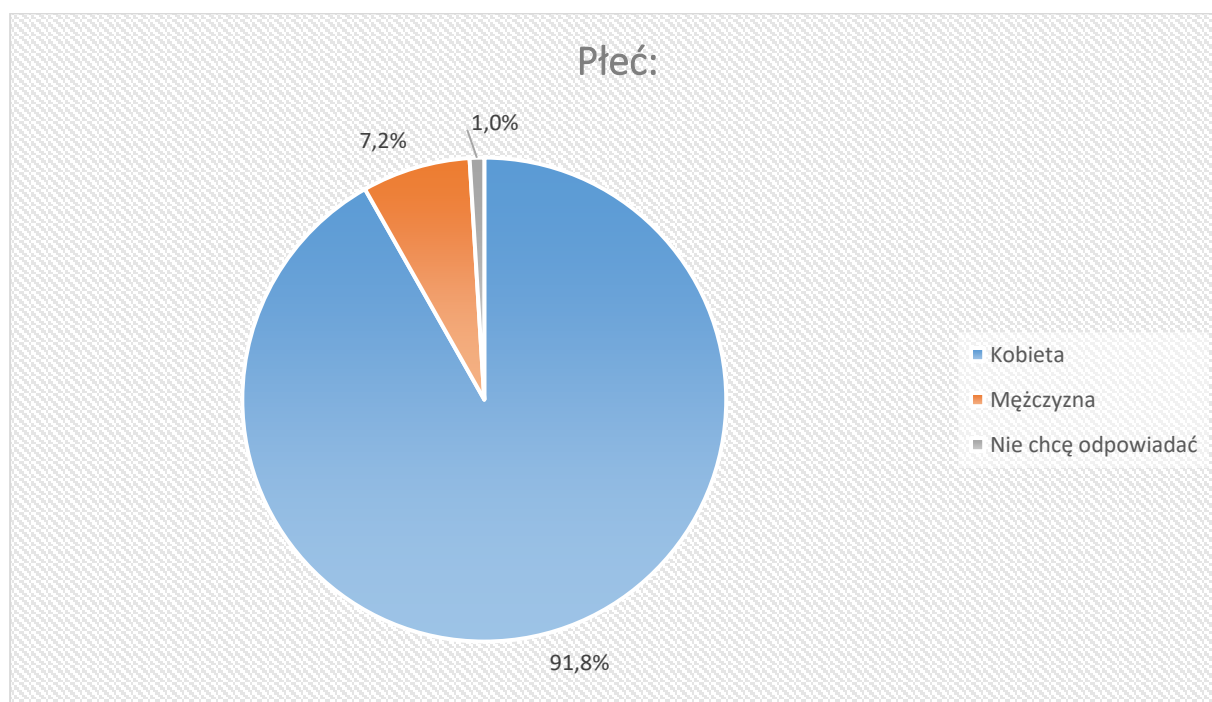
„Pierwsza pomoc rodzicielska: Uzależnienia dzieci i młodzieży” to otwarte webinary realizowane pod parasolem programu Wsparająca Szkoła skierowane do wszystkich rodziców i opiekunów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat uzależnień u młodych osób. Podczas spotkania edukacyjnego uczestnicy dowiedzieli się czym jest uzależnienie (w tym uzależnienie behawioralne), jakie są jego biologiczne, psychologiczne i społeczne mechanizmy oraz jakie wyróżniamy fazy jego rozwoju. Webinar poświęcony był również najczęstszemu sygnałom ostrzegawczym, budowaniu zaufania oraz skutecznej komunikacji z dzieckiem i nastolatkiem.

Odbyły się 4 webinary otwarte, w których łącznie wzięło udział 513 osób.

Ankieta sprawdzająca wiedzę przed otwartym webinarium dla rodziców i opiekunów

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę przed otwartym webinarium pt. „Pierwsza pomoc rodzicielska: uzależnienia dzieci i młodzieży” zawierał metryczkę składającą się z 2 pytań oraz 5 pytań sprawdzających wiedzę przed realizacją webinaru.

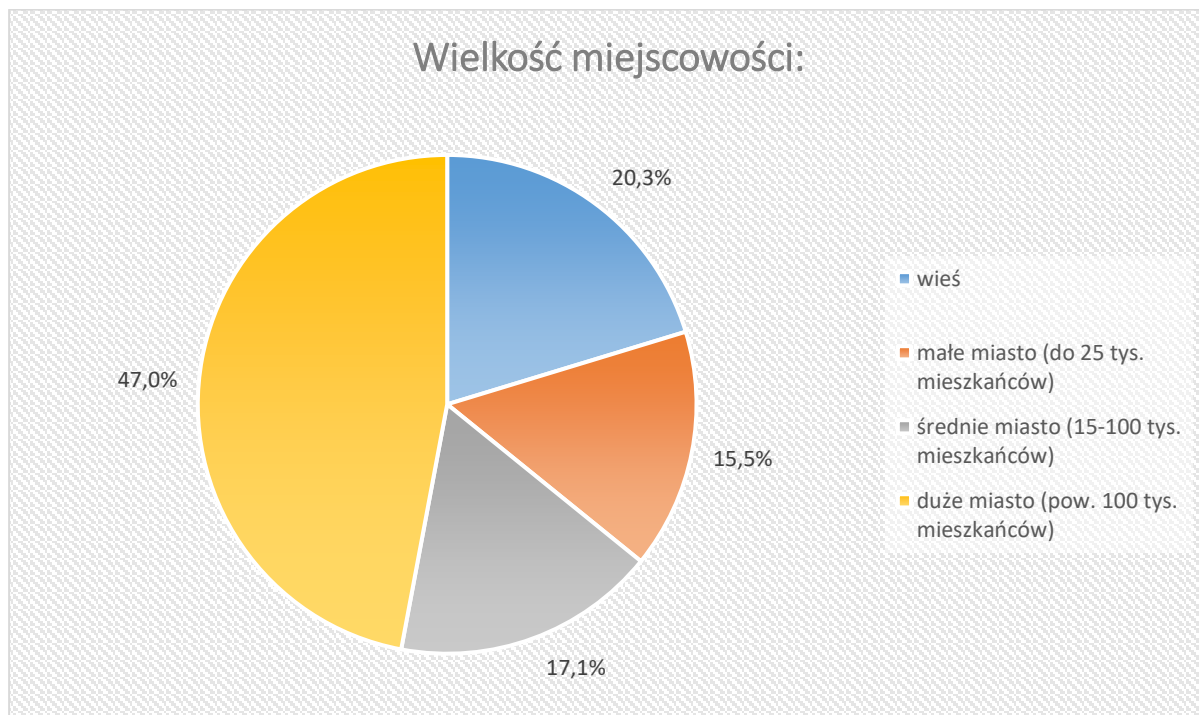
Preankieta została wypełniona przez 1113 osób. Preankieta (ankieta sprawdzająca wiedzę przed webinarium) była wypełniana przez uczestników na etapie zapisywania się na wydarzenie. Wynik ten wskazuje, że zdecydowana większość osób zapisuje się na webinar, niż ostatecznie bierze w nim udział.



Wykres przedstawia strukturę płci respondentów ankiety sprawdzającej poziom wiedzy przed szkoleniem. Zebrane dane wskazują na wyraźną dominację kobiet, które stanowiły 91,8% badanych (1040 osób). Mężczyźni reprezentowali 7,2% respondentów (82 osoby), natomiast 1,0% ankietowanych (11 osób) zdecydowało się nie udzielać odpowiedzi na pytanie o płeć. Uzyskane wyniki pokazują, że w badaniu wstępnym zdecydowaną większość uczestników stanowili respondenci płci żeńskiej.

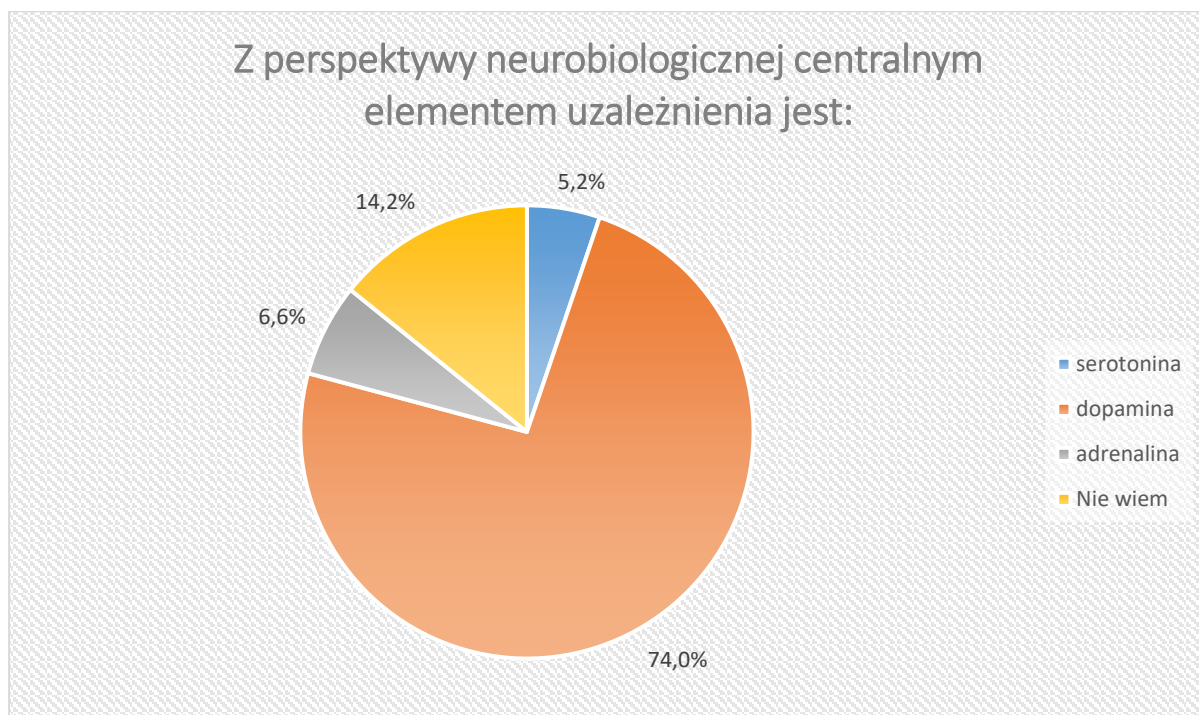


Wielkość miejscowości:



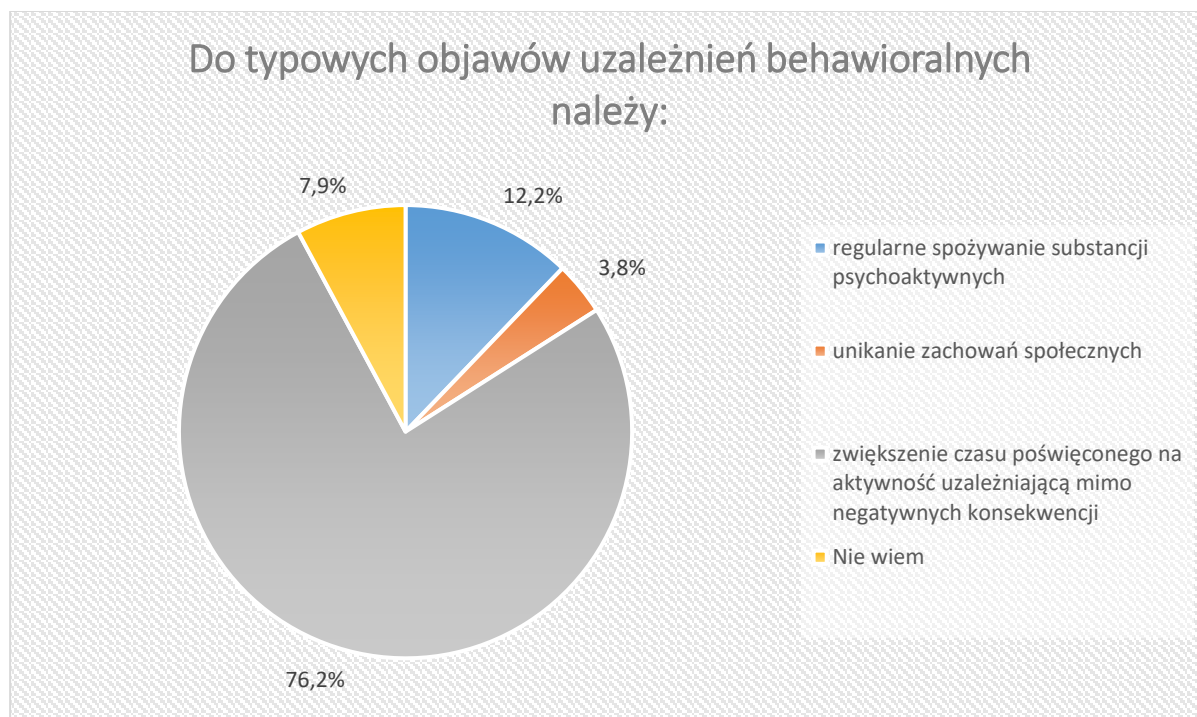
Wykres przedstawia strukturę respondentów ankiety sprawdzającej poziom wiedzy przed szkoleniem ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania. Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) – 47,0% badanych (533 osoby). Kolejną grupą byli respondenci mieszkający na wsi, którzy stanowili 20,3% próby (230 osób). Uczestnicy ze średnich miast (15–100 tys. mieszkańców) stanowili 17,1% badanych (194 osoby), natomiast osoby z małych miast (do 25 tys. mieszkańców) – 15,5% respondentów (176 osób). Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowaną strukturę respondentów pod względem miejsca zamieszkania, z wyraźną przewagą osób zamieszkujących duże miasta.

Z perspektywy neurobiologicznej centralnym elementem uzależnienia jest:





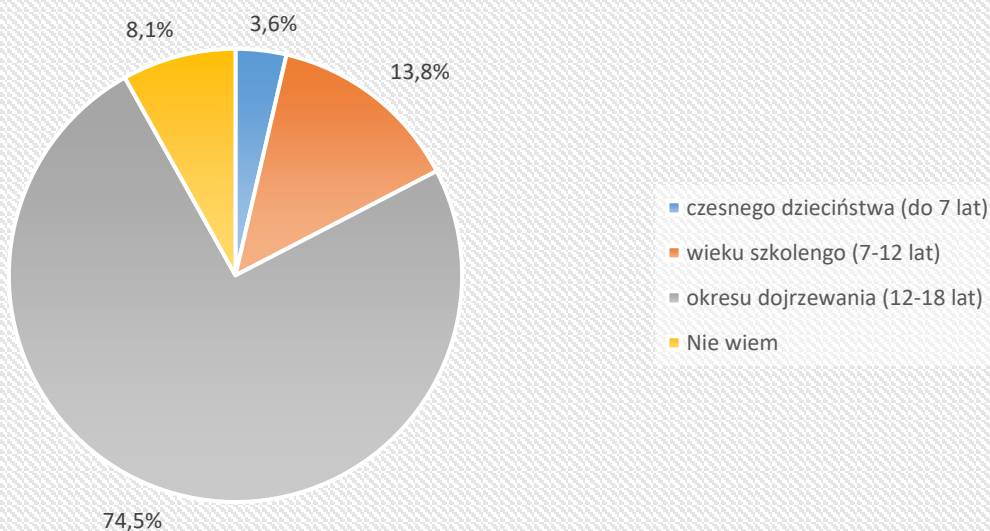
Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium na pytanie: „Z perspektywy neurobiologicznej centralnym elementem uzależnienia jest:”. Poprawną odpowiedzią była dopamina, którą wskazała zdecydowana większość respondentów – 74,0% (838 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 26,0% wskazań (295 osób). Uzyskane wyniki pokazują, że choć większość uczestników posiada prawidłową wiedzę na temat neurobiologicznych mechanizmów uzależnienia, ponad co czwarty respondent wymaga dalszego wsparcia edukacyjnego w zakresie roli dopaminy w procesach uzależnienia.



Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium na pytanie: „Do typowych objawów uzależnień behawioralnych należy:”. Poprawną odpowiedzią było zwiększanie czasu poświęcanego na aktywność uzależniającą mimo negatywnych konsekwencji, które wskazała zdecydowana większość respondentów – 76,2% (863 osoby). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 23,8% wskazań (270 osób). Uzyskane wyniki pokazują, że większość uczestników prawidłowo identyfikuje kluczowy objaw uzależnień behawioralnych. Jednocześnie niemal co czwarty respondent udzielił odpowiedzi błędnej lub zadeklarował brak wiedzy, co wskazuje na potrzebę dalszych działań edukacyjnych w zakresie rozróżniania uzależnień behawioralnych i substancjalnych oraz ich podstawowych objawów.

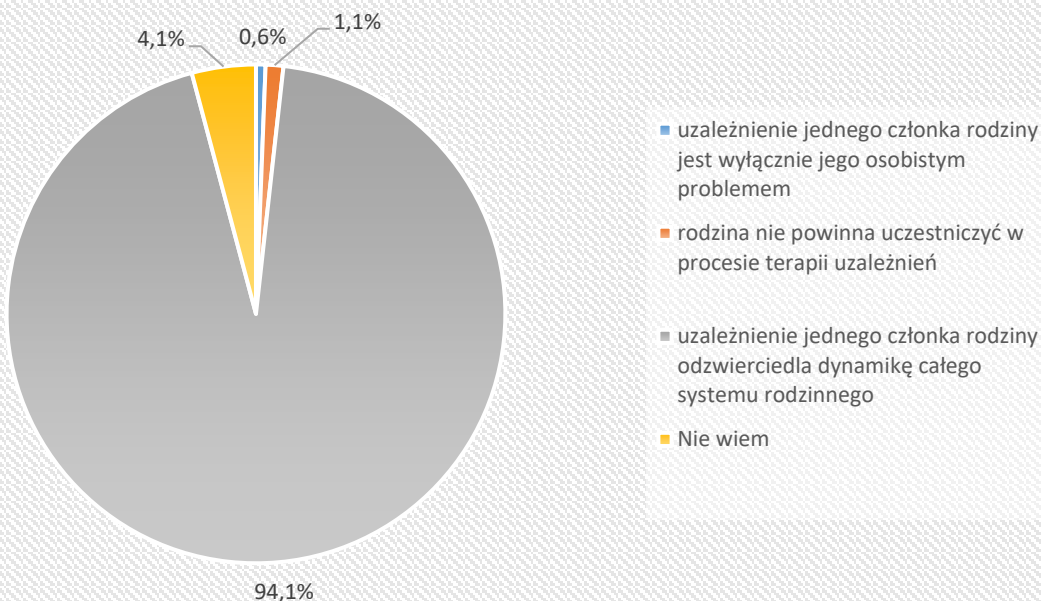


Największa podatność na uzależnienia przypada na okres:



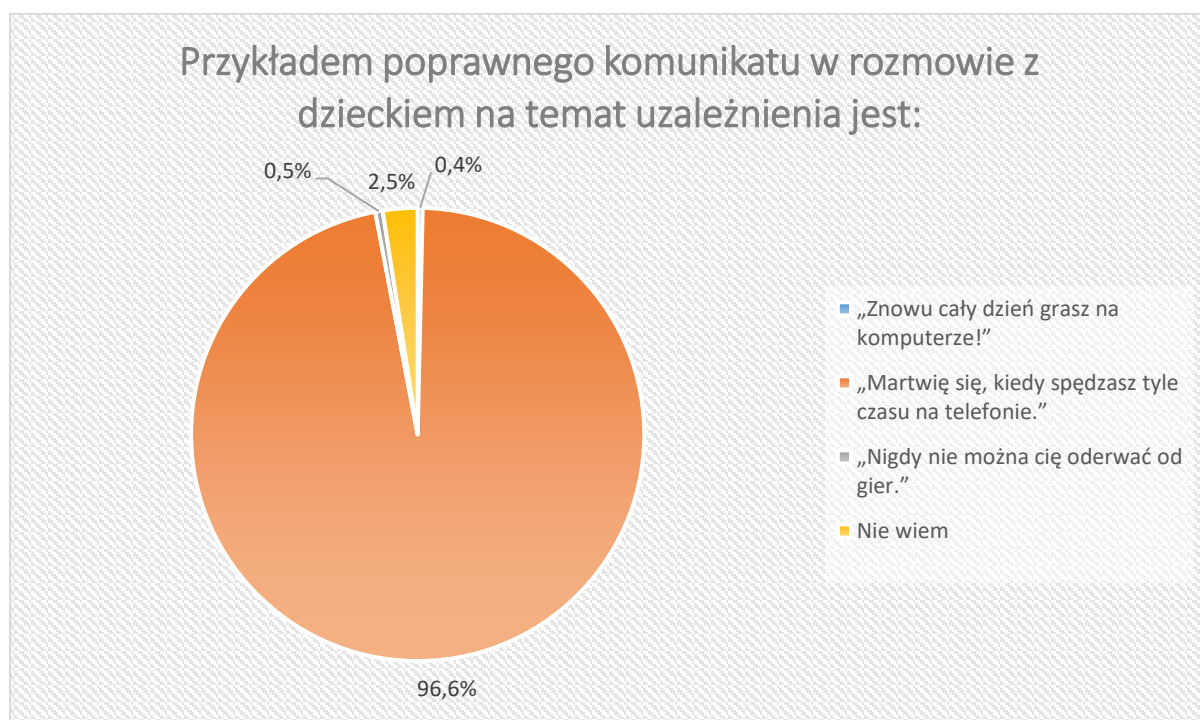
Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarium na pytanie: „Największa podatność na uzależnienia przypada na okres:”. Poprawną odpowiedzią był okres wczesnego dzieciństwa (do 7 lat), który wskazało 3,6% respondentów (41 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 96,4% wskazań (1092 osoby). Uzyskane wyniki pokazują, że wiedza uczestników w zakresie okresu największej podatności na uzależnienia jest wyraźnie niewystarczająca. Zdecydowana większość respondentów błędnie wskazała późniejsze etapy rozwoju, co podkreśla potrzebę intensyfikacji działań edukacyjnych dotyczących znaczenia wczesnego dzieciństwa dla kształtowania mechanizmów podatności na uzależnienia.

Systemowe ujęcie rodziny zakłada, że:





Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarzem na pytanie: „Systemowe ujęcie rodziny zakłada, że:”. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie, że „uzależnienie jednego członka rodziny odzwierciedla dynamikę całego systemu rodzinnego”, które wskazała zdecydowana większość respondentów – 94,1% (1066 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 5,9% wskazań (67 osób). Uzyskane wyniki pokazują bardzo wysoki poziom wiedzy uczestników w zakresie systemowego rozumienia rodziny i uzależnień. Nieliczna grupa respondentów udzielających odpowiedzi błędnych lub deklarujących brak wiedzy wskazuje jednak na potrzebę dalszego, choć już bardziej pogłębionego, wzmacniania perspektywy systemowej w działaniach edukacyjnych.



Wykres przedstawia odpowiedzi uczestników ankiety wstępnej sprawdzającej poziom wiedzy przed webinarzem na pytanie: „Przykładem poprawnego komunikatu w rozmowie z dzieckiem na temat uzależnienia jest:”. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie „Martwię się, kiedy spędzasz tyle czasu na telefonie.”, które wskazała zdecydowana większość respondentów – 96,6% (1095 osób). Pozostałe odpowiedzi należy uznać za nieprawidłowe – łącznie stanowiły one 3,4% wskazań (39 osób). Uzyskane wyniki pokazują bardzo wysoki poziom świadomości uczestników w zakresie prawidłowej, empatycznej komunikacji z dzieckiem na temat zachowań problemowych. Niewielki odsetek odpowiedzi błędnych sugeruje jednak, że warto nadal wzmacniać kompetencje dorosłych w obszarze komunikatów opartych na wyrażaniu troski i własnych emocji, zamiast ocen i krytyki.

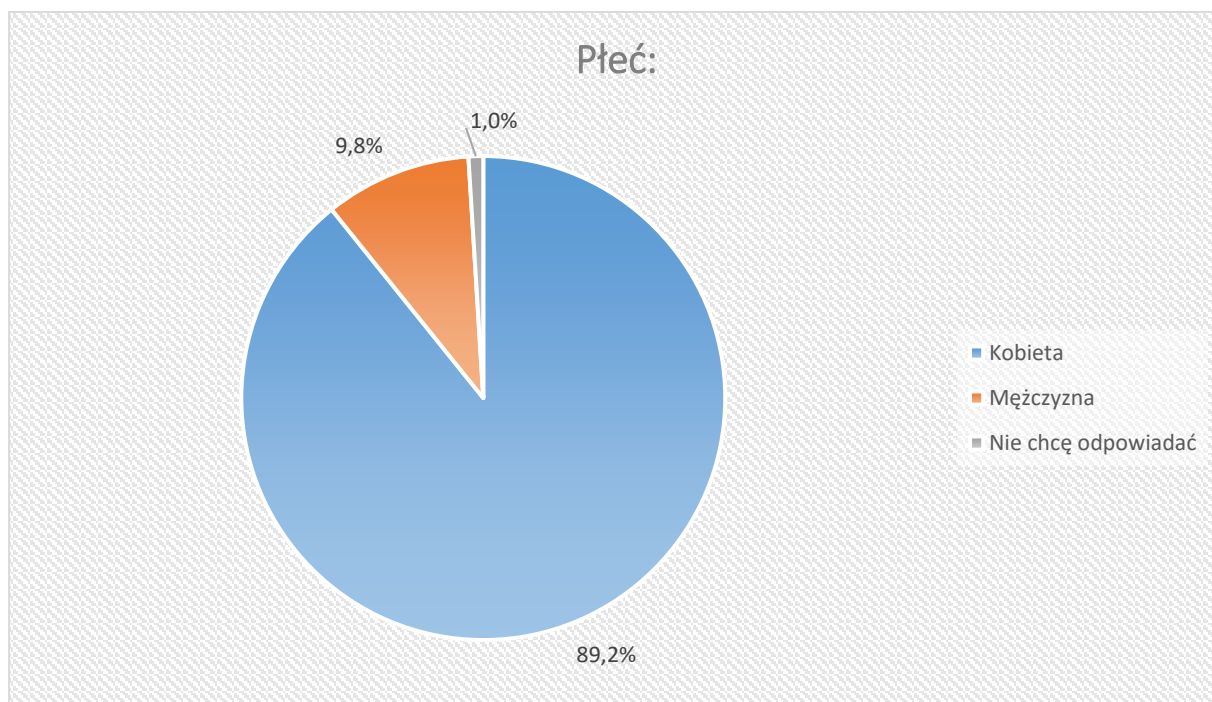
Ankieta sprawdzająca wiedzę po otwartym webinarze dla rodziców i opiekunów

Formularz ankiety sprawdzającej wiedzę po otwartym webinarze pt. „Pierwsza pomoc rodzicielska: uzależnienia dzieci i młodzieży?” zawierał: metryczkę składającą się z 2 pytań oraz 5 pytań sprawdzających poziom wiedzy po odbytych webinarze.

Post została wypełniona przez 102 osoby, co stanowi wyraźnie mniejszą liczbę w porównaniu do liczby osób zapisanych oraz uczestniczących w webinarze. Należy podkreślić, że udział w ankiecie miał charakter dobrowolny, co mogło istotnie wpłynąć na poziom responsywności. Dodatkowo webinar odbywał się w godzinach popołudniowo-wieczornych, a jego późna godzina zakończenia mogła ograniczać gotowość rodziców do pozostania do końca spotkania i wypełnienia ankiety. Istotnym czynnikiem była również konieczność wcześniejszego opuszczania webinaru przez część uczestni-



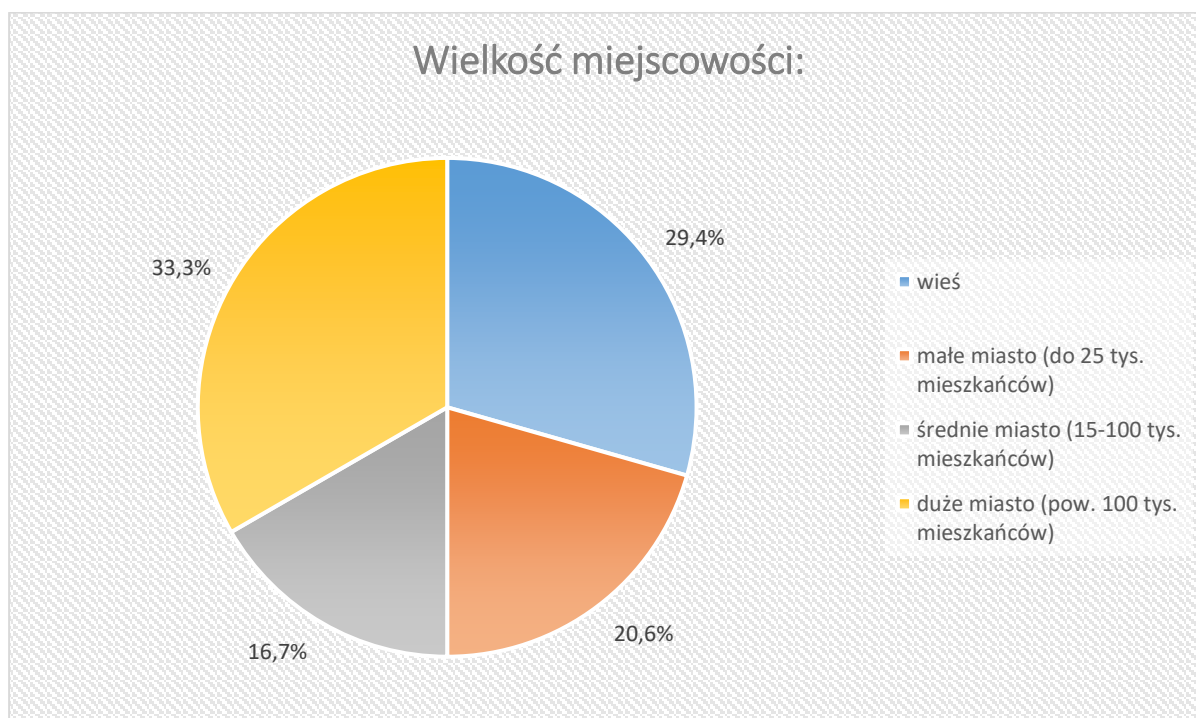
ków z uwagi na inne obowiązki rodzinne i zawodowe. W związku z powyższym niska liczebność postankiety nie powinna być interpretowana jako brak zaangażowania uczestników, lecz raczej jako efekt organizacyjnych i czasowych uwarunkowań udziału w spotkaniu oraz dobrowolnego charakteru badania ewaluacyjnego.



W badaniu ankietowym zdecydowaną większość respondentów stanowiły kobiety – 89,2% (91 osób). Mężczyźni stanowili 9,8% badanych (10 osób), natomiast 1,0% respondentów (1 osoba) nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o płeć.

Porównując te wyniki z ankietą wstępną (preankietą), można zauważyć, że również na wcześniejszym etapie badania dominującą grupą respondentów były kobiety, które stanowiły 91,8% badanych (1040 osób). Udział mężczyzn w preankiecie wyniósł 7,2% (82 osoby), natomiast 1,0% respondentów (11 osób) nie wskazało swojej płci.

Zestawienie obu pomiarów wskazuje, że struktura płci respondentów pozostaje spójna, z wyraźną przewagą kobiet zarówno w preankiecie, jak i w badaniu właściwym. W drugim pomiarze widoczny jest nieznacznie wyższy udział mężczyzn, co jednak należy interpretować z ostrożnością, mając na uwadze mniejszą liczebność próby oraz dobrowolny charakter udziału w badaniu.



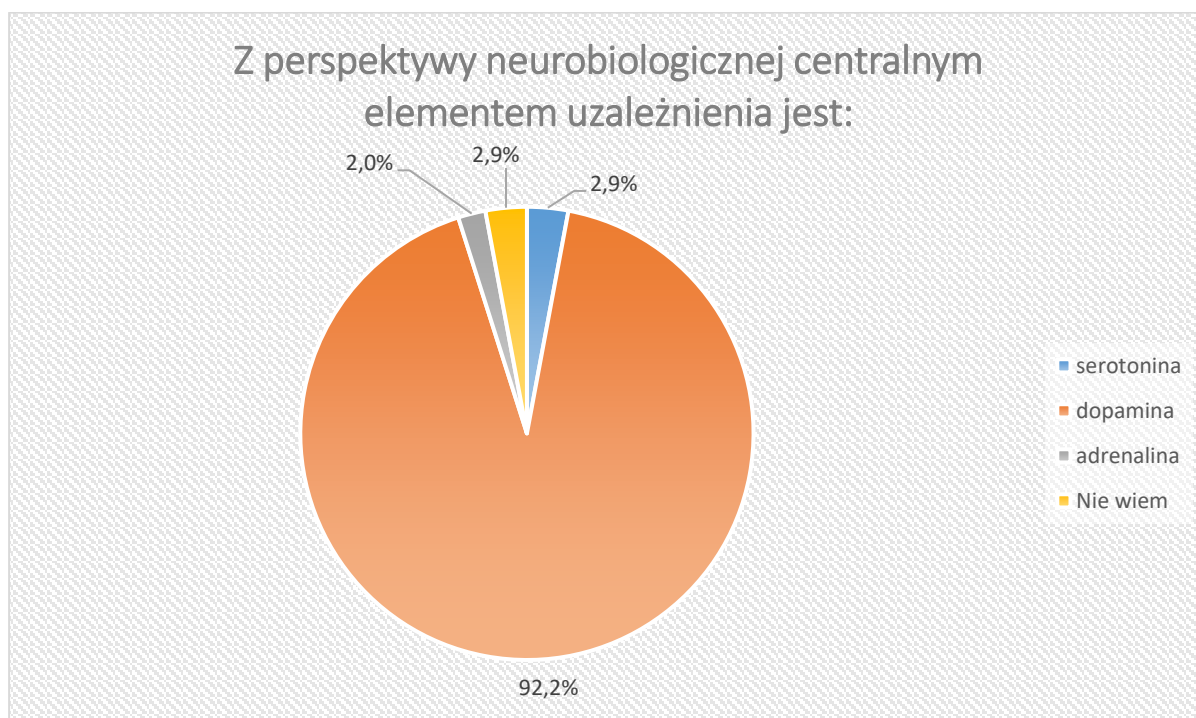
W ankiecie sprawdzającej poziom wiedzy po webinarze największą grupę respondentów stanowiły osoby mieszkające w dużych miastach – 33,3% (34 osoby). Niewiele mniejszy odsetek uczestników pochodził ze wsi, które reprezentowało 29,4% badanych (30 osób). Respondenci z małych miast (do 25 tys. mieszkańców) stanowili 20,6% próby (21 osób), natomiast osoby zamieszkujące średnie miasta (15–100 tys. mieszkańców) – 16,7% (17 osób).

W ankiecie wstępnej (preankiecie) rozkład miejsca zamieszkania respondentów był bardziej zróżnicowany liczebnie. Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy dużych miast, którzy odpowiadali za 47,0% badanych (533 osoby). Kolejną grupą byli respondenci mieszkający na wsi – 20,3% (230 osób). Uczestnicy ze średnich miast stanowili 17,1% próby (194 osoby), natomiast osoby z małych miast – 15,5% (176 osób).

Porównanie wyników pre- i postankiety wskazuje, że struktura respondentów pod względem wielkości miejscowości zamieszkania pozostaje w dużej mierze spójna. Zarówno przed rozpoczęciem działań, jak i po ich zakończeniu, najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy dużych miast, a istotny udział miały również osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

W badaniu końcowym widoczny jest relatywnie wyższy udział respondentów ze wsi oraz z małych miast, przy jednocześnie niższym udziale mieszkańców dużych miast w porównaniu z preankietą. Różnice te należy jednak interpretować z ostrożnością, mając na uwadze znacznie mniejszą liczebność próby w badaniu końcowym oraz dobrowolny charakter udziału respondentów.

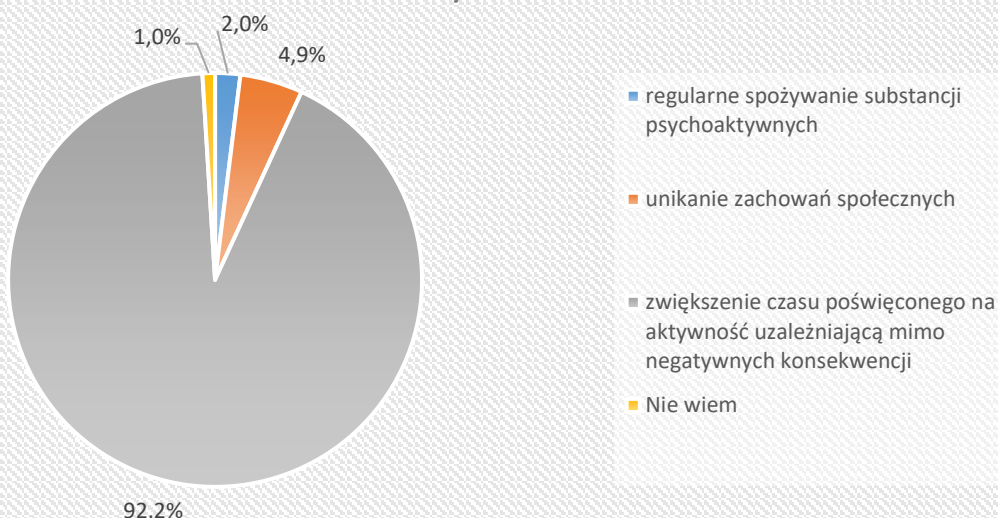
Uzyskane wyniki sugerują, że działania objęte badaniem dotarły do uczestników zamieszkujących różne typy miejscowości, co potwierdza ich dostępność oraz potencjał do realizacji działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym skierowanych do zróżnicowanych grup odbiorców, niezależnie od miejsca zamieszkania.



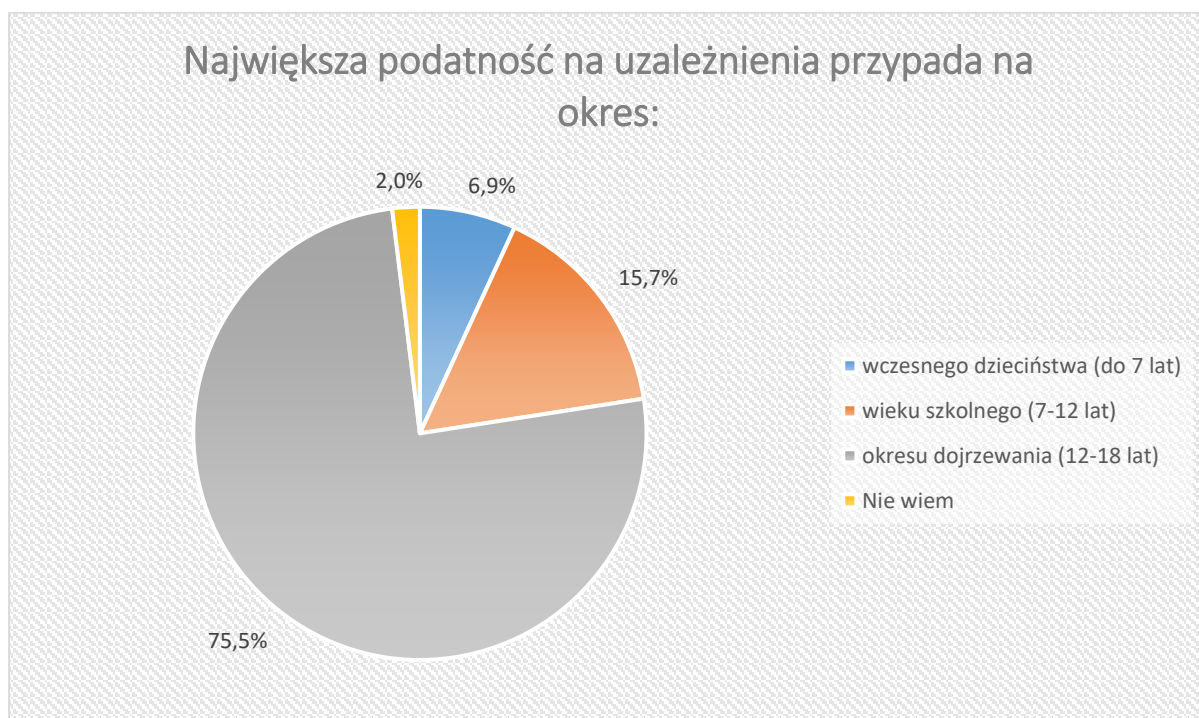
Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Z perspektywy neurobiologicznej centralnym elementem uzależnienia jest:”, zadane przed i po zakończeniu szkolenia. Poprawną odpowiedzią była dopamina. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość respondentów, tj. 92,2% badanych (94 osoby). Odpowiedzi błędne lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie 7,8% respondentów (8 osób), w tym odpowiedzi wskazujące serotoninę, adrenalinę oraz odpowiedź „nie wiem”. Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 74,0% badanych (838 osób), natomiast 26,0% respondentów (295 osób) udzieliło odpowiedzi błędnych lub zadeklarowało brak wiedzy. Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na istotny wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie neurobiologicznych mechanizmów uzależnienia. Odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł o 18,2 punktu procentowego, przy jednoczesnym wyraźnym spadku liczby odpowiedzi błędnych oraz deklaracji braku wiedzy. Pomimo różnic w liczebności respondentów biorących udział w badaniu przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają skuteczność szkolenia w porządkowaniu i utrwalaniu wiedzy dotyczącej roli dopaminy jako kluczowego neurobiologicznego mechanizmu uzależnienia.



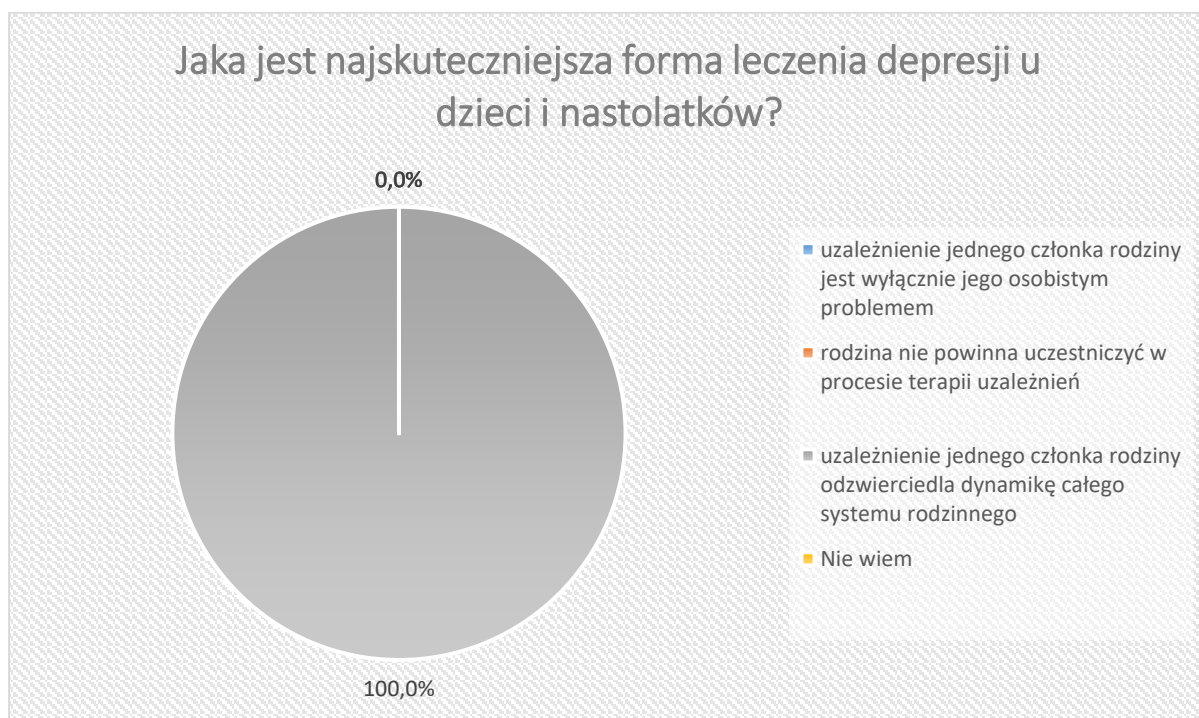
Do typowych objawów uzależnień behawioralnych należy:



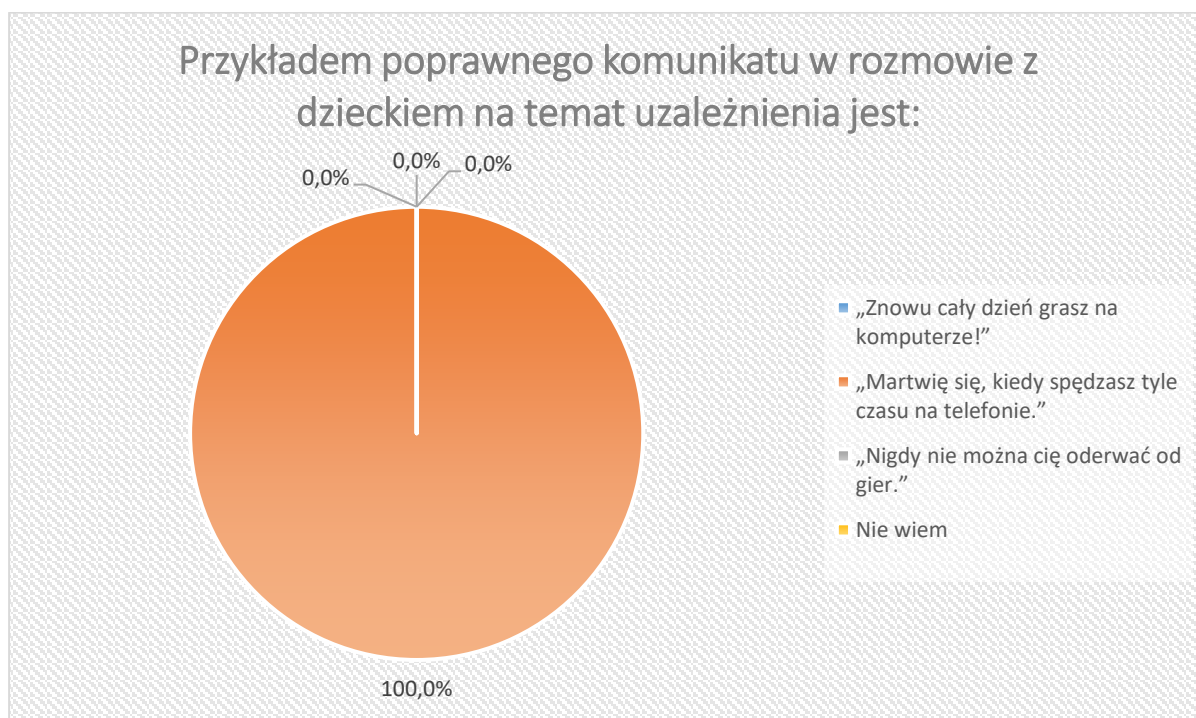
Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Do typowych objawów uzależnień behawioralnych należy:”, zadane przed i po zakończeniu szkolenia. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: „zwiększanie czasu poświęcanego na aktywność uzależniającą mimo negatywnych konsekwencji”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość respondentów, tj. 92,2% badanych (94 osoby). Odpowiedzi błędne lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie 7,8% respondentów (8 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed webinarzem poprawną odpowiedź wskazało 76,2% badanych (863 osoby). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy udzieliło łącznie 23,8% respondentów (270 osób). Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wyraźny wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie rozumienia istoty uzależnień behawioralnych. Odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł o 16,0 punktów procentowych, przy jednoczesnym znaczącym spadku liczby odpowiedzi błędnych oraz deklaracji braku wiedzy. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w badaniu przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają skuteczność szkolenia w porządkowaniu i utrwalaniu wiedzy dotyczącej kluczowych objawów uzależnień behawioralnych, w szczególności w odróżnianiu ich od symptomów charakterystycznych dla uzależnień od substancji psychoaktywnych.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Największa podatność na uzależnienia przypada na okres:”, zadane przed i po zakończeniu szkolenia. Poprawną odpowiedzią było wskazanie: wczesnego dzieciństwa (do 7 lat). W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliło 15,7% badanych (16 osób). Odpowiedzi błędne lub deklarację braku wiedzy wskazało łącznie 84,3% respondentów (86 osób). Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 3,6% badanych (41 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy udzieliło łącznie 96,4% respondentów (1092 osoby). Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi po szkoleniu (z 3,6% do 15,7%), co sugeruje poprawę wiedzy uczestników w zakresie rozumienia szczególnej wrażliwości rozwojowej we wczesnym dzieciństwie. Jednocześnie nadal widoczna jest silna dominacja odpowiedzi wskazującej okres dojrzewania, co może świadczyć o utrwalonych intuicyjnych przekonaniach dotyczących podatności na uzależnienia. Pomimo różnic w liczebności respondentów biorących udział w badaniu przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki potwierdzają, że szkolenie przyczyniło się do zwiększenia rozpoznawalności poprawnej odpowiedzi, choć w tym obszarze wskazane może być dalsze wzmacnianie przekazu edukacyjnego.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie odnoszące się do systemowego ujęcia rodziny, sformułowane jako: „Systemowe ujęcie rodziny zakłada, że:”, zadane przed i po zakończeniu szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „uzależnienie jednego członka rodziny odzwierciedla dynamikę całego systemu rodzinnego”. W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzielili wszyscy respondenci, tj. 100,0% badanych (102 osoby). Nie odnotowano odpowiedzi błędnych ani deklaracji braku wiedzy, co wskazuje na pełne zrozumienie omawianego zagadnienia wśród uczestników badania końcowego. Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 94,1% badanych (1066 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy udzieliło łącznie 5,9% respondentów (67 osób). Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na pełne utrwalenie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie systemowego rozumienia funkcjonowania rodziny w kontekście uzależnień. Odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł o 5,9 punktu procentowego, osiągając poziom maksymalny w badaniu końcowym, przy jednoczesnej eliminacji odpowiedzi błędnych i deklaracji braku wiedzy. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w badaniu przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają wysoką skuteczność szkolenia w kształtowaniu systemowego, całościowego podejścia do problematyki uzależnień, podkreślającego znaczenie relacji rodzinnych w procesie rozumienia i leczenia problemów uzależnieniowych.



Wykres przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie: „Przykładem poprawnego komunikatu w rozmowie z dzieckiem na temat uzależnienia jest:”, zadane przed i po zakończeniu szkolenia. Poprawną odpowiedzią było stwierdzenie: „Martwię się, kiedy spędzasz tyle czasu na telefonie.” W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu prawidłowej odpowiedzi udzieliłi wszyscy respondenci, tj. 100,0% badanych (102 osoby). Nie odnotowano odpowiedzi błędnych ani deklaracji braku wiedzy, co wskazuje na pełne zrozumienie zasad właściwej, empatycznej komunikacji z dzieckiem w kontekście zachowań ryzykownych. Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej przed szkoleniem poprawną odpowiedź wskazało 96,6% badanych (1095 osób). Odpowiedzi błędnych lub deklarację braku wiedzy udzieliło łącznie 3,4% respondentów (38 osób). Porównanie wyników obu pomiarów wskazuje na pełne utrwalenie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zasad prawidłowej komunikacji z dzieckiem na temat zachowań problemowych i uzależnień. Odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł o 3,4 punktu procentowego, osiągając poziom maksymalny w badaniu końcowym, przy jednoczesnym całkowitym wyeliminowaniu odpowiedzi błędnych oraz deklaracji braku wiedzy. Pomimo różnic w liczbie respondentów uczestniczących w badaniu przed i po szkoleniu, uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają wysoką skuteczność szkolenia w kształtowaniu empatycznego, nieocenającego i opartego na komunikatach „ja” stylu rozmowy z dzieckiem, kluczowego w działaniach profilaktycznych i wychowawczych.

Podsumowanie

Analiza wyników ankiet sprawdzających poziom wiedzy przed i po webinarze „Pierwsza pomoc rodzicielska: Uzależnienia dzieci i młodzieży” wskazuje, że udział w spotkaniu edukacyjnym przyczynił się do istotnego wzrostu wiedzy uczestników w kluczowych obszarach związanych z rozumieniem mechanizmów uzależnień, ich objawów oraz roli rodziny i komunikacji w procesie profilaktyki i wsparcia dziecka.

Już na etapie preankiety uczestnicy wykazywali wysoki poziom wiedzy w zakresie systemowego rozumienia uzależnień oraz zasad prawidłowej, empatycznej komunikacji z dzieckiem. Po webinarze wiedza ta została w pełni utrwalona, co potwierdza osiągnięcie 100% poprawnych odpowiedzi w pytaniach dotyczących systemowego ujęcia rodziny oraz właściwego komunikatu w rozmowie z dzieckiem na temat zachowań problemowych.

Szczególnie wyraźny wzrost poziomu wiedzy odnotowano w obszarach wymagających bardziej specjalistycznego rozumienia mechanizmów uzależnień. Dotyczy to przede wszystkim neurobiologicznych podstaw uzależnienia, gdzie odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł o ponad 18 punktów procentowych, oraz rozpoznawania kluczowych objawów uzależnień behawioralnych, gdzie wzrost poprawnych wskazań wyniósł 16 punktów procentowych. Wyniki te potwierdzają skuteczność webinaru w porządkowaniu wiedzy i korygowaniu błędnych przekonań dotyczących różnic między uzależnieniami behawioralnymi a uzależnieniami od substancji psychoaktywnych.



Jednocześnie analiza wyników ujawniła obszar, w którym poziom wiedzy uczestników, mimo poprawy, pozostaje relatywnie niski. Dotyczy to pytania o okres największej podatności na rozwój uzależnień. Choć po webinarze odsetek poprawnych odpowiedzi wzrósł ponad czterokrotnie, nadal większość respondentów wskazywała późniejsze etapy rozwoju, w szczególności okres dojrzewania. Wynik ten sugeruje istnienie silnie utrwalonych, intuicyjnych przekonań dotyczących podatności na uzależnienia i wskazuje na potrzebę dalszego wzmacniania przekazu edukacyjnego dotyczącego znaczenia wczesnego dzieciństwa w profilaktyce uzależnień.

Należy podkreślić, że niższa liczebność postankiety w porównaniu z preankietą wynikała z dobrowolnego charakteru udziału w badaniu oraz organizacyjnych uwarunkowań udziału w webinarze i nie powinna być interpretowana jako obniżone zaangażowanie uczestników. Pomimo tej różnicy, uzyskane wyniki są spójne i pozwalają na formułowanie wiarygodnych wniosków dotyczących efektywności działań edukacyjnych.

Podsumowując, wyniki ankiet jednoznacznie wskazują, że webinar „Pierwsza pomoc rodzicielska: Uzależnienia dzieci i młodzieży” był skutecznym narzędziem podnoszenia kompetencji rodziców i opiekunów, szczególnie w zakresie rozumienia mechanizmów uzależnień, objawów uzależnień behawioralnych oraz roli empatycznej komunikacji i systemowego podejścia do rodziny. Jednocześnie wyniki badania dostarczają cennych wskazówek dotyczących obszarów wymagających dalszego pogłębienia w przyszłych działaniach edukacyjnych.





Wnioski

Przeprowadzona analiza wyników ankiet sprawdzających poziom wiedzy przed i po szkoleniach oraz webinarach realizowanych w ramach II edycji programu „Wsparająca Szkoła” jednoznacznie wskazuje, że program stanowi skuteczne i adekwatne narzędzie wzmacniania kompetencji dorosłych odpowiedzialnych za dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. Zarówno nauczyciele, specjaliści szkolni, jak i rodzice oraz opiekunowie, po udziale w działaniach edukacyjnych wykazywali wyższy poziom wiedzy, większą spójność rozumienia kluczowych pojęć oraz lepsze przygotowanie do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Wyniki badań pokazują, że przed udziałem w szkoleniach uczestnicy często posiadali fragmentaryczną, intuicyjną lub nieuporządkowaną wiedzę, szczególnie w obszarach wymagających specjalistycznego rozumienia procesów psychicznych, mechanizmów kryzysu oraz zasad bezpiecznej interwencji. Dotyczyło to m.in. rozróżniania kryzysu psychicznego od zaburzeń psychicznych, właściwego prowadzenia rozmowy wspierającej z uczniem, etapów pierwszej pomocy emocjonalnej, współpracy z rodzicami w sytuacji kryzysu, a także neurobiologicznych i rozwojowych uwarunkowań zależności. Ankiety wstępne ujawniły również istnienie utrwalonych przekonań potocznych, które nie zawsze były zgodne z aktualną wiedzą naukową, szczególnie w odniesieniu do podatności rozwojowej dzieci oraz interpretacji zachowań ryzykownych.

Porównanie wyników pre- i posttestów wskazuje na wyraźny i konsekwentny wzrost odsetka poprawnych odpowiedzi we wszystkich analizowanych modułach szkoleniowych. Największe przyrosty wiedzy odnotowano w obszarach praktycznych i interwencyjnych, które bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Dotyczy to w szczególności znajomości etapów pierwszej pomocy emocjonalnej, zasad prowadzenia rozmowy wspierającej z uczniem w kryzysie psychicznym, konieczności sprawdzania obecności zachowań autodestrukcyjnych oraz umiejętności reagowania w sytuacjach wymagających współpracy z rodzicami i systemem ochrony zdrowia psychicznego. W tych obszarach wzrost poprawnych odpowiedzi był nie tylko statystycznie istotny, ale również praktycznie znaczący z punktu widzenia codziennej pracy szkoły.

Istotnym wnioskiem płynącym z analizy jest fakt, że szkolenia nie tylko podnosiły poziom wiedzy, ale również porządkowały i ujednoliciły sposób rozumienia kluczowych zagadnień wśród uczestników. Widoczny spadek liczby odpowiedzi „nie wiem” oraz odpowiedzi błędnych po zakończeniu szkoleń wskazuje na wzrost pewności poznawczej uczestników oraz lepsze osadzenie wiedzy w spójnych ramach teoretycznych i praktycznych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysie, gdzie brak pewności lub obawa przed popełnieniem błędu może prowadzić do zaniechania reakcji.

Wyniki badań pozwoliły zidentyfikować obszary, które wymagają dalszego wzmacniania w przyszłych edycjach programu. Dotyczy to w szczególności wiedzy na temat okresów największej podatności rozwojowej na uzależnienia, gdzie mimo zauważalnego wzrostu poprawnych odpowiedzi po webinarach, nadal dominowały odpowiedzi odwołujące się do potocznych przekonań o szczególnej roli okresu dojrzewania. Wskazuje to na potrzebę dalszego pogłębiania wiedzy rodziców i nauczycieli w zakresie znaczenia wczesnego dzieciństwa dla kształtowania mechanizmów regulacji emocjonalnej i podatności na zachowania ryzykowne.

Podsumowując, analiza wyników ankiet jednoznacznie wskazuje, że II edycja programu „Wsparająca Szkoła” była działaniem skutecznym, potrzebnym i adekwatnym do wyzwań stojących przed współczesną szkołą i rodziną. Program nie tylko zwiększył poziom wiedzy uczestników, ale również przyczynił się do wzrostu ich kompetencji praktycznych, poczucia odpowiedzialności oraz gotowości do podejmowania działań wspierających dzieci i młodzież w kryzysie. Uzyskane rezultaty potwierdzają zasadność kontynuowania i dalszego rozwijania programu jako elementu systemowych działań profilaktycznych w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Podsumowując, kluczowe wnioski z programu „Wsparająca Szkoła” to:

- Skuteczność szkoleń i spotkań edukacyjnych w podnoszeniu świadomości i kompetencji uczestników.
- Wzrost wiedzy w zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego i udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej.
- Poprawa umiejętności komunikacji i współpracy z rodzicami uczniów w kryzysie.
- Podkreślenie znaczenia dbałości o dobrostan psychiczny nauczycieli.
- Konieczność ciągłego rozwoju i wzmacniania wiedzy w pewnych obszarach, np. identyfikacji zachowań autodestrukcyjnych.
- Potrzeba kontynuacji działań edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców, w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności.